

目 录

上篇 灸法的基础知识

一、灸法的起源和发展·····	(1)
二、灸法的定义和治疗作用·····	(4)
三、灸法的适应证和禁忌证·····	(6)
四、施灸材料·····	(8)
五、常用灸法·····	(10)
六、施灸的体位和顺序·····	(32)
七、施灸的手法及壮数·····	(33)
八、灸疮的处理及灸后调养·····	(34)
九、施灸的注意事项·····	(35)
十、施灸常用腧穴·····	(36)

下篇 临床各科疾病的灸疗法

一、内科疾病

昏迷·····	(115)	感冒、流行性感冒···	(127)
晕厥·····	(117)	痢疾·····	(130)
休克·····	(120)	病毒性肝炎·····	(133)
中暑·····	(122)	肺结核·····	(135)
一氧化碳中毒·····	(124)	霍乱·····	(138)
食物中毒·····	(125)	疟疾·····	(140)

慢性支气管炎·····	(144)	黄疸·····	(203)
支气管哮喘·····	(148)	胁痛·····	(206)
慢性阻塞性肺气肿 ·····	(153)	肝硬变·····	(209)
慢性肺源性心脏病 ·····	(155)	眩晕·····	(213)
冠状动脉粥样硬化性 心脏病·····	(157)	中风·····	(217)
心悸·····	(160)	面神经麻痹·····	(221)
失眠·····	(164)	水肿·····	(225)
低血压·····	(167)	泌尿系感染·····	(227)
神经衰弱·····	(168)	癃闭·····	(230)
癫痫·····	(170)	遗精、早泄·····	(234)
呕吐·····	(174)	阳痿·····	(237)
反胃·····	(176)	男性不育症·····	(240)
慢性胃炎·····	(178)	糖尿病·····	(241)
消化性溃疡·····	(179)	甲状腺功能减退症 ·····	(243)
胃粘膜脱垂·····	(181)	内伤发热·····	(246)
呃逆·····	(183)	白细胞减少症·····	(247)
胃脘痛·····	(185)	特发性血小板减少性 紫癜·····	(249)
腹痛·····	(188)	头痛·····	(251)
泄泻·····	(191)	腰腿痛·····	(256)
麻痹性肠梗阻·····	(194)	痹证·····	(260)
便秘·····	(196)	肢端动脉痉挛病(雷 诺病)·····	(265)
胃下垂·····	(199)	痿证·····	(267)
溃疡性结肠炎·····	(201)		

二、妇科疾病

月经不调·····	(269)	妊娠呕吐·····	(287)
痛经·····	(273)	胎位不正·····	(289)
功能失调性子宫出血 ·····	(278)	产后乳汁不足(附:退 乳)·····	(290)
闭经·····	(281)	子宫脱垂·····	(292)
带下病·····	(284)	外阴瘙痒症·····	(294)
盆腔炎·····	(286)	不孕症·····	(296)

三、儿科疾病

惊风·····	(299)	小儿厌食·····	(311)
流行性腮腺炎·····	(303)	疳积·····	(313)
百日咳·····	(305)	小儿遗尿·····	(317)
小儿腹泻·····	(308)	鹅口疮·····	(319)

四、外科疾病

疖病·····	(321)	·····	(335)
疔疮·····	(324)	颈淋巴结结核·····	(337)
急性淋巴管炎·····	(326)	脱肛·····	(341)
急性乳腺炎·····	(328)	痔疮·····	(344)
急性阑尾炎·····	(332)	肩关节周围炎·····	(346)
血栓性闭塞性脉管炎 ·····		扭伤·····	(349)

五、皮肤科疾病

带状疱疹·····	(351)	手足癣·····	(356)
疣·····	(353)	荨麻疹·····	(358)

湿疹·····	(360)	硬皮病·····	(366)
神经性皮炎·····	(364)	外阴白斑病·····	(368)

六、健美

单纯性肥胖症·····	(370)	白癜风·····	(379)
消瘦·····	(372)	斑秃·····	(381)
面部皮肤皱纹·····	(373)	酒渣鼻·····	(383)
黄褐斑·····	(375)	臭汗症·····	(385)
雀斑·····	(377)	保健灸·····	(387)

上篇 灸法的基础知识

一、灸法的起源和发展

(一) 灸法的起源

灸法是以艾绒为材料,放在体表一定部位(穴位)烧灼,利用燃艾灸火的热力治病的一种方法。这种传统治疗方法,具体起源于何时,已无法考证,但因其需用火,故可追溯到人类开始用火之后的旧石器时代。自人类懂得利用火以后,古人用火来驱除寒冷,腐熟水谷,炮生为熟,同时火作用于人体之后,还具有温通血脉,舒筋活络,解除疲劳的作用,使人们在无意中接受了医疗,起到了间接的保健作用,很自然会想到用火来治疗病痛。随着人们用火日益频繁,在接触火时,燃烧暴跳的火星沾在身上,烧伤皮肤,有时这种意外的烧伤,却消除或减轻了某种病痛。人们就记住这个烧伤的位置,当这种病痛再次出现时,就试探着用点燃的枝条,再烧灼原来的地方,同样使症状消除或缓解。通过这些零星、点滴的多次重复经验,日积月累,就逐渐发展为灸法。在殷商甲骨文中,有一个字,其形象为一个人躺在床上,腹部安放着一撮草,很像用艾灸治病的示意。施灸主要用艾绒,《孟子·离娄》篇说:“九年之病,求三年之艾,苟为不蓄,终身不得。”说明春秋战国时期,存蓄艾蒿以备艾灸治疗应用,已成为普遍的知识。后人也有用其它物品施灸的,除灸法外,还有熨法、熏法、角法(拔火罐)及淬刺(火

针),类同灸疗,都是借助火的热力在医疗上的应用。

(二) 灸法的发展

灸法在春秋时期应用已很普遍,长沙马王堆出土的《五十二病方》记载灸法较多,其中有“……以艾裹,以艾灸癰者中颠,令烂而已”。指出艾灸头顶百会穴以治疝气,并要达到化脓才有好的疗效。这个时期已能运用灸法治疗足小趾痛、腰痛、日痛、心痛、痈、疥、疝气等上百种不同疾病。《内经》指出“北方者,天地所闭藏之域也,其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,藏(脏)寒生满病,其治宜灸”。“灸寒热之法,先灸项大椎”,“大风汗出,灸谿谿”,“失枕……灸脊中”,“形乐志苦,病生于脉,治之以灸刺”,“陷下则灸之”等等,这是当时医家对艾灸疗法临床经验的初步总结。

东汉医家张仲景十分重视灸法,在《伤寒论》中涉及灸法有关的内容 12 条,许多条文有“可火”、“不可火”的记载。提出阳证宜针;阴证宜灸的见解。三国时出现我国最早的灸疗专著《曹氏灸经》,总结了秦汉以来灸法的经验,促进了灸法的发展。

葛洪注重灸法,突破了灸法只治虚寒证及作为康复手段,而用灸疗作为抢救措施之一,治疗猝死、五尸、霍乱吐利等急症。到两晋南北朝时期,已运用灸法预防霍乱,灸足三里健身,发明使用瓦甑灸,为器械灸的发明打下基础。

唐代针灸保健占有重要地位,著名医家孙思邈在《千金要方》中辑录了很多针灸保健的资料,如灸足三里称为“长寿灸”,可以防病抗衰老。提出采用灸法预防传染病,治疗某些热性病。发展了隔蒜灸、隔盐灸、豆豉灸、黄蜡灸、黄土灸,并采用苇管灸治疗耳病,开创了灸疗器械的运用。此后,王焘崇尚灸法,在《外台秘要》中重点介绍了艾法,多采用艾火治疗心疝、

骨疽、偏风、脚气入腹等疑难病证。《骨蒸病灸方》专门介绍灸治癆病的方法,使四花穴灸法,流传于后世。唐时灸法已发展成为一门独立科学,并有了专业灸师。

宋元时期针灸有较大发展,灸法倍受重视,受宠于皇宫,国家医疗机构太医局设针灸专科,宋太祖亲自为其弟施灸,并取艾自灸,为后人传为佳话。北宋王惟一的《铜人腧穴针灸图经》较详细地叙述了经络、腧穴等内容,考证了人体 354 个穴位。此后,他又制造了两具我国最早进行针灸研究的人体模型——铜人,这些对经穴的统一,针灸学的发展起到很大的促进作用。《太平圣惠方》、《普济本事方》、《圣济总录》等医方书中收集了大量的灸疗内容,灸法已成为当时的主要急救措施之一。还出现了用“睡圣散”进行麻醉施灸,以减轻火灼给病人带来的痛苦;利用毛茛叶、芥子泥、旱莲草、斑蝥等有刺激性药物贴敷穴位,使之发泡,进行“天灸”、“自灸”等。朱丹溪完善了热证可灸的理论,阐明了热证包括实热与虚热两方面,灸法有攻、有补,把灸法用于热证的作用归纳为“泄引热下”、“散火祛痰”、“养阴清热”三方面。

明代是针灸发展的高潮时期,《针灸大成》、《针灸大全》、《针灸聚英》等一批针灸著作相继问世,出现了艾卷温灸法,后来发展为加进药物的“雷火神针”、“太乙神针”。还出现了“桑枝灸”、“神针火灸”、“灯火灸”、“阳燧灸”等等。

清代灸法专著《神灸经论》倡导灸重审穴。在施灸的方法上也有所创新,出现了磁缸灸、针柄烧艾灸(温针)、隔面碗灸等。至清末,由于西方文化的侵入,灸法如同中医、针刺一样,陷入了停滞发展时期,但由于灸疗简便安全,疗效卓著,广大劳动人民需要灸疗,在缺医少药的民间仍广为流传,并以其简便、灵验扎根于民众之中。

建国后,灸灸疗法如同中医一样,在医、教、研诸方面都得到了发展,通过现代科学实验手段对灸灸的机制进行了大量研究,并取得了显著成绩。随着改革开放的春风,国内外出现“中医热”、“针灸热”,灸灸疗法也随之复兴,并取得了长足的进步,出现了“燎灸”、“火柴灸”、“硫黄灸”等新灸法,发明了电热仪、电灸仪等各种现代灸疗仪器,使灸法可定时、定量、定性、无烟,灸温可调节,操作更方便。对休克、心绞痛、慢性支气管炎、支气管哮喘、骨髓炎、硬皮病、白癜风等危重疑难病证的防治,取得了较好的效果。灸灸还开始步入减肥防皱、美容防老领域,受到医学界的注目。

综上所述,灸法是我国劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结,是针灸学的组成部分,为我国传统优秀医疗方法之一。它为中华民族的繁衍昌盛作出了重大贡献,对世界医学的发展也产生过一定影响。当今,灸法的卓著疗效已得到世界医学界公认,受到世界卫生组织的重视。我们深信,今后随着医学科学的发展,灸灸在防治疾病、康复保健方面必将继续发挥更大的作用,使这一国宝,在世界医林中放射出更加灿烂的光彩,结出丰满的硕果。

二、灸法的定义和治疗作用

(一) 灸法的定义

“灸”字,《说文解字》作“灼”字解释,是灼体疗法的意思。灸法是用艾绒或其它药物放置在体表的穴位上或患处烧灼温熨,借灸火的温和热力或药物的作用透入肌肤,通过经络的传导作用,深入脏腑,温通经络,调和气血,扶正驱邪,达到防治疾病和保健强身目的的一种外治疗法。是火力在医疗上的直

接应用。施灸的材料很多,其中以艾绒作为施灸材料者,称艾灸疗法;采用其它材料施灸者,称非艾灸疗法。

(二) 灸法的治疗作用

灸法是利用燃艾的温和热力刺激体表腧穴,通过经络传导,藉以激发人体脏腑经络的功能,调整机体阴阳气血运行(调气)和神气活动(调神)而调和阴阳,温通经络,行气活血,逐寒除湿,消肿散结,平肝降逆,补虚泻实,扶正祛邪,补中益气,回阳救逆及防病保健,延缓衰老,强身益寿。现代科学实验和临床研究业已揭示,这种作用的机制是艾灸具有调整脏腑组织功能,促进体内新陈代谢,增加红、白细胞的数量和吞噬细胞的吞噬功能,调整和提高机体的免疫功能,增加机体的抗病能力。这与传统的认识是一致的。

1. 调和阴阳 人体阴阳的偏盛偏衰是疾病发生发展的根本原因。因此,调整阴阳,泻其有余,补其不足,使失调的阴阳向着协调的方向转化,恢复相对平衡状态,则是治病的根本原则。灸法可通过刺激经络、脏腑,运用灸法的补泻作用,以达调和阴阳,如慢性腹泻的虚寒证,在中脘、天枢、关元、足三里等穴施灸,温补脾肾,即可止泻。

2. 温经散寒 《素问·调经论》说:“血气者,喜温而恶寒,寒则泣而不流,温则消而去之”。艾叶辛温,燃艾热力可深达肌层,温气行血。因此,灸法具有良好的温通经络、散寒除湿、调理气血、宣痹止痛的作用。如冬季灸气海、阳关、足三里等穴,可起温阳散寒,温通经络的作用,以防止寒痹的发生。

3. 行气活血,消瘀散结 气见热则行,见寒则凝,气温则血滑。灸法为温热刺激,可使气血协调,营卫和畅,血脉和利,故起到行气活血,消瘀散结的作用。如对一些经脉气血阻滞不通引起的四肢活动障碍、疼痛、麻痹、口眼喎斜、中风瘫痪等病

有康复的作用。

4. 温阳补虚，补中益气 《灵枢·官能》说：“上气不足，推而扬之”。灸法对气血运行能起“推而上之”的引导作用。因此，灸百会穴有补中益气、升阳举陷的作用。临床对脾阳不足、脾虚泄泻、腹胀、命火不足而致的阳痿、夜尿频多、遗尿或子宫发育不良等疾病的康复保健有良效。

5. 回阳救逆 《本草从新》指出：“艾叶苦辛，……纯阳之性，能回垂绝之阳”。《伤寒论》有“少阴病吐利，手足逆冷……脉不至者，灸少阴七壮”，“下利手足厥冷，无脉者，灸之”等条文，均为热性病过程中阳气虚脱的危重证候用灸法治疗的论述，可见灸法治疗疾病有回阳复脉的功效。临床上对阴寒内盛、阳气衰微的中风脱证，阳气衰微或阴阳离决而出现面色苍白、四肢逆冷、大汗淋漓、血压下降、脉微弱等证，用灸法能回阳救逆。

6. 防病保健，强身益寿 人以阳气为本，得其所则体强而寿彰，失其所则体弱而寿夭。灸能温阳，无病自灸，可以激发人体阳气，阳气充沛则化精养神，使精神饱满，卫外防御功能旺盛，不仅能增强抗病能力，抵抗外邪的侵袭，而且还能使精力充沛，体健长寿。俗话说“若要身体安，丹田、三里常不干”，不无道理，现代临床已证明：常灸足三里、大椎等穴，能激发人体正气，增强抗病能力，起到防病保健、延缓衰老、强身益寿的作用。

三、灸法的适应证和禁忌证

（一）灸法的适应证

灸法是通过火力的温热刺激穴位，激发经络的功能而起

作用,从而达到调节机体各器官组织功能失调的治疗方法。《灵枢·官能》指出:“针所不为,灸之所宜”。说明灸法有其特殊功效,可补针药之不足。临床应用十分广泛,既可单独使用,也可与针刺或药物配合应用。临床各科的急性和慢性疾病、常见病、多发病、疑难危重病,不论阴阳、表里、寒热、虚实各种证候都有灸法的适应证。但因灸法是借助于燃艾灸火的热力透入肌肤以达到温经散寒、疏通经络、扶阳固脱的目的,故适应证范围一般以寒证、阴证、阳虚证及慢性久病为主。具体适应证如下:

1. 外感风寒表证,咳嗽气喘等,灸之以疏风散寒,止咳平喘。

2. 寒凝血滞,经络闭阻引起的风寒湿痹、寒疝腹痛、痛经、闭经等各种病证。灸之以温经散寒,疏通经络,行气活血,宣痹止痛。

3. 外科疮疡、乳痈、瘰癧初起,疔肿未化脓者,各种痛证,灸之可拔毒泄热,消瘀散结,和畅营卫,活血止痛。对于疮疡久溃不愈,灸之还有促进愈合、生肌长肉的作用。

4. 气滞积聚,小儿疳积等灸之通滞散积。

5. 气逆上冲,如脚气冲心、肝阳上升等引起的病证。灸涌泉可镇逆下气;灸足三里、绝骨以平肝降逆,引气下行。可预防中风发作。

6. 中焦虚寒出现呕吐、腹痛、腹泻诸证,灸之可温经散寒。

7. 气虚下陷引起胃、肾下垂,子宫脱垂,脱肛,崩漏等证,灸之可补中益气,升阳举陷。

8. 脾肾阳虚引起久泻、久痢、遗精、早泄、阳痿、遗尿、男子虚羸少气、老人阳衰多尿等证,灸之以温补脾肾。

9. 阳气虚脱而出现大汗淋漓、四肢厥冷、脉微欲绝的亡阳脱证及休克、中风脱证可急灸之，以回阳固脱。

10. 预防疾病，保健强身，常可灸丹田、足三里等穴。

（二）灸法的禁忌

灸法是借火治病，灸之不当，则火邪内攻，灼耗阴血，引起不良效果，不可不慎。除了一般不宜在过饥、过饱、醉酒、大惊、大恐、大怒、大渴、大汗、极度疲劳时，以及对艾灸恐惧者不宜施灸外，还有以下两方面：

1. 部位禁忌 血管表浅部位、头面五官部位及关节筋腱部位不宜施化脓灸；重要器官附近、肌肉浅薄处、乳头、阴部、妇女月经期和妊娠期的腹部及腰骶部均不宜施灸。如遇急重病证，必须施灸，有些部位可改用艾条灸、间接灸等变通灸法。至于古文献记载的禁灸穴位，可根据上述原则，结合临床实际，灵活掌握。

2. 病情禁忌 由于灸法用火，火性属阳，既能益阳，又能伤阴，对于实热证、阴虚发热者，一般不适宜灸治，如阴虚癆瘵、咯血吐血、心悸怔忡、高热神昏、中风闭证、肝阳头痛、多梦遗精、阳明胃实等一切阴虚阳亢、邪热内炽的病症，均不属灸法适应证范围。此外，不论外感或阴虚内热病症，凡脉象数疾者，或极度衰竭者，亦不宜灸治。

四、施灸材料

施灸的材料很多，但以艾叶为主。远古时代是用一般树枝或杂草来灸灼以治病的，到春秋时期才以艾叶作为施灸材料，《素问》有“鑱石针艾治其外”的记载。近代除了用艾绒施灸外，根据不同疾病或特殊要求，可在艾绒中加进其它灸料，或单独

使用其它灸料施灸。

(一) 艾叶

1. 艾叶的性能和作用 艾叶又称艾蒿、蕪艾、灸草。全国各地均普遍野生,以湖北蕪州产者为佳,叶厚、绒多,称蕪艾。作为灸料的艾绒,主要用艾叶制成。艾叶气味芳香、味苦、性辛温,入脾、肝、肾经。主要含无氮素的有机物(纤维质)、有氮素的有机物(蛋白质)、离子成分(钾、钠、钙、铝、镁)、溶酶成分(其中含挥发油 0.02%)。《本草从新》说:“艾叶苦辛、性温,属纯阳之性,能回垂危之阳,通十二经,走三阴,理气血,逐寒湿,暖子宫……以之灸火,能透诸病而治百病。”说明艾叶用作灸料具有温通经络,行气活血,祛湿逐寒,消肿散结,回阳救逆等功效,主灸百病。艾叶经过加工,制成细软的艾绒,便于搓捏成大小不同规格的艾炷,易于燃烧,火力温和,适用于各种灸法和温针。

2. 艾绒的制法、选择和贮藏

(1) 艾绒的制法:每年 3~5 月间,采集鲜嫩肥厚的艾叶,日光曝晒干燥,放石臼中捣碎,筛去泥沙杂梗,即成艾绒,适用于一般灸法;如再精细加工,经数十次晒杵筛拣者,变成土黄色,即为细绒,可用于直接灸法。

(2) 艾绒的选择:艾绒质量的优劣,对灸治效果有直接影响。质劣或新艾绒含挥发油较多,燃烧时火力强烈,使人感到灼痛,难以忍受。含杂质多的艾绒,燃烧时容易散裂;而质优的陈艾,燃烧时火力温和耐燃,不易散裂,使热力能穿透皮肤,直达深部。所以,艾灸应选择存放陈久的优质艾绒为佳。艾绒质量优劣的鉴别:以质纯柔软如细绒,干燥无杂质,黄白略带青色,存放久的陈艾绒为优;反之,新采且混有杂质,粗糙成块,生硬潮湿,黑褐色为劣。

(3) 艾绒的贮藏:艾绒以陈久者为佳,故有“求三年之艾”之说。艾绒制成后,要存放一定时间才能应用,但由于艾绒易吸水,容易受潮、虫蛀霉变。因此,应将制好的艾绒晾晒后放在干燥密闭的容器内,勿使透气,置干燥处贮存。霉雨季节尤应防潮,晴天宜常晾晒。

(二) 其它材料

1. 灯心草、桑枝、桃枝、竹茹、麻叶、硫黄、黄蜡等容易点燃生热,可用作灸料或制炷施灸。

2. 生姜片、蒜片、附子片、食盐等可单独或制成复方药饼,作为隔物施灸中的隔垫物。

3. 毛茛、旱莲草、白芥子、斑蝥等直接贴敷皮肤可以发泡,可用作天灸中的灸料。其它尚有麝香、木香、豆豉、葱白、吴萸、胡椒等亦可作灸料。

4. 香硫饼、阳燧锭、救苦丹等,系用多种药物共研细末,与硫黄熔化在一起制成药锭或用絮棉纸制成药捻,因此亦可作为灸料。

五、常用灸法

(一) 艾灸法

艾灸法是将艾绒置于体表应灸穴位或患处烧灼施灸的方法,是艾灸中最常用的一种方法。包括艾炷灸、艾条灸、艾饼灸及熏灸4类。

1. 艾炷灸 是用艾绒制成圆锥形艾炷,直接或间接置于穴位上施灸的方法。

艾炷的制作是将纯净的艾绒放在平板上,用拇、食、中三指边捏边旋转,把艾绒捏紧成规格大小不同的圆锥形艾炷,捏

得越紧越好。艾炷规格有大、中、小3种，习惯以植物种子比喻，大艾炷如半截橄榄大；中艾炷如半截枣核大；小艾炷如麦粒大(见图1)。



图1 艾炷图

用于直接灸的，一般用小炷或中炷；用于间接灸的，一般用大炷。每燃尽1炷为1壮。施灸的壮数多少，可根据疾病的性质、病情的轻重、体质的强弱而定。按艾炷灸的不同操作方式可分直接灸(着肤灸)和隔物灸(间接灸)两类。

(1) 直接灸：是把艾炷直接安放在皮肤上施灸的一种方法，又称着肤灸、明灸(见图2)。施灸时可在皮肤上涂点凡士林(大艾炷)或蒜汁(小艾炷)，增加粘附作用，以防艾炷安放不稳倾倒。按施灸对皮肤刺激程度不同，又分为瘢痕灸、无瘢痕灸和发泡灸3种。



图2 直接灸图

①瘢痕灸：用小艾炷直接安放在穴位上施灸，灸后局部皮肤被烧伤，产生无菌性化脓现象，故又称化脓灸。可以发挥治疗保健作用。施灸前要选择平整而舒适的体位，在选好的穴位上涂些蒜汁后，安放艾炷

点燃施灸，需待艾炷燃尽，除去艾灰，更换新炷再灸。每次换新炷时，需重新涂蒜汁1次，一般灸7~9壮。在施灸过程中，当燃艾烧近皮肤，患者感到灼痛时，施术者可用手轻轻拍打施灸部位四周，以减轻疼痛。灸毕，可在施灸部位敷贴灸疮膏药(淡膏药)或一般膏药，封护灸疮，大约1周左右可化脓形成灸疮，化脓期每日换药1次，约经5~6周结痂愈合，结痂脱落后遗

留瘢痕。因此,施灸前必须征得患者同意,方可使用此法,且在灸疮化脓后应注意保护局部清洁,预防继发感染,一旦继发感染,应予以治疗。本法一般多用于四肢穴位,临床常用于治疗哮喘、慢性肠胃病、肺癆、瘰癧、痞块、癰痛、发育障碍等慢性疾病,以及皮肤溃疡日久不愈、痣、疣、鸡眼和局限难治的皮肤病。对高血压、中风的防病保健也有较好作用。临床实践证明,治疗施瘢痕灸发生的灸疮,确有良效,然而烧灼疼痛是其缺点,不易被患者接受,因此影响了它的使用范围。现在,为了解决施灸烧灼痛,临床上除了采用施灸周围皮肤拍打外,还采用0.2%普鲁卡因1毫升~2毫升作施灸处皮下注射局麻或采用中药液(川乌、细辛、花椒各30克,蟾酥1.8克;用75%酒精300毫升浸泡24小时,取棕红色上清液备用)外涂局麻无痛施灸法,取得了较好效果。身体虚弱者、糖尿病、皮肤病及头面部不宜用瘢痕灸法。

②无瘢痕灸:这种灸法虽然也是将艾炷直接安放在皮肤上灸治,但以不烧伤皮肤为度。操作时,先在选好的穴位上涂些凡士林或甘油,以使艾炷便于粘附,然后选用中、小艾炷粘固,从上端点燃施灸。当艾炷燃烧至患者感到皮肤发烫时,即将艾炷压灭或用镊子取下,更换新炷再灸,一般灸3~7壮,以施灸处局部皮肤充血出现红晕,无烧伤,患者自觉舒适为度。适用于治疗哮喘、眩晕、慢性腹泻等一般性虚寒病轻证和疥癣、湿疹、痣、疣及皮肤病溃疡不愈。因不起泡,不溃烂化脓,不遗留瘢痕,易为患者接受,但疗效不如瘢痕灸。

③发泡灸:用小艾炷施灸,待患者感到发烫时继续灸3~5秒钟。此时施灸部位皮肤可出现黄斑,1~2小时后局部发泡,一般不需挑破,3~4日后可自然吸收,短期内可有色素沉着,不遗留瘢痕。适用于一般慢性虚寒疾病,如哮喘、瘰癧及疖

疮、皮炎、疥癣、白癜风等。

(2) 隔物灸：隔物灸是在艾炷与皮肤之间隔垫某种物品而施灸的方法(见图3)，又称间接灸、间隔灸。临床所用隔垫物种类很多，既有植物、动物、矿物，也有药物，大多属中药，有单方，也有复方，或切成片，或制成药饼，或研成药末，因病症不同而定。将艾灸与药物合起来，既发挥艾灸的作用，又发挥药物的作用，因而具有特殊的效果，可应用于临床各科疾病的治疗。又因火力温和，无烧伤灼痛，故患者乐于接受。临床较直接灸常用。主要灸法有：



图3 隔物灸图

①隔姜灸：是用姜片作隔垫物的一种施灸方法。施灸时，取鲜生姜切成0.2厘米～0.3厘米的薄片，中间用针扎数孔，放在施灸穴位上，然后将艾炷置于姜片上点燃施灸5～10壮。灸中，如患者感到灼烫不能忍受时，可将姜片略提起或缓慢移动，待灼烫感消失后放下再灸。艾炷燃尽，更换新炷，灸至局部皮肤潮红为度。适用于一切虚寒证。对寒性呕吐、腹痛、泄泻、遗精、早泄、阳痿、不孕、痛经、面瘫及风寒湿痹疗效较好，也用于皮肤冷痛、冻疮、各种皮炎、疮癣等皮肤疾病。

②隔蒜灸：是用蒜片或蒜泥作隔垫物的一种施灸方法。施灸时，取独头大蒜切成厚约0.2厘米～0.3厘米薄片或捣成

蒜泥，制成蒜饼，中间用针扎数孔，放在施灸穴位上，上置艾炷点燃施灸 5~7 壮。因蒜汁对皮肤有刺激性，灸后容易起疱，如不使起疱，可将蒜片向上提起或缓慢移动。灸中如蒜片（饼）烧焦，应更换新片（饼）。本法具有发散拔毒、消肿止痛的作用，目前临床多用来治疗肺结核、瘰癧、腹中积块、未溃疮疡、皮肤红肿、瘙痒、蛇蝎毒虫所伤等。若治疗痈疽疮毒疼痛麻木者，可以湿纸覆盖，再放蒜片（饼）施灸，若痒痛者可灸至不痒痛；若麻木者，可灸至疼痛。亦可在蒜片下涂以麝香用来进行类风湿病的康复施灸。

若治疗虚劳，操作时可采用长蛇灸。令患者俯卧，在脊柱正中大椎至腰俞铺蒜泥一层，厚约 0.3 厘米，宽约 2 厘米，周围用棉皮纸封固，勿令泄气，然后用中艾炷置大椎至腰俞之间的每一脊椎凹陷处点燃施灸，不计壮数，直灸到患者自觉口鼻中有蒜味时停灸，灸毕少待，用温开水渗湿棉皮纸周围，除去蒜泥。因大蒜和灸火对皮肤的刺激，灸后多起水疱，须休息一段时间。

③隔葱灸：是用葱作隔垫物的一种施灸方法。施灸时，将葱白切成 0.2 厘米~0.3 厘米厚数片或捣成葱泥，平敷在脐中及周围，或者敷于患处，上面放置大艾炷点燃施灸 5~10 壮，以局部温热舒适，不感灼痛为度。临床上用于治疗虚脱、腹痛、尿闭、疝气、乳痈等疾病，疗效很好，还可用于减肥、保健美容和抗衰老。

④隔盐灸：是用食盐填平脐窝作隔垫物的一种施灸方法。一般只用于脐部施灸，故又称神阙灸。施灸时，取纯净燥白食盐研细，填平脐窝（脐窝突起者，可用湿面条围脐如井口，然后再填盐），在盐上置大艾炷点燃施灸 3~7 壮，或在盐上放置姜片、药饼等隔垫物再施灸。灸中如患者稍感灼痛，即更换新炷

再灸。临床多用于治疗中寒、腹痛、吐泻、痢疾、淋病、阳痿、滑泄、中风脱证、不孕等，还有强壮保健、美容、抗衰老作用。用大艾炷连续施灸，有回阳救逆固脱作用，治疗大汗亡阳，肢冷脉伏的虚脱证有效。施灸时不计壮数，灸至汗止脉复，四肢复温为止。

⑤隔附子片(饼)灸：是用附子片(饼)作隔垫物的一种施灸方法。施灸时，选大熟附子浸润后切成0.5厘米厚片或将其研为细末，用黄酒调制成0.5厘米厚、5分硬币大的药饼，用针在中间扎数孔，放在施灸穴位，上置艾炷点燃施灸。现临床有用附子3份、肉桂2份、丁香1份，共研细末，炼蜜调制成复方药饼，或取附子、白芷、藁本、丁香各等份，共研细末调制成饼作隔垫物而施灸的。施灸中如附子片(饼)被烧焦，可更换新片(饼)再灸，至皮肤出现红晕为度，每日1次，灸至病愈。因附子性味辛温大热，有温阳补火、温肾壮阳的功效，故适用于治疗遗精、早泄、阳痿等命门火衰的疾病和痈疽肿毒、阴性流注日久不消及疮毒瘰管久不收口等疾病，可将附子片(饼)置瘰管上灸之，有祛腐生新、促进疮口愈合的功效。还可治疗身肿、面黑有尘的皮肤色素沉着病证。临床经验提示，在施灸时使用潮湿的附子片(饼)效佳。

⑥隔胡椒饼灸：是用胡椒饼作隔垫物的一种施灸方法。施灸时，取白胡椒末加适量面粉，用水调制成五分硬币大、厚约0.3厘米，中间按成凹陷的圆药饼，再取丁香、肉桂、麝香各等份，共研细末，用药末填平凹陷，放在施灸穴位，上置艾炷点燃施灸5~7壮，以局部温热舒适为度。可治疗风寒湿痹、局部麻木不仁、胃寒呕吐及腹痛诸证，亦可用于治疗湿疹、顽癣等皮肤病。

⑦隔豆豉饼灸：是用豆豉饼作隔垫物的一种施灸方法。施

灸时，取豆豉（或加花椒、生姜、青黛、葱白各等份）适量捣烂，用黄酒调制成直径2厘米、厚0.3厘米药饼，中间扎数孔，放在施灸穴位，上置艾炷点燃施灸3~5壮。施灸中如豉饼被烧焦，可更换新饼再灸。因豆豉有发汗解表的作用，故可用于疮疡初起（将豉饼放在疮面上，如疮已破溃，可置疮口周围施灸），灸至疮部的皮肤湿润汗出，邪毒外泄，病可随愈。临床适用于治疗痈疽发背、顽疮恶疮、肿硬不溃或溃后不收口，疮面黑黯。

⑧隔巴豆饼灸：是用巴豆饼作隔垫物的一种施灸的方法。有用巴豆1味或与其它药物混合成复方的。施灸时取不去油巴豆10粒（或加黄连末适量）研细末加面粉少量，用水调制药饼放脐中，上置艾炷点燃施灸，也可与隔蒜灸合用，灸毕以温湿纱布擦净施灸处皮肤，避免药物刺激起疱。适用于治疗食积、泄泻、腹痛、胸痛、小便不通诸证，亦可用于水肿和肥胖症。

⑨隔鸡子灸：是用鸡蛋作隔垫物的一种施灸方法。施灸时取煮熟鸡蛋1个，对半切开，取一半去蛋黄，覆盖于患处，于蛋壳上置中艾炷点燃施灸，至患者感觉局部热痒为度，适用于发背、痈疽初起诸证。

⑩蒸脐灸：又名封脐灸、熏脐灸、炼脐灸。是以各种不同中药配方研末填平脐窝（脐窝突出者，可用湿面围脐如井口，然后再填药末），上置艾炷施灸的一种方法。有温阳祛邪、健身防病的作用，可治疗多种疾病。所用配方，因病而异，如取生五灵脂24克，生青盐15克，炒地鼠粪、木通各9克，炒夜明砂6克，乳香、没药、干葱头各3克，麝香少许，共研细末，填脐中，上盖槐树皮，置艾炷点燃施灸，每岁一壮，以预防疾病。取人参、附子、胡椒各21克，五灵脂、龙骨、蛇骨、虎骨（豹骨代）、没药、朱砂、夜明砂、白附子各15克，小茴香、青盐各12克，乳

香、丁香、木香、雄黄各 9 克，共研细末。先取麝香 1.5 克纳脐中，再将其余药末填平围脐，用槐皮覆盖，上置艾炷点燃施灸至遍身大汗，以治虚劳；取五灵脂、白芷、青盐各 6 克，麝香 0.3 克，共研细末，用荞麦粉水调围脐，将药末填平脐中，上置艾炷施灸至脐中温暖为度，有温脐作用，可治疗脐腹结冷，下元虚冷，宫寒不孕，气虚崩漏，血寒闭经等；取白附子、白芷、白及、白藜、川芎、柴胡、枳实、紫草、红花各等份，共研细末纳脐中，胶布覆盖，上置艾炷施灸，治疗面部黄褐斑、色素沉着有效。

此外，尚有隔黄土灸治疗背痛诸证、局限性湿疹、白癣及因湿毒而致的其它皮肤病；隔脐蟾灸治疗破伤风（宜用大艾炷）、疮疡诸证；隔麦面硫黄蒜灸、隔钱灸、隔蚯蚓灸、隔韭菜灸、隔苦瓠灸等以治疗各种疮疡痈疖；隔面灸治疗恶疮与腹中冷痛；隔甘遂灸治疗小便不通；隔蟾灸、隔桃树皮灸、隔莨菪根灸、隔蚯蚓泥灸等治疗瘰癧疔肿；隔麻黄灸治疗风寒感冒、鼻渊与气喘诸证；隔木香灸治疗闪挫仆损、气滞血瘀等证；隔川椒灸治疗一切肿毒疼痛、跌仆扭伤所致伤筋积血、腹胀痞满等证；隔陈皮灸治疗腹胀满、食欲不振、呕吐呃逆；隔葶苈灸治疗痔疮、瘰癧；隔厚朴灸治疗胸腹胀满、脘腹疼痛、咳嗽与咯痰不畅等证；隔蓖麻仁灸治疗内脏下垂（灸百会）、面瘫（灸印堂、下关、颊车、阳白等穴）；隔香附灸治疗瘰癧、痰核、痹证等；隔白附子灸治疗疝气；隔徐长卿灸治疗风湿痹痛、跌打损伤、荨麻疹及鼻渊等；隔苍术灸、隔土瓜根灸、隔槟榔灸等治疗耳鸣、耳聋；隔商陆灸治疗瘰癧、痿管久治不愈；隔矾灸治疗外痔和痿管；隔桃叶灸治疗疟疾；隔皂角灸治疗蜂螫、蚊叮、虫咬等；隔藕节灸治疗高血压、脑溢血、鼻出血、肺炎及急性支气管炎等证；隔芒硝灸治疗慢性阑尾炎、肠胀气、肠梗阻、急性胃扭转及

术后腹胀等证；隔赤小豆灸治疗风寒湿痹和各种原因引起的下肢水肿及尿闭等证；隔黄豆灸治疗口腔炎、牙龈炎、脓疱病及下肢溃疡等证；隔莱菔根灸治疗腹胀、干脚气、冻疮、足癣及神经性皮炎等；隔山药灸治疗泌尿系感染、急慢性肾盂肾炎、肾小球肾炎、老年性腰椎骨质增生及进行性肌萎缩；隔生铁粉灸治疗顽固性风寒湿痹、急性腰扭伤、创伤性关节炎、外伤引起的局部血肿及腰椎间盘突出症等病；隔牛奶灸治疗痤疮、头面疖肿、脱发、肛裂及大便秘结等；隔蜂房灸治疗类风湿性关节炎、牛皮癣、疖肿、末梢神经炎及三叉神经痛等；隔王不留行灸治疗胆结石、泌尿系结石、乳腺炎、肋间神经痛及脂肪肝等；隔芹菜根灸治疗阴虚引起的手足烦热，肺癆引起的骨蒸劳热，心肾不交引起的失眠、眩晕、高血压及高脂血症等。其制法、施灸方法同上，可参照使用。

2. 艾条灸 又称艾卷灸。是用棉纸把艾绒包裹卷成圆筒形的艾卷，点燃一端，在穴位或患处进行熏灸的一种施灸方法。后来发展为在艾绒中加进药物，再用棉纸卷成条状施灸，称为雷火神针或太乙神针。在此基础上演变成现代单纯艾条灸和药物艾条灸。

艾条制法：普通艾条是取纯艾绒 24 克，平铺在长 26 厘米、宽 20 厘米的桑皮纸上，将其卷成直径约 1.5 厘米的圆柱形，卷得越紧越好，用浆糊封口粘固，两头余纸拧成结，即成艾条。纸上印上分寸刻度，作为施灸时的标准（见图 4）。如在艾绒中掺入药物而制成的艾条，就称药物艾条，简称药条。药条

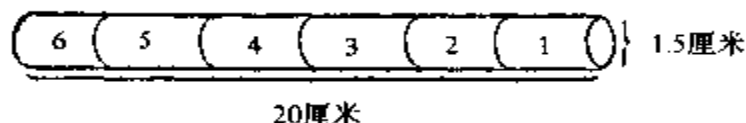


图 4 艾条式样图

所用药物处方很多,可根据临床需要而定。一般药物处方有:肉桂、干姜、丁香、木香、独活、细辛、白芷、雄黄、苍术、乳香、没药、川椒各等份;或麝香、沉香、松香、硫黄、细辛、桂枝、川芎、羌活、杜仲、枳壳、白芷、茵陈、巴豆、川乌、斑蝥、全蝎、皂角刺、穿山甲、桃树皮各等份。上药共研细末,每支艾条掺入药末6克。因药条疗效较好,故临床应用较普遍。现在有人在500克艾绒中加入金粉(或铝粉)40克,甘松30克,羌活、白芷、细辛各6克,制成无烟或微烟艾条,施灸时不出现烟雾,效果良好。艾条灸可分为悬起灸、触按灸和间接灸3种。

(1) 悬起灸:是将点燃的艾条悬于施灸部位穴上的一种施灸方法。一般艾火距皮肤约3厘米~5厘米,每次灸5~30分钟,可使皮肤有温热感而又不致被烧伤。按其操作方法又可分为温和灸、回旋灸和雀啄灸3种。

①温和灸:将艾条一端点燃,对准施灸部位,距皮肤约3厘米~5厘米进行熏灸10~15分钟(见图5),使患者局部有温热感而无灼痛,至皮肤稍起红晕为度。对昏厥、局部知觉减退及小儿施灸,操作者可将食指、中指分开置于施灸部位两侧,以测知局部受热程度,便于

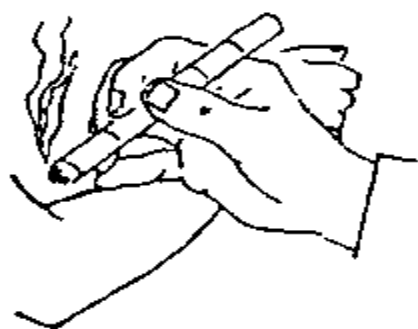


图5 温和灸图

随时调节施灸距离,控制灸温,以免烫伤。本法有温经散寒作用,多用于风寒湿痹及慢性病,临床应用最为广泛。

②回旋灸:又称熨热灸。是将点燃的艾条悬于施灸部位距皮肤约3厘米~5厘米处,平行往复回旋施灸20~30分钟,使皮肤有温热感而不觉灼痛。适用于面积较大的风湿痹痛、软

组织劳损、神经性麻痹及广泛皮肤病等。

③雀啄灸：将点燃的艾条对准施灸部位，一上一下摆动，像麻雀啄食一样，忽近忽远地施灸 5~20 分钟左右。有温阳起陷作用，多适用于灸治急性病、昏厥急救等需较强火力施灸的疾病。施灸时应避免烫伤皮肤。

(2) 触按灸：是用药条施灸的方法。施灸时，先在施灸的部位铺上布或棉纸数层，然后再将点燃的药条乘热按到穴位上，使热气透达穴位深部，若艾火熄灭，点燃再按；或以棉布 6~7 层包裹艾火熨于穴位上，艾火灭了点燃再熨。因临床需要不同，艾绒里掺的药物处方亦异。临床常用的有雷火神针、太乙神针、神灯照灸等。适用于风寒湿痹、痿证及虚寒证。

①雷火神针：又称雷火针。其所以称针，是因为施灸时将药条实按在穴位上，很像针。其药条用药处方有多种，临床上使用较多的是取艾绒 60 克，沉香、乳香、木香、茵陈、羌活、干姜、穿山甲各 9 克，麝香少许。依法制成药条。先在施灸部位覆盖棉布 5~7 层或棉纸 10 层，然后将药条一端点燃，对准穴位紧按在棉布或纸上，亦可将点燃的药条用 7 层棉布包好直接按在穴位上，停留 1~2 秒钟，使药气温热透入深部。如患者感觉太烫，可将药条稍提起，待热减再灸，每穴可灸 5~7 次。如药条熄灭，可重新点燃施灸。多用于治疗风寒湿痹、痿证、腹痛、腹泻及挫伤肿痛等证。

②太乙神针：又称太乙针。是在雷火针的基础上改变药物处方发展而来。通用方是：艾绒 90 克，硫黄 6 克，麝香、乳香、没药、松香、桂枝、杜仲、枳壳、皂角、细辛、川芎、独活、雄黄、白芷、全蝎、穿山甲各 3 克。制法和施灸的方法同雷火针。适应证更广泛，尤其是治疗风寒湿痹、顽麻、痿弱无力、半身不遂等效果更好。现在临床使用特制的黄（紫）铜管作为套筒，内装太

乙神针施灸，较为简便易行。

③艾火针衬垫灸：简称衬垫灸。是仿雷火神针、太乙神针与隔姜灸改进而成。施灸前先将生姜片 15 克水煎，取汁 300 毫升，加面粉调成稀浆糊，涂布在白棉布上，制成 5~6 层硬衬，晒干后剪成 10 厘米方块备用。施灸时取衬垫放置施灸穴位或患处，然后将药条点燃紧按在衬垫上 5 秒钟左右，待局部感到灼热时即提起药条，每穴可反复 5 次，以施灸处皮肤出现红晕为度。适于治疗关节痹痛、骨科痛证、哮喘、慢性胃肠病、阳痿、遗尿等。

④神灯照灸：将特制药条用麻油浸透后晒干，点燃明火，谓之神灯。用神灯徐徐烘照施灸穴位以治疗疾病的方法，谓之神灯照灸。通用处方是：雄黄、朱砂、血竭、没药各 6 克，麝香 1.5 克。上药共研细末，每次取药末 1 克，用桑皮纸卷成 20 厘米长条，再用麻油渗透晾干，点燃一端后移距施灸部位 3 厘米左右徐徐烘照，至皮肤温热为度。有消肿、溃坚、止痛作用。可治疗外科疮疡。

此外，尚有百发神针（处方：乳香、没药、川乌、草乌、血竭、檀香、降香、麝香、贝母、生附子各 9 克，母丁香 49 枚，蕲艾绒 60 克）治疗偏正头风痛、漏肩风、鹤膝风、半身不遂、痞块、腰痛、小肠疝气及痈疽等症；消癰神针（处方：麝香 9 克，硫黄、牙皂、穿山甲、闹羊花各 6 克，五灵脂、乳香、没药、三棱、莪术、雄黄、阿魏、木鳖、皮硝、甘草各 3 克，甘遂 1.5 克，蜈蚣 1 条，艾绒 60 克）可治偏食消瘦、积聚痞块等症；阴证消毒针（处方：乳香、没药、羌活、川乌、草乌、白芷、细辛、雄黄、硫黄、贝母、牙皂、肉桂、五灵脂、穿山甲各 3 克，蟾酥、麝香各 1 克，艾绒 30 克）可治疗痈疽阴证。药条的制法及施灸方法均同雷火神针。

（3）隔核桃皮壳眼镜灸：取眼镜框架一副（亦可用细铁丝

仿制),沿框架周边缠上胶布隔热,以防烫伤皮肤,框架两侧用铁丝向内弯一个钩形,以备插艾卷施灸。然后取核桃1枚,从中线劈开,去仁取壳(有裂纹者不用),置菊花液(取菊花、蝉蜕、薄荷、石斛各10克,用纱布包好,浸于250毫升温水中15分钟即成)中浸泡15分钟,取出套在镜框上,插上艾条(约3厘米长),距核桃壳2厘米,点燃艾条两端后让患者带上眼镜施灸,每次15~20分钟,每日1次,10次为1个疗程。施灸时,如属眼肌病,可闭目受灸;如属眼球病可睁眼受灸,但应注意掌握灸温,避免烫伤眼睛。适用于老年性白内障、青光眼、结膜炎、近视、中心视网膜炎、视神经萎缩及眼肌麻痹等病的灸治。

3. 温针灸 是针刺与艾灸相结合的一种治病方法。适用于既需要针刺留针,又需施灸的病证。操作时,在针刺得气后,保留一定深度,于针柄顶端捻裹艾绒(枣核大)或套艾条2厘米,艾团距皮肤3厘米,然后点燃艾团(艾条)下端施灸(见图6),热力通过辐射和针身的传导经穴位传人体内以加强治疗



图6 温针灸图

作用。待艾团烧尽,除去残灰,再换上新艾团施灸,一般可更换1~3次,使针下有温热感即可。捻裹艾团要紧,表面要光洁,避免艾团在燃烧过程中散落和火星脱落,烧伤皮肤和衣物。为了预防艾灰脱落烧伤皮肤,可在穴位周围放一张硬纸片。如使用银针,因其导热性能强,捻裹艾团宜小些。

温针灸具有温通经脉、宣畅气血的作用,适用于寒凝气滞、经脉闭阻、寒湿痹痛、关节酸痛、冷麻不仁等为主的一类疾病,以及形体虚寒、便溏腹胀等证,也可

用于保健灸。

4. 艾饼灸 包括熨灸和日光灸两种。

①熨灸：是将艾绒平铺在腹部、穴位上或患处，上面覆盖几层棉布，用熨斗或热水袋在布上面温熨，可以发挥艾和热熨双重作用。临床多用于风寒湿痹、痿证、寒性腹痛、腹泻等证。

②日光灸：是将艾绒铺在患处或穴位上，在日光下曝晒，每次 10～20 分钟，既有日光浴又有艾的作用，但应预防中暑；亦可借助聚光镜聚焦施灸，但应掌握好温度，以患者有温热感为度。适用于风寒湿痹、小儿五迟、皮肤色素变性及虚弱性疾病。

5. 艾熏灸 包括烟熏灸、蒸气灸和温灸器灸 3 种。

(1) 烟熏灸：是把艾绒放在容器内燃烧，用艾烟熏灸患处或穴位的一种治病方法。又称温杯灸。临床上多用于治疗风寒湿痹及痿证。

(2) 蒸气熏灸：是把艾叶或艾绒放在容器内水煎煮开，用蒸气熏患处的一种治疗方法，可边煮边熏，也可煮开后倒入盆中再熏。适用于风寒湿痹。

(3) 温灸器灸：是利用专门器具施灸的一种方法。可以较长时间地连续给患者以舒适的温热刺激，达到局部红晕发热，起到温行气血的作用，使用方便。适用于风寒湿痹、胃痛腹胀、腹痛泄泻、痿证等。温灸器的式样很多，近年来又不断有新产品研制出来，目前临床常使用的有以下 3 种：

①温灸筒：用一种特制的筒状金属灸具，内装艾绒或在艾绒中掺入适量药物，燃着后置施灸部位反复温灸，至局部发热红晕，患者自觉舒适为度，一般可灸 15～30 分钟。温灸筒式样有多种，都是内有 1 小筒可以装艾绒及药物，底部有许多小散热孔，常用的有平面式和圆锥式两种（见图 7）。平面式适用于

较大面积灸治；圆锥式适用于较小面积灸治。适应证同艾条灸。

②温灸盒：是一种特制的盒形木制灸具，内装艾条，固定在一个部位施灸的方法。按规格大小分大（长20厘米、宽14厘米、高8厘米）、中（长15厘米、宽10厘米、高8厘米）、小（长11厘米、宽9厘米、高8厘米）3种。以规格不同的木板（厚约

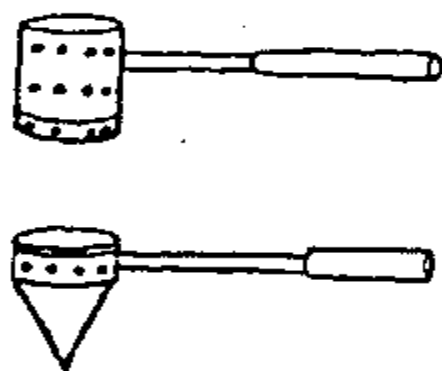


图7 温灸盒图

0.5厘米）制成长方形木盒，下面不装底，上面制作一个可以取下的盒盖，在盒内距底边3厘米~4厘米处安装铁纱窗一块（见图8）。施灸时，把温灸盒放在施灸部位的中央，把点燃的艾条放在铁纱窗上，对准穴位，盖上盒盖灸15~30分钟。灸温可用盒盖进行调节。适应证同艾条灸。

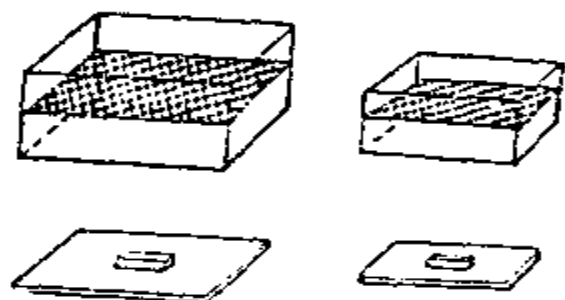


图8 温灸盒图

③温灸管：是用特制温灸管（古代用苇管，也有用竹管的）插入耳道内施灸的一种方法。目前临床上应用的温灸管有两种：一种是一节管状器，另一种是两节管状灸器。施灸时取大艾炷放在管灸器半个鸭嘴形处，点燃后用胶布封闭管灸器内端，插入耳道内施灸（见

嘴形处，点燃后用胶布封闭管灸器内端，插入耳道内施灸（见

图 9), 每次 3~9 壮, 每日 1 次, 10 次为 1 个疗程, 施灸时耳内有温热感, 用于治疗面瘫。

(二) 非艾灸法

1. 热源灸法 除艾绒以外, 还可使用其它材料作为热源施灸。主要有:

(1) 灯草灸: 又名灯火灸、打灯火。是用灯心草蘸麻油点燃后, 快速接触穴位淬灸的方法。施灸时, 将点燃的灯心草迅速接触穴位, 即可听到“啪”的爆响声, 然后迅速离开, 如无响声, 应重复施灸 1 次 (见图 10)。灸后皮肤有一发黄点或起小疱, 应保持清洁, 防止感染。本法多用于小儿惊风、流行性腮腺炎、腹泻、麻疹、喉蛾、痧胀、脐风等急性病证, 也可用于胃痛、腹痛。



图 10 灯草灸图



图 9 温灸管图

(2) 桑枝灸: 是将桑枝点燃后, 用炭火在疮口上施灸以治疗疮疡的一种灸法。施灸时取干桑枝条 (或桑柴条) 点燃, 然后吹灭火焰, 用炭火灸患处。此法具有解毒止痛、消肿散瘀、助阳生肌的作用。疮疡未溃者, 用之能拔毒止痛; 已溃者, 可补接阳气, 去腐生肌。应用于疮疡肿毒、顽疮、臃疮、瘰癧、流注。

(3) 桃枝灸: 是用干桃枝蘸麻油点燃, 吹灭火焰, 乘热施灸的一种方法。操作方法同雷火神针法。适用于风寒湿痹、心腹冷痛及阴疽等。

(4) 火柴灸：是将火柴擦燃后按在穴位上灸治的一种方法。施灸时将火柴擦燃，待燃至中段去掉火柴头部，对准穴位迅速淬灸。适用于疔腮、乳蛾、麻疹、吐泻等。

(5) 烟草灸：用香烟代替艾条施灸的一种灸法。可按艾条温和灸的方法操作。适用于风寒湿痹、寒性痛经、冻疮等。

(6) 麻叶灸：是用大麻叶和花捣碎作炷，类似艾炷灸的一种灸法。有消肿散结、生肌敛疮的作用，适用于瘰病、瘰管等。

(7) 竹茹灸：是用竹茹作炷代替艾绒施灸的一种灸法。有解毒消肿止痛作用，适用痈疽疔毒、蛇咬伤等。

(8) 线香灸：是用线香点燃后，快速按在穴位上淬灸的一种灸法。亦可按艾条温和灸法操作，适用于哮喘、肝硬变腹水、毛囊炎等。

(9) 硫黄灸：是用硫黄作施灸材料的一种灸法。施灸时，取硫黄一块（随疮口大小）置患处，另取硫黄少许于火上烧着，用其点燃疮口上的硫黄，以脓水干为度。适用于顽固性溃疡或已成瘰管者。

(10) 黄蜡灸：是将黄蜡烤热熔化，用以施灸的方法。施灸时，先用面团将患处围成约3厘米高一圆圈，圈外周围铺数层棉布，避免烘烤正常皮肤，圈内放优质黄蜡片约1厘米厚，用铜勺（或铁勺）盛炭火在蜡上烘烤，使之熔化，待患者皮肤有热痛感即可。本法近似于近代蜡疗，可以代替。有拔毒消肿作用，适用于风寒湿痹、无名肿毒、痈疖、臃疮等。

(11) 药燄灸：又称药片灸，是将多种药物研末与硫黄熔化在一起，制成药燄放在穴位上，点燃施灸的一种灸法。因药燄药物组成不同，临床适应证也不同。如香硫饼适用于寒湿气；阳燄灸适用于痈疽流注、经久不消、内溃不痛；救苦丹适用于风痹、跌仆、小儿搐搦、口眼喎斜及妇人心腹痞块疼痛等。

(12) 药捻灸：是用多种药物粉末制成药捻以施灸的一种灸法。如“蓬莱火”(牛黄、雄黄、乳香、没药、丁香、火硝、麝香各等份，或去牛黄加硼砂、草乌)。施灸时，取药捻 0.5 厘米~1 厘米，用浆糊粘于患处或穴位上，点燃灸之。适用于风痹、瘰癧、水肿、脘腹胀满等。

(13) 穴位药熏灸法：是利用药液蒸气喷患处或穴位而达到治病目的的一种灸法。如利用补中益气汤熏灸治疗久痢体虚、血崩、脱肛。临床可因药物不同，适应证也不一样。近代有人利用药熏器械喷熏施灸治疗顽痹证。

常用药液蒸气灸有：①姜椒蒸气灸(生姜、辣椒各等份)、棉籽蒸气灸(棉籽适量)，水煎后用蒸气熏灸患处治冻疮。②葱白蒸气灸(葱白 500 克，蒲公英 60 克，牙皂 15 克，水煎用蒸气熏灸患部)治疗乳痈未化脓。③荆防蒸气灸(荆芥、防风、艾叶、去皮大蒜各等份，水煎用蒸气熏灸患部)治疗风湿痹痛、关节痛、腰腿痛等证。④侧柏叶蒸气灸(鲜侧柏叶 300 克，水煎熏灸患部)治疗鹅掌风。⑤海桐皮蒸气灸(海桐皮、透骨草各 30 克，当归 18 克，川芎、白芷、丹皮各 12 克，乳香、没药、川椒、红花、甘草、威灵仙各 9 克)；八仙逍遥蒸气灸(苦参 60 克，花椒 30 克，当归、荆芥、防风、黄柏、苍术各 18 克，川芎、丹皮各 12 克)，水煎利用蒸气熏灸患处，治疗骨结核。⑥枸杞根蒸气灸(枸杞根适量)，治疗痔疮。⑦五倍子蒸气灸(五倍子 250 克，白矾 10 克，水煎用蒸气坐熏)治疗脱肛。⑧乌梅蒸气灸(乌梅 60 克，五味子、石榴皮各 10 克，水煎用蒸气坐熏)治疗阴挺。⑨地肤子蒸气灸(地肤子、蛇床子各 30 克，白鲜皮、苦参各 15 克，川椒 9 克，白矾 3 克，水煎用蒸气熏灸患处)治疗湿疹。⑩巴豆蒸气灸(巴豆 5~15 粒，用 60 度白酒 250 毫升煮沸，乘热用蒸气熏灸劳宫穴)治疗口眼喎斜。

(14) 铝灸:是利用中药和化学合成物通过化学反应产生温热的一种灸法。施灸时,将治疗某种疾病的中药末 100 克,同升汞、花椒面各 20 克,氯化钠 10 克,按 1:5 加水和甘油混合调制成药膏,涂于一定规格的铝纸上,敷贴于施灸部位。由于化学反应引起铝氧化而产热,使施灸部位出现温热或灼烫的感觉,这种治疗方法就称铝灸。适用于治疗风寒湿痹、风寒咳嗽、肺虚气喘证、脾胃虚弱证、月经不调等。

(15) 电热灸:利用电热作热源的一种施灸方法。施灸时,用电灸器接通电源后,调到合适温度在施灸部位熨灸,每次 10~15 分钟。适用于风寒湿痹、寒凝腹痛、泄泻等。

(16) 电子温针灸:利用电热作用来代替艾炷、艾条使毫针发热行温针灸治疗疾病的一种灸法。施灸时,用毫针刺进预先选好的穴位或患处,施行手法得气后接通温针治疗机,每次灸治 15~30 分钟。适用于治疗颈椎病、骨质增生、关节痛、肩凝症、心痛、偏瘫、下肢痹痛、哮喘、少腹痛、不孕症等。

2. 无热源灸法(药物发泡灸) 是指不用艾绒及其它材料作热源的施灸方法。古称“天灸”、“自灸”,近人称为药物发泡灸。是用一些对皮肤有刺激性,能引起发泡的药物敷贴于穴位或患处的一种无热源灸法。敷药后能使局部皮肤潮红、充血,甚至起疱如火燎,故称灸。所用药物大多是单味中药,但也有用复方的。常用的有大蒜、斑蝥、白芥子、鲜毛茛、巴豆、细辛、吴萸、甘遂、天南星、蓖麻子等数十种。

(1)毛茛叶灸:将鲜毛茛叶适量捣烂,敷贴于穴位或患处,初时皮肤有热辣感,继而局部潮红、充血,稍后出现水疱。敷灸时间约为 1~2 小时。发泡后局部遗留色素沉着,以后可自行消退。常用于治疗疟疾(敷贴寸口、内关、大椎)、寒痹(敷贴局部)、急性结膜炎(与食盐和捣,敷于少商、合谷)等。

(2)斑蝥灸：施灸时先取一块胶布，中间剪一黄豆大圆孔，将胶布贴于穴位上，以暴露施灸穴位并保护周围皮肤，然后取斑蝥末适量(或与甘油调和)置孔中，上面再用胶布固定，灸至局部发疱为度。或用95%酒精浸泡斑蝥10日后，取药液涂抹患处。适用于顽癣、银屑病、神经性皮炎、着痹、胃痛、黄疸等。孕妇忌用。

(3)白芥子灸：取白芥子末5克~10克，用水或醋调为糊状，敷贴穴位上，再以油纸覆盖，胶布固定；或取白芥子末1克，置于直径3厘米的圆形胶布中央，直接贴在穴位上。敷灸2~4小时，以局部充血、潮红或皮肤起疱为度。可用于治疗关节痹痛、肺结核、口眼喎斜等。现在，临床常用复方白芥子敷灸(冬病夏治哮喘膏)治疗支气管哮喘和支气管炎。取炙白芥子、延胡各21克，甘遂、细辛各12克，共研细末(为1人3次用量)。在夏季伏天施灸时，每次取药末1/3量用生姜汁调如糊膏状，并加麝香少许，分摊于6块直径3厘米的油纸上，分别敷于肺俞、心俞、膈俞处，用胶布固定，每次敷灸4~6小时。从初伏开始，每伏(10日)各敷灸1次，每年敷3次，连续治疗3年。

(4)旱莲草灸：取鲜旱莲草捣烂敷于大椎穴上，胶布固定。约1~4小时，以局部皮肤充血潮红或起疱为度。可治疗疟疾。

(5)蒜泥灸：取紫皮大蒜适量捣烂敷涌泉穴治疗咯血、吐血；敷合谷穴治疗扁桃体炎；敷鱼际治疗喉痹。一般敷灸1~3小时，以局部皮肤发痒、潮红或起疱为度。

(6)天南星灸：取天南星末适量，以生姜汁调成糊状，敷于颊车、颧髎穴，上用油纸覆盖，胶布固定，可治疗面瘫，左喎贴右，右喎贴左。

(7)威灵仙灸：取威灵仙嫩叶捣烂，加入少许红糖拌匀，敷

贴足三里穴可治痔疮下血；敷贴身柱穴可治百日咳；敷贴天容穴可治扁桃体炎；敷贴太阳、内关穴可治麦粒肿、结膜炎；涂擦患处可治疥癣、神经性皮炎、痣、疣等。敷贴后如局部出现蚁爬感，应将药去除，以起疱为度，避免过度刺激。

(8)蓖麻仁灸：取蓖麻仁捣烂敷于涌泉穴，可治滞产及包衣不下；敷贴百会穴，可治胃下垂、脱肛、子宫脱垂；敷贴患侧颊车、下关、地仓，可治面瘫。

(9)细辛灸：取细辛末适量，用陈醋调敷于涌泉或神阙可治疗小儿口疮。

(10)吴萸灸：取吴萸末适量，用陈醋调敷涌泉穴可治高血压、口腔溃疡、小儿水肿。如加入黄连亦可治疗急性扁桃体炎。

(11)甘遂灸：取甘遂末少量敷贴肺俞穴治疗哮喘；敷贴大椎治疗疟疾；敷贴中极治疗尿潴留。亦可于甘遂末中加入适量面粉，用温开水调成糊状，敷贴穴位上，再用油纸覆盖，胶布固定。

(12)马钱子灸：取马钱子切片或研细末，敷贴颊车、地仓，可治疗面瘫。

(13)食盐灸：取细净食盐炒热待温纳满脐窝，再取麸皮适量，加醋炒热，装入布袋放脐部盐上敷灸，以治疗脱证。

(14)半夏灸：取生半夏、葱白各等份，共捣烂如膏，敷贴患处，或制成栓剂塞入患侧鼻孔，每次 30 分钟，每日 2 次，可治疗急性乳痈。

(15)荆芥穗灸：取荆芥穗切碎炒热，装入布袋内敷患处，可治荨麻疹。

此外，尚有葱白灸、巴豆霜灸、小茴香灸、芫花灸、鸦胆子灸、生附子灸、生姜灸、乌梅灸、五倍子灸、桃仁灸、川芎灸、透骨草灸、山楂灸、薄荷叶灸、蓖麻饼灸、丁桂散灸、椒豉膏灸、白

胡椒丸灸、车桂散灸、桂术散灸、鹅透膏灸、复方公丁香灸等等，临床可随证选用。

（三）熨法

熨法，是用一些中药及其它传热的物体，加热后用布包好，直接或间接地放在穴位或患处皮肤上，作来回往返或旋转移动行熨烫以治疗疾病的一种方法。

1. 熨法的作用和适应证 熨法通过使特定部位皮肤受热或借助热逼药气进入体内，起到温经散寒、疏通经脉、调和气、活血消瘀、祛邪止痛等作用。故临床应用颇为广泛，内、外、妇、儿等科均有其适应证。大凡外寒侵入经络脏腑，或素体阳虚，气血不和而致的病证，如风寒湿痹、外感风寒、霍乱吐泻、脘腹冷痛、二便不调、癥瘕痞块、痈疽肿毒、跌仆扭挫等，均可选用。但高热、急性炎症等实热证，以及肿瘤、局部皮肤溃烂、急性出血证等应忌用。

2. 熨法的种类

（1）按取热方式：可分直接和间接熨两种。直接熨是将温热的物体直接放在穴位或患处的皮肤上熨烫；间接熨是将温热物体先熨熨药物或盛有药物的布帛上，借助温热的作用使药力透入皮肤、经络之内。

（2）按熨用材料：可分为药熨、盐熨、砖土熨、水熨、酒熨、烙铁熨、热罨熨等。

①药熨：将配好的药物加热后装入药袋，温熨患处，借温热烫熨使药物透入皮肤经络以发挥治疗作用。熨烫时间随病情而定，一般为20～60分钟。

②盐熨：取纯净大粒盐适量炒热，用布包乘热熨烫患处，或加入适当药末同炒热熨烫亦可，热力下降后，可炒热再熨，时间同药熨。

③砖土熨：取大小适中的青砖（或红砖）2块，放炉上烧至烫手，用厚布包好，或取适量灶心土煨热装入布袋，并在治疗部位铺3~5层棉布，乘热在上面熨烫，热力降低后再换一块，反复多次，约20~60分钟。

④水熨：是用烫壶、烫瓶或热水袋盛贮热水温熨患处，也可用毛巾浸热水拧干后熨烫患处。有活血散结、消肿止痛作用，临床广泛用于血瘀肿痛等。

⑤酒熨：将60°~65°白酒置酒壶烫热后，用纱布蘸热酒熨摩患处。用于气郁不舒、胸膈胀闷、局部红肿等证。

⑥烙铁熨：将烙铁烧热，待温后反复熨贴患处，一般适用于外科疮疡。治疗腰背痛及疟疾可熨贴背部；治疗眼部疾患则熨眼睑近处。

⑦热罨熨：取干净砂粒炒热布包，乘热反复熨贴腹部以治疗腹泻等。

六、施灸的体位和顺序

（一）施灸的体位选择

临床施灸应选择合适的体位，以达到方便医生施灸操作，有利于准确选穴和安放艾炷施灸，病人感觉自然舒适，并能坚持施灸的全过程为原则。常用体位有卧位（包括仰卧位、侧卧位和俯卧位）、仰靠坐位、俯伏坐位。四肢的位置可根据取穴施灸的要求选用仰掌式、曲肘式和屈膝式。

（二）施灸的顺序

施灸的顺序，临床上一般是先灸上部，后灸下部，先灸背部，后灸腹部，先灸头身，后灸四肢，先灸阳经，后灸阴经；施灸壮数先少后多，施灸艾炷先小后大。如不按顺序施灸，先灸下

部,后灸头面,患者可能会出现头面烘热,口干咽燥等不适感觉。但临床具体操作时亦需结合病情,因病制宜,不可拘泥不变。特殊情况灵活掌握,如脱肛施灸,就可先灸长强以收肠,再灸百会以举陷。

七、施灸的手法及壮数

(一) 施灸的手法

施灸手法有补有泻,需根据辨证而定,虚者宜补,实者宜泻。艾灸施补,于点燃艾炷后,不吹其艾火,待其慢慢燃尽自灭,火力微缓而温和,且时间较长,壮数较多,灸毕要用手按其施灸部位,使灸气聚而不散。如用艾卷灸,可取用雀啄灸弱刺激,每穴灸 0.5~2 分钟,或温和灸、回旋灸 3~5 分钟,以促进机体生理功能,解除过度抑制,引起正常兴奋。艾灸施泻,于点燃艾炷后,速吹旺火,促其快燃,火力较猛,快燃快灭,当患者感觉灼烫时,即迅速更换艾炷再灸,灸治时间较短,壮数较少。灸毕不按其穴,以冀开其穴邪气易散。若用艾条灸,可选用温和灸或回旋灸,每穴每次灸 10 分钟以上的强刺激,以达镇静,促进正常抑制。

此外,根据选用不同部位、经络、穴位、时间,亦可进行补泻,如用雀啄灸或蒜泥敷灸涌泉穴,滋阴泻火,以治鼻出血、咯血;用温和灸或蓖麻仁敷灸百会穴,补气固脱,以治胃下垂、脱肛、阴挺等脏器下垂。选用不同的施灸方法也可以进行补泻,如急性病采用着肤灸、雀啄灸以泻实;慢性病采用温和灸、回旋灸及温针灸以补虚。隔物灸和敷灸中所用的药物,按药物的性能、功效和主治进行补泻,如甘遂灸可以逐水泻水,附子灸可以温阳补虚。

（二）施灸的壮数

施灸艾炷的大小，壮数的多少，可根据疾病的性质，病情的轻重，体质的强弱，年龄的大小及施灸部位的不同，全面考虑，各适其宜，恰到好处，达到无太过与不足的目的。一般少则1~3壮，多则数十壮乃至数百壮（每次施灸累积总和数）。前3日每日灸1次，以后每隔2~3日灸1次，急性病每日可灸2~3次；慢性病隔3、5、7日灸1次亦可；保健灸每月可灸3~4次，终身使用，获益匪浅。凡青壮年，初病体实者，所用艾炷宜大，壮数宜多；凡小儿、妇女、老人及久病体弱者，所用艾炷宜小，壮数宜少。在肌肉丰厚的腰背、臀腹、臂等处宜大炷多灸；在肌肉浅薄的头面、颈项、四肢末端宜小炷少灸。直接着肤灸，一般以麦粒大小艾炷为宜，每穴灸5~7壮，小儿3~5壮，每次灸3~5穴。但急救时，可不计壮数，直到阳回脉起为止。

此外，在施灸时，还须结合病情，对沉寒痼冷、元气将脱等证宜大炷多灸，以温散寒凝，振奋阳气；对外感风寒则宜小炷，不宜重灸，即可达到温经通络，驱散外邪，否则火邪内郁产生不良效果。

八、灸疮的处理及灸后调养

（一）灸疮的处理

艾炷着肤灸，可使灸处发泡，产生无菌性化脓的灸疮。古人认为艾炷直接着肤灸，必须发灸疮，才能发挥治疗作用。现在，临床普遍使用温和灸，亦可达到治疗目的，不一定都要发灸疮。

艾炷着肤施灸后，局部皮肤都有红晕灼热感，属正常现象，无需处理。经数小时后即可消失，或遗留黄色瘢痕。如果

灸后起疱,需要保持局部清洁,小者可自行吸收,大者可用消毒针管抽出疱液,用消毒纱布或淡膏药覆盖固定。若灸火较重,发了灸疮,除了放液外,还要保护灸疮,避免感染,并可用赤皮葱、薄荷各适量煎汤乘热淋洗,外贴玉红膏,促进结痂而愈。一旦灸疮感染化脓,应给予抗菌药物治疗;如灸疮痛不可忍,可用桃枝、柳枝、芫荽、黄连各适量煎汤温洗;灸疮久不收口,多为气虚,宜内服内托黄芪丸(黄芪48克,当归12克,肉桂、木香、乳香、沉香各6克)。灸疮脱痂后,除用桃柳枝汤温洗外,应保护局部皮肤,免受风寒侵袭。

(二) 灸后调养

古人善用瘢痕灸,灸后对病人的精血津液多少会有些影响,故重视灸后调养;今人喜用温和灸法,灸后一般无不适感觉,不需特别调养。个别体质虚弱患者,灸后可能出现低热、口干、疲劳等不适感觉,不须停灸,继续施灸,即可消失。如这种不适感觉较重,且出现口渴、尿黄、便秘等症状,为灸火伤阴之象,可予加味增液汤(生地、麦冬、玄参、肉苁蓉各15克),即可消除。

九、施灸的注意事项

1. 施灸者态度 施灸者应举止端庄,态度和蔼,操作认真,专心致志。

2. 灸前做好病人工作 施灸前应做到耐心解释,消除病人的恐惧心理,以取得病人的信任和配合。若需要选用瘢痕灸时,必须征得病人的同意,方可使用。

3. 选择灸法、穴位及火力 根据病人的病情和体质,选择合适的灸法,施灸时取穴要准,灸穴不要过多,火力宜均匀,

壮数需足剂,切忌乱灸暴灸。

4. 预防晕灸 一旦出现晕灸,应立即停止灸治,让病人平卧休息,饮些开水,片刻即可恢复。

5. 防止烧伤和火灾 施灸过程中,严防艾火滚落,烧伤正常皮肤和烧坏衣物被褥等物,灸后必须把艾火彻底熄灭,以防发生火灾。

十、施灸常用腧穴

腧穴是人体脏腑、经络之气输注于体表的部位,也是在人体施灸的特定处所。人体腧穴很多,可归纳为十四经穴、经外奇穴、阿是穴和特殊新穴 4 类。这里不作全面叙述,只介绍与艾灸疗法有关的内容。对十四经穴名称,以传统名称为主。书中腧穴定位所应用的骨度分寸均为同身寸法。

(一) 十四经穴

1. 手太阴肺经腧穴(左右各 11 穴,见图 11,选 6 穴)

中 府

【位置】 在胸前壁外上方,距前正中线任脉华盖穴 6 寸,平第一肋间隙处。

【类别】 肺的募穴,为手、足太阴之会。

【功能】 清热宣肺,止咳平喘,宽胸理气,清上焦热。据实验研究提示:可缓解支气管平滑肌痉挛及改善肝的血液循环。

【主治】 咳嗽气喘,咳吐脓血,胸痛,胸中烦满等胸肺疾病及肩背部疼痛。现在,临床可应用于治疗支气管炎、肺炎、肺结核等。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

尺 泽

【位置】 在肘横纹上，当肱二头肌腱的桡侧缘，仰掌微屈肘取穴。

【类别】 手太阴之合穴。

【功能】 清宣肺气，泻火降逆，和胃舒筋。据实验研究提示：可调整结肠蠕动，并能降血压。

【主治】 咳嗽气喘，咯血潮热，胸部胀满，咽喉肿痛，腹痛吐泻，乳痈，小儿惊风，肘臂挛痛。临床多用于治疗感冒、咽炎、喉炎、扁桃体炎、支气管炎、百日咳、肺炎、胸膜炎、肋间神经痛、麻疹、丹毒、高血压及胎位不正。

【灸法】 同中府。

孔 最

【位置】 在前臂屈侧，尺泽与太渊的连线上，腕横纹上7寸处。

【类别】 手太阴之郄穴。

【功能】 发表清热利咽，理气润肺止血。

【主治】 咳嗽气喘，咯血，胸痛，咽喉肿痛，失声，头痛，热病，无汗，肘臂痛不能屈伸，痔疮。现在多用于治疗支气管炎、肺炎、肺结核、扁桃体炎、痔疮出血。

【灸法】 艾炷灸5~7壮，艾条灸5~10分钟。

列 缺

【位置】 在桡骨茎突上方，腕横纹桡侧端上1.5寸处。取穴时，两手交叉虎口，一手食指按在另一手腕后桡侧茎突上，当食指指尖所指处是穴（见图12）。

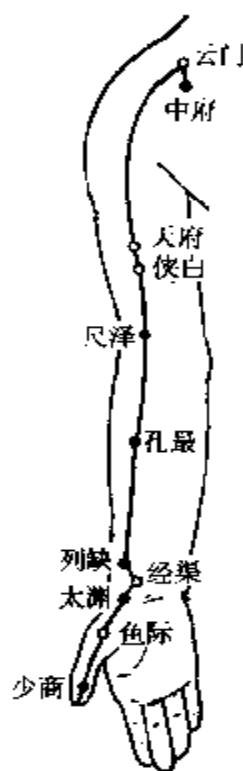


图 11 手太阴肺
经腧穴图

【类别】 手太阴之络穴，别走阳明，八脉交会穴之一，通于任脉。



图 12 列缺简便取穴图

【功能】 疏风解表，宣肺理气，平喘利咽，通经活络，利水调肠。据实验研究提示：有改善肺通气量，增强肾功能，使膀胱收缩，排尿量增加的作用并使小腿血管收缩。

【主治】 偏正头痛，颈项强痛，咳嗽气喘，咽喉肿痛，音哑，齿痛，面目水肿，中风口眼喎斜，牙关紧闭，手腕无力。现在，临床常用于治疗糖尿病、血尿、蛋白尿、感冒、鼻炎、喉炎、风疹、荨麻疹、神经性头痛、三叉神经痛、落枕、桡侧茎突狭窄性腱鞘炎、腕部软组织损伤等。

【灸法】 同孔最。

太 渊

【位置】 在掌后腕横纹桡侧端，桡动脉桡侧凹陷处。

【类别】 手太阴之输穴和原穴，八会穴之脉会。

【功能】 清热宣肺，止咳平喘，利咽消肿，通血脉。实验研究提示：可调整肺功能，对出血性疾病有显著作用，对高血压有降压作用。

【主治】 咳嗽气喘，咯血，吐血，心悸胸痛，咽喉肿痛，目痛生翳，腕臂痛，冻伤，手皲裂。临床常用于治疗流感、鼻炎、百日咳、支气管炎、脉管炎、无脉症。

【灸法】 艾条灸 3~5 分钟，不宜艾炷直接灸。

少 商

【位置】 拇指桡侧指甲角旁约 0.1 寸处。

【类别】 手太阴之井穴。

【功能】 清肺利咽，醒脑开窍，启闭苏厥。为急救穴之一。实验研究提示：可使血中一氧化碳血红蛋白分离，有助于一氧化碳中毒昏迷的苏醒。

【主治】 咳嗽，鼻出血，咽喉肿痛，热病昏厥，中暑呕吐，癫狂，中风闭证，小儿惊风，手指挛痛。临床常用于治疗流感、急性咽喉炎、扁桃体炎、腮腺炎、白喉、百日咳、精神分裂症、休克、胎位不正等。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

2. 手阳明大肠经腧穴(左右各 20 穴,见图 13,选 8 穴)

商 阳

【位置】 食指桡侧指甲角旁约 0.1 寸。

【类别】 手阳明大肠之井穴。

【功能】 清阳明热，宣肺利咽，泄热止痉，开窍苏厥。实验研究提示：可使胃蠕动增强。

【主治】 热病昏厥，中风昏迷，齿痛，腮肿，目赤，咽喉肿痛，耳鸣耳聋，手足麻木，青盲。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

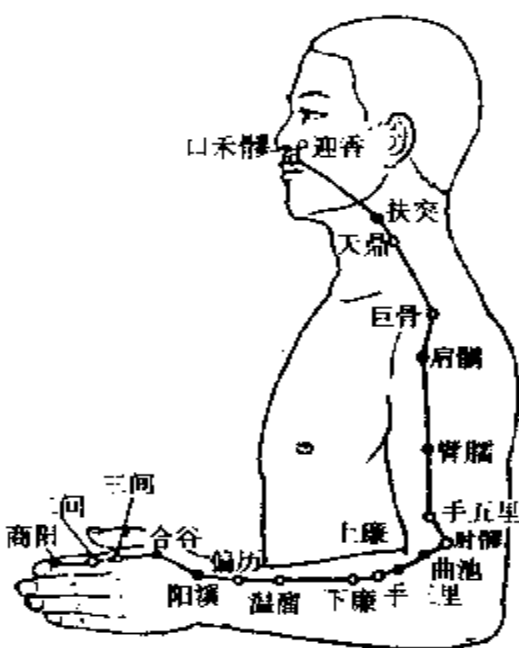


图 13 手阳明大肠经腧穴图

合 谷

【位置】 在手背第一、二掌骨之间，约平第二掌骨桡侧之中点。取穴时以一手拇指的指关节横纹正对另一手的拇、食指

之间的指蹼缘上,当拇指尖到达之处是穴(见图 14)。

【类别】 手阳明之原穴。



图 14 合谷简便取穴图

【功能】 清泄阳明,祛风解表,疏经镇痛,通络开窍,和胃通肠,通经引产。实验研究提示:能调整消化、呼吸、神经、血液循环、内分泌、性腺、免疫等功能,促进子宫收缩。

【主治】 头痛眩晕,目赤肿痛,鼻出血,齿痛,咽喉肿痛,外感发热、中风牙关紧闭,口眼喎斜,闭经滞产等。现在临床多用于治疗感冒发热、流行性感、面神经麻痹、面肌痉挛、三叉神经痛、咽炎、扁桃体炎、鼻炎、支气管炎、哮喘、结膜炎、电光性眼炎、风疹、荨麻疹、带状疱疹、丹毒、疔疮、神经性皮炎、颞颌关节功能紊乱、单纯性甲状腺肿、小儿消化不良、急性胰腺炎、前臂神经痛、痤疮、酒渣鼻、面部黄褐斑、疥癣、面部疖疮、冻疮、唇裂等。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

【附注】 孕妇慎用。

阳 溪

【位置】 在腕背横纹桡侧两筋间。取穴时拇、食指向上翘起,正当拇长、短伸肌腱之间的凹陷处。

【类别】 手阳明之经穴。

【功能】 清热散风。

【主治】 热病无汗,头痛齿痛,目赤生翳,咽喉肿痛,耳鸣耳聋,手腕痛,小儿消化不良,荨麻疹,冻疮,桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎。

【灸法】 同合谷。

手三里

【位置】 在前臂内侧，阳溪与曲池连线上，当曲池下 2 寸处。

【功能】 疏风通络，健脾和胃，清肠止泻。实验研究提示：能调整胃肠蠕动，并使神经中枢兴奋性下降，抑制增强，从而起镇静作用。

【主治】 腹痛泄泻，齿痛颌肿，失声，瘰癧，肩膊，腰背痛，上肢不遂。临床多用于治疗中风偏瘫、肘臂痛、面神经麻痹、消化性溃疡、胃炎、睾丸炎等。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

曲池

【位置】 在肘外侧部，屈肘横纹桡侧尽头处。

【类别】 为手阳明之合穴。

【功能】 祛风解表，清热利湿，调和气血，行气降逆。实验研究提示：有降压作用，并可调节血管舒缩，使心肌收缩力增强，心率下降；降低脑血管阻力，增强脑血流量；对动物实验性阑尾炎，能抑制炎症病灶的白细胞游出，有防治效果。

【主治】 感冒发热，咽喉肿痛，齿痛，目赤痛，腹痛腹泻，痢疾，上肢关节痛，中风上肢不遂，瘰癧，丹毒，腋臭，月经不调，闭经，不孕。现在临床多用于治疗流感、肺炎、中风偏瘫、扁桃体炎、肘臂神经痛、肩胛神经痛、高血压、发热、荨麻疹、肱骨外上髁炎。

【灸法】 同手三里。

臂臑

【位置】 上臂外侧，三角肌止点稍前处。垂臂取穴，当曲池与肩髃连线上，距曲池 7 寸处。

【类别】 手阳明、手太阳、足太阳、阳维之会，手阳明络之会。

【功能】 祛风通络，明目止痛，对乳腺手术有镇痛作用。

【主治】 肩臂痛，颈项强急，眼病，瘰癧。临床多用于治疗肩关节周围炎，肺叶切除术针麻穴之一。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

肩 髃

【位置】 在肩峰与肱骨大结节之间，三角肌上部中点处。取穴时，当上臂外展平举时，肩峰锁骨关节前缘下际出现前后两个凹陷，前凹陷是本穴。

【类别】 手阳明、阳跷之会。

【功能】 疏散经络风湿，清泄阳明气火，通利关节，祛邪解热，理气化痰。对食管癌手术有镇痛作用，能调整血液循环，针麻效佳。使肌电图波幅升高。

【主治】 肩臂痛，手臂挛急，抬举困难，中风上肢不遂，高血压，风疹，荨麻疹，瘰癧，癭瘤，腋臭。

【灸法】 同臂臑。

扶 突

【位置】 在颈外侧部，结喉旁开 3 寸，人迎后 1.5 寸，当胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间凹陷处。

【功能】 清咽利膈，理气化痰，消肿散结。对甲状腺针麻手术有良好的镇痛效果。

【主治】 咳嗽气喘，咽喉肿痛，吞咽困难，音哑，瘰癧，气瘰，声带疾患。甲状腺手术可选用本穴针麻。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

3. 足阳明胃经膺穴(左右各 45 穴，见图 15，选 18 穴)

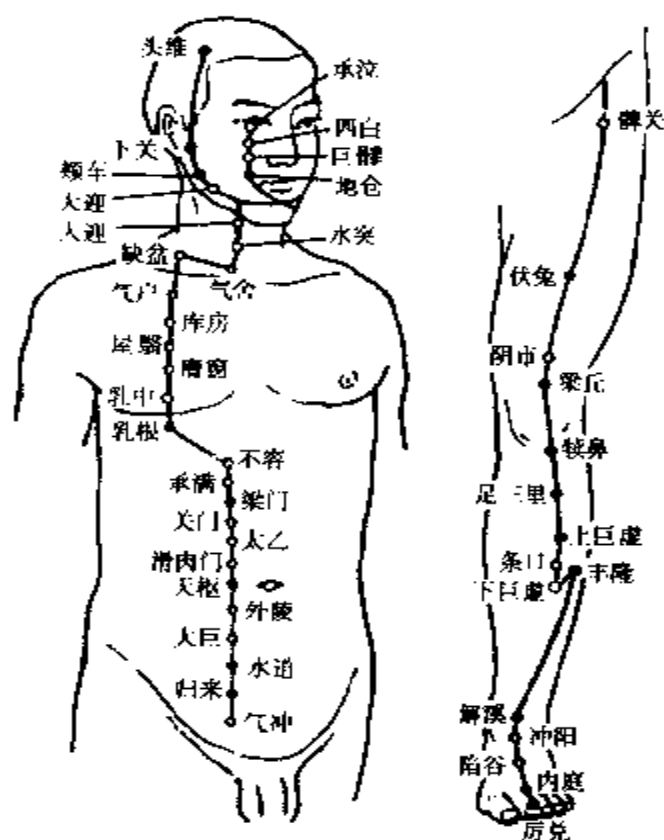


图 15 足阳明胃经腧穴图

地 仓

【位置】口角外旁开 0.4 寸处。

【类别】手足阳明、阳跷之会。

【功能】疏风行气，通经活络，利口颊。

【主治】面瘫，面肌痉挛，三叉神经痛，流涎，鹅口疮，面痒，口唇皸裂，面颊疔疮。

【灸法】艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

颊 车

【位置】下颌角前上方约 1 横指凹陷中，当咀嚼时，咬肌隆起处。

【功能】祛风活络，利牙关。实验研究提示：能抑制甲状

腺功能,镇痛,使唾液分泌减少,使孕妇子宫收缩增强。

【主治】 面瘫,牙关紧闭,齿痛颊肿,咬肌痉挛,颞颌关节炎,腮腺炎,下颌脱臼。

【灸法】 同地仓。

下 关

【位置】 在颧弓下缘,当颧弓与下颌切迹之间所形成的凹陷处。闭口有孔,开口即闭。

【类别】 足阳明、少阳之会。

【功能】 疏风清热,活络止痛,通利牙关,聪耳开窍。实验研究提示:对大脑皮质运动有一定影响。

【主治】 口噤,齿痛,口眼喎斜,牙关紧闭,开合不利,下颌脱臼,耳鸣耳聋。现在多用于治疗面神经麻痹、面肌痉挛、中耳炎、颞颌关节炎、黄褐斑。

【灸法】 同地仓。

头 维

【位置】 额角直上入发际 0.5 寸,前正中线旁开 4.5 寸处。

【类别】 足阳明、少阳、阳维之交会穴。

【功能】 疏风止痛,清头明目。实验研究提示:针刺可使血液中血细胞上升,对胃、十二指肠溃疡的抑制率为 36.7%。

【主治】 头痛目眩,目痛,迎风流泪,眼睑瞤动,视物不明。现在多用于治疗前额痛、偏头痛、精神分裂症、功能性子宫出血、脱发、秃眉、额部皱纹、发际疮。

【灸法】 艾条灸 3~5 分钟。

乳 根

【位置】 乳头(锁骨中线)直下,第五肋间隙中,前正中线旁开 4 寸处。

【功能】理气宽胸，降逆通乳。实验研究提示：可使风湿性心脏病房性早搏短期内相对减少，对早期房颤有一定复律作用，对冠心病能增强心肌收缩力，减慢心律，改善心电图。

【主治】咳嗽气喘，胸下满痛，噎膈，呕逆，乳痛，乳少。现在多用于治疗产后乳汁分泌不足、乳腺炎、乳腺增生、乳房过大或过小。

【灸法】艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

梁 门

【位置】脐上 4 寸（中脘），前正中线旁开 2 寸处，仰卧取穴。

【功能】健脾胃，调中气，助运化，消积滞。实验研究提示：能调整肠功能，抑制胃、十二指肠的胃电幅值；使呼吸功能下降；代谢功能降低。

【主治】胃痛呕吐，食欲不振，腹胀腹泻。现在多用于治疗急性和慢性胃炎、消化不良、消化性溃疡、幽门痉挛。

【灸法】艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

天 枢

【位置】脐中旁开 2 寸。

【类别】手阳明大肠之募穴。

【功能】调理肠胃，化湿消滞，和营调经。实验研究提示：能调整胃肠功能和改善症状；提高免疫力；对泌尿系结石有 50% 的排石率。

【主治】腹胀肠鸣，绕脐痛，呕吐腹泻，便秘，痢疾，月经不调，痛经，带下，水肿，癫狂，荨麻疹，肥胖症，消瘦。现在多用于治疗急性和慢性胃炎、急性和慢性肠炎、肠麻痹、阑尾炎、腹膜炎、肠蛔虫病、急性肠梗阻、子宫内膜炎、胃下垂。

【灸法】同梁门。

【附注】 孕妇不可灸。

水道

【位置】 脐下3寸(关元),前正中线旁开2寸处。仰卧取穴。

【功能】 温经散寒,理气调经,通利三焦,利水消胀。实验研究提示:可使动物输尿管蠕动加强,对泌尿系结石有止痛作用。

【主治】 腹胀便秘,小便不利,水肿,疝气,月经不调,痛经,不孕。现在多用于治疗肾炎、膀胱炎、尿潴留、腹水、睾丸炎、附件炎、子宫脱垂。

【灸法】 同梁门。

归来

【位置】 脐下4寸(中极),前正中线旁开2寸处。

【功能】 温经散寒,理气调经,调补冲任,提胞治疝。实验研究提示:可使继发性闭经出现激素退出性出血现象,有促性腺功能作用。

【主治】 小腹胀痛,疝气,月经不调,闭经,阴冷肿痛,白带,阴挺,男子卵缩,茎中痛,遗精,阳痿,小便不利,遗尿,阴囊湿疹,阴痒,肛门瘙痒。现在多用于治疗睾丸炎、子宫内膜炎、附件炎、不孕症、产后恶露不止。

【灸法】 同梁门。

伏兔

【位置】 在髌前上棘与髌骨外上缘的连线上,髌骨外缘上6寸处。

【功能】 散风寒,祛风湿,通经络,强腰膝。

【主治】 腰膝冷痛,下肢痿痹,疝气,脚气。现在常用于治疗下肢瘫痪、膝关节炎、股外侧皮神经炎、荨麻疹。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

梁 丘

【位置】 在髌前上棘与髌骨外上缘的连线上,髌骨外上缘上 2 寸处。

【类别】 足阳明之郄穴。

【功能】 和胃降逆,通经活络,祛风化湿。实验研究提示:能调节胃功能,抑制胃酸分泌。

【主治】 胃痛,腹胀,膝胫痹痛,乳房胀痛,乳痈,面部斑疹。现在多用于治疗胃炎、乳腺炎、膝关节炎、股外侧皮神经炎。

【灸法】 同伏兔。

犊 鼻

【位置】 屈膝取穴,在髌骨下缘髌韧带外侧凹陷中。

【功能】 疏利关节,祛风散寒,活络止痛。

【主治】 膝关节及周围软组织疾病,下肢痿软,脚气。

【灸法】 同伏兔。

足 三 里

【位置】 犊鼻下 3 寸,距胫骨前嵴外约 1 横指处。取穴时可以掌心按膝盖,拇指抵内膝眼,次指抵胫骨前嵴,中指止处定穴。

【类别】 足阳明之合穴。

【功能】 健脾和胃,理气降逆,利肠消滞,调理气血,清热化湿,通经活络,扶正培元,调补气血。本穴有强壮作用,为保健要穴。实验研究提示:能调整胃功能,促进胃蠕动;使胆囊收缩;使呼吸、代谢功能显著增强;降血压,使休克动物下降的血压明显上升;调整心功能;使阑尾炎的白细胞总数下降;对全血系统有调整作用;有助于免疫功能;调节血糖;恢复疲劳;

用于胃手术针刺麻醉,配公孙可抑制牵胃反应。

【主治】 一切胃肠疾病,虚损劳疾,半身不遂,膝胫酸痛及保健防病。临床可用于治疗急性和慢性胃炎、急性和慢性肠炎、消化性溃疡、返流性胃炎、幽门梗阻、肠梗阻、小儿消化不良等消化系统疾病及肝炎、高血压、高脂血症、哮喘、泌尿和生殖系统疾病,还能治疗虚弱、消瘦、衰老、贫血、白细胞减少症、神经衰弱、癫狂、过敏性疾病、风疹、荨麻疹、肥胖症、下肢瘫痪、脚气、丹毒、疔疮、脉管炎、痤疮等病证。

【灸法】 艾炷灸 5~10 壮,艾条灸 10~30 分钟,可重灸。

上 巨 虚

【位置】 在小腿外侧部,足三里直下 3 寸,胫骨嵴旁开 1 横指处。

【类别】 手阳明大肠之下合穴。

【功能】 调和脾胃,通腑化滞,清利湿热,行气活血,通经活络。实验研究提示:能调整胃肠蠕动,使痢疾患者和实验动物的血浆杀菌活力及免疫力均增强。

【主治】 脘腹胀满,肠鸣腹痛,泄泻,便秘,肠痛,下肢瘫痪。现在还用于治疗阑尾炎、急性和慢性胃炎、急性和慢性肠炎、菌痢、脚气。

【灸法】 同足三里。

丰 隆

【位置】 在小腿外侧部,外踝上 8 寸,相当于外膝眼与外踝尖连线的中点,胫骨前嵴旁开两横指处。

【类别】 足阳明之络穴。

【功能】 健脾化痰,和胃降逆,化湿通络,通便,清神志。实验研究提示:可使小腿血管收缩。

【主治】 痰饮咳喘,咽喉肿痛,眩晕头痛,呕吐,肢肿,便

秘，下肢痿痹，癫狂。现在还用于治疗慢性气管炎、支气管哮喘、高血压（对Ⅱ期高血压效著）、高血脂、脱发、痤疮、肥胖症。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

解 溪

【位置】 足背踝关节前横纹中央两筋（拇长伸肌腱与趾长伸肌腱）之间凹陷中。

【类别】 足阳明之经穴（五输穴）。

【功能】 健脾化湿，清胃化痰，疏经活络。实验研究提示：对动物炎症病灶有促进肉芽组织、细胞修复再生和瘢痕化的作用。

【主治】 头痛眩晕，腹胀便秘，踝关节痛，足下垂，癫疾。现在还用于治疗肾炎、鼓胀、肠炎、踝关节及周围软组织病、血栓闭塞性脉管炎、血栓性静脉炎。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~10 分钟。

内 庭

【位置】 在足背第二、三趾缝间的缝纹端赤白肉际处。

【类别】 足阳明之荣穴。

【功能】 清胃泄火，理气化滞，通络止痛。实验研究提示：能调整肠运动，可促进家兔肠蠕动，肠蠕动亢进者，可使之减弱。

【主治】 齿痛，咽喉痛，面瘫，鼻出血，胃痛吐酸，口臭，腹胀泄泻，痢疾，便秘，足背痛，痤疮。临床还用于治疗三叉神经痛、扁桃体炎、急性肠炎、肠疝痛、脚气。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

厉 兑

【位置】 第二趾外侧趾甲角旁约 0.1 寸处。

【类别】 足阳明之井穴。

【功能】 清胃泻火，镇静化痰，苏厥开窍。实验研究提示：能调节肺功能，增加通气量。

【主治】 热病，鼻出血，齿痛，面肿，喉痹，腹胀，足胫寒冷，癫狂。现在还用于治疗神经衰弱、三叉神经痛、扁桃体炎、瘰病。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

4. 足太阴脾经腧穴(左右各 21 穴，见图 16，选 9 穴)

隐 白

【位置】 足大趾内侧趾甲角旁约 0.1 寸处。

【类别】 足太阴之井穴。

【功能】 健脾和胃，益气摄血，宁神苏厥。实验研究提示：能使胃蠕动减慢。

【主治】 腹胀，吐泻，鼻出血，便血，尿血，月经过多，崩漏，惊风，晕厥，休克，癫狂，精神分裂症。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

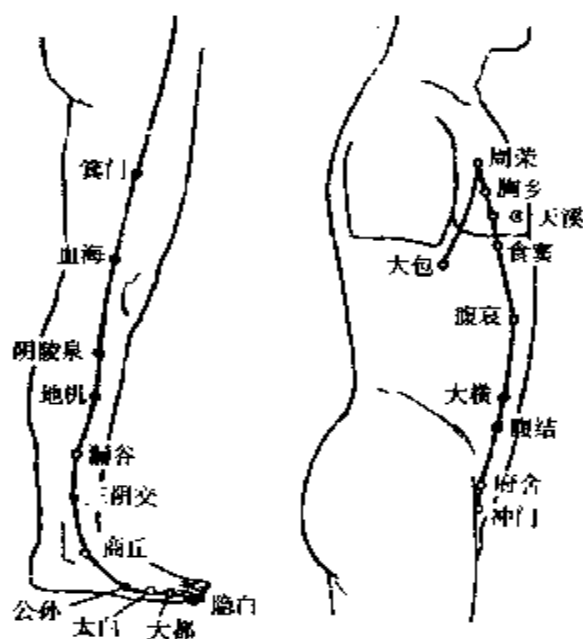


图 16 足太阴脾经腧穴图

公 孙

【位置】 在足内侧第一跖骨基底前下缘赤白肉际处。

【类别】 足太阴之络穴，别走阳明，八脉交会穴之一，通于冲脉。

【功能】 健脾化湿，理气和胃，调冲脉。实验研究提示：能抑制胃酸分泌，使小肠分泌明显增加，对小肠运动有调节作用，能抑制内脏疼痛。

【主治】 胃脘疼痛，呃逆呕吐，饮食不化，腹痛腹泻，痢疾，肋间神经痛，月经不调，足踝痛。现在还用于治疗头晕、心悸、胸痛、急性和慢性肠炎、消化性溃疡、下腹部痉挛、痛经、子宫内膜炎、胎盘滞留。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟

三 阴 交

【位置】 在小腿内侧面，内踝尖直上 3 寸，当胫骨内侧面后缘处。

【类别】 足太阴、少阴、厥阴之会。

【功能】 健脾胃，助运化，益肝肾，疏下焦，祛风湿，行气血，疏经络，调经带。实验研究提示：能调整胃分泌功能，调整女性生殖功能，调整心律、心率，使嗜酸性白细胞增加，对正常胰腺有调节胰岛素分泌作用，对妇科手术的镇痛作用明显。

【主治】 脾胃虚弱，饮食不化，腹胀肠鸣，腹痛腹泻，大小便难，遗精，早泄，阳痿，遗尿，尿频，尿闭，水肿，不寐，腿痛，疝气，偏瘫，突眼，脱发，月经不调，痛经，崩漏，白带多，不孕，滞产，阴挺，丹毒，臁疮，脚气，冻疮，面部黄褐斑。现在多用于治疗泌尿生殖系疾病如急性和慢性肾炎、淋病、癰闭、睾丸炎、盆腔炎、子宫出血等，高血压、糖尿病、急性和慢性肠炎、神经衰弱、神经官能症、消化不良、肠疝痛、血栓闭塞性脉管炎、荨麻疹、神经性皮炎、湿疹、皮肤瘙痒等。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

地 机

【位置】 在阴陵泉与内踝尖的连线上，阴陵泉直下 3 寸

处。

【类别】 足太阴之郄穴。

【功能】 健脾胃，理下焦，补肝肾，调经带。实验研究提示：使胰岛分泌功能亢进。

【主治】 腹痛泄泻，水肿，小便不利，月经不调，痛经，功能性子宫出血，精液减少，遗精。

【灸法】 同三阴交。

阴 陵 泉

【位置】 在膝下，胫骨内侧踝下缘凹陷中，与胫骨粗隆平齐，屈膝取穴。

【类别】 足太阴之合穴。

【功能】 健脾利湿，理血调经，调补肝肾，通利三焦。实验研究提示：调整膀胱张力，增强降结肠、直肠蠕动，对大脑皮质运动区有影响。

【主治】 腹胀，腹痛，喘逆，水肿，泄泻，小便不通或失禁，遗尿，遗精，阳痿，月经不调，赤白带下，膝痛，痢疾，前阴痒痛，肥胖症。临床还用于治疗肾炎、腹水、肠炎、黄疸。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

血 海

【位置】 髌骨内上缘上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起



处。屈膝取穴，以手掌按膝盖上，掌心对准髌骨中央，2~5 指向上直伸，拇指偏向膝内侧呈 45°角斜置，当拇指指端所止处是穴（见图 17）。

【功能】 理血调经，散风祛湿，宣通下焦。实验研究提示：调节垂体性腺（卵巢）功能，使继发性闭经出现激素

图 17 血海简便取穴图

撤退性出血,使黄体生成素分泌增加,促使排卵,形成黄体,孕酮分泌增加。

【主治】 月经不调,痛经,闭经,崩漏,带下,五淋,贫血,股内侧痛,湿疹,荨麻疹,皮肤瘙痒,疥癣,丹毒,阴部痒痛,银屑病,痤疮,为治疗皮肤病要穴。

【灸法】 同阴陵泉。

箕 门

【位置】 在大腿内侧面,髌骨内侧端上8寸,血海与冲门的连线上。

【功能】 健脾利湿,利水通淋。

【主治】 淋证,小便不通,遗尿,腹股沟肿痛,睾丸炎,性功能减退,下肢瘫痪,阴囊湿疹。

【灸法】 同阴陵泉。

腹 结

【位置】 在腹外侧,气海穴旁开4寸,直上0.2寸处。

【功能】 温经散寒,行气活血,理气降逆。

【主治】 脐周痛,腹胀便秘,疝痛,腹寒泻利。现在还用于治疗菌痢、肠梗阻、急性阑尾炎。

【灸法】 同阴陵泉。

大 横

【位置】 脐中旁开4寸,当腹直肌外缘处。

【类别】 足太阴、阴维之会。

【功能】 调理肠胃,行气通腑。实验研究提示:可调整肠功能,有驱蛔作用。

【主治】 绕脐腹痛,泄泻,痢疾,便秘,肠麻痹,肠寄生虫病,胆道蛔虫症,肥胖症,脏躁。

【灸法】 同阴陵泉。

5. 手少阴心经腧穴(左右各 9 穴,见图 18,选 6 穴)

极 泉

【位置】 举臂开腋取穴,在腋窝正中,腋动脉搏动处的前方或后方取之。

【功能】 宁心安神,通经活络,止痛。实验研究提示:可调整心律。

【主治】 心痛,胸闷,心悸气短,腋窝痛,咽干烦渴,肋下满痛,肩臂痛,瘰癧。现在还用于治疗心肌炎、心包炎、肋间神经痛、腋臭、上肢手术针麻。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

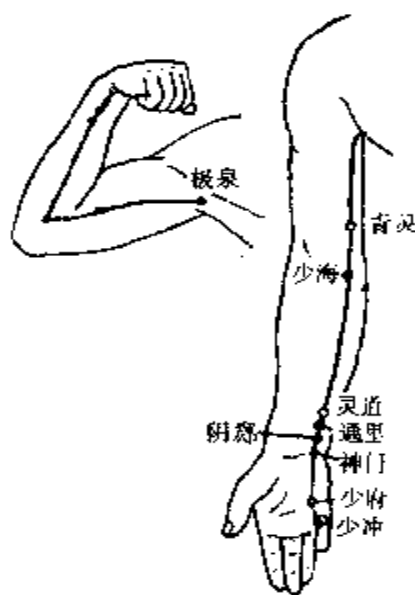


图 18 手少阴心经腧穴图

少 海

【位置】 屈肘取穴,在肘横纹尺侧端与肱骨内上髁连线之中点处。

【类别】 手少阴之合穴。

【功能】 清心宁神,化痰通络,行气活血。实验研究提示:有调整心律,调整肾上腺皮质功能,缓解结肠痉挛等作用。

【主治】 心绞痛,神经衰弱,头项痛,腋胁痛,手臂挛痛,上肢麻木,瘰癧。现在还用于治疗淋巴结炎、肋间神经痛、尺神经痛、痉挛性结肠炎、精神分裂症。

【灸法】 同极泉。

通 里

【位置】 在前臂屈侧面,腕横纹尺侧端上 1 寸,尺侧屈腕

肌腱桡侧缘。

【类别】 手少阴之络穴，别走太阳。

【功能】 宁心安神，和营熄风，通经活络，调理气血。实验研究提示：能改善心绞痛，调整大脑皮质功能，使部分癫痫大发作病人的脑电图趋于规则化。

【主治】 头晕目眩，心痛，心悸怔忡，失眠，咽喉肿痛，暴暗，舌强不语，腕臂痛，遗尿，月经过多，崩漏。现在还用于治疗心绞痛、心律失常、房颤、急性舌骨肌麻痹、神经衰弱、癔病性失语、癔病。

【灸法】 同极泉。

阴 郄

【位置】 在前臂屈侧面，腕横纹尺侧端（神门）直上0.5寸，当尺侧屈腕肌腱桡侧凹陷处。

【类别】 手少阴之郄穴。

【功能】 清心安神，益气固表，调理气血。实验研究提示：能调整膀胱张力，并可使部分癫痫大发作病人脑电图趋于规则化。

【主治】 心痛惊悸，头痛目眩，肺结核，骨蒸盗汗，吐血，暴暗，神经衰弱。

【灸法】 同极泉。

神 门

【位置】 前臂屈侧面，腕横纹尺侧端，腕豆骨后方，当尺侧屈腕肌腱的桡侧凹陷处，仰掌取穴。

【类别】 手少阴之腧穴，心之原。

【功能】 清心安神，凉营调气，通经活络。实验研究提示：能改善心绞痛症状，纠正心律失常，降血压，调节大脑皮质功能，使部分癫痫病人脑电图趋向规则化，增强肺功能，使心源

性喘息降低呼吸频率。

【主治】 心烦不寐,心痛心悸,多梦健忘,胁痛,掌中热,癲狂,痫证,痴呆,瘰病,喉痹,失声,吐血,喘逆,遗溺。

【灸法】 同极泉。

少 冲

【位置】 手小指桡侧,指甲角旁约 0.1 寸处。

【类别】 手少阴之井穴。

【功能】 泄热救逆,宁心安神,开窍苏厥。实验研究提示:可使一氧化碳中毒动物的血中一氧化碳含量速减,苏醒时间明显提前。

【主治】 心痛心悸,中风昏厥,热病昏迷,面色紫暗,面目红肿,胸胁痛,癲狂,疥疮。现在还用于治疗喉炎、心肌炎、休克、肋间神经痛。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

6. 手太阳小肠经膈穴(左右各 19 穴,见图 19,选 10 穴)

少 泽

【位置】 手小指尺侧,指甲角旁约 0.1 寸处。

【类别】 手太阳之井穴。

【功能】 清热利咽,醒神开窍,活络通乳。实验研究提示:使缺乳妇女血中生乳素含量增加。

【主治】 热病,头痛,咽痛,目翳,晕厥,中风昏迷,乳痈,乳少,乳房过大或过小。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

后 溪

【位置】 手小指尺侧缘,第五掌指关节后掌横纹赤白肉际处,微握拳取穴。

【类别】 手太阳之腧穴,八脉交会穴之一,通于督脉。

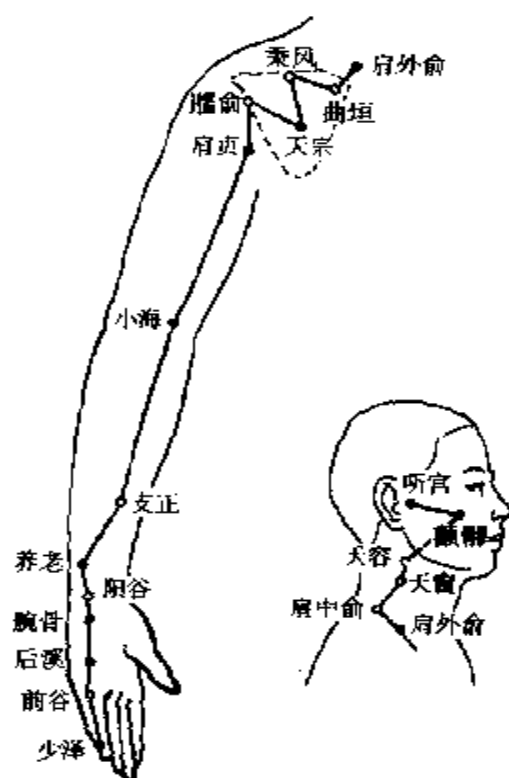


图 19 手太阳小肠经腧穴图

【功能】 疏风清热，宁心安神，舒筋通络，通督脉，固表汗。

【主治】 头项强痛，耳鸣耳聋，热病，目赤，目翳，盗汗，腰痛，肘臂、手指挛急。现在常用于治疗落枕、肩周炎、急性腰扭伤、肋间神经痛、神经衰弱、精神分裂症、疟疾。

【灸法】 艾炷灸 3～5 壮，艾条灸 5～10 分钟。

腕 骨

【位置】 手腕尺

侧，第五掌骨底后，钩骨前凹中。

【类别】 手太阳之原穴。

【功能】 疏风清热，通经活络，利湿。实验研究提示：使降结肠和直肠下部蠕动增强，并有便意感。

【主治】 头痛项强，耳鸣，目翳，胁痛，黄疸，热病，指挛臂痛。现在常用于治疗胃炎、胆囊炎、糖尿病、肘腕及指关节炎。

【灸法】 同后溪。

养 老

【位置】 前臂伸侧面，尺骨小头桡侧缘凹中，取穴时，屈肘前臂旋后，掌心对胸，当尺骨小头桡侧缝中。

【类别】 手太阳之郄穴。

【功能】 清热明目，舒筋活络。实验研究提示：对痹证显效，使其血流图趋于正常。

【主治】 肩、背、肘、臂酸痛，目视不明，项背强痛。临床可用于治疗肩臂痛、呃逆、落枕、急性腰扭伤、急性角膜炎、视神经萎缩。

【灸法】 同后溪。

小 海

【位置】 屈肘在肘关节内侧，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷中。

【类别】 手太阳之合穴，别走少阴。

【功能】 清头明目，祛风散结，活血通络。实验研究提示：使降结肠远端的顽固性迷走神经过敏现象好转。

【主治】 头痛眩晕，颈项强痛，咽喉肿痛，颊肿，齿痛，颈后、肩背外后侧痛，耳鸣耳聋，痫症。现在还用于治疗尺神经痛、过敏性结肠炎、舞蹈病、精神分裂症。

【灸法】 同后溪。

肩 贞

【位置】 垂臂合腋，在腋后皱襞尽头直上1寸处。

【功能】 疏风活血散结，舒筋活络利节。

【主治】 肩胛酸痛，肩关节周围炎，手臂麻木不能高举，耳鸣耳聋，腋汗，瘰癧，上肢瘫痪。

【灸法】 同后溪。

天 宗

【位置】 肩胛冈下窝的中央处，当肩胛冈下缘与肩胛下角之间连线的上1/3折点处。

【功能】 散风解表，行气宽胸，通经活络，利湿消肿。实验研究提示：可提高免疫功能，对乳腺增生有效。

【主治】 肩胛酸痛,肘臂外侧痛,颊颌肿痛,肋间神经痛,落枕,肩关节周围炎,咳嗽气喘,乳腺炎,乳腺增生,产后乳少。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~15 分钟。

肩外俞

【位置】 第一胸椎棘突下旁开 3 寸,肩胛骨上方凹陷中。

【功能】 祛风,舒筋,活络,利肩臂。

【主治】 肩臂酸痛,颈项强急,上肢冷痛。现在多用于治疗颈椎病、落枕、咳嗽气喘。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

颧 髎

【位置】 目外眦直下,颧骨下缘凹陷处。

【类别】 手太阳、少阳之会。

【功能】 清热散风,疏经活络,利面颊。实验研究提示:对三叉神经痛有镇痛作用。

【主治】 面神经麻痹,面肌痉挛,三叉神经痛,牙龈肿痛,黄褐斑,口疮,拔上颌牙麻醉穴。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

听 宫

【位置】 在耳屏正中前当下颌髁状突的后缘,张口呈凹陷处。

【类别】 手足少阳、手太阳之会。

【功能】 聪耳开窍,安神通络。实验研究提示:能改善耳蜗微循环,提高耳蜗功能。

【主治】 耳鸣耳聋,中耳炎,外耳道炎,梅尼埃病,下颌关节炎,面神经麻痹,耳部湿疹。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 5~15 分钟。

7. 足太阳膀胱经膈穴(左右各 67 穴,见图 20、21,选 24

穴)。

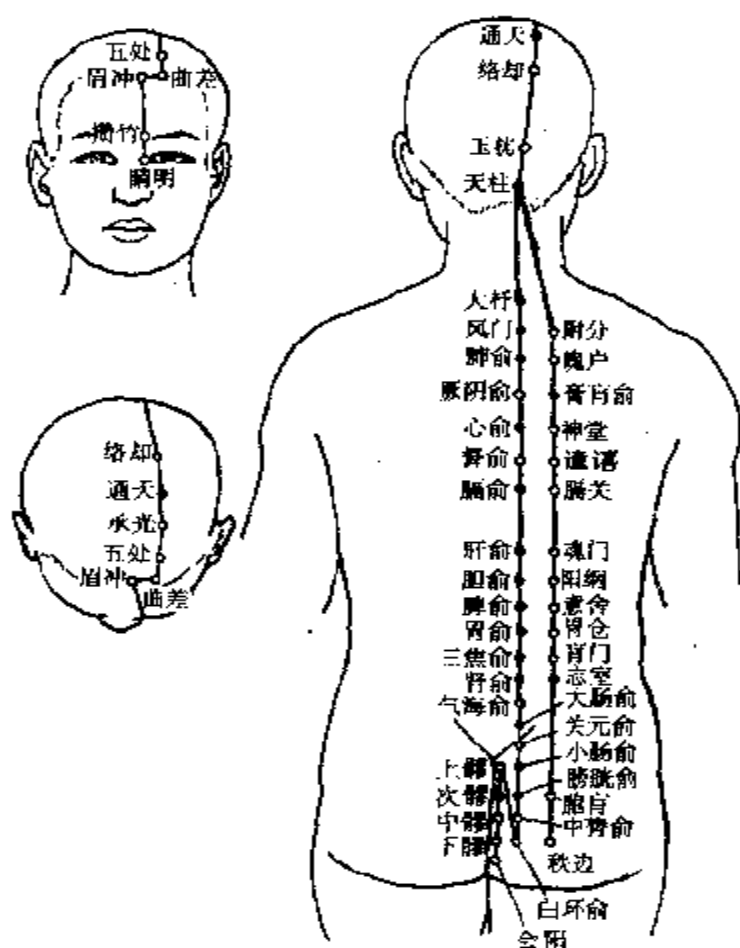


图 20 足太阳膀胱经腧穴图(一)

通 天

【位置】 前正中线入发际 4 寸旁开 1.5 寸处。

【功能】 祛风通络,通鼻窍。实验研究提示:可使部分癫痫大发作病人的脑电图趋于规则化。

【主治】 头痛,眩晕,鼻塞,鼻出血,鼻渊,鼻疳。临床多用于治疗副鼻窦炎、鼻炎、高血压、中风后遗症、遗尿、足跟痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

天 柱

【位置】 后正中线入发际0.5寸(哑门)旁开1.3寸,当斜方肌外缘凹陷处。

【功能】 散风清热,活血止痛,明目利窍,通经活络。实验研究提示:可使脑血栓形成恢复期肌电幅度升高。

【主治】 头痛项强,眩晕,目赤肿痛,鼻塞,落枕,肩臂痛,咽喉炎,食管痉挛,神经衰弱,脑血管功能不全,癯病。

【灸法】 同通天。

大 杼

【位置】 第一胸椎棘突下(陶道)旁开1.5寸处。

【类别】 手足太阳之会,督脉别络,八会穴之骨会。

【功能】 祛风清热,宣肺降逆,疏经通络。实验研究提示:能调整肺功能,增加肺通气量。

【主治】 感冒发热,咳喘胸满,头痛鼻塞,腰脊疼痛,肩胛酸痛,颈项强直。临床还用于治疗支气管炎、肺炎、胸膜炎、中暑、癯病、背肌风湿痛、脊神经综合征、骨结核。

【灸法】 艾炷灸3~7壮,艾条灸5~15分钟。

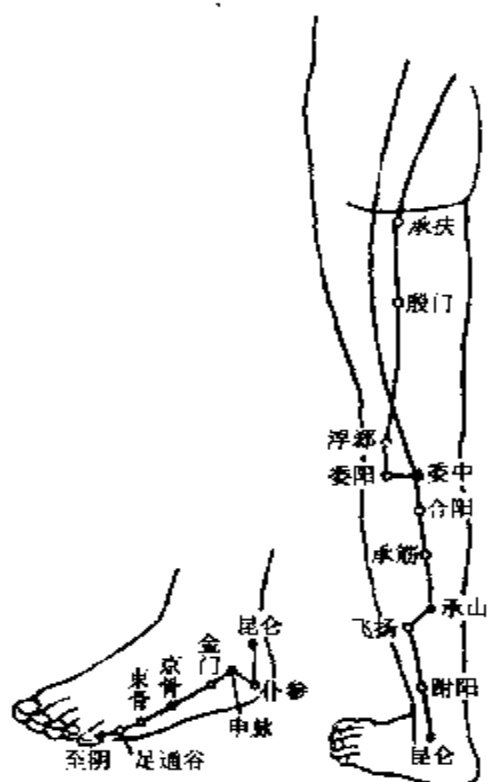


图 21 足太阳膀胱经腧穴图(二)

风 门

【位置】 第二胸椎棘突下旁开 1.5 寸处。

【类别】 督脉、足太阳之会。

【功能】 疏风泄热，宣肺解表，益气固表。

【主治】 感冒咳嗽，发热头痛，项强，腰背痛。临床还用于
治疗流感、支气管炎、胸膜炎、百日咳、荨麻疹，预防感冒。

【灸法】 同大杼。

肺 俞

【位置】 第三胸椎棘突下(身柱)旁开 1.5 寸处。

【类别】 肺之背俞穴。

【功能】 清热宣肺，止咳平喘，调气补虚。实验研究提示：
能改善肺功能，增加肺通气量；抑制冠状动脉粥样硬化斑块的
形成；使肝血流量明显增加，能增强机体免疫力；对热带嗜酸
性白细胞增多症有效。

【主治】 咳嗽气喘，胸满吐血，潮热盗汗。临床还用于治
疗感冒咳嗽、支气管炎、肺炎、胸膜炎、肺脓疡、百日咳、肋间神
经痛、皮肤瘙痒症、湿疹、荨麻疹、痤疮、酒渣鼻、皮肤干燥、毛
发焦枯、热带嗜酸性白细胞增多症。

【灸法】 同大杼。

心 俞

【位置】 第五胸椎棘突下(神道)旁开 1.5 寸处。

【类别】 心的背俞穴。

【功能】 清心安神，宽胸通络，理气止痛。实验研究提示：
能抑制冠状动脉粥样斑块形成，控制心率，对房颤有效。能抑
制支气管平滑肌痉挛，对内脏有镇痛作用。

【主治】 心悸心痛，胸闷心烦，失眠健忘，遗精盗汗，脏
躁，癲狂病。临床上还用于治疗心脏疾病、上消化道出血、神经

衰弱、心律失常、支气管炎、癫痫、精神分裂症、肋间神经痛、体癣、痤疮。

【灸法】 同大杼。

膈 俞

【位置】 第七胸椎棘突下(至阳)旁开 1.5 寸处,约与肩胛骨下角平齐。

【类别】 血之会。

【功能】 清血热,和营卫,宽胸降逆,理血化瘀,调气补虚。实验研究提示:能生血止血,降血压,调整肺功能,调节血糖,改善膈肌运动幅度。

【主治】 呕吐呃逆,噎膈,胃脘疼痛,胸胁胀痛,咳嗽气喘,吐血,鼻出血,潮热盗汗,膈肌痉挛,虚损昏厥。临床多用于治疗贫血、慢性气管炎、风湿性关节炎、皮肤紫癜、荨麻疹、瘙痒症、黄褐斑、痤疮、毛囊炎、酒渣鼻、神经性皮炎、白塞病、皮肤粗糙。

【灸法】 同大杼。

肝 俞

【位置】 第九胸椎棘突下(筋缩)旁开 1.5 寸处。

【类别】 肝的背俞穴。

【功能】 疏肝利胆,清热利湿,养肝明目,潜阳熄风。实验研究提示:能调整消化道功能,使肠功能障碍、胃及十二指肠溃疡症状改善,使胆囊收缩,胆道括约肌舒张,胆管内压力下降,使血小板减少性紫癜及脾性全血细胞减少症状好转,调节血糖、血胆固醇和免疫功能,使垂体-肾上腺系统功能增强。

【主治】 黄疸胁痛,吐血,鼻出血,头晕目赤,夜盲,胸肋满闷,脊背痛,癫疾,痫证。临床常用于治疗急慢性肝炎、胆囊炎、肝硬化、胃病、眼病、肋间神经痛、神经衰弱、月经不调、皮

肤紫癜、痤疮、黄褐斑、脱发。

【灸法】 同大杼。

胆 俞

【位置】 第十胸椎棘突下(中椎)旁开 1.5 寸处。

【类别】 胆的背俞穴。

【功能】 疏肝利胆,理气宽胸,调和脾胃,熄风定志。实验研究提示:能调整胃肠功能,使胆囊收缩,胆道括约肌舒张,消炎排石,提高人体免疫力,使垂体-肾上腺系统功能增强,对无黄疸性肝炎有效。

【主治】 黄疸胁痛,口苦呕吐,饮食不下,肺癆潮热,高血压。临床常用于治疗病毒性肝炎、急性腹痛、胆绞痛、胆囊炎、胃炎、胆道蛔虫症。

【灸法】 同大杼。

脾 俞

【位置】 第十一胸椎棘突下(脊中)旁开 1.5 寸处。

【类别】 脾之背俞穴。

【功能】 健脾助运,化湿除满,益气和胃,养血摄血。实验研究提示:能调整胃功能,升高血小板,降血糖、胆固醇。

【主治】 脾胃虚弱,面黄身肿,消瘦,肌肉松弛,皮肤干燥,胃痛腹胀,呕吐泄泻,完谷不化,痢疾,水肿,便血,黄疸,背痛,崩漏,小儿慢惊风。临床常用于治疗胃炎、胃溃疡、肠炎、神经性呕吐、消化不良、胃下垂、贫血、肝炎、肝脾肿大、慢性腹泻、呃逆、慢性出血性疾病、白细胞减少症、糖尿病、荨麻疹、子宫脱垂。

【灸法】 同大杼。

胃 俞

【位置】 第十二胸椎棘突下旁开 1.5 寸处。

【类别】 胃之背俞穴。

【功能】 健脾胃，消积滞，理气化湿。实验研究提示：能调整胃蠕动和胃液分泌，使胃蛋白酶活性增强，促进溃疡愈合，改善心肌缺血，对内脏的镇痛作用较好。

【主治】 脾胃虚弱，消瘦，噎膈，反胃呕吐，腹胀肠鸣，泄痢，完谷不化，胃痛纳少，胸胁痛，口臭。临床常用于治疗胃炎、消化性溃疡、胰腺炎、神经性呕吐、胃扩张、胃下垂、消化不良、肠炎、肝炎、失眠、肥胖症。

【灸法】 同大杼。

三焦俞

【位置】 第一腰椎棘突下旁开 1.5 寸处。

【类别】 三焦俞之背穴。

【功能】 健脾利湿，通利三焦，疏调水道。实验研究提示：对泌尿系结石大部分有效，半数可排出结石。

【主治】 身热水肿，小便不利，腹胀肠鸣，呕吐泄泻，完谷不化，痢疾，遗尿，癃闭，鼓胀，黄疸，腰脊强痛。临床还用于治疗胃炎、肠炎、肾炎、腹水、尿潴留、遗尿、神经衰弱、发际疮、酒渣鼻。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

肾俞

【位置】 第二腰椎棘突下(命门)旁开 1.5 寸处。

【类别】 肾之背俞穴。

【功能】 补肾益精，聪耳明目，壮腰祛湿，利水消肿。实验研究提示：能调整肾功能，促进肾上腺皮质功能，调整膀胱张力，兴奋网状内皮系统的吞噬能力。

【主治】 肾虚腰痛，耳鸣耳聋，头昏目眩，虚喘，水肿，遗精阳痿，早泄遗溺，消渴，小便混浊，尿血，泄泻，月经不调，白

带多。临床常应用于治疗肾炎、蛋白尿、肾下垂、尿路感染、贫血、高血压、糖尿病、神经衰弱、衰老、脱发、皱纹多、头发早白、面黑、慢性盆腔炎、小儿麻痹后遗症、老年性瘙痒症、银屑病、白癜风。

【灸法】 艾炷灸 5~10 壮，艾条灸 10~20 分钟。

大肠俞

【位置】 第四腰椎棘突下(腰阳关)旁开 1.5 寸处，约与髂嵴最高点相平。

【类别】 大肠之背俞穴。

【功能】 通肠利腑，强壮腰膝。

【主治】 腰痛，腹胀肠鸣，腹痛泄泻，便秘，痢疾，消化不良，肠痈，痔漏，腰背酸痛，下肢不利，痿软。临床常用于治疗肠炎、菌痢、肠梗阻、遗尿、骶髂关节炎、痛经、丹毒、脓疮、湿疹、荨麻疹、瘙痒症。

【灸法】 同肾俞。

小肠俞

【位置】 第一骶椎棘突下旁开 1.5 寸处。俯卧取穴，当髂后上棘内缘与骶骨间凹陷处，与第一骶后孔相平。

【类别】 小肠之背俞穴。

【功能】 通调小肠，清利湿浊。

【主治】 遗精，遗尿，尿血，小腹胀痛，泄泻，痢疾，痔疾，疝气，肠炎，盆腔炎，赤白带下，骶髂关节炎。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

膀胱俞

【位置】 第二骶椎棘突下旁开 1.5 寸处。当髂后上棘内缘下与骶骨之间凹陷中，平第二骶后孔。

【类别】 膀胱之背俞穴。

【功能】 通调膀胱，清热利湿，健腰固本。

【主治】 小便不利，遗尿，遗精，阳痿，腹痛，泄泻，便秘，阴部湿疹，腰脊强痛，下肢痿痹。临床常用于治疗腰腿痛、坐骨神经痛、糖尿病、尿路感染、前列腺炎、盆腔炎、膀胱炎、性功能障碍。

【灸法】 同小肠俞。

次 髂

【位置】 第二骶后孔凹陷中，约当髂后上棘下缘与督脉的中点处，与膀胱俞相平。

【功能】 理下焦，强腰脊，调经血。实验研究提示：能使膀胱收缩，增强宫缩，缩短产程，有利于无痛分娩。

【主治】 腰骶痛，疝气，月经不调，痛经，赤白带下，阴挺，遗精阳痿，小便不利，下肢痿痹，催产引产。临床常用于治疗腰腿痛、坐骨神经痛、尿路感染、尿潴留、阴道炎、睾丸炎、闭经、痔疮、下肢瘫痪、尿失禁。

【灸法】 同小肠俞。

委 中

【位置】 在腘横纹之中点处，当半腱肌肌腱与股二头肌肌腱的中间，屈膝或俯卧取穴。

【类别】 足太阳之合穴和下合穴。

【功能】 清热解毒，醒神，舒筋活络，利腰腿，止吐泻。实验研究提示：能调整膀胱内压力，对体温有调节作用。

【主治】 腰背痛，髋关节屈伸不利，腓筋挛急，下肢痿痹，中风，中暑，半身不遂，腹痛，吐泻，疟疾，小便不利，遗尿，丹毒。临床常用于治疗急性腰扭伤、坐骨神经痛、急性胃肠炎、腓肠肌痉挛、膝关节痛、风疹、湿疹、疖疮、臀部毛囊炎、斑疹、脱发。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

膏 肓 俞

【位置】 第四胸椎棘突下旁开 3 寸处。

【功能】 养阴清肺，补虚益损。实验研究提示：能缓解支气管痉挛，增加血红蛋白和红细胞数。

【主治】 虚劳体弱，脾胃虚弱，肺癆，咳嗽，咳血，吐血，骨蒸潮热，盗汗，心悸，失眠，健忘，遗精，阳痿。临床常用于治疗支气管炎、哮喘、肺结核、胸膜炎、神经衰弱、消化不良、菱形肌劳损。

【灸法】 同委中。

志 室

【位置】 第二腰椎棘突下（命门）旁开 3 寸处，与肾俞和第十一肋下端相平。

【功能】 补肾益精，壮腰渗湿，通阳利尿。

【主治】 遗精阳痿，早泄，阴部肿痛，小便不利，腰脊强痛，淋浊，水肿。临床常用于治疗肾炎、肾绞痛、肾下垂、前列腺炎、阴囊湿疹、腰部软组织损伤、下肢瘫痪。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

承 山

【位置】 委中直下 8 寸，在腓肠肌两肌腹之间的陷沟下端。取穴时，用力伸足，小腿后正中出现人字纹的凹陷处。

【功能】 舒筋活络，理肠提肛，利腰腿，疗痔疾。实验研究提示：对室性早搏有效。

【主治】 腰痛，腿痛转筋，痔疾，便秘，疝气，腹痛，脚气，湿疹，肛门瘙痒。临床多用于治疗腰腿痛、腓肠肌痉挛、坐骨神经痛。

【灸法】 同志室。

昆 仑

【位置】 外踝尖与足跟腱水平连线的中点处。

【类别】 足太阳之经穴。

【功能】 祛风热，清头目，舒筋骨，理胞宫。实验研究提示：使降结肠下部和直肠增强蠕动，并有便意。对原发性高血压有降压作用。

【主治】 头痛项强，目眩，鼻出血，肩臂拘急，腰痛，脚跟痛，小儿痢证，便秘，难产，胞衣不下。临床多用于治疗甲状腺肿大、急性腰扭伤、坐骨神经痛、踝关节痛、滞产、胎盘滞留、胎位不正。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

申 脉

【位置】 外踝下缘中点直下 0.4 寸处。

【类别】 八脉交会穴之一，通于阳跷。

【功能】 清头明目，宁心安神，疏筋通络，利腰腿。

【主治】 头痛眩晕，目赤肿痛，失眠，项背强痛，腰腿酸痛，下肢麻木乏力，癫狂痫，中风口噤。临床还用于治疗踝关节痛、内耳性眩晕、脑脊髓膜炎、精神分裂症。

【灸法】 同志室。

至 阴

【位置】 在足小趾外侧，距趾甲角 0.1 寸处。

【类别】 足太阳之井穴。

【功能】 祛风湿，清头目，通血脉，理气机，正胎位，顺胎产。实验研究提示：能使子宫活动加强，宫缩频率加快，子宫紧张度升高，胎儿心率加快，矫正异常胎位（以横位成功率最高）。

【主治】 头痛，眩晕，鼻塞，鼻出血，目痛，目翳，足下热，

难产,胞衣不下,小便不利。临床常用于治疗胎位不正、滞产、胎盘滞留。

【灸法】 同志室。

8. 足少阴肾经腧穴(左右各 27 穴,见图 22、23,选 7 穴)

涌泉

【位置】 在足底中线(去趾)前 1/3 交点处,蜷足时足底前呈凹陷处取之。

【类别】 足少阴之井穴。

【功能】 滋肾泄热,交通心肾,开窍苏厥。实验研究提示:能纠正胎位,灸之能降血压。

【主治】 头顶痛,眩晕,失眠,目昏花,舌干,失声,咽喉痛,便秘,小便不利,足心热,中暑,昏厥,中风昏迷,小儿惊风,癫痫,霍乱转筋,下肢痉挛。临床常用于治疗高血压、咯血、休克、风疹、筋挛、中暑、中风昏迷、膝痛不可屈伸、精神分裂症。

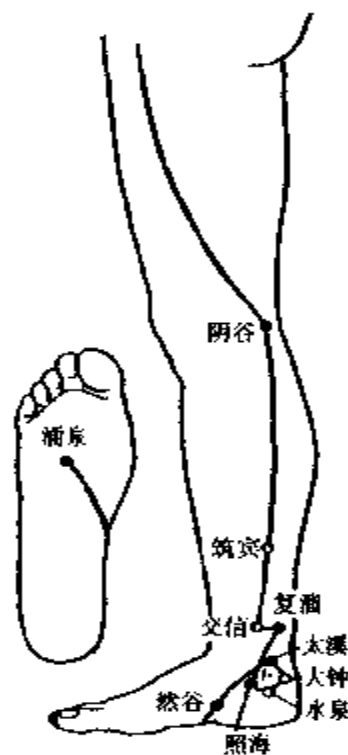


图 22 足少阴肾经腧穴图(一)

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

然谷

【位置】 在内踝前下方,当舟骨粗隆下缘凹陷处。

【类别】 足少阴之荥穴。

【功能】 滋阴清热,利湿消胀,宁神。实验研究提示:能提高内分泌系统功能,对嗜酸性白细胞的影响有特异性,对原发

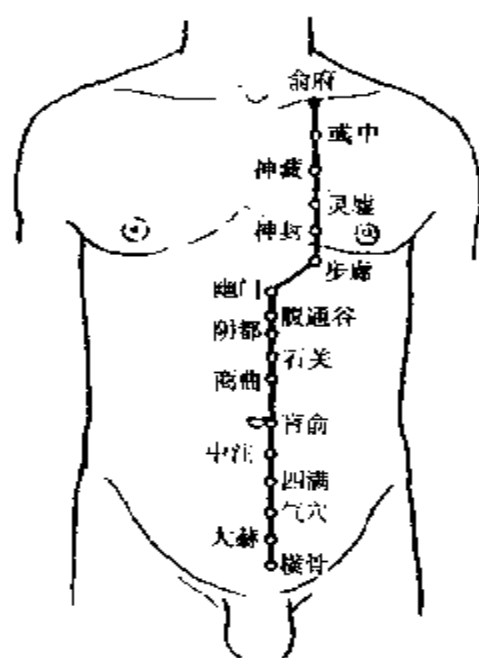


图 23 足少阴肾经腧穴图(二)

性高血压病有效。

【主治】 阴痒,阴挺,月经不调,崩漏,带下,遗精,阳痿,癰闭,咯血,黄疸,泄泻,消渴,足跗肿痛,下肢痿痹,小儿脐风口噤。临床常用于治疗咽喉炎、扁桃体炎、膀胱炎、糖尿病、破伤风。

【灸法】 同涌泉。

太 溪

【位置】 在内踝尖与跟腱水平连线中点处。

【类别】 足少阴之输

穴、原穴。

【功能】 滋阴清热,益肾壮阳,清肺止咳,通调冲任。实验研究提示:能改善呼吸功能,使肾泌尿功能增强,使嗜酸性白细胞减少。

【主治】 咳嗽气喘,咯血,失眠,健忘,耳鸣,耳聋,消渴,遗精,阳痿,小便频数,月经不调,齿痛龈肿,咽喉干痛,足跟肿痛。临床常用于治疗慢性咽喉炎、尿路感染、膀胱炎、肾炎、眩晕、失眠、面黑、水肿、神经衰弱、肾虚牙痛、中心视网膜脉络膜炎、遗尿、足底痛、下肢瘫痪、脚气、冻疮、衰老。

【灸法】 同涌泉。

照 海

【位置】 在内踝尖直下约 1 寸处,当内踝下缘与距骨相接的凹陷中。

【类别】 八脉交会穴之一。

【功能】 滋阴补肾，清利下焦，清心宁神，调经利尿。实验研究提示：能调节肾功能，促进泌尿，使动脉压下降，尿蛋白减少，酚红排出量增加。

【主治】 月经不调，痛经，赤白带下，阴挺阴痒，小便频数，癃闭，疝气，目赤肿痛，咽喉干痛，便秘，癫痫。临床常用于治疗肾炎、高血压、失眠、慢性咽炎、梅核气、足跟痛。

【灸法】 同涌泉。

复 溜

【位置】 在小腿内侧面，太溪直上2寸处，当跟腱之前缘。

【类别】 足少阴之经穴。

【功能】 温肾利水，调和营卫，止汗，理肠。

【主治】 腹胀，泄泻，肠鸣，水肿，盗汗自汗，身热无汗，腰脊强痛，腿肿足痿，小便不利，淋证，崩漏。临床常用于治疗尿路感染、肾炎、睾丸炎、功能性子宫出血、急性腰扭伤、足跟痛、脑外伤后遗症、下肢瘫痪。

【灸法】 同涌泉。

阴 谷

【位置】 在腘横纹内侧端，与委中相平，当半腱肌腱与半膜肌腱之间，屈膝取穴。

【类别】 足少阴之合穴。

【功能】 调补肝肾，滋阴清热，利尿消胀，调经。实验研究提示：能引起膀胱收缩，有利尿作用，能抑制肠液分泌。

【主治】 遗精，阳痿，疝气，崩漏，赤白带下，小便不利，阴囊湿疹，膝关节痛，膝股内侧痛，癫狂。

【灸法】 同涌泉。

俞 府

【位置】 在锁骨下缘，前正中线旁开 2 寸处。

【功能】 宣肺平喘，宽胸理气，降逆化痰，有调整心率的作用。

【主治】 咳嗽气喘，胸胁胀痛，呃逆呕吐，房颤，肋间神经痛。

【灸法】 同涌泉。

9. 手厥阴心包经腧穴(左右各 9 穴，见图 24，选 7 穴)

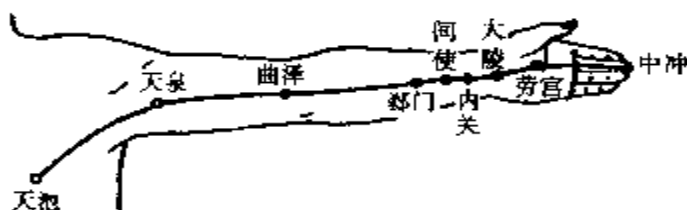


图 24 手厥阴心包经腧穴图

曲 泽

【位置】 在肘横纹肱二头肌腱尺侧缘，仰掌微屈肘取穴。

【类别】 手厥阴之合穴。

【功能】 泄热宁心，降逆镇惊，疏经活络。实验研究提示：能保护心肌，有加速急性缺血性心肌损伤的恢复和抑制损伤发展的作用。

【主治】 胃痛呕逆，热病烦渴，心痛心悸，肘臂痛，手臂震颤。临床常用于治疗风湿性心脏病、心肌炎、急性胃肠炎、中暑、血栓性静脉炎、肘窝囊肿、面紫暗、风疹、疥癣。

【灸法】 艾条灸 5~10 分钟。

郄 门

【位置】 在腕横纹直上 5 寸，曲泽与大陵的连线上，当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间凹陷处。

【类别】 手厥阴之郄穴。

【功能】 宁心安神,调和气血,疏经通络,止血。实验研究提示:能调整肺、心功能,使冠心病、心绞痛的心率减慢,增强心肌收缩力,促进心肌的恢复,改善心电图。

【主治】 心悸心痛,鼻出血,咯血,呕血,疔疮,痔疮,癰疾,前臂痛。临床常用于治疗风湿性心脏病、心绞痛、心肌炎、心动过速、胸膜炎、膈肌痉挛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 10~15 分钟。

间 使

【位置】 在腕横纹正中直上 3 寸,当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间凹陷处。

【类别】 手厥阴之经穴。

【功能】 清心宽胸,开郁除烦,安神,治疟,疏经活络。实验研究提示:对冠心病有增强心肌收缩力,减慢心率,改善心电图,使左心室舒张期终末压降低,有镇痛作用。

【主治】 心痛心悸,胃痛呕吐,热病烦躁,疟疾,癫狂,痫证,臂痛,腋肿肘挛。临床常用于治疗风湿性心脏病、心绞痛、心肌梗死、单纯性甲状腺肿、乳腺增生、精神分裂症。

【灸法】 同郄门。

内 关

【位置】 在腕横纹正中直上 2 寸,当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间凹陷处。

【类别】 手厥阴之络穴,别走少阳,八脉交会穴之一,通于阴维。

【功能】 宁心安神,和胃止痛,降逆止呕,疏经活络。实验研究提示:对心功能有明显调节作用,改善心律、心率、心肌收缩力、心肌代偿功能;对急性心肌缺血性损伤有明显的治疗作

用,增加冠状动脉血流量;改善血糖和血脂;抑制胃酸分泌,调整肠蠕动;改善呼吸功能;增强免疫力;对内脏有镇痛作用。

【主治】 心痛眩晕,心悸怔忡,胃痛胁痛,胸闷气短,呕吐呃逆,热病,中暑,中风偏瘫,疟疾,癫狂,痫证,肘臂挛痛,手麻。临床常用于治疗冠心病、心绞痛、心肌梗死、心律失常、高血压、休克、风湿性心脏病、无脉症、脑动脉硬化、头痛、失眠、神经衰弱、胃肠炎、妊娠恶阻、瘧病、醉酒、肋间神经痛、正中神经损伤、冻疮、晕车船。

【灸法】 同郄门。

大 陵

【位置】 在腕横纹中央,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间凹陷中。

【类别】 手厥阴之输穴、原穴。

【功能】 清心宁神,泄热止痛,理气和胃,疏经活络。实验研究提示:能改善心功能,加强心肌收缩力。对部分癫痫大发作患者,可使其脑电图趋向规则化。

【主治】 心痛心悸,胃痛呕吐,胸胁痛,烦躁失眠,热病,中暑,喉痹,癫狂,癫痫,疥癣,天疱疮,手皲裂。临床常用于治疗胃炎、心肌炎、肋间神经痛、腕管综合征。

【灸法】 同郄门。

劳 宫

【位置】 仰掌,在掌心横纹第二、三掌骨之间,屈指握拳时当中指端下是穴(见图 25)。

【类别】 手厥阴之荥穴。

【功能】 清心安神,泄热开窍。

【主治】 心痛,中暑,热病烦躁,中风昏迷,胃痛,呕吐,癫狂,癫痫,口臭,口疮,鹅掌风,冻疮。

【灸法】 同郄门。

中 冲

【位置】 手中指尖端之中央,距指甲 0.1 寸处。

【类别】 手厥阴之井穴。

【功能】 清热开窍,宁心安神。



图 25 劳宫简便取穴图

【主治】 热病,中暑,晕厥,中风昏迷,舌强不语,小儿惊厥,心痛,心胸烦闷,急性胃肠炎,小儿夜啼。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 5~10 分钟。

10. 手少阳三焦经腧穴(左右共 23 穴,见图 26,选 9 穴)

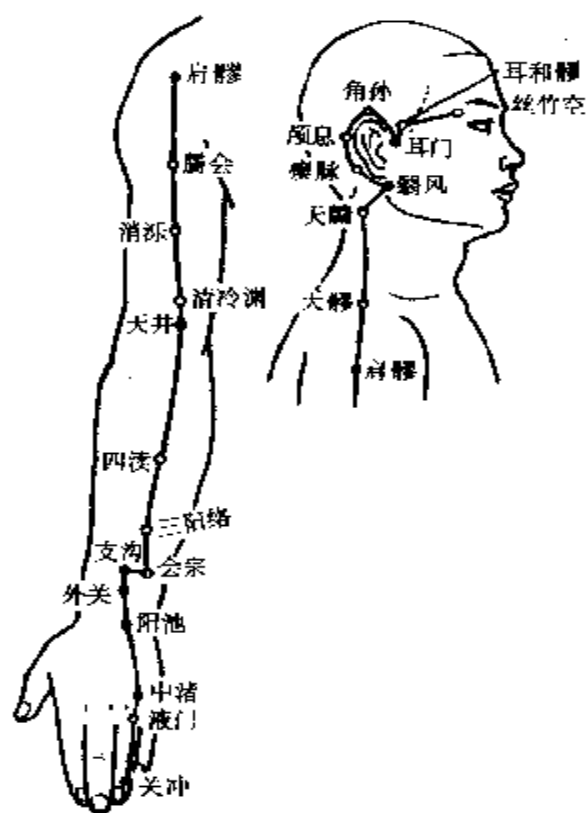


图 26 手少阳三焦经腧穴图

关 冲

【位置】 在无名指尺侧，距指甲角 0.1 寸处。

【类别】 手少阳之井穴。

【功能】 疏风泄热，醒神开窍，利喉舌。

【主治】 头痛目赤，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，舌强，热病心烦，中暑，中风昏迷，小儿惊厥。临床常用于治疗急性扁桃体炎、喉炎、结膜炎。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

中 渚

【位置】 在手背第四、五掌骨小头后缘之间的凹陷中，当腋门穴上 1 寸，握拳取穴。

【类别】 手少阳之输穴。

【功能】 散风清热，疏经通络，开窍聪耳。

【主治】 头痛目眩，目赤肿痛，耳鸣耳聋，咽喉肿痛，肘臂痛，手指麻木，热病。临床常用于治疗中耳炎、急性结膜炎、眶上神经痛、甲状腺肿大、肋间神经痛、手部冻疮。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

阳 池

【位置】 在腕背横纹上，当指总伸肌腱与小指伸肌腱之间凹陷中。

【类别】 手少阳之原穴。

【功能】 散风清热，舒筋活络，调三焦原气。实验研究提示：能促进肠蠕动。

【主治】 腕痛无力，肩背痛，目赤肿痛，耳聋，热病无汗，消渴，疟疾。临床常用于治疗感冒、扁桃体炎、荨麻疹、腕背腱鞘囊肿。

【灸法】 同中渚。

外 关

【位置】 在腕背横纹正中直上 2 寸，当尺、桡骨之间，指伸肌桡侧凹陷中。

【类别】 手少阳之络穴，别走少阴，八脉交会穴之一，通于阳维。

【功能】 清热解毒，散风解表，通经活络，利胁镇痛。

【主治】 热病头痛，目赤肿痛，齿痛颊肿，耳鸣耳聋，胁肋痛，肘臂屈伸不利，手指痛，手颤。临床常用于治疗感冒、肺炎、急性结膜炎、中耳炎、腮腺炎、遗尿、腕下垂、神经性皮炎、手癣、冻疮、近视。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 5~10 分钟。

支 沟

【位置】 在腕背横纹直上 3 寸，当尺、桡骨之间凹陷处。

【类别】 手少阳之经穴。

【功能】 清三焦，和少阳，疏经络，利胸胁，通腑气。实验研究提示：使孕子宫收缩增强，对胸腔手术有镇痛作用。

【主治】 热病无汗，口噤，暴暗，目赤肿痛，耳鸣耳聋，呕吐便秘，胁肋痛，肩臂酸重。临床常用于治疗胸膜炎、心绞痛、肋间神经痛、急性胆囊炎、带状疱疹、产后乳少。

【灸法】 同外关。

天 井

【位置】 在尺骨鹰嘴上 1 寸处，屈肘时当肘尖上 1 寸取之。

【类别】 手少阳之合穴。

【功能】 疏风清热，通络散结，宁神。

【主治】 咽痛，偏头痛，颈项痛，胁肋痛，肩臂痛，瘰癧，瘰癧，瘰癧。临床常用于治疗荨麻疹、神经性皮炎、颈淋巴结核。

【灸法】 同外关。

肩 髃

【位置】 在肩峰突起后端之下方,取穴时,上臂外展平举,当肩髃穴后约1寸凹陷中。

【功能】 祛风湿,通经络。

【主治】 肩痛,臂垂不能举,肩关节周围炎,中风上肢瘫痪。

【灸法】 艾炷灸3~5壮,艾条灸5~10分钟。

翳 风

【位置】 耳垂后耳根部,颞骨乳突与下颌角之间,张口取穴。

【类别】 手、足少阳之会。

【功能】 疏风泄热,聪耳通窍,活络利颊,正口僻。实验研究提示:能调整大脑皮质功能。

【主治】 耳鸣耳聋,口眼喎斜,牙关紧闭,齿痛颊肿,瘰癧。临床常用于治疗面神经麻痹、聋哑、腮腺炎、颞颌关节痛、风疹、神经性皮炎、瘙痒症、脱发。

【灸法】 同肩髃。

耳 门

【位置】 耳屏上切迹前方,颞颌关节之间凹中,张口取穴。

【功能】 疏风清热,聪耳开窍,利牙关。实验研究提示:使动物凝血时间明显缩短,对链霉素性耳聋有显著疗效。

【主治】 耳鸣耳聋,聤耳,眩晕,齿痛。临床常用于治疗中耳炎、梅尼埃病、颞颌关节功能紊乱症、外耳湿疹、耳道疖肿、面瘫。

【灸法】 艾炷灸1~3壮,艾条灸5~10分钟。

11. 足少阳胆经腧穴(左右各 44 穴, 见图 27, 选 19 穴)

瞳子髎

【位置】目外眦外侧 0.5 寸, 当眶骨外侧缘凹陷处。

【类别】手太阳、手足少阳之会。

【功能】疏风泄热, 明目止痛。

【主治】头痛, 目赤肿痛, 迎风流泪, 畏光羞明, 目翳, 视力减退, 口眼喎斜, 鱼尾纹多。临床常用于治疗角膜炎、视网膜炎、视神经萎缩、近视、夜盲、角膜白斑、面瘫、面肌痉挛、三叉神经痛。

【灸法】艾条灸 3~5 分钟。

听会

【位置】在耳屏间切迹前, 听宫直下, 下颌骨髁状突后缘, 张口取穴。

【功能】聪耳开窍, 祛风通络, 安神, 利牙关。

【主治】耳鸣耳聋, 头痛, 面痛, 齿痛, 腮肿, 下颌骨脱臼。临床常用于治疗聋哑、中耳炎、面神经麻痹、三叉神经痛、梅尼

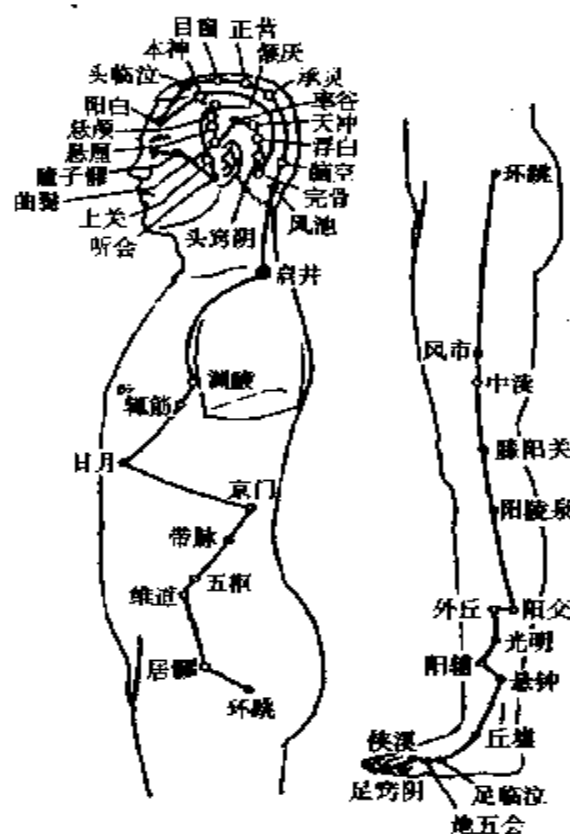


图 27 足少阳胆经腧穴图

埃病、颞颌关节功能紊乱综合征。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

率 谷

【位置】 在颞部，耳尖直上入发际 1.5 寸处。

【类别】 足少阳、太阳之会。

【功能】 祛风清热，镇惊除烦，熄风止痉，和胃止痛，疏经活络。

【主治】 偏头痛，眩晕，烦满呕吐，小儿急、慢惊风，腮腺炎，头癣，斑秃，脱发。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 3~5 分钟。

阳 白

【位置】 眼平视，眉毛中央直上 1 寸，直对瞳孔处。

【类别】 足少阳、阳维之会（一说手足阳明、少阳、阳维之会）。

【功能】 祛风泄热，清头明目，通经活络。

【主治】 前额痛，目赤肿痛，迎风流泪，外眦疼痛，眼睑瞤动，夜盲。临床常用于治疗面瘫、眶上神经痛、三叉神经痛、眼睑下垂、黄褐斑、额纹增多。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

头 临 泣

【位置】 眼平视，瞳孔直上入发际 0.5 寸处，当神庭与头维连线的中点处。

【类别】 足少阳、太阳、阳维之会。

【功能】 祛风泄热，醒神明目，宣通鼻窍。

【主治】 头痛目眩，目赤肿痛，迎风流泪，外眦疼痛，目翳，鼻渊鼻塞，近视，小儿惊风，癫痫。

【灸法】 同阳白。

风 池

【位置】 在项后枕骨下两侧，翳风与风府之间，当胸锁乳突肌后缘与斜方肌外缘间的凹陷处。

【类别】 足少阳、阳维之会。

【功能】 清热解表，醒脑开窍，聪耳明目，通经活络。实验研究提示：能调整胃液。

【主治】 热病无汗，头痛，眩晕，鼻渊，鼻出血，目赤肿痛，迎风流泪，耳鸣耳聋，失眠健忘，中风瘫痪，落枕，颈项强痛，肩背痛。临床常用于治疗感冒发热、高血压、脑震荡、风疹、荨麻疹、瘙痒症、急性结膜炎、电光性眼炎、视网膜动脉阻塞、青光眼、内分泌突眼症、近视、面肌痉挛、神经性皮炎、疥癣、痤疮、脱发。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮；艾条灸 5~10 分钟。

肩 井

【位置】 在大椎与肩峰连线之中点处，肩峰最高处取之。

【类别】 手少阳、足少阳、足阳明、阳维之会。

【功能】 疏风通络，理气降逆，催产下乳，利肩臂。

【主治】 颈项强痛，肩背疼痛，手臂不举，胸闷，嗜睡，神疲乏力，痰壅咳逆，反胃，乳痈，肠痈，瘰癧，落枕，中风偏瘫，难产，产后血晕，乳汁不下。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

日 月

【位置】 锁骨中线乳头下方第七、八肋间隙。

【类别】 足太阴、少阳、阳维之会，胆之募穴。

【功能】 疏肝利胆，降逆和中，调理胃肠。实验研究提示：促进胆汁分泌，收缩胆囊，利胆排石。

【主治】 肋肋疼痛，腹胀，呕吐吞酸，黄疸，呃逆。临床常

用于治疗阻塞性黄疸、胆囊炎、胆石症、肝炎、肋间神经痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

带 脉

【位置】 腋中线直下，与脐相平处，侧卧取穴。

【类别】 足少阳、带脉之会。

【功能】 调经止带，泻湿热，调带脉，利腰腹。

【主治】 月经不调，经闭腹痛，赤白带下，阴挺，疝气，少腹痛，腰肋痛。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

环 跳

【位置】 股骨大转子最高点与骶管裂孔连线的外 1/3 折点处，或于髂后上棘、坐骨结节与股骨大转子所连成之三角形之中央处定穴。常用两种取穴方法：①侧卧伸小腿，屈大腿成 90°，以拇指关节横纹压在大转子上，指尖指向脊椎，拇指尖到达处是穴；②侧卧或俯卧，尾骨尖上 2 寸（骶骨裂孔）与股骨大转子连线的中外 1/3 交界处。

【类别】 足少阳、太阳之会。

【功能】 祛风湿，散风寒，通经络，利腰腿。实验研究提示：能调整胃液分泌及甲状腺功能，有抗炎退热作用，有针麻效应，使痛阈明显提高。

【主治】 腰胯疼痛，风寒湿痹，下肢痿痹，半身不遂，挫闪腰痛，膝不得伸，风疹，脚气，水肿，痔疮，带下，膝踝肿痛。临床常用于治疗坐骨神经痛、下肢痉挛、下肢瘫痪、臀部软组织疾病。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~20 分钟。

风 市

【位置】 在大腿外侧正中线上，膕横纹上 7 寸处。取穴

时，直立垂手，中指尖所到处是穴。

【功能】 调气血，通经络，祛风湿，强筋骨，利腿足。

【主治】 腰腿麻木，疼痛，下肢痿痹，中风，半身不遂，遍身瘙痒。临床常用于治疗坐骨神经痛、股外侧皮神经炎、下肢瘫痪、风疹、荨麻疹、湿疹、脚气。

【灸法】 同环跳。

膝 阳 关

【位置】 在阳陵泉上 3 寸处，屈膝取穴，当股骨外上髁后髂胫束与股二头肌腱之间凹陷中。

【功能】 舒筋脉，祛风湿，利关节。

【主治】 膝髌肿痛，腓筋挛急，小腿麻木。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

阳 陵 泉

【位置】 屈膝在小腿外侧腓骨小头前下方凹陷中。

【类别】 足少阳之合穴，八会穴之筋会。

【功能】 疏泄肝胆，清利湿热，舒筋活络，强筋壮骨。实验研究提示：能使胆总管有规律地收缩，胆囊收缩，促进胆汁分泌，增加脑血流量。

【主治】 胁肋痛，口苦，呕吐，黄疸，膝肿痛，下肢痿痹，半身不遂，脚气，小儿惊风，癫痫，破伤风。临床常用于治疗胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、肝炎、高血压、习惯性便秘、耳鸣耳聋、带状疱疹、肋间神经痛、下肢动静脉炎、落枕、肩周炎、膝关节疼、踝关节扭伤、坐骨神经痛、下肢瘫痪、足内翻。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

光 明

【位置】 在小腿外侧，外踝上 5 寸处，当腓骨前缘凹陷中。

【类别】 足少阳之络，别走厥阴。

【功能】 清肝明目，祛风通络。实验研究提示：能改变屈光度，提高视力。

【主治】 膝痛胫酸，下肢痿痹，目赤痛，视物不清，乳痈胀痛。临床常用于治疗夜盲、视神经萎缩、白内障、青少年近视、偏头痛、腓肠肌痉挛。

【灸法】 同阳陵泉。

悬 钟

【位置】 在小腿外侧面，外踝尖上 3 寸，腓骨后缘。

【类别】 八会穴之髓会。

【功能】 补益精髓，疏肝理气，舒筋活络，祛风止痛，清热通便。

【主治】 膝腿痛，半身不遂，颈项强痛，胸腹胀满，肋肋疼痛，便秘，脚气。临床常用于治疗落枕、偏头痛、淋巴结结核、肋间神经痛、足内翻。

【灸法】 同阳陵泉。

丘 墟

【位置】 在外踝之前下方，当趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

【类别】 足少阳之原穴。

【功能】 清热明目，疏肝利胆，舒筋络，利胸胁。实验研究提示：使胆囊收缩，明显增强胆总管规律性收缩，促使胆汁分泌。

【主治】 头痛目眩，胸胁满痛，噎膈吐酸，下肢痿痹，外踝肿痛，足跟痛，转筋，疟疾，疝气，目赤肿痛，目翳。临床常用于治疗胆囊炎、胆石症、高血压、肋间神经痛、腋窝淋巴结炎、踝关节扭伤、足内翻。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

足临泣

【位置】 第四、五跖骨结合部的前方，当小趾伸肌腱外侧，距第四、五趾缝端上 1.5 寸处。

【类别】 足少阳之输穴，八脉交会穴之一，通于带脉。

【功能】 清头明目，疏泄肝胆，祛风泻火，理气宽胸，活络散结。实验研究提示：能使肠鸣亢进。

【主治】 头痛目眩，目赤肿痛，胁肋痛，乳痈胀痛，遗溺，月经不调，足跗肿痛，足趾挛痛，瘰癧，疟疾。临床常用于治疗结膜炎、乳腺炎、乳腺增生、肋间神经痛、带状疱疹、颈淋巴结结核、湿疹、脚气、退乳。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮，艾条灸 5~10 分钟。

侠溪

【位置】 第四、五趾缝间，当趾蹼缘上 0.5 寸处。

【类别】 足少阳之荥穴。

【功能】 清热熄风，启闭开窍，清头目，利胸胁，疏通经络。实验研究提示：使胆汁分泌明显增加。

【主治】 偏头痛，颊颌痛，胸胁痛，乳痈肿痛，膝骨酸痛，足跗肿痛，足趾挛痛，足趾麻木，肋间神经痛，热病，眩晕，耳鸣，耳聋。

【灸法】 同足临泣。

足窍阴

【位置】 在足第四趾外侧，趾甲角 0.1 寸处。

【类别】 足少阳之井穴。

【功能】 清头明目，清热熄风，启闭开窍，疏肝清胆，理气利胁。实验研究提示：可使主观色觉改变，眼底视网膜颞侧反光增强。

【主治】 偏头痛，目眩，目赤肿痛，胸胁痛，耳鸣耳聋，咽

喉肿痛,高血压,肋间神经痛,热病,失眠多梦,呃逆,月经不调,足跗肿痛。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

12. 足厥阴肝经腧穴(左右各 14 穴,见图 28,选 8 穴)

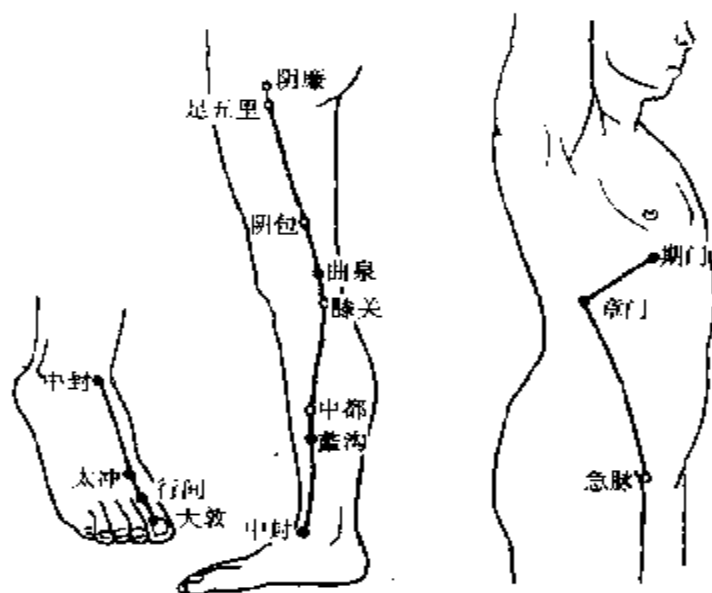


图 28 足厥阴肝经腧穴图

大 敦

【位置】 在足拇趾外侧,距趾甲角 0.1 寸处。

【类别】 足厥阴之井穴。

【功能】 疏肝理气,调血解痉,清热醒脑。实验研究提示:能调整大肠运动,可加强神门的降压效应。

【主治】 昏厥,阴挺,阴肿痛,月经不调,崩漏,小便失禁,遗尿,癃闭,淋证,疝痛缩阴,便秘,癫狂痫。临床常用于治疗子宫脱垂、功能性子宫出血、腹股沟斜疝、阴囊鞘膜积液、精索静脉曲张、附睾睾丸炎、滞产。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~15 分钟。

行 间

【位置】 足背第一、二趾蹼缘后方，约当趾跖关节至趾蹼缘之中点处。

【类别】 足厥阴之荣穴。

【功能】 疏风清热，清肝明目，镇惊熄风。

【主治】 月经过多，痛经，闭经，带下，阴中痛，小便不通，尿道疼痛，淋证，遗尿，疝气，口眼喎斜，目赤肿痛，头痛目眩，胸胁满痛，呃逆，咳嗽，痫症抽搐，失眠。临床常用于治疗结膜炎、青光眼、扁扁桃体炎、面肌痉挛、高血压、视力减退、肋间神经痛、神经性头痛、功能性子宫出血、乳腺增生、睾丸炎、前阴瘙痒疼痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

太 冲

【位置】 足背第一、二趾间上 1.5 寸处，当第一、二跖骨结合部前方凹陷中。

【类别】 足厥阴之输穴、原穴。

【功能】 清热明目，舒肝利胆，镇惊熄风，通络活血。实验研究提示：能降血压，调整嗜酸性白细胞。

【主治】 头痛眩晕，目赤肿痛，失眠，胸胁胀痛，腹胀，呃逆，黄疸，口眼喎斜，小便不通，遗溺，崩漏，疝气，小儿惊风，痫证，内踝前缘痛。临床常用于治疗肝炎、高血压、神经衰弱、肋间神经痛、血小板减少、胆囊炎、中风昏迷、面肌痉挛、手指震颤、月经不调、闭经、功能性子宫出血、乳腺炎、乳腺增生、滞产、结膜炎、视力减退、青光眼、近视、癩病、前阴瘙痒疼痛、面部黄褐斑。

【灸法】 同行间。

中 封

【位置】 足内踝下缘前 1 寸，当胫骨前肌腱内侧缘凹陷处，在解溪与商丘之间。

【类别】 足厥阴之经穴。

【功能】 疏肝泄胆，清利下焦，通经活络。

【主治】 黄疸，小便不利，脐腹痛，疝痛，阴部痛，足痛，遗精。现在临床常用于治疗肝炎、胆囊炎、膀胱炎。

【灸法】 同行间。

蠡 沟

【位置】 内踝尖直上 5 寸，当胫骨后缘凹陷处。

【类别】 足厥阴之络穴，别走少阳。

【功能】 疏泄肝胆，调经利湿。

【主治】 小便不利，遗尿，小腹胀痛，疝气，月经不调，崩漏，赤白带下，阴挺，阴痒，丹毒，臃疮，小腿酸痛。现在临床常用于治疗肝炎、湿疹、睾丸炎、子宫内膜炎、阴部瘙痒疼痛、性功能亢进。

【灸法】 同行间。

曲 泉

【位置】 膝股内侧，屈膝腠横纹内侧端上方凹陷处，当股骨内上髁与半腱肌肌腱之间。

【类别】 足厥阴之合穴。

【功能】 清肝火，利湿热，调气血，舒筋脉，通水道。

【主治】 小腹痛，小便不利，遗尿，尿闭，遗精，月经不调，痛经，赤白带下，阴痒，阴挺，产后腹痛，疝气，头痛，目眩，膝痛，下肢痿痹。现在临床常用于治疗高血压、肾炎、前列腺炎、子宫脱垂、阴道炎。

【灸法】 同行间。

章 门

【位置】 胁部第十一浮肋游离端前缘下，当上肢合腋屈肘时肘尖所止处是穴。

【类别】 足厥阴、少阳之会，脾之募穴，八会穴之脏会。

【功能】 疏泄肝胆，健脾和胃，活血化瘀。

【主治】 积聚痞块，腹胀肠鸣，胃脘痛，呕吐泄泻，完谷不化，黄疸，痞积，腰背痛不能转侧，肋肋疼痛。现在临床常用于治疗肝炎、肝脾肿大、胆石症、消化不良、呃逆、肠炎。

【灸法】 同行间。

期 门

【位置】 锁骨中线的第六肋间隙中，或脐上 6 寸（巨阙）旁开 3.5 寸于第六肋间隙内端处。

【类别】 足厥阴、太阴、阴维之会，肝之募穴。

【功能】 疏肝理气，健脾和胃。

【主治】 胁肋、胸腹胀满疼痛，胁下积聚，呕吐呃逆，吐酸。现在临床常用于治疗肝区胀痛、肝脾肿大、肝炎、胆囊炎、胆石症、胸膜炎、肋间神经痛、膈肌痉挛、胃神经官能症、消化不良、消瘦、乳腺炎、乳腺增生、湿疹、面部黄褐斑。

【灸法】 同行间。

13. 任脉（共 24 穴，见图 29，选 14 穴）

会 阴

【位置】 会阴部正中，男性当肛门与阴囊根部连线之中点；女性当肛门与大阴唇后联合连线之中点。

【类别】 任脉别络，挟督脉、冲脉之会。

【功能】 苏厥回阳，通利下焦，提肛。

【主治】 阴痒，阴挺，阴囊肿痛，脱肛，痔疮，小便不通，遗尿，遗精，阳痿，不射精，月经不调，闭经，昏迷，癫狂，先天性腰

骶椎裂引起的排尿困难。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

中 极

【位置】 前正中线脐下 4 寸处，当耻骨联合上缘上 1 寸取之。

【类别】 任脉、足三阴之会，膀胱之募穴。

【功能】 补肾培元，助阳固精，理气利尿，清利湿热，调经止

带。实验研究提示：对神经系统疾病伴有膀胱功能障碍者有调整作用，对垂体-性腺功能有影响，促排卵。

【主治】 阳痿，遗精，早泄，遗尿，小便频数，尿闭，小腹痛，水肿，月经不调，痛经，崩漏，赤白带下，阴挺，不孕，产后胞衣不下，恶露不尽，阴囊湿疹，阴部痛，外阴、肛门瘙痒。现在临床常用于治疗尿路感染、肾炎、尿潴留、痛经、产后宫缩痛、男性性功能障碍。

【灸法】 同会阴。

关 元

【位置】 前正中线脐下 3 寸处。

【类别】 任脉、足三阴之会，小肠之募穴。

【功能】 温肾益精，培元固本，益气回阳，调理冲任，理气除寒，清热利湿，通利下焦。实验研究提示：能调整膀胱张力，

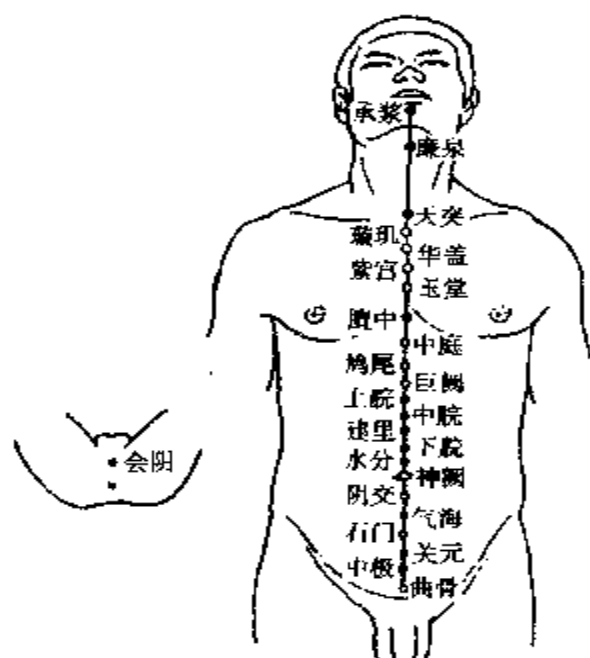


图 29 任脉腧穴图

促进垂体-性腺功能,提高肿瘤患者的免疫力。本穴有强壮作用,为保健要穴。

【主治】 虚劳羸弱,中风脱证,消渴,腹痛腹泻,痢疾,阳痿,遗精,早泄,小便不利,尿频,遗尿,尿道痛,尿血,便血,月经不调,痛经,闭经,崩漏,赤白带下,产后恶露不止,不孕,疝痛。现在临床常用于治疗休克早期、呃逆、反胃、尿路感染、肾炎、尿潴留、乳糜尿、痢疾、肠道蛔虫症、衰老、精子缺乏症、不射精、消瘦、面色无华、脱肛、子宫脱垂、功能性子宫出血、盆腔炎、肥胖症、脱发。

【灸法】 艾炷灸 7~10 壮,艾条灸 15~30 分钟。

气 海

【位置】 在前正中线脐下 1.5 寸处。

【类别】 育之原。

【功能】 补肾固精,升阳益气,补虚固本,调理冲任。实验研究提示:能提高免疫力,调整肾、肠功能。本穴有强壮作用,为保健要穴。

【主治】 虚劳羸弱,中风脱证,小腹痛,水肿,鼓胀,脘腹胀痛,泄痢,便秘,脱肛,遗精,阳痿,遗尿,尿闭,淋证,疝气,月经不调,痛经,闭经,崩漏,带下,产后胞衣不下,恶露不尽。现在临床常用于治疗神经衰弱、精子缺乏症、功能性子宫出血、尿潴留、肠麻痹、胃下垂、呃逆、衰老、子宫脱垂、不孕症、肥胖症、脱发。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~20 分钟。

神 阙

【位置】 当脐窝正中处。

【功能】 培元固本,回阳救逆,健运脾胃,温中止泻。

【主治】 休克,中风脱证,四肢厥冷,肠鸣腹痛,痢疾,泄

泻，脱肛，水肿鼓胀，小便不利、失禁，淋证，便秘，不孕。现在临床常用于治疗急慢性胃肠炎、神经性呕吐、肠结核、肠粘连、消瘦、衰老、面色萎黄、荨麻疹、干燥综合征、晕动病、面部黄褐斑。

【灸法】 大艾炷隔盐(或姜、蒜及药饼)灸 5~15 壮，艾条灸 20~30 分钟。孕妇慎用。

水分

【位置】 前正中线脐上 1 寸处。

【功能】 健脾化湿，利水消肿，缓拘急。

【主治】 腹胀腹痛，肠鸣腹泻，反胃吐食，饮食不下，小便不通，水肿鼓胀。现在临床常用于治疗胃炎、肾炎。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。孕妇不可灸。

下脘

【位置】 前正中线脐上 2 寸处。

【类别】 任脉、足太阴之会。

【功能】 温胃散寒，理气散结，消积化滞。实验研究提示：可提高免疫力，促进胃、十二指肠溃疡愈合，调整肠功能。

【主治】 脘腹胀痛，呕吐，呃逆，消化不良，痢疾，泄泻，完谷不化。现在临床常用于治疗胃炎、消化性溃疡、胃扩张、胃痉挛、胃下垂、胃扭转、贲门痉挛、食管癌、急性胰腺炎。

【灸法】 同水分。

建里

【位置】 前正中线脐上 3 寸处。

【功能】 健脾胃，助消化，化积滞。

【主治】 胃痛呕吐，腹胀肠鸣，饮食不化，泄泻，水肿。现在常用于治疗慢性胃炎、消化性溃疡。

【灸法】 同水分。

中 脘

【位置】 前正中线脐上 4 寸处。

【类别】 任脉、手太阳、少阳、足阳明之会，胃之募穴，八会穴之腑会。

【功能】 健脾化湿，和胃降逆，理气消滞，止痛。实验研究提示：能调整胃肠功能，增加肺通气量，提高免疫功能。

【主治】 脾胃虚弱，胃痛腹胀，饮食不化，呕吐，呃逆，反胃，肠鸣，腹泻，痢疾，痞积，鼓胀，便秘，便血，虚劳吐血，黄疸。现在临床常用于治疗急性胃炎、慢性胃炎、消化性溃疡、胃下垂、胃扭转、肠梗阻、消化不良、急性胰腺炎、失眠、神经衰弱、肝炎、早期肝硬化、食管癌、消瘦、慢惊风、荨麻疹、肥胖症。

【灸法】 同水分。

上 脘

【位置】 前正中线脐上 5 寸处。

【类别】 任脉、足阳明、手太阳之会。

【功能】 健脾和胃，调中降逆，理气化湿，宁神定志。实验研究提示：对胃酸分泌有调整作用，促进胃、十二指肠溃疡愈合。

【主治】 胃脘胀痛，腹胀呕吐，呃逆反胃，饮食不化，腹泻，痢疾，黄疸，痞症。现在临床常用于治疗胃炎、消化性溃疡、胃扩张、胃痉挛、胃下垂、贲门痉挛、急性胰腺炎、食管癌。

【灸法】 同水分。

膻 中

【位置】 两乳头连线之中点，即前正中线平第四肋间隙处。

【类别】 任脉、足太阴、少阴、手太阳、少阳之会，八会穴

之气会，心包之募穴。

【功能】理气活血，宽胸利膈，宁心安神，健胸丰乳，催乳。实验研究提示：能调整心功能。

【主治】胸痛，心痛，胸闷，咳嗽，气喘，咯吐脓血，心悸，呃逆，噎膈，缺乳。现在临床常用于治疗支气管炎、胸膜炎、冠心病、心绞痛、心律失常、乳腺炎、乳腺增生、食管炎、食管痉挛、梅核气、肋间神经痛、肺癆。

【灸法】艾炷灸3~5壮，艾条灸5~10分钟。

天 突

【位置】胸骨上窝正中，即前正中线，胸骨切迹上缘上0.5寸凹陷处。

【类别】任脉、阴维之会。

【功能】宣肺平喘，化痰利咽，理气宽胸，利气降逆。实验研究提示：对外周性呼吸衰竭有显效，对甲状腺功能亢进、地方性甲状腺肿、支气管哮喘有效，使食管蠕动增加、内径增宽，可调整免疫细胞功能。

【主治】咳嗽气喘，失声，噎膈，咽喉肿痛，梅核气，瘰气。现在临床常用于治疗咽喉炎、支气管炎、支气管哮喘、百日咳、食管炎、食管痉挛、食管癌、声带疾病、膈肌痉挛、神经性呕吐、单纯性甲状腺肿。

【灸法】同膻中。

廉 泉

【位置】前正中线喉结上方，当舌骨体下缘凹陷处，仰头取穴。

【类别】任脉、阴维之会。

【功能】清痰热，利喉舌，开窍。实验研究提示：对甲状腺功能有良好的调节作用。

【主治】 舌下肿痛，中风舌强不语，舌缓流涎，舌根挛缩，吞咽困难，口舌生疮，咳嗽，失声。现在临床常用于治疗咽喉炎、扁桃体炎、支气管炎、急性腮腺炎、舌肌麻痹、声门肌痉挛、声带疾病、软腭麻痹、梅核气、聋哑、瘰病。

【灸法】 同膻中。

承 浆

【位置】 在颏唇沟正中凹陷处。

【类别】 任脉、足阳明之会，（一说任、督脉，手足阳明之会）。

【功能】 祛风通络，消肿镇痛，疏调任督，利口齿。实验研究提示：可提高痛阈，有良好镇痛作用。

【主治】 面肿，齿龈肿痛，齿痛，口噤，面瘫，流涎，消渴，口疮，口唇部疾病，口唇皸裂，癫狂。

【灸法】 同膻中。

14. 督脉（共 28 穴，见图 30，选 13 穴）

长 强

【位置】 跪伏，在尾骨端下 0.5 寸，约当肛门与尾骨尖端间之中点处。

【类别】 督脉之络穴，别走任脉，足少阴肾经之所结，督脉、足少阴、少阳之会。

【功能】 温补下焦，提肛固脱，清热利湿，镇痉熄风。实验研究提示：对隐性骶椎裂引起排便困难者有效。

【主治】 便秘，痔疮，脱肛，泄泻，痢疾，便血，遗精，阳痿，癯淋，惊风，癫狂，痫证，腰脊痛。现在，临床常用于治疗癫痫、遗尿、肛裂、破伤风、尾骨痛、阴囊湿疹、阴痒、肛门瘙痒、前列腺炎、精神分裂症、引产。

【灸法】 艾炷灸 5~10 壮，艾条灸 5~10 分钟。

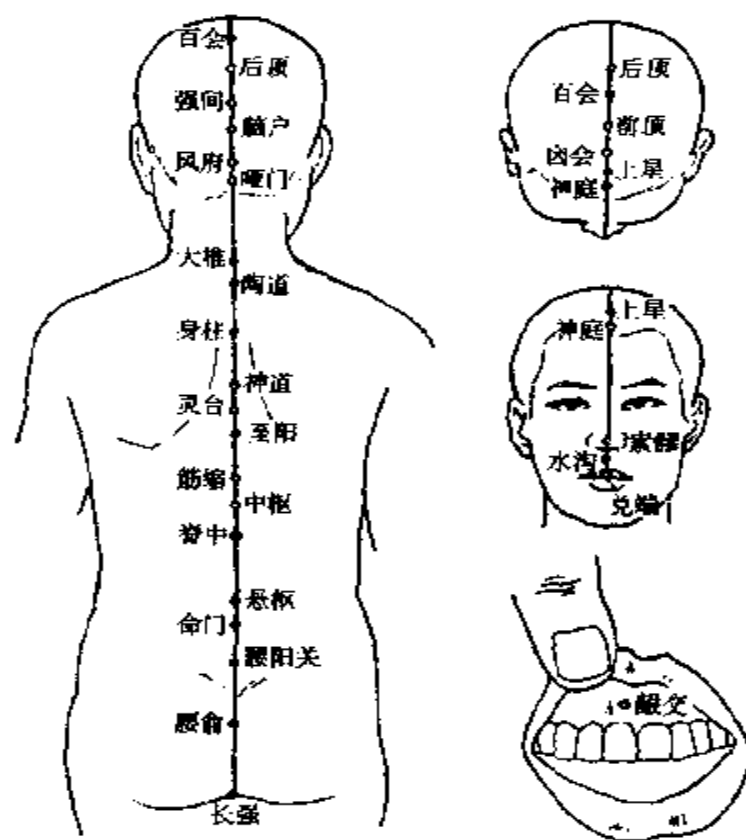


图 30 督脉腧穴图
腰 俞

【位置】 第四骶椎棘突下，骶管裂孔中。

【功能】 祛风湿，强腰膝，理气止泻。

【主治】 腰脊强痛，下肢痿痹，腰椎间盘突出症，泄泻，痢疾，便秘，月经不调，闭经，遗尿，淋浊，脱肛，痔疮，便血，痢证，肛门瘙痒。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~10 分钟。

腰 阳 关

【位置】 第四腰椎棘突下凹陷处。

【功能】 温肾阳，益下元，通经络，强腰膝，祛寒湿。

【主治】 腰骶痛，下肢痿痹，遗精阳痿，月经不调，闭经，带下，淋浊，痔疮。现在，临床常用于治疗小腹痛、慢性肠炎、盆腔炎、产后宫缩痛、前列腺炎、多发性神经炎、坐骨神经痛、腰椎肥大、腰椎间盘突出症、糖尿病、膀胱麻痹、尿崩症。

【灸法】 同腰俞。

命 门

【位置】 第二腰椎棘突下，约与第十一浮肋下端相平。

【功能】 补肾壮阳，强壮腰膝，固精止带，舒筋活络，清热理血。实验研究提示：对男性性功能障碍、精子缺乏症有效，增强抗病力，有较好的镇痛作用，对嗜酸性白细胞的作用同促肾上腺皮质激素(ACTH)。

【主治】 腰痛，耳鸣，头痛，神经衰弱，阳痿，遗精，早泄，泄泻，遗尿，脱肛，月经不调，痛经，赤白带下，腰脊强痛，膝冷乏力，下肢麻痹。现在，临床常用于治疗脊椎炎、腰椎肥大、截瘫、小儿麻痹后遗症、贫血、消渴、硬皮病、荨麻疹、盆腔炎、子宫内膜炎、不孕症、血栓闭塞性脉管炎、阴部湿疹、皮肤肿瘤。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

脊 中

【位置】 第十一胸椎棘突下凹陷处。

【功能】 益肾强脊，调理胃肠，健脾化湿。

【主治】 黄疸，泄泻，痢疾，痞证，痔疮，便血，脱肛，小儿疳积，腰脊强痛。现在，临床常用于治疗胃炎、消化性溃疡、胰腺炎、肝炎、胆道蛔虫症、肛门瘙痒。

【灸法】 同长强。

至 阳

【位置】 第七胸椎棘突下凹陷处，约与肩胛下角相平。

【功能】 清肝胆，除湿热，利胸膈，健脾胃，益气。实验研究提示：使食管蠕动减弱。

【主治】 胸胁痛，胃脘胀满，咳嗽气喘，腹痛，黄疸，身热，腰背痛，脊强。现在，临床常用于治疗心绞痛、心律失常、肝炎、胆囊炎、胆道蛔虫症、胸膜炎、胃痛、疟疾、肋间神经痛、疔疮、银屑病。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

身 柱

【位置】 第三胸椎棘突下凹陷处，约与肩胛冈内侧端相平，俯卧取穴。

【功能】 祛风泄热，宣肺止咳，清神定惊，止痛。

【主治】 身热，头痛，咳嗽，气喘，惊厥，癫狂，腰脊强痛，疔疮发背。现在，临床常用于治疗支气管炎、肺炎、肺结核、百日咳、精神分裂症、癔病、佝偻病、风湿性心脏病、银屑病、面部黄褐斑。

【灸法】 同至阳。

陶 道

【位置】 第一胸椎棘突下凹陷处，俯伏取穴。

【类别】 督脉、足太阳之会。

【功能】 宣肺解表，祛风退热，熄风止痉，镇惊安神。实验研究提示：可调整机体免疫功能。

【主治】 热病，头痛项强，咳嗽气喘，骨蒸盗汗，疟疾，脊背痛。现在临床常用于治疗肺结核、精神分裂症、湿疹、银屑病、痤疮、雀斑、黄褐斑。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

大 椎

【位置】 第七颈椎棘突下凹陷处，约与肩相平，俯伏取

穴。

【类别】 督脉、手足三阳之会(一说骨会)。

【功能】 解表通阳,清热解毒,清脑宁神,熄风止痉,肃肺宁心,益气补虚。实验研究提示:能调整肺、甲状腺、免疫功能及血循环,对白细胞也有调整作用。

【主治】 外感热病,头痛项强,胸胁胀痛,咳嗽气喘,骨蒸劳热,小儿惊风,疟疾,肩背、腰脊痛,痫证。现在临床常用于治疗感冒发热、百日咳、支气管炎、肺炎、肺结核、肺气肿、中暑、肝炎、黄疸、血液病、白细胞减少、脑炎、脑脊髓膜炎、咽炎、淋巴结炎、扁桃体炎、乳腺炎、乳腺增生、发际疮、疔疮、丹毒、静脉炎、风疹、荨麻疹、神经衰弱、神经分裂症、颈椎病、湿疹、银屑病、痤疮、面部黄褐斑。

【灸法】 同陶道。

百 会

【位置】 后发际正中直上7寸,当头顶正中线与两耳尖连线之交点处。

【类别】 督脉、足太阳之会(一说督脉、手足少阳、足太阳、足厥阴会于此)。

【功能】 清热苏厥,开窍宁神,升阳固脱,平肝熄风,醒脑明目。实验研究提示:能调整血压和免疫功能,有退热作用,能调整胃液分泌,能矫正胎位。

【主治】 头痛目眩,耳鸣耳聋,心悸健忘,中风失语,泄泻,痔疮,脱肛,阴挺,癫痫,头发早白,发际疮。现在临床常用于治疗高血压、低血压、休克、遗尿、神经衰弱、抑郁症、竞技综合征、眼睑下垂、舞蹈病、精神分裂症、鼻炎、鼻窦炎、脚气。

【灸法】 艾炷灸5~10壮,艾条灸10~15分钟。

上 星

【位置】 头部前正中线入发际 1 寸处。

【功能】 清肝明目,散风泄热,宣通鼻窍。

【主治】 前头痛,目眩,目赤肿痛,迎风流泪,鼻渊,鼻出血,小儿惊风,疟疾,热病。现在,临床常用于治疗鼻炎、角膜炎、发际疮、脂溢性脱发。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

神 庭

【位置】 头部前正中线直上入发际 0.5 寸处。

【类别】 督脉、足太阳、阳明之会。

【功能】 清肝明目,镇惊安神,熄风止痉,泄热通窍。

【主治】 前头痛,目眩,目赤肿痛,迎风流泪,目翳,惊悸失眠,鼻渊,鼻出血,癫痫。现在,临床常用于治疗高血压、精神分裂症。

【灸法】 艾炷灸 5~10 壮,艾条灸 5~10 分钟。

水沟(人中)

【位置】 在人中沟正中线上 1/3 折点处。

【类别】 督脉、手足阳明之会。

【功能】 开窍启闭,苏厥救逆,清热化痰,清神升阳,消肿止痛,利腰脊。实验研究提示:能调整呼吸功能,镇痛,抗休克,增强心功能。

【主治】 中风昏迷,牙关紧闭,口眼喎斜,小儿惊风,癫痫,腰脊强痛。现在,临床常用于治疗晕厥、虚脱、中暑、休克、昏迷、面瘫、破伤风、癫痫、精神分裂症、遗尿、尿潴留、面肌痉挛、呃逆、舞蹈病、晕动病、急性腰扭伤。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

(二) 经外奇穴

1. 头颈部奇穴(选 12 穴)

四 神 聪

【位置】 在头顶百会穴前后左右各旁开 1 寸处,共 4 穴。

【功能】 清利头目,醒脑开窍,宁心安神。

【主治】 偏正头痛,眩晕,失眠健忘,惊悸,脏躁,癫狂痫,中风半身不遂,脑震荡后遗症,夜尿症,脑积水,脑发育不全,湿疹,神经性皮炎,斑秃,脂溢性脱发。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 5~10 分钟。

印 堂

【位置】 两眉头连线的中点处。

【功能】 清热解毒,宁心安神,清头熄风。

【主治】 感冒发热,头痛眩晕,眉棱骨痛,目赤肿痛,失眠,呕吐,高血压,低血压,小儿惊厥,产后血晕,子痫,三叉神经痛,鼻炎,鼻出血,结膜炎,麦粒肿,酒渣鼻,痤疮。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~15 分钟。

翳 明

【位置】 在翳风穴后 1 寸。

【功能】 活血,明目,宁神。

【主治】 目疾,如视物不清、夜盲、近视、远视,头痛,眩晕,耳鸣,失眠,面瘫,癫狂,腮腺炎。

【灸法】 艾条灸 5~10 分钟。

太 阳

【位置】 在眉梢与目外眦连线中点外开 1 寸凹陷处。

【功能】 疏风泄热,清头明目,通络止痛。

【主治】 感冒,偏正头痛,眩晕,目赤肿痛,牙痛,三叉神经痛,面瘫,口眼喎斜,视网膜出血,视神经萎缩,神经衰弱。

【灸法】 艾条灸 5~10 分钟。

鼻 通

【位置】 鼻唇沟上端尽处。

【功能】 宣通鼻窍,清热解毒。

【主治】 头痛,鼻塞,过敏性鼻炎,肥大性鼻炎,萎缩性鼻炎,鼻窦炎,鼻部疖肿。

【灸法】 艾条灸 5~10 分钟。

牵 正

【位置】 在耳垂中点前 0.5 寸~1 寸处。

【功能】 祛风通络,清热解毒。

【主治】 面瘫,口疮,口臭,下齿痛,腮腺炎。

【灸法】 同鼻通。

安 眠

【位置】 在翳风与风池连线中点处。

【功能】 宁心安神。

【主治】 失眠,头痛,眩晕,心悸,瘧病,高血压,精神病。

【灸法】 同鼻通。

颈 百 劳

【位置】 在大椎直上 2 寸,旁开 1 寸处。

【功能】 补肺除癆,滋阴清热,舒筋通络。

【主治】 肺癆咳喘,骨蒸潮热,白汗盗汗,百日咳,癆癆,落枕,颈肌痉挛,颈部扭伤。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

崇 骨

【位置】 第六颈椎棘突下凹陷处。

【功能】 疏风解表,宣肺止咳,泄热截疟,活血通络。

【主治】 感冒,咳嗽,百日咳,疟疾,肺癆,癲癇,颈扭伤,

颈项强痛。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~15 分钟。

新 设

【位置】 风池直下,项后发际下 1.5 寸,约当第四颈椎横突尖端,颈部斜方肌外缘处。

【功能】 祛风邪,舒筋脉,利颈项。

【主治】 后头痛,落枕,颈项强痛,肩背酸痛,项肌扭伤及痉挛,枕神经痛,角弓反张,咽喉痛,淋巴结肿大,咳嗽,喘息,瘰疬。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮,艾条灸 5~15 分钟。

血 压 点

【位置】 第六颈椎棘突下(崇骨)旁开 2 寸处。

【功能】 调血活血,调节血压。

【主治】 高血压,低血压,落枕,头项强痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

耳 尖

【位置】 耳尖上,取穴时将耳郭向前按压,在耳郭尖端处取之。

【功能】 泄热,凉血,明目。

【主治】 偏正头痛,目赤肿痛,目翳,麦粒肿,沙眼,喉痹,颜面疔疮。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 5~10 分钟。

2. 胸腹部奇穴(选 7 穴)

胃 上

【位置】 脐上 2 寸(下脘)旁开 4 寸处。

【功能】 健脾和胃,升举下陷,补中益气。

【主治】 胃脘痛,腹胀,消化不良,胃下垂。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

脐中四边

【位置】 脐之中点及上下左右各旁开 1 寸处(包括脐上水分和脐下阴交)共 5 穴。

【功能】 健脾和胃，理气止痛。

【主治】 胃腹疼痛，消化不良，饮食不化，肠鸣泄泻，慢性肠炎，胃痉挛，胃扩张，小儿惊痫，痛经，疝痛。

【灸法】 同胃上。

三角灸

【位置】 以患者两口角之间的长度为一边，以脐孔中心为顶角，作一等边三角形，使底边在脐下呈水平线，两底角处是穴。

【功能】 调理胃肠，舒肝理气，行气止痛。

【主治】 疝气，偏坠，腹痛，奔豚气，胃痉挛，慢性胃肠炎。

【灸法】 同胃上。

利尿点

【位置】 脐下 2.5 寸处，当脐中与耻骨联合上缘连线之中点处。

【功能】 清热利湿，通淋利尿，理气止泻。

【主治】 遗尿，癃闭，尿潴留，淋证，血尿，肠鸣，腹痛，腹泻，肠炎，痢疾，胃下垂，子宫下垂。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~15 分钟。

气 门

【位置】 脐下 3 寸(关元)旁开 3 寸处。

【功能】 调理冲任，利水通淋。

【主治】 淋证，小便不利，癃闭，少腹痛，崩漏，恶露不止，子宫脱垂，不孕症，睾丸炎。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮,艾条灸 10~20 分钟。

提 托

【位置】 脐下 3 寸(关元)旁开 4 寸处。

【功能】 调理冲任,升阳举陷,理气止痛。

【主治】 痛经,崩漏,子宫下垂,肾下垂,疝痛,腹胀,下腹痛。

【灸法】 同利尿点。

子 宫

【位置】 脐下 4 寸(中极)旁开 3 寸处。

【功能】 调理冲任,暖宫调经,理气止痛。

【主治】 月经不调,痛经,崩漏,带下,子宫脱垂,不孕症,睾丸炎,疝痛,少腹痛,腰骶痛,淋证。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~15 分钟。

3. 背腰部奇穴(选 10 穴)

定 喘

【位置】 第七颈椎棘突下(大椎)旁开 0.5 寸处。

【功能】 宣肺理气,止咳平喘,舒筋活络。

【主治】 咳嗽哮喘,支气管炎,呼吸困难,落枕,项背酸痛,上肢疼痛,荨麻疹,瘰癧。

【灸法】 艾炷(隔姜或附片)灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

夹 脊

【位置】 背部自第一胸椎至第五腰椎各棘突下旁开 0.5 寸处,每侧 17 穴,共 34 穴。

【功能】 调阴阳,理脏腑,和气血,舒筋络,利关节。

【主治】 适应范围较广,与背俞穴相类似。上胸背部夹脊穴多主治胸部,如心、肺,还有上肢疾病;下胸背部夹脊穴多主

治腹部，如肝、胆、脾、胃、肠道疾病；腰背部夹脊穴多主治腰腹部，如肾、膀胱、盆腔及下肢疾病。具体如：咳嗽、哮喘、胸胁痛、肋间神经痛、肺结核、肝胆疾病、胃肠疾病、泌尿生殖系统疾病、神经衰弱、肢体瘫痪、腰背痛、下肢麻痹等。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~15 分钟。

巨 阙 俞

【位置】 第四、五胸椎棘突间凹陷处。

【功能】 宁心安神，宽胸理气，止咳平喘。

【主治】 咳嗽气喘，心痛，心悸失眠，支气管炎，支气管哮喘，心绞痛，神经衰弱，胸胁痛，肩背痛，肋间神经痛。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

胃管下俞

【位置】 第八胸椎棘突下旁开 1.5 寸处。

【功能】 养阴生津，润燥止渴，理气止痛。

【主治】 胃痛，腹痛，呕逆，胰腺炎，咳嗽，饮证，消渴，咽喉干燥，胸胁痛，肋间神经痛。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮，艾条灸 10~20 分钟。

接 脊

【位置】 第十二胸椎棘突下凹陷处。

【功能】 健脾助运，理气安神，疏调下焦，清热利湿。

【主治】 腹痛，泄泻，消化不良，痢疾，脱肛，癰疽，腰痛，疝痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

痞 根

【位置】 第一腰椎棘突下旁开 3.5 寸处。

【功能】 舒肝健脾，行气活血，软坚消痞。

【主治】 腹部痞块，肝炎，肝脾肿大，胃脘痛，反胃，呕逆，

肠炎,泄泻,肾下垂,腰痛,疝痛。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮,艾条灸 5~15 分钟。

下极俞

【位置】 第三腰椎棘突下凹陷处。

【功能】 健脾利湿,疏利关节。

【主治】 腹痛腹泻,膀胱炎,小便不利,遗尿,腰痛,下肢疼痛,肠疝痛,痔疮。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

腰眼

【位置】 约当第四腰椎棘突下旁开 3~4 寸凹陷处。

【功能】 益肾壮腰,活血通络。

【主治】 腰痛,尿频,腰部软组织损伤,虚弱羸瘦,肺结核,消渴,肾下垂,睾丸炎,月经不调,带下。

【灸法】 艾炷灸 5~7 壮,艾条灸 10~15 分钟。

十七椎穴

【位置】 在第五腰椎棘突下凹陷处。

【功能】 舒筋络,利腰膝,调冲任,理胞宫。

【主治】 腰骶痛,腿痛,下肢瘫痪,月经不调,痛经,崩漏,遗尿,妊娠痿闭,肛门疾病。

【灸法】 同腰眼。

腰奇

【位置】 尾骨尖端直上 2 寸凹陷处。

【功能】 宁心安神,镇惊止痛。

【主治】 癫痫,头痛,失眠,便秘。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

4. 上肢部奇穴(选 15 穴)

肩 前

【位置】 垂臂合腋，腋前皱壁尽端直上 1.5 寸，在腋前皱壁尽端与肩髃连线中点处。

【功能】 疏筋络，利肩臂。

【主治】 肩周炎，肩痛不举，上臂内侧痛，中风上肢瘫痪。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

夺 命

【位置】 垂臂，在肩髃与尺泽连线的中点处。

【功能】 清头苏厥，疏经活络。

【主治】 头昏，晕厥，上臂酸痛，丹毒。

【灸法】 同肩前。

手 逆 注

【位置】 在前臂屈侧，腕横纹上 6 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间凹陷处。

【功能】 疏经，活络，宁神。

【主治】 前臂痉挛，麻木，疼痛，瘰病，癫狂。

【灸法】 同肩前。

二 白

【位置】 腕后横纹直上 4 寸，在桡侧腕屈肌腱两侧，一穴在筋中间，一穴在大筋外。

【功能】 利肠腑，清湿热，举下陷，舒筋骨，消痔止血。

【主治】 痔漏下血，里急后重，脱肛，胸胁痛，前臂痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

肘 尖

【位置】 屈肘，在肘后尺骨鹰嘴突起之尖端处。

【功能】 清热解毒，软坚散结。

【主治】 瘰癧，痈疽，疔疮。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮,艾条灸 5~15 分钟。

中 泉

【位置】 在手背腕横纹上,腕背指总伸肌腱桡侧,阳溪与阳池中间凹陷处。

【功能】 疏调气机,理气宽胸,调和气血,通经活络。

【主治】 咳嗽气喘,胸胁胀闷,胃气上逆,胃痛,吐血,腹胀腹痛,心腹中诸气痛,掌中热,腕关节软组织疾病,腱鞘炎。

【灸法】 同肩前。

威灵、精灵(即腰痛点)

【位置】 威灵在手背第二、三掌骨中点,第二指伸肌腱桡侧凹陷处;精灵在手背第四、五掌骨间中点,第四指伸肌腱尺侧凹陷处。

【功能】 救逆,舒筋活络,壮腰止痛。

【主治】 晕厥,休克,昏迷,小儿急慢惊风,急性腰扭伤,腰肌劳损,腕关节炎,手背红肿疼痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

外劳宫(落枕)

【位置】 手背第二、三掌骨间,指掌关节后 0.5 寸凹陷处。

【功能】 舒筋活络,健脾助运,和中理气。

【主治】 落枕,腕腹疼痛,消化不良,腹泻,掌指麻木,不能屈伸,手背红肿疼痛,小儿急慢惊风,颈椎综合征。

【灸法】 艾炷灸 1~3 壮,艾条灸 3~5 分钟。

五 虎

【位置】 握拳于食指、无名指手背第二、四掌骨小头高突处取之,两手共 4 穴。

【功能】 舒筋活络。

【主治】 手指拘挛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~10 分钟。

拳 尖

【位置】 握拳于中指手背第三掌骨小头高突处。

【功能】 清热明目。

【主治】 目赤肿痛,目翳。

【灸法】 同五虎。

八 邪

【位置】 手背各指缝中的赤白肉际处,左右计 8 穴,微握拳,于手背第一至五指间蹠缘上赤白肉际处。

【功能】 清热解毒,通络止痛。

【主治】 头痛烦热,咽痛齿痛,目痛,头项强痛,手指麻木,痉挛,毒蛇咬伤,手背肿痛。

【灸法】 同五虎。

大 骨 空

【位置】 拇指背侧,指骨关节横纹中点处。

【功能】 明目和胃。

【主治】 吐泻,鼻出血,目疾。

【灸法】 同五虎。

中 魁

【位置】 于手指背侧,近端指骨关节横纹中点。

【功能】 理气和中,和胃降逆。

【主治】 呕吐,呃逆,反胃,噎膈,鼻出血,崩漏,牙痛,白癫风。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮,艾条灸 5~15 分钟。

小 骨 空

【位置】 于小指背侧,近端指关节横纹中点处。

【功能】 清热明目。

【主治】 目翳，目赤肿痛，喉痛，耳聋，指关节痛。

【灸法】 艾炷灸 3~5 壮，艾条灸 5~10 分钟。

十 宣

【位置】 手十指尖端，距指甲角游离缘约 0.1 寸处。

【功能】 泄热救逆，开窍止痉，清神志，利咽喉。

【主治】 高热，中暑，晕厥，休克，昏迷，中风，癫痫，瘧病，小儿惊厥，咽喉肿痛，扁桃体炎，指端麻木。

【灸法】 艾条灸 10~15 分钟。

5. 下肢部奇穴(选 12 穴)

环 中

【位置】 臀部，在环跳与腰俞连线的中点处。

【功能】 祛风湿，舒筋络。

【主治】 坐骨神经痛，腰腿痛。

【灸法】 艾炷灸 3~15 壮，艾条灸 10~30 分钟。

百 虫 窝

【位置】 膝内髁上 3 寸，即髌骨内上角上 3 寸。

【功能】 养血祛风止痒，清热利湿杀虫。

【主治】 风疹，荨麻疹，皮肤瘙痒症，过敏性皮炎，湿疹，下部生疮，蛔虫症。

【灸法】 艾炷灸 3~7 壮，艾条灸 5~15 分钟。

鹤 顶

【位置】 屈膝，在髌骨上缘正中凹陷处。

【功能】 舒筋络，利腿膝。

【主治】 鹤膝风，下肢痿软，膝关节酸痛，脚气。

【灸法】 同百虫窝。

膝 眼

【位置】 屈膝，在髌骨下缘，当髌韧带两侧与股骨和胫骨

内、外侧所构成的凹陷处。

【功能】 同鹤顶。

【主治】 膝关节痛，下肢麻痹，腿痛，腹绞痛，脚气，鹤膝风。

【灸法】 艾条灸 10～15 分钟。

陵 后

【位置】 在小腿外侧面，当腓骨小头后缘下方凹陷处，与阳陵泉相对。

【功能】 祛风通络。

【主治】 坐骨神经痛，下肢瘫痪，膝胫酸痛，膝关节及周围软组织炎，足下垂，足内翻。

【灸法】 艾炷灸 3～5 壮，艾条灸 5～10 分钟。

胆 囊 穴

【位置】 阳陵泉直下 1～2 寸压痛最明显处。

【功能】 舒肝利胆，清利湿热。

【主治】 急、慢性胆囊炎，胆石症，胆道蛔虫症，胆绞痛，胃窦炎，胸胁痛，腰腿痛，下肢麻痹，瘫痪。

【灸法】 艾炷灸 3～5 壮，艾条灸 10～15 分钟。

阑 尾 穴

【位置】 在小腿外侧面，足三里穴下约 2 寸之压痛最明显处。

【功能】 行气通腑，清热化痰，消炎止痛。

【主治】 急、慢性阑尾炎，胃脘痛，消化不良，急、慢性肠炎，下肢痿痹，足下垂。

【灸法】 艾炷灸 5～7 壮，艾条灸 10～15 分钟。

女 膝

【位置】 在足后跟正中线赤白肉际，当跟腱附着部下缘处。

【功能】 宁神定惊，熄风止痉。

【主治】 气逆，惊悸，癫狂，齿痛，齿龈炎，齿槽脓肿，吐泻转筋。

【灸法】 同阑尾穴。

八 风

【位置】 在足背五趾各趾缝间的缝纹端赤白肉际处，每足 4 穴，两足共 8 穴。

【功能】 消肿解毒，疏经通络。

【主治】 头痛，牙痛，胃痛，疟疾，月经不调，足跗肿痛，末梢神经炎，足背红肿，足趾紫绀症，脚气，毒蛇咬伤。

【灸法】 艾条灸 5～10 分钟。

里内庭

【位置】 足底第二、三趾夹缝中，与内庭穴相对处。

【功能】 疏经通络，熄风止痉。

【主治】 小儿惊风，癫痫，食积，急性胃痛，五趾麻木、疼痛。

【灸法】 同八风。

独 阴

【位置】 在足底第二趾下远端趾间关节横纹中点处。

【功能】 行气止痛，调理冲任。

【主治】 心痛，胸胁痛，胃痛，泛酸，呕吐，少腹急痛，积聚，小肠疝气，月经不调，难产，胞衣不下。

【灸法】 同八风。

气 喘

【位置】 在足十趾尖端，共 10 穴。

【功能】 启闭开窍，疏经通络。

【主治】 中风昏迷，足趾麻木，足背红肿、疼痛，脚气。

【灸法】 同八风。

下篇 临床各科疾病的灸疗法

一、内科疾病

昏 迷

昏迷是一种严重的意识障碍,对体内和外界刺激失去了应有反应的一种临床表现,是指神志不清,不省人事而言,是脑代谢发生障碍,高级神经活动处于极度抑制状态。中医根据昏迷深浅程度的不同,有“昏愦”、“昏厥”、“尸厥”等名称,多见于温病邪传营血或痰证、痫证、喘证、消渴、中风、急黄等疾病的严重阶段。

【病因病机】

昏迷的病因比较复杂,主要由于不同病因影响了大脑皮质下网状结构上行激动系统,阻断了它的投射功能,不能维持大脑皮质的兴奋状态,或大脑皮质遭到广泛的损害,以及上述两者均受到损害所致。归纳起来,引起昏迷的原因可分为全身性病变和颅脑病变两大类,多由颅脑疾病、脑血管意外、癫痫持续状态、感染性疾病、内分泌与代谢障碍、水电解质紊乱、酸碱平衡失调、重要脏器衰竭、急性中毒及颅脑外伤、热射病、电击伤、溺水等引起。中医认为,多由于外感时疫,热毒内攻,以及痰浊、热毒、风阳、瘀血等阻塞,上蒙清窍,神明不用;或各种原因引起气血亏耗、脏腑虚损、阴阳衰竭,导致心神失养,阴阳

离绝，神明失守，神无所依而昏迷。

【临床表现】

意识丧失，运动、感觉和反射等功能障碍，对外界刺激无反应。按其严重程度分浅昏迷和深昏迷两大类。浅昏迷时，患者对外界声、光等强刺激失去了反应，但对疼痛尚有一定无意识反应，各种生理反射尚可引出，血压、脉搏、呼吸等生命体征尚无显著改变，常表现四肢躁动，腱反射亢进。深昏迷时，患者的意识、感觉和随意活动完全丧失，肢体瘫软，二便失禁，对外界一切刺激包括强烈的疼痛刺激均无反应；对光反射，角膜与吞咽反射均消失；瞳孔散大，所有深反射均不能引出。生命体征亦出现不同程度的障碍。

【辨证施灸】

中医辨证可分为闭证和脱证。凡牙关紧闭，两手握固，肢体强痉，二便闭结者，多属闭证；凡目合口张，手撒肢冷，汗多体软，大小便失禁者，多属脱证。闭证多实，脱证多虚。此外，尚有痰浊内盛，蒙闭清窍，又兼气血耗散，神不守舍，以致神昏者，乃属内闭外脱的虚实兼证。昏迷初期多出现闭证，久则正不胜邪，由闭证转为脱证而死亡。

治则 昏迷属重危证候，急宜苏厥醒神，以挽救生命，必须采取综合措施抢救。闭证宜通关开窍；脱证宜回阳固脱。艾灸疗法，一般多适用于脱证的治疗。

取穴 膏肓、百会、神阙、气海、关元、足三里、隐白。

方义 百会升阳固脱，苏厥开窍；膏肓补益虚损；神阙回阳固脱；气海益肾固精；关元培元固本；足三里扶正培元；隐白苏厥。诸穴合用，共奏救阴敛阳，回阳救逆之功。

灸法

(1) 艾炷灸：取气海、关元、隐白各灸 15～20 壮。

(2) 隔盐(或姜)灸:在神阙灸 5~10 壮。

(3) 艾条熏灸:在百会、膏肓各灸 30 分钟,4 小时重复 1 次。

(4) 温针灸:在气海、关元、足三里各灸 15~30 分钟,每日 1~2 次。

按:昏迷属重危证候,必须迅速送医院抢救。在采用各种抢救措施时,如能配合艾灸,可提高抢救成功率。在抢救的过程中,要严密观察患者的心跳、呼吸、血压、体温、气味以及瞳孔变化、对光反射、各种病理反射、脑膜刺激征和肢体瘫痪等情况。

晕厥

晕厥是一种因血液循环紊乱,引起一过性广泛性脑缺血、缺氧而突发的一种短暂的意识丧失现象。中医古称“薄厥”、“郁冒”、“昏晕”、“昏厥”、“昏仆”等,皆属晕厥范畴。

【病因病机】

急性脑缺血是引起晕厥的主要原因,而急性脑缺血可能与血压急剧下降、心排出量骤减或脑动脉本身疾患有关,彼此相互联系或共同作用而致病。其病因较复杂,大致可归纳为四类:①血管舒缩障碍,主要是血管抑制性晕厥及直立性低血压所致的晕厥。②心源性晕厥。③脑源性晕厥。④血液成分异常。其中以血管抑制性晕厥最为常见,而心律失常所致的晕厥最为严重。各种心脑血管疾病、失水、失血、低血糖、重度贫血、过度换气综合征、疼痛、出血、各种穿刺及小手术、精神刺激、情绪激动、惊恐紧张、天气闷热、空气污浊、悲痛、失眠、咳嗽、排尿、妊娠、体弱疲劳、空腹、高山反应及蹲后突然起立等均可诱发。中医认为,多由外邪侵袭,七情内伤,饮食劳倦,剧烈疼痛,痰饮内伏,瘀血阻滞等引起气机一时逆乱,升降失司,阴阳

不相顺接,致十二经脉的气血不能正常循头濡脑而发生昏厥。有实厥与虚厥两类,实厥与肝有关,肝气郁则一身之气皆郁,肝气逆则一身之气皆逆,气血并走于上,则昏不知人;虚厥与肺脾关系密切,肺脾气虚,清阳不升,气陷于下,血不上达,血虚则神明浮越,发为昏厥。

【临床表现】

患者突感头昏,心慌,恶心,眼黑目眩,全身发软等先兆症状,随即意识不清和倒地,不省人事,面色苍白,四肢厥逆,肌肉松弛,血压(收缩压)下降,脉搏缓慢,平卧移时能逐渐清醒,伴有出汗和乏力感,稍事休息即可恢复,不遗留后遗症,偶可发生外伤,但特别严重者,亦可一厥不复而死亡。晕厥与昏迷不同,昏迷的意识障碍通常持续较长,恢复较难;晕厥与眩晕的区别是后者主要感到自身周围景物旋转,而一般无意识障碍;血压低是晕厥的普遍现象,使晕厥与休克有时无明显界限,其区别在于休克的早期意识仍清楚,或仅表现精神迟钝,周围循环衰竭的症状比晕厥更为明显而持久。

【辨证施灸】

晕厥之种类很多,有气、血、痰、食、暑、酒、色、蛔厥和中恶等,施灸时可将其分成虚实两类进行。

1. 实证 素来体盛之人,卒然昏仆,气雍息粗,喉间痰鸣,牙关紧闭,脉沉实或沉伏。

治则 开闭通阳。

取穴 百会、神阙、人中、膻中、大陵、十二井。

方义 百会、人中、十二井振奋阳气,醒脑开窍;神阙回阳固脱;膻中、大陵调气宁神。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~5穴,各灸5~10壮。

(2) 艾炷隔面灸：每次选 3~6 穴，用黄豆大艾炷各灸 5~7 壮。

(3) 艾炷隔盐灸：用食盐填平脐窝，上置黄豆大艾炷灸 5~10 壮。

(4) 艾条灸：每次选 4~6 穴，各灸 20~60 分钟（紧急无艾条时，可用香烟头代替）。

2. 虚证 久病体虚之人，忽然仆倒，气息微弱，口开目合，自汗肤冷，脉沉细。

治则 回阳救逆，温阳散寒。

取穴 百会、神阙、气海、关元、足三里、太溪。

方义 百会苏厥开窍，醒脑安神，升阳固脱；气海、关元壮阳培元、理气除寒；神阙温阳救逆，苏厥固脱；足三里扶正培元；太溪滋阴补肾。

灸法

(1) 艾炷灸：各穴用麦粒大艾炷施灸，不计壮数，灸至脉回汗止为度。

(2) 艾炷隔蒜灸：取食盐填平脐窝，上盖蒜片，用黄豆大艾炷灸 5~10 壮。

(3) 艾条灸：用艾条灸至脉回汗止为度。

(4) 胡椒粉熨灸：用胡椒粉纳满脐窝，热熨之。

(5) 吴萸食盐熨灸：选吴萸 30 克，食盐 100 克，共炒烫，布包熨脐下。

按：晕厥易与眩晕、昏迷、休克、心律失常、高血压脑病、低血糖症及癔病等相混淆，临证应仔细鉴别。艾灸治疗晕厥效果很好，治疗时患者平卧，取头低足高位，松解衣扣，做好保暖。如因低血糖、脑血管痉挛等引起晕厥，应送医院以治疗原发病为主，在治疗原发病的基础上配合艾灸治疗。

休 克

休克是人体受到各种有害因素侵袭后,迅速出现循环系统及其它系统功能活动急剧降低,引起微循环血流障碍,重要脏器血流灌注不足,组织缺血、缺氧,导致代谢紊乱为特征的急性循环功能不全综合征。与中医的“厥脱”、“亡阴”、“亡阳”相类似,属急重证候,如不及时抢救,很快危及生命。

【病因病机】

休克的原因很多,如各种细菌严重感染引起的中毒性休克;严重心脏疾病导致的心源性休克;失水、失血、严重烧伤,使血容量突然大量减少所引起的低血容量性休克;对某些物质过敏引起的过敏性休克;创伤、剧烈疼痛或脊髓麻痹引起的神经源性休克;肺梗死、心包填塞、张力性气胸、夹层动脉瘤、心内梗阻等引起的血流梗阻性休克;肾上腺皮质、胰岛功能不全引起的内分泌性休克及药物中毒引起的休克等等。其共同病理是有效血量不足,心排出量骤然减少,微循环障碍,导致生命器官血流灌注急剧减少,全身组织器官出现严重缺氧,组织代谢失常,终至细胞死亡的一系列过程。

中医认为,本病多由感受温热邪毒,内陷营血;剧痛、惊恐;汗、吐、下、失血、失精、中毒及久病、劳伤等耗伤气阴,脏腑功能、气血严重损耗,以致心气衰微,心阳不振,使气血循环障碍,从而导致阴阳之气不相顺接,气机逆乱而发生休克,甚则亡阴、亡阳,阴阳离绝而死亡。

【临床表现】

休克早期出现精神淡漠,萎靡不振,反应迟钝,心悸气短,烦躁不安,面色苍白,汗出肢冷,脉搏细弱。稍久则血压下降(原血压正常而收缩压 <10.67 千帕或低于基础血压30%以

上,脉压差 <2.67 千帕),口渴,尿量减少(尿量 <30 毫升/小时),神志不清,脉搏细速。严重者呼吸短促微弱,唇指紫绀,四肢厥逆,心音低钝,血压继续下降,收缩压 <7.98 千帕,甚至测不出,无尿,脉微欲绝或摸不到,抽搐,进入昏迷状态。休克与体质性低血压均出现低血压,但体质性低血压多见于体质较弱的女性,尤其在罹患慢性疾病至营养欠佳时更为明显,收缩压有时可 <10.7 千帕(80毫米汞柱)。但无神志迟钝、面色苍白、出冷汗、尿量减少、脉搏细速等循环功能不全的表现,据此可与休克相鉴别。

【辨证施灸】

临证可见热厥、寒厥、阴脱(亡阴)、阳脱(亡阳)及阴阳俱脱的证候,应分辨清楚,并要注意厥脱的严重程度。灸法通常适用于寒厥、脱证。

治则 苏厥开窍,回阳救逆。

取穴 百会、神阙、关元、足三里、涌泉。

方义 百会升阳固脱,益气醒脑;神阙回阳救逆;关元固命门真阳;足三里扶正培元;涌泉开窍,交通心肾。

灸法 艾炷或艾条灸,不计壮数或时间,灸至脉回汗止,血压回升为度。

按:休克的发生,其势急骤凶险,需迅速送医院抢救。患者取平卧高足位,注意保暖,少翻动,并严密观察患者的神志、血压、呼吸、面色、尿量、脉搏等变化。艾灸能增强机体代谢能力,对纠正血流动力学紊乱有一定作用,对防止缺氧不断加重和延缓休克发展均具有积极意义,可作为抢救休克的辅助措施之一。

中 暑

中暑是因高温或烈日暴晒引起人体体温调节功能紊乱所致的一种急性疾病。炎夏季节在烈日下、高热辐射、高湿度和风速较小的环境中停留时间较长或从事体力劳动,如果防暑措施做得不好,就可能导致中暑发生。多见于老年人,按其发病机制和临床特点,可分为中暑高热、中暑痉挛、中暑衰竭和日射病等,但常混合出现。中暑古称“中热”、“中喝”,轻者称“发痧”、“伤暑”;重证可出现中暑阳证和阴证、“暑痢”、“暑风”、“暑厥”、“暑痉”、“暑闭”等情况。

【病因病机】

夏日天气炎热,气温增高,正气亏虚,若不能适应外界气温的变化,或在烈日下劳动时间过长,感受炎暑或暑湿秽浊之气,致暑热郁蒸,正气耗损,甚则清窍被蒙,经络之气厥逆不通而出现神昏痉厥。如津气耗散过甚,往往发生虚脱而死亡。

【临床表现】

在高温环境下劳作,如出现大量出汗,口渴,头昏,耳鸣,胸闷,心悸,恶心,四肢无力,注意力不集中等即为中暑先兆症状。继之体温升高,皮肤灼热,面色潮红,烦躁不安或恶心呕吐,面色苍白,汗出肢冷,血压下降,脉搏细弱而快,则发展为中暑轻症。若除上述症状外,还出现高热(体温 40°C 以上),皮肤干燥无汗,神志不清,猝然昏迷或痉挛抽搐,周围循环衰竭等症状,则为中暑重症。中暑高热者,体内有大量热蓄积,除高热外,有昏迷无汗;中暑衰竭最为常见,体内并无大量积热,而出现失水或低钠血症所致的周围循环衰竭;中暑痉挛主要表现为肌肉性抽搐,常发生在剧烈劳动之后,并不直接与高温有关;热射病乃因夏季烈日暴晒所致。

【辨证施灸】

1. 中暑重症 发热汗出。阳证兼见烦躁，口渴多饮，溲赤或兼见恶寒，舌红少津，脉洪大；阴证兼见精神衰惫，四肢困倦，胸闷气短，不思饮食，大便溏薄，脉洪缓。

治则 清泄暑热(阳证)；补气，益肾，生津(阴证)。

取穴 阳证选大椎、曲池、合谷、内关、足三里；阴证选肾俞、神阙、气海、关元、阴郄、太渊。

方义 大椎为督脉经穴，诸阳之会，能疏泄热邪，配内关有疏泄阳明，解暑清热之效；曲池、合谷解肌清热；内关配足三里益气扶正，和中化湿，可防暑邪内犯；肾俞益肾气；神阙温阳救逆，气海、关元益气补肾培元；阴郄益阴固表；太渊调肺气。若转筋者加承山、承筋以通经活络；惊厥者加后溪、涌泉以清热开窍，清心宁志；暑热夹湿者加阴陵泉以化湿。

灸法

(1) 艾炷着肤灸：每穴灸 3~5 壮，每日 1~2 次。

(2) 艾炷隔盐灸：在神阙灸 5~7 壮，每日 1~2 次。

(3) 艾条悬起灸：每穴 10~15 分钟，每日 1~2 次。

(4) 田螺敷灸：选大田螺(去壳)3 只，青盐 2 克，共捣烂敷灸气海穴。

(5) 地龙吴萸敷灸：中暑阳证取地龙、吴萸各等份，共研细末，与适量面粉混合后，用醋调敷灸双涌泉穴。

(6) 人丹敷灸：取人丹 15 克，研细末纳脐内，胶布固定，有退热止痉开窍之功。

(7) 温熨小腹：用温水烫壶、盛火熨斗或熨热的砖块(布包)在小腹上直接熨灸。

2. 中暑脱证 身热大汗不止，继则厥逆，冷汗自出，烦躁不安，面色苍白，渐至呼吸浅促，甚至昏迷，不省人事，脉微细

欲绝。

治则 回阳固脱。

取穴 神阙、气海、关元、涌泉。

方义 神阙温阳救逆，苏厥固脱；气海培元；关元温肾壮阳；涌泉滋肾醒神。

灸法

(1) 艾炷隔盐灸：在神阙隔盐灸，壮数不拘，以苏醒为度。

(2) 艾炷隔姜灸：壮数不拘，以苏醒为度。

(3) 附子干姜敷灸：取附子、干姜各 20 克，共研细末，用热水调成膏状，敷灸涌泉穴 30~60 分钟。

(4) 锈铁淬醋熏鼻：取锈铁 1 块，烧红淬醋熏鼻，有苏厥安神之功。

按：中暑发病急骤。遇有中暑需立即将患者移至通风阴凉的地方，解开衣扣，轻症患者采取必要的降温措施，给予含盐清凉饮料，安静休息，多可恢复，亦可施以刮痧及艾灸疗法；重症患者，需迅速送医院抢救，艾灸可作为急救措施之一，并要密切观察患者的体温、血压、呼吸、脉搏等变化。

一氧化碳中毒

一氧化碳中毒，俗称煤气中毒。

【病因病机】

一氧化碳中毒是因含碳物质燃烧不全产生一氧化碳对人体的毒害。一氧化碳侵入被人体吸收后，与血红蛋白结合成稳定的碳氧血红蛋白，使其失去携氧能力而造成低氧血症。一氧化碳浓度较高时，还可以与细胞色素氧化酶的铁结合，抑制组织的呼吸过程。中枢神经系统对缺氧最敏感，并首先出现症状。

【临床表现】

急性中毒,轻者仅头痛眩晕,恶心呕吐,四肢乏力,精神不振,心悸,并可虚脱,一般无昏迷;严重中毒时,多突然昏倒,不省人事,迅速昏迷(昏迷可持续数小时至数日),并伴呕吐,大小便失禁。有些患者可出现抽搐谵语,还可并发脑水肿,肺水肿,皮肤粘膜苍白或紫绀,体温升高,呼吸困难,心肌受损以致呼吸循环衰竭而死亡。深度昏迷经抢救苏醒后,常遗留神经、精神方面的后遗症,如癫痫、肢体瘫软、吞咽困难、震颤麻痹、智力减退等。

治则 醒脑开窍,解毒苏厥。

取穴 百会、神阙、气海。

方义 百会升阳固脱,醒脑苏厥;神阙回阳固脱;气海主一身之气,益肾固精。

灸法 神阙隔盐灸,余穴用大艾炷直接灸,不拘壮数,以苏醒为度。

按:遇有一氧化碳中毒时,应立即打开门窗通风,迅速使患者脱离现场,并做好保暖。轻者经吸氧,休息后可逐渐缓解;重者应迅速送医院抢救,最好送高压氧仓治疗,艾灸疗法属急救措施之一,可酌情选用。抢救复苏后,如遗留后遗症,可参照“中风”节治疗。

食物中毒

食物中毒是指食入被细菌及其毒素污染的食物引起急性感染性中毒性的疾病。多在夏秋季节发病,常集体呈暴发性小流行。罹患者均与食物有明显的联系。属中医的“霍乱”、“痧证”、“泄泻”范畴。

【病因病机】

本病的发生是由于感受秽浊疫疠之气及饮食不节，恣食生冷，进食腐馊变质和不洁（被细菌及其毒素污染）食物，食毒损伤脾胃，以致气机逆乱，清浊相混，升降失司而发病。引起食物中毒的主要致病菌有沙门菌属、嗜盐杆菌、变形杆菌、大肠杆菌、葡萄球菌、肉毒杆菌等细菌，尤以沙门菌属和嗜盐杆菌多见。主要病理是这些细菌在肠道内繁殖，引起急性感染，或细菌大量繁殖后产生外毒素，被肠道吸收后引起中毒反应，导致水、电解质吸收紊乱，并产生各种胃肠道症状。

【临床表现】

各种细菌性食物中毒一般有1~24小时的潜伏期，潜伏期愈短，病情愈重。均以腹泻腹痛，恶心呕吐为主要表现。沙门菌属食物中毒的特点是腹泻多为黄绿色水样便或呈米泔水样；嗜盐菌食物中毒的特点为腹痛剧烈，呈持续疼痛或阵发性绞痛，腹泻呈水样或夹脓血粘液，少数可呈洗肉水样；变形杆菌食物中毒的腹泻亦为水样，有恶臭，伴有头痛，面潮红，醉酒貌、荨麻疹等过敏现象；金黄色葡萄球菌食物中毒时，呕吐较剧，常吐出胆汁性或血性粘液；肉毒杆菌食物中毒的胃肠道症状不明显，以头晕乏力，全身软弱，眼睑下垂，复视，瞳孔散大，声音嘶哑，吞咽、咀嚼、言语、呼吸困难等神经系统症状为主，可发生心力衰竭、吸入性肺炎等并发症。

【辨证施灸】

治则 清热化湿消滞，调理脾胃气机。以选取手足阳明经穴为主。

取穴 中脘、天枢、神阙、气海、关元、大肠俞、阴陵泉、足三里、上巨虚。

方义 中脘、气海、关元、足三里等穴扶正祛邪；大肠俞、

天枢、上巨虚调整胃肠功能，止痛止泻；神阙益气止泻；阴陵泉健脾化湿。

灸法

(1) 艾炷隔盐灸：在神阙灸 7~9 壮，每日 1~2 次。

(2) 艾炷隔姜灸：每次选 2~4 穴（或在脐四边），各灸 7~9 壮，每日 2 次。

(3) 艾条熏灸：每次选 2~4 穴，各灸 15~60 分钟。

(4) 吴萸敷灸：取吴萸末 30 克，用盐卤调涂敷双手足心，每日更换 1 次。

按：灸法抢救各种急性中毒，不能起对抗解毒作用，也不能立即将毒素排出，但临床上采用灸法对急性中毒进行抢救，确有较好效果。对各种中毒或变态反应的患者，除迅速送医院抢救，尽快找出中毒原因，采用针对性解毒措施外，应及早采用灸法治疗，如食物中毒灸大肠俞；水中毒灸肾俞；药物中毒灸筑宾，均有一定效果，能提高治愈率，减少并发症、后遗症的发生。

感冒、流行性感

感冒，中医称“伤风”。以发热恶寒，鼻塞流涕，喷嚏咳嗽为主要症状。一般病程 3~7 日，病情较轻，在整个病程中很少传染，但发病率高，几乎没有人未患过感冒，且易反复发作，还常与某些传染病初起症状相混淆。流行性感，简称流感，中医称“时行感冒”。与普通感冒症状相似，但病情较重，有很强传染性，常普遍流行，儿童与老人易感，是冬、春季多发的一种呼吸道传染病。

【病因病机】

感冒是病毒或病毒与细菌混合感染，流感是由流感病毒

经口、鼻直接传染引起的上呼吸道感染而发病。中医认为是由外邪乘人体正气不足时侵袭肺卫皮毛所致。临床以风寒、风热两种类型多见,由于体质和感邪性物质的不同,又有夹湿、夹暑、夹燥的兼证及气血阴阳诸虚兼感外邪之别。流感因感受时邪较重,故传染迅速,易动风惊厥。

【临床表现】

早期可见鼻塞声重,或鼻塞流清涕,咽喉痒痛,咳嗽,咯痰稀薄,甚则恶寒发热,头痛,无汗或有汗,肢体酸痛,苔薄白,恶寒时脉浮紧,发热时脉浮数。如夹湿则身热不扬,头胀重如裹,肢体困重,或外有风寒表证,内有胸闷泛恶,纳呆苔腻等里证。流感症状与风热感冒重证类似,如并发肺炎则出现高热,咳嗽,痰黄等寒包火证候。

【辨证施灸】

1. 风寒感冒:鼻塞声重或鼻痒喷嚏;流涕清稀,咽痒咳嗽,痰清稀薄,甚则发热恶寒,头痛无汗,肢体酸痛,苔薄白,脉浮紧。

治则 疏散风寒,宣肺解表。

取穴 风池、风门、肺俞、列缺、合谷。

方义 风池、风门疏风散寒以解表;肺俞宣肺止咳;列缺宣利肺气;合谷增强祛风散寒解表宣肺作用,并能防止外邪传里。气虚者加足三里以健脾益气;全身酸痛者加大杼以散寒止痛。

灸法

(1) 艾炷隔姜(或麻黄饼)灸:每次选2~4穴,各灸5~7壮,每日1~2次。

(2) 艾条温和灸:每穴20~30分钟,热度以患者感到舒适为宜,灸至局部皮肤潮红为度,每日1~2次。

(3) 葱豉糊敷灸：取生姜 60 克，淡豆豉 30 克，食盐适量，共捣烂成糊状，炒热敷于神阙，包扎固定。亦可用热水袋置穴上热敷保温，每日换敷 2 次。

(4) 丁椒膏敷灸：取丁香 10 克，胡椒 15 克，淡豆豉 30 克，共研细末，加葱白适量，捣烂成膏状，每穴取 5 克敷灸，先敷大椎、神阙两穴，胶布固定，再取 10 克置劳宫穴上，合掌夹于两大腿内侧，夹足覆被侧卧，得汗则愈。

(5) 苍术羌活散敷灸：感冒头痛无汗，取苍术、羌活各 30 克，明矾 10 克，共捣粗末，炒热用葱白汁和药末，趁热敷灸神阙穴。

2. 风热感冒 发热微恶寒，头痛汗出，涕浊，咯痰黄稠，口干欲饮，咽喉红肿疼痛，苔薄黄，脉浮数。

治则 疏风散热，清肃肺气。

取穴 风池、大椎、曲池、外关。

方义 风池、曲池、大椎疏风清热解表，配外关可疏散高热，解除头痛目赤等症。咽喉肿痛加少商以清热利咽；咳嗽加尺泽、天突以祛痰止咳；头痛加印堂、太阳以散邪止痛。

灸法

(1) 艾条温灸：每穴灸 3~5 分钟，每日 1~2 次。

(2) 芭蕉根敷灸：感冒高热，取芭蕉根 500 克，食盐适量，共捣烂敷灸中庭、鸠尾、巨阙，直至体温正常。

(3) 复方淡豆豉敷灸：取淡豆豉、连翘、薄荷各等量，共研细末，先取 20 克加葱白适量捣烂成膏状，敷灸大椎、风池，外以胶布固定，再取药末 15 克纳脐中，然后滴冷水包扎，每日 1 次。

3. 气虚感冒 发热恶寒、汗出，肢体酸楚，倦怠乏力，脉浮无力。

治则 益气解表。

取穴 大椎、曲池、气海、足三里。

方义 大椎、曲池疏风清热解表；气海、足三里益气固表。

灸法 艾条灸每穴每次 15~30 分钟，每日 1 次。

4. 流行性感冒 症状与风热感冒重证类同。

治则 辛凉解表，清热解毒。

取穴 大椎、肺俞、委中。

方义 大椎、委中散风解表退热；肺俞宣肺解表。

灸法

(1) 艾条温和灸：每穴 20 分钟或艾炷隔姜灸，每穴 3~5 壮，每日 2~3 次。

(2) 避瘟散敷灸：取生石膏、绿豆粉各 100 克，白芷、滑石各 10 克，麝香 1 克，甘油、薄荷水各 15 毫升。前 4 药共研细末，对入后 3 药调匀，每次取 1 克，用白酒或冷水调膏，分别敷灸囟门、太阳穴上，以胶布固定，每日 1 次。

5. 预防感冒

预防感冒取大椎、足三里；预防流感加风门，或取风池、大椎、合谷。各以艾炷灸 3~5 壮或艾条温和灸 20 分钟，每日 1 次，连灸 3~5 日。也可用避瘟散 0.2 克，以绢包塞鼻孔敷灸，每日 2 次，左右鼻孔交替使用。

痢 疾

痢疾是以大便次数增多，腹部胀痛，里急后重，脓血便为特征的夏秋季节常见的肠道传染病。人群普遍易感，儿童发病率远较成人高。中医称“肠癖”、“滞下”，包括西医的细菌性痢疾和阿米巴痢疾。

【病因病机】

痢疾的发生,外因感受暑湿疫毒之邪,内因饮食生冷、酸馊不洁之物,湿热积滞肠中,与气血相搏,化为脓血,大肠传导失常而引起。若热毒炽盛,正气不支或胃虚气逆,可发为疫毒痢、噤口痢,均为痢疾之重症。此外,休息痢、久痢、虚寒痢尚与七情内伤、肝郁犯脾或脾肾虚弱等因素有关。

【临床表现】

起病急,腹痛腹泻,泻后不爽,每日数次至数十次,初为稀便或水样便,渐转脓血便,赤白夹杂,肛内灼热,里急后重,胸脘痞满,食欲不振,或恶心呕吐,或发热恶寒,小便短赤,苔黄腻,脉滑数。

【辨证施灸】

临床有急性痢疾和慢性痢疾两种。若热重于湿者,泻下以脓血为主;湿重于热者,泻下以粘冻为主;若痢下脓血或鲜紫血水,腹痛剧烈,高热烦躁,甚或神昏,惊厥,抽搐者,则为疫毒痢;下痢兼气逆,呕哕不食者为噤口痢;下痢时发时止,久痢不愈,则为久痢、休息痢、虚寒痢。

治则 通肠导滞,清热利湿,调和气血,多取大肠募穴和任脉、阳明经穴。湿热痢佐以足太阴、少阳经穴以加强清热利湿;疫毒痢急取大椎、十宣放血以泄热解毒;噤口痢、寒湿痢、休息痢、虚寒痢多加肝、脾、肾、任脉经穴以温中和胃,祛寒化湿,温补脾肾。

取穴 下脘、天枢、气海、上巨虚、大肠俞。

方义 下脘消胀化滞,理气止痛;天枢为大肠募穴,通调胃肠,攻逐积滞,清热化湿;气海理气和血化湿;上巨虚为大肠下合穴,“合治六腑”,具有通腑化滞之功;大肠俞通调肠腑,五穴合用,通调大肠气血,“行血则便血自愈,调气则后重自除”。

临床应用,颇具卓效。如发热重者加曲池、合谷以清热散邪;湿重者加阴陵泉、足三里以健脾化湿;里急后重甚者加中脘俞以缓急止痢;寒重加神阙、关元以温阳化湿;热毒痢加大椎以清热解毒;出现昏迷者加神阙益气回阳;噤口痢加中脘、内关以和胃止呕,降逆开噤;久痢、休息痢、虚寒痢加脾俞、胃俞、肾俞以温补脾肾。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸:每次选 2~4 穴,各灸 7~10 壮,每日 1 次。

(2) 艾炷隔蒜(或隔姜)灸:每次选 2~4 穴,各灸 5~7 壮,每日 1 次,3 次为 1 个疗程。

(3) 艾炷隔盐灸:在神阙隔盐覆姜灸 5~7 壮,每日 1 次。对慢性痢疾,可在中脘、神阙、关元隔盐各灸 3 壮,每日 1 次,连灸 7~14 日。

(4) 艾条温和灸:每次选 2~4 穴,各灸 20~30 分钟,灸至皮肤潮红为度,每日灸 1~2 次,3~5 日为 1 个疗程。

(5) 温针灸:每次选 2~3 穴,各灸 2~4 壮或 15~20 分钟,每日 1 次,3 次为 1 个疗程。对急性菌痢、阿米巴痢疾能迅速控制症状。

(6) 太乙针灸:在中脘、神阙、天枢、气海、足三里各灸 10~15 分钟。

(7) 大黄敷灸:取大黄 1 克,纳入神阙,外用胶布固定,每日换药 1 次,以愈为度。

(8) 吴萸敷灸:①取吴萸末适量,用醋调成糊状,敷灸脐中或涌泉穴,2 小时后取下。②取吴萸 24 克,滑石 18 克,甘草 3 克,共研细末,每次取药末 2 克,分撒于神阙、止泻穴上,以胶布覆盖固定,每日换药 1 次,5 日为 1 个疗程。

(9) 黄瓜藤末敷灸：取煨黄瓜藤末填满脐窝，用胶布覆盖固定，每日更换 1 次，以愈为度。

(10) 肉桂敷灸：寒湿痢取肉桂、针砂、枯矾各等份，共研细末，用凉开水调成糊状，敷灸脐窝，外以纱布覆盖，胶布固定，每日更换 1 次，以愈为度。

(11) 田螺敷灸：噤口痢取活田螺肉捣烂，加麝香少许，纳脐中，外以胶布覆盖固定，每日更换 1 次，以愈为度。

(12) 大蒜敷灸：取大蒜 1 头，捣烂敷灸涌泉，1 小时后取下。

按：艾灸治痢，疗效较好。温针灸能提高自身抗菌力，较快控制菌痢症状；久痢不愈，应用艾灸疗法治疗，效果尤著。但应注意，如属疫毒痢、噤口痢，应迅速送医院抢救。在抢救中配合艾灸，可提高抢救成功率。

病毒性肝炎

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的以肝脏炎症为主的全身性传染病。根据病原体不同，可分为甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎，各型肝炎的临床症状基本相似，主要症状有食欲减退、恶心、厌油、乏力、肝脾肿大及肝功能异常等。部分病例出现发热及黄疸。临床以甲、乙两型肝炎最常见，尤以乙型肝炎发病率最高。病毒性肝炎好发于儿童和青壮年，传染性强，传播途径复杂，流行面广。临床可分为急性（黄疸和无黄疸型）、慢性（迁延和活动型）及重症肝炎。急性肝炎多于 2~4 个月恢复，乙型肝炎易成慢性，少数可发展成肝硬化甚至肝癌。中医无病毒性肝炎病名，可将其归属于“黄疸”、“胁痛”、“积聚”、“鼓胀”等病证之中。

【病因病机】

本病是由多种肝炎病毒感染引起肝细胞变性、坏死及肝

脏间质炎性浸润等一系列病理变化所致。但肝炎病毒的组织损害并不是肝炎病毒在肝细胞的繁殖复制的直接结果,而是通过一系列变态反应而产生的,现已发现与乙型肝炎相关的3对抗原抗体和核心抗体及e抗原和e抗体。中医认为,病毒肝炎是由于情志、酒食、劳倦等内伤导致正气虚弱,疫毒、湿热等外邪乘虚而入,蕴结于中焦,脾失健运,肝失疏泄,胆液不循常道,内郁血分,外溢肌表,而出现黄疸。由于患者体质差异及外邪性质的不同,湿可从热化发为阳黄,亦可从寒化发为阴黄。如正气较强或受邪较轻,黄疸不显于面目,则发为无黄疸型肝炎;如肝胆热毒炽盛,内传营血,邪陷心包,则发为急黄(重症肝炎)。

【临床表现】

病毒性肝炎最常见的症状是食欲减退,恶心呕吐,厌食油腻,腹胀胁痛,小便黄,大便干结或稀薄,肝肿大,有压痛或扣击痛,肝功能损害,部分病例出现巩膜、皮肤黄染。急性肝炎多有发热恶寒。如果病程迁延,可转为慢性肝炎,尤以乙型肝炎较易转为慢性,出现肝病面容,肝脾肿大明显,质硬,压痛更明显,或出现蜘蛛痣及肝掌,最后发展为肝硬化。如病情发展迅猛,黄疸迅速加深,肝脏迅速缩小,出现肝臭,烦躁不安,精神错乱,嗜睡,甚至昏迷及明显出血倾向,即为重症肝炎。

【辨证施灸】

1. 急性肝炎

治则 疏肝解郁,清热解毒。

取穴 内关、石子头穴(太渊直上3寸)。

方义 内关疏肝和胃,治胁痛、热病、呕吐;石子头穴为治肝炎经验穴。

灸法 取鲜毛茛嫩叶适量,捣烂敷灸穴上,待发泡后去

药,用消毒针挑破流尽黄水,再敷以消炎膏,2~3日敷灸1次。

2. 慢性肝炎

治则 除湿解郁,理气化痰,健脾和中,补益肝肾。

取穴 膈俞、肝俞、脾俞、右期门、承满、天枢、足三里。

方义 膈俞理气化痰;肝俞、期门疏泄肝胆湿热,退黄疸;承满、天枢理气化湿,行气活血;脾俞、足三里健脾和胃,化湿浊。

灸法 每次选2~3穴,用小艾炷各灸3~5壮,2日1次。

3. 预防肝炎 在肝俞、阳陵泉采用艾条温和灸,可以预防肝炎。

肺 结 核

结核是一种慢性消耗性传染病。肺结核是由结核杆菌引起的肺部感染。全身各器官的结核病中,以肺结核最多见。中医称为“肺癆”、“癆瘵”。

【病因病机】

本病是由结核杆菌引起肺部感染而发病。传播的主要方式是人与人之间呼吸道传播。但其发生和发展与机体抵抗力、结核杆菌侵入数量及毒力强弱密切相关,如患者抵抗力较强,能抑制细菌的生长繁殖,使炎症消退或被纤维组织包围,则病变逐渐消散或钙化而愈;如果患者体质虚弱,则炎症发展,导致组织坏死,形成干酪样或液化而成空洞,细菌大量生长繁殖,可出现血行播散。

中医认为,本病是癆虫侵蚀肺叶所致。多因禀赋薄弱,或七情、劳倦内伤,色欲过度,大病、久病失调,耗损气血津液,

正气内虚,抵抗力弱,癆虫乘虚侵入,肺脏受损,发为癆疾。病理本质为阴虚,主脏在肺,可累及脾、肾,甚至传遍五脏,而至五脏虚损。先是肺阴受损,肺气耗伤,进而导致肺脾两虚,肺肾阴虚,阴虚火旺,病至后期,可阴损及阳终至阴阳两虚。

【临床表现】

咳嗽、咯血、潮热、盗汗、胸痛、消瘦为肺结核六大主症。疾病初起阶段,先有咳嗽,胸中隐痛,痰中偶带有少量血丝,长期低热或有不规则高热,颧红,食欲减退,形体日渐消瘦,疲乏无力,妇女月经不调。病程长者咳嗽加剧,干咳少痰,咯血量增多,胸闷作痛,午后潮红加重,失眠盗汗,口干少饮,男子遗精,女子闭经,血沉增快,X线检查大多能发现病灶。

【辨证施灸】

肺结核的中医辨证可分为阴虚和阳虚两大类型。阴虚者除上述主症外,兼见午后潮热,颧红升火,咳痰黄粘,口干咽燥,心烦失眠,舌红绛,脉细数;阳虚者兼久咳短气,自汗,形寒肢冷,食少便溏,甚则心悸气怯,面浮肢肿,大肉消脱,口唇紫暗,或五更泄泻,舌光剥而淡或紫暗,苔黄少津,脉微细而数或虚大无力。艾灸疗法对肺癆阳虚证有效。

治则 培补肺气,健脾助运,温肾培元固本。

取穴 ①主穴:肺俞、膏肓俞、大椎、身柱、膈俞、肾俞、关元、太溪。②配穴:风门、心俞、脾俞、胃俞、足三里、百劳、结核穴。

方义 肺俞补肺益气;百劳、膏肓俞、结核穴补虚益损,均为治癆有效穴;大椎、身柱、风门宣肺止咳,治骨蒸潮热;膈俞为血之会,调气补虚,调整肺功能,止血生血;肾俞、关元补肾益精,温阳培元;太溪滋阴降火;心俞养心益血;脾俞、胃俞、足三里健脾益气,补土生金,扶正培元。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸：每次选主配穴 2~4 穴，背部每穴灸 5~7 壮；腹部及四肢每穴灸 7~15 壮，每日 1 次。小儿不宜多灸，艾炷宜小。

(2) 艾炷着肤灸：每次选主配穴 1~3 穴，各灸 1~5 壮，隔日 1 次或每周 2 次。

(3) 艾炷隔姜灸：每次选主配穴 1~3 穴，各灸 3~10 壮，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 7~10 日。Ⅲ型或其它吸收期肺结核：第一疗程取膏肓俞、足三里、三阴交、膏肓俞施艾炷隔姜灸，余施艾条灸，疗程同上，第二个疗程取膈俞、足三里、三阴交，灸法同第一疗程，两组穴位交替使用。溶解期肺结核：主穴取腰俞，配穴足三里；或主穴取膏肓俞，配穴三阴交，灸法同上，两组穴位交替使用。

(4) 艾条温和灸或回旋灸：①每次取主配穴 2~4 个，各灸 15~20 分钟，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 7~10 日。②经常艾条熏灸肾俞、膈俞、足三里，可预防肺结核。

(5) 温灸器灸：每次选主配穴 2~4 个，各灸 15~30 分钟，每日 1 次，疗程同上。

(6) 白芥子敷灸：选结核穴、风门、肺俞、心俞、膏肓俞等穴，然后取炒白芥子末醋调药糊约 2 克，摊于温化的拔毒膏中心，每次选 1 对穴敷灸 1~3 小时，待局部有烧灼感或发泡时去掉，4~5 日敷灸 1 次，诸穴交替应用，共治疗 3 个月。

(7) 蒜泥膏敷灸：取去皮独头蒜 1 头，硫黄末 6 克，肉桂末 3 克，共捣烂，分贴于双侧涌泉穴敷灸 3~5 小时，每日 1 次，连灸 3 日。此法对突然中等量咯血及肺阴虚者效果较好，而持续小量咯血或痰中带血及肺气虚者效果较差。

(8) 肺癆膏敷灸：取肺癆膏(白鴿糞、五靈脂、白芥子、大蒜各 15 克，生甘草 6 克，醋化麝香 0.3 克，先将除大蒜、麝香外諸藥共研細末，再與大蒜搗成膏狀，加入麝香調勻)綠豆大 1 塊置于直徑 2 厘米大小的膠布中心，貼于肺俞、膏肓俞、肺癆、結核穴等中之一對穴上敷灸 30~60 分鐘，諸穴依次交替選用，每周 1 次。敷後若起水疱，不要擦破，保持清潔，讓其自然吸收。

霍 亂

霍亂是指由霍亂弧菌引起的烈性腸道傳染病。臨床以劇烈無痛性頻繁瀉吐米泔樣物，嚴重脫水，電解質紊亂，肌肉痙攣與虛脫為特徵。一般以夏秋季節多发，常呈暴發性流行，死亡率很高。中醫也有“霍亂”一證，因其發病急驟，病變起于頃刻之間，揮霍撩亂，故名霍亂。包括西醫的霍亂、副霍亂、急性胃腸炎、食物中毒等疾病。

【病因病機】

霍亂的病因是霍亂弧菌經水、食物、生活接觸及蒼蠅為媒介傳染而發病。中醫則認為是受暑濕、寒濕等穢濁之氣及飲食不潔，疫毒隨飲入胃，致脾胃受傷，氣機逆亂，清濁不分，升降失司，引起吐瀉交作，津液過度喪失。由于患者體質的差異而形成寒霍亂、熱霍亂和干霍亂的不同。若患者中陽素虛，或重感寒濕，或過食生冷，則病從寒化而發為寒霍亂；如素體陽盛，濕熱內蘊，或復感暑熱之邪，過食辛辣醇酒之物，則病從熱化而發為熱霍亂；如飲食損傷脾胃，重感穢濁之氣，邪阻中焦，升降氣機窒塞，上下不通而形成干霍亂。

【臨床表現】

本病初起即有劇烈腹瀉嘔吐，多無腹痛及里急後重，嘔吐

呈喷射状和连续性,多无恶心,吐泻物为白色混浊的米泔水样,剧烈吐泻常致迅速脱水,轻度脱水表现为唇舌、皮肤干燥,无神志改变;重度脱水则出现“霍乱面容”(面颊深凹,目眶下陷),血压下降,表情淡漠,脉搏细微,如不及时抢救,则危及生命。中医临床辨证可分为寒霍乱、热霍乱和干霍乱。

【辨证施灸】

灸法只适用于寒霍乱。临证除上述见证外兼见吐泻物清稀不甚臭秽,胸膈痞闷,四肢清冷,舌淡苔白腻,脉濡弱。严重者面色苍白,形寒肢厥,倦怠乏力,或眼眶凹陷,指纹螺瘪,或筋脉挛急,甚至大汗淋漓,声音嘶哑,四肢厥逆,拘急转筋,脉沉微欲绝。

治则 轻者温中化湿散寒,多取任脉经穴灸熨或用温针灸;重者回阳固脱,补虚益阴。

取穴 中脘、天枢、神阙、气海。

方义 中脘为腑会,具有健脾益胃,降逆和中,理气止痛,化湿消滞之功;配天枢调整胃肠功能,止泻,消胀,止痛;配气海以疏通腑气;神阙温阳降逆,苏厥固脱,补益脾胃,理气和肠。如四肢厥逆加关元、涌泉;肠绞痛加太冲;热甚加大椎、曲池。

灸法

(1)艾炷无瘢痕灸:每穴灸5~10壮,每日1~2次。

(2)艾炷隔盐灸:用食盐填满脐窝,上置艾炷灸7~10壮,每日2~3次。

(3)艾条雀啄灸:每穴灸10~20分钟,每日2~3次。

(4)灯火灼灸:一般暴灼2~4次,可宣通营卫,使邪外出而症状减轻。

(5)太乙神针灸:取中脘、期门、足三里,各灸5~15分钟。

(6)盐熨灸：取食盐 500 克，炒热布包反复熨灸脘腹部，使气透病止，或熨背部，使手足逆冷转暖。

(7)药熨灸：取吴萸、食盐各 90 克，炒热布包熨灸脐下，可使腹中温热有汗，寒邪可散。

(8)酒熨灸：用上好烧酒炖热，用布蘸热酒摩擦转筋处，以软散为度。

(9)吴萸敷灸：取吴萸 30 克，研细末，用盐卤调敷两足心，包扎固定。

(10)蒜泥敷灸：取大蒜适量，去皮杵烂敷灸两足心，包扎固定。

(11)盐卤淋灸：用热盐卤淋灸两足心，并以手蘸盐卤摩擦之。

按语：霍乱发病急剧，病情凶险，传染性强，必须送医院隔离抢救，以控制症状，挽救生命及防止传染，寒霍乱在抢救中配合灸疗，可增强疗效。

疟疾

疟疾俗称“打摆子”、“冷热病”。因其冷来发抖，热来发吼，极似酷刑，十分痛苦，故称为疟疾。是人体感染疟原虫引起的传染病。临床以周期性寒战发热，头痛出汗，肝脾肿大和贫血为特征。多在夏秋季节发病，有间日疟、三日疟和恶性疟疾，我国以间日疟发病率最高，其次为恶性疟疾。

【病因病机】

疟疾是人体感染疟原虫引起，患者和疟原虫携带者是本病的传染源，雌性按蚊是疟疾的传播媒介。疟原虫通过按蚊叮咬侵入人体后，经血进入肝细胞及红细胞内增殖，并使红细胞周期性大批破坏而发病。中医认为，疟疾是感受时行疟邪、瘵

毒所致。由风寒暑湿、痰食内伤、体虚劳损等因素诱发。由于体质差异和兼感不同而形成不同类型的疟疾证候。疟邪侵入人体，客于半表半里，出入营卫之间，人与阴争而恶寒，出与阳争则发热，正邪交争，阴阳相移则寒热往来。邪在阳分病浅则发作日早，邪陷阴分病深则发作日迟，故疟疾有1日一发、2日一发和3日一发之不同。一般说，感受疟邪而不兼夹时令邪气则发为正疟；如素体阳盛，暑邪内蕴则形成温疟；素体阳虚，复感风寒则发寒疟；如久疟不愈，耗伤气血，可导致虚劳；痰湿郁结，气滞血瘀，痞积成块，可以形成疟母。

【临床表现】

感染了疟原虫之后，一般经过2~4周的潜伏期。发病之初自觉肢体酸楚，阿欠乏力，继则恶寒渐起，毛孔粟起，寒战鼓颌，全身颤抖，即便在炎夏酷暑，或身盖厚被，亦不感温暖，约经1小时左右，寒罢全身灼热，体温可达40℃，头痛如劈，面赤唇红，心烦呕恶，口渴引饮，随后汗出热退身凉，疲惫不堪。如此周期发作，隔日发作1次者为间日疟；3日发作1次者为3日疟；如发作不规则且病情险恶者，即为恶性疟疾；经久不愈，引起肝脾肿大而成为疟母。如屡发不止，大量红细胞被破坏，可引起贫血。在发疟过程中如表现为热甚寒微，甚至但热不寒者，称为温疟；相反寒甚热微或但寒不热者，称为寒疟；身热不扬，胸闷体重者，称湿疟。脉弦，寒战时弦紧；发热时弦滑或数，苔白腻或黄腻。

【辨证施灸】

治则 疏导督脉，和解少阳，祛邪截疟。多取督脉、少阳、厥阴经穴为主，大多于疟发前1~2小时施灸，效果好。

取穴 ①大椎、身柱、膏肓、脾俞、公孙。②大椎、间使、内关、复溜。③大椎、间使、液门、后溪。④大椎、完骨、神阙、内关。

方义 大椎为督脉与手足三阳经之会,可宣通诸阳经之气而祛邪,为截疟要穴;身柱通阳散邪;膏肓补虚截疟;脾俞、公孙健脾化湿;间使、内关疏泄三焦,和解少阳;复溜调补脾肾;液门和解少阳,治寒热往来;后溪宣太阳经气,领邪外出;完骨和解少阳;神阙调理胃肠;诸穴合用,可调阴阳,扶正祛邪。痰多加丰隆;高热加陶道、曲池;久疟加足三里;疟母加章门、痞根、太冲。

灸法

(1) 艾炷着肤灸:每次选1组穴,用小艾炷各灸3~5壮,每日1次。

(2) 艾炷隔姜灸:每次选1组穴,各灸5~7壮,每日1次。

(3) 艾条温和灸:每次选1组穴,每穴灸10~15分钟,每日1次。

(4) 温针灸:每次选1组穴,每穴灸3壮(或10~15分钟),每日1次。

(5) 白胡椒敷灸:①于疟发前1~2小时,先用针刺陶道穴,稍见血后,再取白胡椒1粒,研细末敷于穴上,覆以膏药贴之。②取白胡椒末0.5克,于疟发前敷灸大椎穴,每日更换1次。

(6) 白胡椒丸敷灸:取白胡椒、附子、肉桂各等份,共研细末,水泛为丸如梧桐子大,于疟发前2~3小时,将药丸分别置于陶道、内关穴上,以胶布固定,每日更换1次。

(7) 马齿苋敷灸:取鲜马齿苋含苞枝头7枚,红糖25克,共捣烂于疟发前4小时敷灸内关穴上,24小时更换1次。

(8) 二甘散敷灸:取甘遂、甘草各等份,共研细末,每次取1克,用棉花包裹成团,于疟发前3小时,敷灸神阙穴,包扎固

定,1~2日更换1次。如用于预防,则不拘时间,随时敷灸即可。

(9) 复方巴豆散敷灸:①取巴豆霜、雄黄各等份,共研细末,用水调成膏状,每次取绿豆大药膏置于直径1.5厘米胶布中心,于疟发前5~6小时敷灸耳后乳突部(相当于完骨穴),7~8小时去药,每日1次。②取巴豆仁10克,天南星5克,共研细末,加入少量面粉,用水调和制成直径2厘米圆小饼,于疟发前2小时敷灸大椎穴,以胶布固定,每次灸4~6小时,第二日敷灸陶道,二穴交替使用。

(10) 朝天椒敷灸:取朝天椒1~2个捣烂,于疟发前敷灸大椎穴,3~4小时去药,每日1次。

(11) 山大蒜番薯叶敷灸:取山大蒜、番薯叶各适量,共捣烂于疟发前1~2小时敷灸双寸口,4小时后去药,每日1次,

(12) 桃叶敷灸:取桃叶10克捣烂,于疟发前敷灸寸口,4小时后去药,男左女右,每日1次,可治疗恶性疟疾。

(13) 毛茛叶敷灸:取鲜毛茛叶3~5片,捣烂于疟发前2~4小时敷灸内关或大椎穴上,使之发疱,隔日1次,5次为1个疗程。

(14) 复方烟丝敷灸:取烟丝2份,大蒜、生姜各1份,共捣烂,每次取2分硬币大小1块于疟发前敷灸内关穴上,每日1次。

(15) 复方苍术敷灸:取苍术、白芷、川芎各等量,共研细末,于疟发前取适量药末填满脐窝,用胶布固定,3日更换1次。

(16) 薄荷叶敷灸:取鲜薄荷叶或大蒜适量捣烂,于疟发前1~2小时敷灸内关穴,3~4小时去掉,每日1次。

(17) 旱莲草敷灸:取鲜旱莲草适量捣烂于疟发前敷灸大

椎穴上,待发疱后去掉,隔日1次。

(18) 山柰敷灸:取山柰10克,研细末,用酒调,于疟发前敷灸列缺穴,疟发后去之。

按:灸法治疗间日疟,不但能有效控制症状,而且能使疟原虫转阴,若能配合针刺及抗疟药物治疗,效果更佳。恶性疟疾需送医院抢救,在采用中西药物治疗的同时,亦可配合艾灸疗法,能提高疗效。

慢性支气管炎

慢性支气管炎,简称慢支。凡咳嗽、咯痰或伴喘息,每年累计至少3个月,连续发病2年以上,并排除具有咳嗽、咯痰及喘息症状的其它疾病引起者,称为慢性支气管炎。是一种秋冬季节容易发病的常见病、多发病。据不完全统计,我国患病人数已逾3000万,患病率约为3%~5%,北方患病率高于南方,农村高于城市,多发生于中年以上人群,发病率与年龄呈正相关。本病属中医“咳嗽”、“痰饮”、“喘证”范畴,治疗不及时可进一步发展为阻塞性肺气肿、肺源性心脏病,严重影响劳动力和生活质量,甚至危及生命。

【病因病机】

慢支的病因复杂,目前仍未完全清楚,主要与微生物感染、理化刺激及机体本身因素有密切关系。可由急性支气管炎发展而来,也可因支气管哮喘、支气管扩张等疾病导致支气管分泌物引流不畅、血液循环供应不充分或气管周围组织增生而形成。主要病理改变是粘液腺体增生肥大和杯细胞增多。随着病情的加重,在肺通气功能损害的同时,肺血管也逐渐发生变化,最早变化的是肌化肺小动脉向肺组织的外周延伸。中医认为,本病的发生和发展与外邪侵袭及内伤脏腑有关,《素

问·咳论》说：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”本病的病机与肺、脾、肾三脏功能失调有关，其标在肺，本在脾、肾。肺主气，肺虚气逆，清肃失职，咳嗽气短；脾主运化，脾虚运化失健，聚湿生痰，上渍于肺，肺失宣降，气逆咳喘痰多；肾主气化，肾虚气失摄纳则咳嗽气短，甚则不能平卧。

【临床表现】

慢支以长期反复咳嗽、咯痰或伴喘息为主要症状。早晚咳嗽较重，痰多薄白或呈粘液性，如继发感染则痰量增多，呈黄脓痰，并伴发热恶寒、头痛等症状。肺部检查，初期可无明显体征，有时可听到散在干湿啰音，后期常出现肺气肿征象，胸部X线检查可见肺纹理粗乱。

【辨证施灸】

1. 痰湿咳嗽 久咳不已，咳声重浊或咳逆喘满，喉间痰声漉漉，痰多色白粘稠或吐白沫痰，痰出咳减，伴胸闷脘痞，食少便溏，体倦乏力，苔白腻，脉濡滑。

治则 健脾燥湿，化痰止咳。

取穴 肺俞、脾俞、太渊、合谷、丰隆。

方义 太渊为肺之原穴，配肺俞、脾俞可健脾化湿，补益肺气，标本同治；丰隆配合谷以和胃行气布津，则痰浊自化，咳嗽可平。胸脘痞闷重者加足三里、内关以健脾化湿，引气下行。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸：每次取2~4穴，各灸3~7壮，每月1次，连续3次。亦可于三伏天施灸，每伏灸1次。

(2) 艾炷无瘢痕灸：每次取3~4穴，各灸3~5壮，每日1次。

(3) 艾炷隔姜灸：每次取3~5穴，各灸3~5壮，每日或隔日1次，7~10次为1个疗程，疗程间休息7日。如在三伏

天施灸，有预防或减轻发作效果。

(4) 艾条温和灸：每次取 3~4 穴，各灸 10~15 分钟，灸至局部皮肤潮红或感温热舒适为度。每日或隔日 1 次，5~10 次为 1 个疗程，疗程间休息 7 日。

(5) 斑螫发泡灸：取斑螫末如米粒大，分别置于肺俞、脾俞、肝俞上敷灸，以胶布固定，灸至发泡去药，保护清洁，让其自然吸收。

2. 气虚咳嗽 咳嗽日久，咳声低沉无力，气短息微，痰多清稀，自汗畏风，神疲乏力，易患感冒，舌淡苔薄白，脉弱。

治则 补益肺气，化痰止咳。

取穴 大椎、身柱、肺俞、脾俞、肾俞、气海、丰隆。

方义 大椎、身柱为督脉经穴，可通阳益气，助肺宣降；肺俞、脾俞、肾俞合用，补益肺气，温运脾肾；气海和肾俞益气培元，补肾固精；丰隆属脾络胃，助脾胃运化而化痰浊。

灸法

(1) 艾炷灸、艾条温和灸：同痰湿咳嗽。

(2) 温盒灸：选大椎、肺俞（或风门）、膏肓俞，每穴 15~20 分钟，每日 1 次。

(3) 毛茛敷灸：先将剪有绿豆孔大的胶布块的小孔对准肺俞、脾俞、肾俞、气海等穴贴好，再取毛茛末适量用姜汁调成稠膏状，于晴天中午时取绿豆大的药膏分别置于胶布小孔内的穴位上，用胶布固定敷灸，待局部有灼痛感时去掉，隔日 1 次，3 次为 1 个疗程。

3. 阳虚咳嗽 咳嗽气短喘促，痰涎清稀，头眩心悸，怯寒肢冷，足跗水肿，小便不利，舌苔白润或灰腻，脉沉细而滑。

治则 温阳散寒，化气行水。

取穴 肺俞、膏肓俞、肾俞、命门、神阙、关元。

方义 肺俞补气利气；肾俞、膏肓俞补肾益气，增强体质，为治疗一切慢性疾病之常用要穴，又有宣肺止咳作用；命门、关元温肾培元；神阙温阳。诸穴合用，具有温阳散寒，化气行水之功。

灸法

(1) 瘢痕灸、艾炷灸、隔姜灸、艾条灸：同痰湿咳嗽。

(2) 复方公丁香敷灸：先取公丁香 0.5 克，半夏、苍耳子各 3 克，白芥子 4 克，麻黄、肉桂各 5 克，共研细末，然后用 75% 酒精消毒神阙，趁酒精未干时，将药末填满穴位，以胶布固定，2 日更换 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 7 日。

(3) 三白膏敷灸：取白芥子、白矾各 30 克，共研细末，加面粉适量，用米醋调成糊状，敷灸时每次选 3~5 穴，取少许药糊置穴位上，胶布固定，12 小时去掉，6 日为 1 个疗程。

(4) 芥砒膏敷灸：取白芥子 1.5 克，砒石 0.3 克，共研细末，用食醋调成糊状，取少许置穴位上，胶布固定，每次敷灸 2~3 穴，每日 1 次，5 次为 1 个疗程。

4. 预防慢性支气管炎发作

(1) 艾炷或艾条灸：取风门、陶道、气喘、肺俞、膏肓俞、肾俞、天突、膻中，每次选 2~4 穴，经常施艾炷或艾条灸。

(2) 复方白芥子敷灸：①取白芥子、延胡各 21 克，甘遂、细辛各 12 克，共研细末，每次取 1/3，加麝香少许，用姜汁调成稠膏状，分摊于 5 块直径为 3 厘米的胶布上，分别敷贴于肺俞(双)、肾俞(双)、关元穴上，以胶布固定，敷灸 4~6 小时，10 日 1 次，3 次为 1 个疗程。②取白芥子、甘遂、细辛、丁香、苍术、川芎各等份，共研细末，用姜汁调成糊状，制成直径约 1 厘米大小药饼，分别敷贴于肺俞、风门、定喘、天突、膻中等穴上，以胶布固定，2~3 日更换 1 次，5 次为 1 个疗程。慢性咳嗽，用

上述方法冬病夏治,于三伏天,初、中、末伏每伏敷灸 1 次,疗效很好。

按:慢性支气管炎咳嗽,除选取督脉经穴和背俞穴灸治外,亦可在背部及胸前寻找病理反应点灸治。足三里引气下行,丰隆能祛痰,对咳嗽痰多者与胸背部诸穴同用,可加强疗效。胸背部穴位施灸时,使热力感传到胸腔,每可取捷效。慢性支气管炎是一种易反复发作的慢性疾病,除发病期治疗外,加强缓解期的扶正固本治疗可以预防复发,夏季三伏天采用敷灸疗法,是一种较好的治疗方法。

支气管哮喘

支气管哮喘(简称支哮),俗称“气喘病”或“吼病”。是由于内在或外在过敏原或非过敏原等因素导致以气道高反应性和可逆性狭窄为特征的疾病。以阵发性呼气性呼吸困难,喉中哮鸣,甚至紫绀为主要特点。一年四季均可发病,尤以寒冷季节及气候急剧变化时发病较多,夏季可转轻或缓解;任何年龄均可罹患,但以 12 岁以前开始发病者较为多见。属中医的“喘证”、“吼证”、“痰饮”范畴。

【病因病机】

支哮的发病与遗传及免疫因素有关,机体本身的特异体质是发病的基础,引起变态反应的抗原为诱发因素。发病机制甚为复杂,可由特异性(吸入性抗原如花粉、螨尘及真菌等)或非特异性(如组织胺、乙酰胆碱、冷空气等)刺激所激发,引起支气管平滑肌痉挛,粘膜充血、水肿,粘液腺分泌增多和炎细胞浸润,因而支气管口径缩小,衬里增厚,管径广泛阻塞,导致呼吸困难。此外,温度、湿度、气候、食物、药物、运动、内分泌、精神因素等,亦可引起支气管痉挛而发生哮喘。

中医认为,本病是在体质素虚,禀赋异常,肺脾肾功能失常,阳气易于逆乱,伏痰留饮内蓄的基础上,外感六淫,精神刺激,过度劳累等因素诱发。其发病与肺、脾、肾三脏关系密切。肺主气,宣散津液,肺虚津液失于宣散而成痰;脾主运化,脾虚运化失健,聚湿生痰上渍于肺,故有“脾为生痰之源,肺为储痰之器”之说;肾主气化,肾虚水不化而上泛为痰。在痰饮内伏,痰湿壅肺的情况下,一旦受外界各种不良因素刺激,就可出现气动痰升,痰气搏结,阻塞气道,发为哮喘。

【临床表现】

哮喘典型发作者常有咳嗽、胸闷或鼻痒、喉痒、喷嚏等先兆症状或无先兆症状突然发作。一般多在夜间发病,突感胸闷痰多喘逆,呼吸困难,喉中哮鸣,呼气延长,甚则张口抬肩,强迫端坐呼吸,汗出淋漓,唇指紫绀,发作停止前开始咳嗽,咳出大量泡沫样痰液而感松快。发作时可见胸部饱满或三凹现象,叩诊呈过度清音,两肺满布哮鸣音,甚至并发肺气肿,如一次哮喘发作持续时间过长成为哮喘持续状态,可并发心衰。

【辨证施灸】

哮喘有寒热虚实之别,病期有发作缓解之分,久病及脏时又有累及肺脾肾之不同,故治疗应有区别。艾灸疗法一般多适用于冷哮和虚喘。

1. 冷哮 突然哮喘,遇寒诱发或加剧,喉中哮鸣,胸闷如窒,呼吸急促,不能平卧,咳痰清稀,背冷,口不渴或喜热饮,面色青灰或苍白,或兼恶寒发热等表证,舌淡苔白滑,脉浮紧。

治则 宣肺散寒,豁痰平喘。多取背俞及任、督脉及阳明经穴。

取穴 大椎、风门、肺俞、天突、膻中、尺泽、列缺、丰隆。

方义 大椎、风门疏风散寒,宣通肺气;肺俞为肺气赖以

输转流注之所在,治肺系外感内伤,喘咳上逆诸证,均具功效,配风门疏散太阳经气;天突平喘;膻中为宗气之所在,主气机宣降,又为气会,可以通调气机;列缺、尺泽宣肃手太阴经气;丰隆化痰,数穴合用有解表散寒,宣肺化痰,平喘降逆之功,使寒饮得蠲,则哮喘可平。

灸法

(1) 艾炷化脓灸:于小暑至白露间,每次选1穴,灸5~9壮,灸后敷以药膏,保持灸疮清洁,可有20~30日化脓期,隔日1次,3~4次为1个疗程,每年灸1疗程,可连灸3年。

(2) 艾炷直接灸:每次取2~4穴,各灸3~5壮,隔日1次,5次为1个疗程。

(3) 艾炷隔姜灸:每次取3~5穴,各灸5~7壮,以皮肤潮红为度,每日或隔日1次,必要时1日2次,7日为1个疗程。

(4) 艾条温和灸:每次取3~4穴,各灸5~10分钟,每日或隔日1次,5次为1个疗程。

(5) 温针灸:每次取2~4穴,各灸3壮(或10~15分钟),每日或隔日1次。

(6) 太乙神针灸:在天突、膻中、气海、丰隆穴各灼灸10~15分钟,隔日1次。

(7) 复方桃仁敷灸:取桃仁60克,栀子20克,杏仁6克,胡椒3克,糯米2克,共研细末,用鸡蛋清调成糊状,分为四份,分别敷灸双涌泉穴及与之相对应的足背阿是穴,24小时后去掉,隔12小时后再敷灸第二次,3次为1个疗程。

(8) 白芥子末敷灸法:①取白芥子末适量,用清水调成糊状,于哮喘发作时敷灸背部肩胛区间30~60分钟,敷灸处局部皮肤呈现红晕发热微痛或起疱,每日或隔日1次,3次为1

个疗程。②取白芥子 30 克,甘遂、细辛各 15 克,共研细末,用生姜汁调成糊状,每穴取药糊如枣核大,分别敷灸大椎、肺俞、膏肓俞、璇玑、膻中等穴,持续 30~60 分钟去药,局部皮肤反应同上,如起疱过大,可用消毒针挑破流尽黄水消毒包扎。

此外,热哮可取生石膏、麻黄各 15 克,杏仁、甘遂、明矾、白芥子各 10 克,共研细末,用醋调制成稠膏状,敷灸神阙,胶布固定,每日换药 1 次。

2. 虚喘 哮喘发作徐缓,持续不解,声低息微,动则喘剧,烦躁汗出,面色苍白。如肺脾两虚则自汗畏风,痰液清稀,纳呆便溏,头面、四肢水肿,倦怠乏力,舌胖淡、边尖有齿痕,苔薄白,脉濡弱;如肺肾两虚则咳喘短气,动而气促,呼长吸短,心悸目眩,腰膝酸软,脑转耳鸣,盗汗遗精,恶寒肢冷,面色黧黑,舌淡,脉沉细无力。

治则 健脾益气,肺肾双补,培元固本。

取穴 定喘、膏肓俞、肺俞、天突、璇玑、膻中、气海、关元、太渊。

方义 定喘能缓解哮喘;膏肓俞治虚劳咳嗽气喘;肺俞补益肺气,与太渊配伍起补土生金的作用;天突、璇玑宽胸降逆,宣肺化痰;膻中为气会,理气定喘;气海、关元补肾纳气。肺脾气虚加脾俞、足三里以健脾益气,扶助后天之本;肺肾两虚加肾俞、命门、太溪以补肾纳气,培补先天之本。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸:每次选 1~2 穴,各灸 3~9 壮,10 日 1 次,3 次为 1 个疗程。

(2) 药物艾炷瘢痕灸:取陈艾叶 500 克,硫黄 30 克,麻黄、桂枝、肉桂、羌活、独活、乳香、没药、细辛、干姜、丁香、白芷、川椒、苍术、防风、广木香、半夏曲各 15 克,苏子、牙皂、乌

药、川乌、菖蒲、陈皮、甘草、炮甲片各 9 克，麝香 1 克，上药共研细末，与艾绒拌匀，制成小艾炷（直径 0.6 厘米～0.8 厘米、高 1 厘米）。每次取 3～4 穴，各灸 5～9 壮（灸前亦可先将穴位皮肤消毒，用 1% 普鲁卡因行局部麻醉后，用大蒜汁涂穴上，再置艾炷施灸），每年灸 1 次或 2 年灸 3 次，成人共灸 3 次，小儿只灸 1 次。

（3）艾炷无瘢痕灸、艾条温和灸：参照冷哮灸法。

（4）毛茛叶敷灸：取鲜毛茛叶适量捣烂敷大椎穴上，使之发泡，10 日敷灸 1 次，3 次为 1 个疗程。灸疱保持清洁，让其自然吸收，灸疱过大，可挑破流尽黄水，消毒包扎。

（5）斑蝥敷灸：取斑蝥 1 只，去翅、足捣烂敷大椎或身柱穴上，使之发泡。灸疱处理同上。

（6）三健膏敷灸：取天雄、川乌、附子、桂心、官桂、桂枝、细辛、川椒、干姜各等份，上药用麻油煎熬，加黄丹收膏，摊于胶布上，敷灸肺俞（双），3 日更换 1 次，10 次为 1 个疗程。

3. 预防支气管哮喘发作

（1）艾炷或艾条灸：同慢性支气管炎。

（2）麝香大蒜敷灸：于端午节中午 12 时，让患者伏卧，用肥皂水、盐水清洁第七颈椎棘突至第十二胸椎棘突以脊柱为中线宽 3 厘米的背中线区域皮肤后，取麝香 1 克～1.5 克（研细），均匀地撒在上述消毒区域内，再取去皮紫皮大蒜 10～15 头，捣烂敷于麝香上面，油纸纱布覆盖，胶布固定，敷灸 60～75 分钟（小儿 30～40 分钟）后去掉，清洗局部，然后涂布消毒硼酸软膏，包扎固定，每年 1 次，连续敷灸 3 年。

（3）冬病夏治哮喘膏敷灸：①取白芥子、延胡各 21 克，甘遂、细辛各 12 克。②取白芥子、半夏各 21 克，细辛、延胡各 10 克。③白芥子 21 克，葶苈子、韭菜子、白芷、细辛各 12 克，麻

黄、甘遂各9克。任选1方,共研细末,加麝香少许调匀,用姜汁调制成直径2厘米、厚度1厘米的药饼,于每年三伏(初、中、末)天时,分别敷贴于肺俞、心俞、膈俞或定喘、肺俞、膏肓俞穴上(两组穴位交替应用),胶布固定。咳嗽甚者加天突;胸闷气窒加膻中,每次敷灸4~6小时。如果敷灸后局部有灼痛感,可提前取下;如无不适感觉亦可延长敷灸时间。每伏(10日)敷灸1次,共3次,可连续敷灸3年。敷灸后皮肤潮红或起小疱是正常现象,不要擦破,禁用水洗,保持清洁,让其自然吸收,若水疱较大,也可挑破消毒包扎。

慢性阻塞性肺气肿

慢性阻塞性肺气肿,是指终末细支气管远端气腔异常扩大与气腔壁的破坏。仅有气腔增大而不伴气腔壁破坏,即肺过度充气,属功能性肺气肿,如代偿性肺气肿和老年性肺气肿,属中医“虚喘”、“肺胀”范畴。

【病因病机】

慢性阻塞性肺气肿的发生与感染、遗传因素、环境因素、大气污染及吸烟等有关,常继发于慢性支气管炎、支气管哮喘和肺纤维化等疾病,亦是这些疾病的常见并发症。中医认为,本病是由于久咳、久喘、支饮、肺癆等肺系疾病反复发作,延久不愈,致使肺叶胀满,气血津液运行敷布障碍、肺脾肾虚损、肺失主气、脾失健运、肾失纳气所致。晚期尚可发展为肺源性心脏病,且易并发自发性气胸与肺部急性感染。

【临床表现】

慢性阻塞性肺气肿的主要症状为慢性咳嗽、咯痰、胸闷和逐年加重的呼吸困难或劳力性呼吸困难,常伴有食欲减退和体重减轻,严重时出现紫绀,头痛,嗜睡,神志恍惚等呼吸衰竭

症状,常见桶状胸,肋间隙增宽,上腹角变钝,语颤减弱,呼吸活动减弱,叩诊反响增强,心界缩小,呼吸音减弱,呼气延长,肺部可闻干湿啰音,X线检查可见两肺透亮度增强,有阻塞性肺功能障碍。

【辨证施灸】

慢性阻塞性肺气肿是多种慢性肺系疾病反复发作,迁延不愈引起肺叶胀满而出现胸闷气短,喘咳倚息不得卧,甚则脘腹胀满,水肿,目如脱状,唇指紫绀等肺肾两虚证候。偏于阳虚者兼见喘促声低气怯,呼多吸少,气不得接续,形瘦神疲,汗出肢冷,腰膝酸软,面青唇紫,舌胖淡或黑润,脉微细或沉弱;偏于阴虚者兼见咳喘面红,口干咽燥,汗出如油,足冷,舌红少津,脉细数。

治则 补肾培本,纳气平喘。阳虚者温补肾阳;阴虚者滋补肾阴。多取任脉、肺经及背俞穴。艾灸疗法常用于阳虚者及缓解期。

取穴 大椎、肺俞、膏肓俞、心俞、肾俞、膻中、气海、关元、太渊、足三里、太溪。

方义 大椎助阳益气;肺俞补益肺气;膏肓俞增强体质定喘促;心俞宁心定悸;肾俞、气海、关元、太溪补肾纳气,培元补先天之本以定喘止嗽;膻中通调气机;太渊补土生金,益肺气;足三里健脾以补后天之本。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸或隔物(附子、姜)灸:每次取3~5穴,各灸3~5壮,以温热为度,每日或隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息7日。

(2) 温针灸:每次取3~5穴,各灸3壮(或5~15分钟),每日或隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息7日。

(3) 复方白芥子敷灸:取白芥子、延胡、细辛各 30 克,甘遂 15 克,共研细末,加面粉适量,用姜汁调制成直径 2 厘米大小药饼,敷灸百劳、肺俞、膏肓俞,以胶布固定,2~4 日更换 1 次。

按:慢性阻塞性肺气肿常是慢性支气管炎、支气管哮喘的并发症,病程长,证情重,故应加强缓解期的施灸治疗及呼吸功能锻炼,对肺功能有一定改善。除上述治疗外,亦可参照慢支及支哮的治疗。

慢性肺源性心脏病

慢性肺源性心脏病是慢性支气管炎、肺气肿等肺胸疾病或肺血管病变引起的心脏病,简称肺心病。呈现肺动脉高压、右心肥大或右心功能不全。属中医“咳喘”、“痰饮”、“心悸”、“水肿”等范畴。

【病因病机】

我国绝大多数肺心病是在慢性支气管炎、肺气肿基础上发生的。是由肺胸疾病或肺血管慢性病变逐渐引起肺动脉高压,进一步发展成右心肥大,导致肺心病,最后发生呼吸、循环衰竭。发病从小动脉开始,早在慢性支气管炎阶段,就逐渐出现肌化肺小动脉向肺组织的外周延伸,随后出现肺中动脉中层肥厚,肺小动脉管腔狭窄或闭塞,阻塞性通气功能障碍逐渐加重,发生肺泡通气量不足和换气功能障碍,肺动脉高压逐渐形成,右心室负荷增加,右心肥厚扩大,心肺功能不全,最后导致呼吸、循环衰竭。中医认为,本病多因慢性咳喘反复发作,迁延不愈,逐渐引起心肺脾肾虚损,肺脾肾的功能失常,导致肺无以通降之力,脾无输转之权,肾失蒸化之职的病理改变,故出现水液内停,为痰为饮,逆于肺则为咳喘,外溢于肌肤则发

水肿,水气凌心则心血瘀阻,痰浊犯心则神昏。

【临床表现】

肺心病发展缓慢、病程长,早期为呼吸和循环功能代偿期,至晚期则出现心肺功能不全的表现。患者长期慢性咳嗽咯痰,胸闷气促,呈肺气肿体征。随着病情的发展,出现心悸气短、呼吸困难、头痛乏力、食欲不振、腹胀等症状。当患者动脉血氧分压(PaO_2) <8.8 千帕、动脉血二氧化碳分压(PaCO_2) >6.6 千帕时,即发生呼吸衰竭而紫绀。缺氧严重时,患者躁动不安,昏迷抽搐。右心衰竭时可见颈静脉怒张、肝肿大、水肿及腹水,心电图、X线检查均有相应变化。

【辨证施灸】

缓解期表现为咳嗽咯痰,气短动则尤甚,腰腿酸软,食少乏力或心悸,苔白,脉无力。发作时,咳喘加重,甚则喘息不能平卧,痰多色黄粘稠,脉沉细。后期及心则心悸,水肿;痰迷心窍则神昏谵语,昏迷抽搐,大汗淋漓,吐血便血,肢冷脉微,甚至阴阳离决而死亡。

治则 温肾纳气,温阳行水。

取穴 肺俞、脾俞、肾俞、天突、中府、膻中、巨阙、气海、尺泽、内关、神门、足三里、丰隆。

方义 肺俞、脾俞、肾俞宣肺健脾补肾,调气利湿行水;天突宣肺化痰,宽胸降逆,治咳喘;膻中、巨阙宽胸利膈,化痰宁心;中府宣肺利气,止咳平喘;气海补肾纳气;尺泽清肺气;内关、神门宽胸宁心安神;足三里、丰隆健脾助运,化湿除痰。

灸法

(1) 艾炷麦粒或隔物(附子饼或姜)灸:每次取3~5穴,各灸3~5壮,隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息7日。急性发作时在百会穴灸3~5壮,每日1次。

(2) 艾炷隔盐灸：急性发作时在神阙穴隔盐灸 3~7 壮，每日 1 次。

(3) 艾条温和灸：每次取 3~5 穴，各灸 15~20 分钟，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 7 日。

冠状动脉粥样硬化性心脏病

冠状动脉粥样硬化性心脏病，是指冠状动脉病变引起管腔狭窄或闭塞，导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病，与冠状动脉痉挛统称为冠状动脉性心脏病，简称冠心病。是中、老年人常见的多发病。属中医的“胸痹”、“真心痛”、“厥心痛”范畴。

【病因病机】

冠心病的病因和发病机制至今尚未完全清楚，一般认为与年龄大、吸烟、肥胖及高血压、高脂血症、糖尿病、某些内分泌功能低下及遗传因素有密切关系。其中脂质代谢紊乱，动脉管壁功能结构的破坏是引起和形成粥样斑块的重要因素，同时也与高级神经活动障碍有关。中医认为，本病的发生与寒邪内侵、恣食肥甘、情志失调、年老体虚等因素有关。在这些因素的作用下，形成气滞血瘀、痰浊内生、寒凝痹阻、阴虚阳亢，以致心脾肝肾诸脏虚损，阴阳失调而发病，其中以心阳不振，瘀血痹阻为主。

【临床表现】

冠心病的临床表现依不同类型及痹阻轻重而异，隐性冠心病痹阻轻者，常无自觉症状，仅有心电图心肌缺血性表现；典型心绞痛常在劳累、情绪激动、饱食、受寒后突然发生胸骨后压榨感或心前区绞痛、刺痛、刀割样痛，伴汗出、压迫窒息感，疼痛可向左颈、肩背放散，持续数分钟可逐渐缓解。当心绞

痛发展到心肌梗死、心肌硬化的严重阶段时,可发生难以缓解的心前区频繁持续剧痛、休克、心律失常、心力衰竭等。

【辨证施灸】

中医辨证可见寒凝心脉、痰浊痹阻、气滞血瘀、心阳不振、心脾两虚、阳气暴脱等证候。

治则 扶正祛邪,标本同治。

取穴 心俞、厥阴俞、膻中、巨阙、通里、间使、内关、足三里。

方义 心俞为心之背俞穴,是心气贯注的门户,有补虚泻实的作用;厥阴俞宽胸理气,宁心和营,治心痛;膻中为气会,可调心肺之气;巨阙助心,缓解心绞痛;内关为心包之络,阴维之会,有宽胸理气,快膈畅中的作用,为治心绞痛要穴;通里为心之络,能活血通络止痛;间使清心宁神治心痛。心阴虚加三阴交、神门、太溪以养阴补气安神;心阳虚加命门、气海、关元以温振心阳;痰浊痹阻加肺俞、中脘、丰隆以祛痰化浊;气滞血瘀加膈俞、阴郄、郄门以活血化瘀。

灸法

(1) 艾炷隔附子饼灸:心阳不振取关元、气海穴各灸 7~9 壮,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次取 3~5 穴,各灸 15~20 分钟,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸:每次取 2~4 穴,各灸 3 壮(或 5~10 分钟),每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(4) 硝酸甘油膏敷灸:每晚临睡前用硝酸甘油膏敷灸心俞,每晚 1 次。

(5) 复方川芎敷灸:取川芎 3 克,冰片 1 克,硝酸甘油 0.6 毫克,共研细末,制成黄豆大药丸 2 粒,分别敷灸膻中、内关

穴,以胶布固定,每日1次,5次为1个疗程。

(6) 冠心膏敷灸:用冠心膏(由丹参、当归、川芎、红花、乳香、没药等组成)敷灸心俞、虚里、膻中,每日更换1次。

(7) 救心膏敷灸:取硝酸甘油1毫克,七厘散20毫克,共研细末,制成油膏剂,于心绞痛发作时,均匀地敷灸心前区2厘米~5厘米大小范围,每日1次,连续灸至心绞痛缓解为止。

(8) 心通膏敷灸:用心通膏(丹参、三七、檀香、乳香、没药、郁金、冰片等组成)敷灸心俞、膻中、鸠尾、天池,3日换1次。

(9) 止痛膏敷灸:取当归、川芎、乳香、没药、细辛、白芷、半夏、丹皮、干姜、大黄各等量,制成止痛膏,敷灸心俞、厥阴俞、心前区、膻中、内关,24小时去药,隔日1次。有缓解心绞痛,改善心电图的作用。

(10) 复方山楂膏敷灸:取白芍270克,厚朴100克,山楂浸膏20克,葛根浸膏10克,甘草浸膏8克,前2味共研细末,加入诸浸膏及乳香、没药醇液70毫升,鸡血藤挥发油6毫升,细辛挥发油1毫升,冰片少许混合,用黄酒调成糊状,放入脐窝,用胶布固定,2日换药1次。

(11) 预防冠心病:取心俞、膻中、内关、郄门、足三里,经常施艾炷或艾条熏灸。

按:灸疗对缓解和减少心绞痛的发作有一定作用,可作为治疗心绞痛的一种辅助疗法。在应用中西药物治疗心绞痛的同时配合灸疗,可提高药物的疗效。冠心病患者在心俞、厥阴俞及附近的背俞穴和步廊穴周围往往能找到敏感点或压痛点,在这些反应点施灸,效果更理想。

心 悸

心悸，古称“惊悸”、“怔忡”，指患者自觉心跳异常，惊慌不安，不能自主或有脉搏跳动参差不齐的一种证候。惊悸常因情绪激动，惊恐劳累而诱发，时作时辍，不发作时如常人，其证较轻，多属功能性病变；怔忡是心跳剧烈、持续不止、终日觉心中悸动不安，稍劳更甚，全身状况较差，病情较重，多属器质性病变。惊悸日久不愈，可发展成为怔忡，故两者往往并提，合称心悸。各种心脏病、神经官能症、甲状腺功能亢进、贫血等均能引起心悸。西医的心律失常，可按心悸辨证施灸。

【病因病机】

心悸的发生主要由于先天体质虚弱或后天劳倦、久病、失血等致气血阴阳耗损，脏腑功能失调，以及外邪侵袭、暴受惊恐、情志内伤、痰浊内停、气滞血瘀等导致心脏受损、心气虚弱、心脉不畅、心失所养、心神不宁引起。此外，某些疾病治疗不当，损伤气血；药物毒性刺激，损伤心阴、心气；嗜好烟酒肥腻，痰热内生，扰乱心神，亦可导致心悸。现代医学认为，心悸是一种常见症状，产生的原因很多，凡能影响心脏的起搏和传导的因素，都有可能产生心律失常而使人感到心悸。有的是心脏本身的疾病引起，如各种心脏病；许多心脏以外的因素，如发热、贫血、妊娠、药物、水和电解质紊乱、自主神经系统功能失调，甚至心神经官能症，也都发生心悸。此外，有些健康人在剧烈运动，情绪异常激动，烟、酒、茶等过量时，也发生短暂的心悸。

【临床表现】

患者自觉心跳异常，惊慌不安，常突然发生或停顿，难以自制，伴眩晕，胸部压迫感，呼吸不畅，倦怠乏力，脉象呈现迟、

数、促、结、代、疾等改变,严重者可发生心绞痛或晕厥。听诊可发现心率、心律出现各种异常,心电图检查可发现各种程度不同的异常改变征象。

【辨证施灸】

1. 气血不足 心悸不安,心中有空虚感,动则悸发,静则悸缓,善惊易恐。气虚为主者,多梦易醒,头晕气短,自汗乏力,纳呆腹胀,面色少华;血虚为主者,头晕目眩,两目干涩,四肢麻木,面色萎黄,唇甲淡白,舌淡苔白,脉细弱或结代。

治则 益气补血,安神定悸。

取穴 心俞、脾俞、膈俞、膻中、气海、关元、间使、内关、足三里。

方义 心俞、膻中调心气;脾俞、足三里健脾益气,培补气血生化之源;膈俞为血之会,配内关宽胸宁心,养血定悸;气海、关元培补元气而固本;间使宁心安神,治心痛心悸,诸穴相配,益气养血,安神定悸,标本同治。失眠加神门;善惊加大陵,虚烦多梦加三阴交、太溪。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 2~4 穴,各灸 5~7 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 15~20 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸:每次选 2~4 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(4) 灯火灼灸:每次选 2~4 穴,从上到下,先背后胸的顺序点灼,每穴灼灸 1 下,3 日 1 次,5 次为 1 个疗程。

2. 心阴亏虚 心悸易惊,虚烦不眠,多梦易醒,头晕耳鸣,盗汗口干,手足心热,舌红少津,脉细数。

治则 滋阴养心,安神定悸。

取穴 心俞、巨阙、阴郄、郄门、神门、三阴交、太溪。

方义 心俞、巨阙俞募相配,镇惊安神,宁心定悸;阴郄、郄门滋阴定悸;神门养心安神定悸;三阴交、太溪滋阴补肾,清心安神。多梦加太冲;面赤加劳宫。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~4穴,各灸3壮,用补法,每日1次,10次为1个疗程,疗程间休息3日。

(2) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸10~15分钟,7次为1个疗程,疗程间休息3日。

3. 脾肾阳虚 心悸倦怠,眩晕气短,胸脘痞满,腹胀纳呆,腰痛阴冷,大便溏薄,畏寒肢凉,水肿尿少,面色苍白,舌淡胖,苔白腻,脉沉细迟或结代。

治则 温补脾肾,利水宁心。

取穴 脾俞、肾俞、命门、关元、内关、足三里。

方义 肾俞、命门、关元温肾壮阳;脾俞、足三里健脾化湿;内关宁心安神。

灸法

(1) 艾炷隔附子饼灸:每次选3~4穴,各灸5~7壮;每日或隔日1次,7次为1个疗程,疗程间休息3日。

(2) 艾条雀啄灸:每次选3~5穴,各灸10~15分钟,每日1次,10次为1个疗程。

4. 痰浊痹阻 心悸眩晕,胸闷气短,脘痞痰多,食少腹胀,苔白腻,脉弦滑。

治则 理气化痰,宁心安神。

取穴 肺俞、脾俞、内关、足三里、丰隆、太白。

方义 肺俞、太白宣肺理气利痰;脾俞、足三里健脾燥湿

化痰；内关宁心，对心率有双向调节作用，为治心悸要穴；丰隆化痰浊，清神气。痰火扰心者加尺泽。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 2~4 穴，用泻法，各灸 3~5 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 灯火灼灸：每次选 3~4 穴，用阴灯火灸法，各灼灸 1 下，3 日 1 次，5 次为 1 个疗程，疗程间休息 10 日。

5. 血脉瘀阻 心悸怔忡，短气喘息，胸闷心痛，或形寒肢冷，面色紫暗，舌暗红或有瘀点瘀斑，脉涩或结代。

治则 心俞、膈俞、气海、曲泽、少海、血海。

方义 心俞、膈俞、血海益气通脉，活血化瘀；气海益气助阳以治本；曲泽、少海强心定悸以治标；心悸绞痛加至阴、内关。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 2~4 穴，各灸 4~7 壮，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 15~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸：每次选 2~4 穴，每灸 3 壮（或 15~20 分钟），每日 1 次，7 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 日。

(4) 灯火灼灸：每次选 4 穴，各灼灸 1 下，3 日 1 次，重症每日可灸 1~2 次，5 次为 1 个疗程，重灸时，避开原灸点。

(5) 活血止痛膏敷灸：取乳香、没药、白芷、当归、川芎、桂枝、细辛、山柰各等量，共研细末。敷灸时取少许药末放在直径 1 厘米的胶布中心，贴敷在上述穴位上，然后用艾条灸 20 分

钟,每日1次,2日更换1次药膏,5次为1个疗程。

此外,如水气宁心引起心悸不安者,可在心俞、关元、间使、足三里、阴陵泉施温针灸,每穴10~20分钟,每日2次,10次为1个疗程。肿甚脉微欲绝者加内关、太渊穴。经常艾灸少海、手三里穴可预防心悸;艾灸心俞、通里穴预防心律失常;艾灸郄门、内关穴预防心动过速或过缓。

按:艾灸疗法不仅有减轻或控制心悸发作的较好效果,而且对引起心悸的原发病也有一定治疗作用,但如果心悸严重或出现心衰时则应迅速送医院救治。

失 眠

失眠,古称“不寐”、“目不瞑”、“不得卧”、“不得眠”等,是指经常性睡眠减少而言,或不能入睡,或睡后易醒,醒后再不能入睡,甚至彻夜不眠的一种病症。很多疾病都可以引起失眠的症状,如神经衰弱、神经官能症、贫血、高血压病、脑动脉硬化病、更年期综合征等。凡出现失眠者,均可按本篇辨证施灸。

【病因病机】

引起失眠的病因很多,凡外感、内伤诸因素导致脏腑功能紊乱,气血阴阳的相对平衡失调,以致心神被扰,神不守舍,均不得安眠。主要病位在心。由外感引起者,主要见于热病过程中,一般在热病治愈后,失眠随之而愈;内伤引起者,多因暴受惊恐,情志内伤,思虑劳倦,耗伤心脾,或禀赋不足,久病失调,房劳伤肾,或年迈体衰等,导致心虚胆怯,气血不足,心神失养,或阴虚火旺,心肾失交,痰热扰心及胃气不和,均能引起失眠。

【辨证施灸】

失眠之治,一般于睡前1小时施灸,疗效更佳。以选心、

脾、肝、肾诸经及背俞穴为主。

1. 心脾不足 夜寐虚烦难眠,或睡中多梦易醒,醒后更难入睡,伴心悸气短,头晕耳鸣,神疲健忘,饮食不香,面色无华,舌淡苔薄,脉细弱。

治则 补益气血,养心安神。

取穴 心俞、脾俞、膈俞、神门、足三里、三阴交。

方义 心俞、膈俞、神门养心补血,安神定惊;脾俞、足三里健脾益气养血,培补气血生化之源;三阴交和脾胃,益气血;多梦加魄户;健忘加百会、志室。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每晚 1 次,7 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 10~15 分钟,每晚 1 次,7 次为 1 个疗程。

2. 心肾不交 心烦不寐、入睡困难,多梦易醒,心悸善惊,头晕耳鸣,烦热盗汗,手足心热,口干津少,口舌生疮,神疲健忘,腰酸腿软,男子遗精,女子月经不调,舌红苔少,脉细数。

治则 交通心肾,清心安神。

取穴 心俞、肾俞、志室、大陵、神门、三阴交、太溪、然谷、涌泉。

方义 心俞、大陵、神门、太溪清心安神;肾俞、志室、三阴交、太溪、然谷、涌泉滋补肾阴,镇心降火,益精安神。合用可以交通心肾。

灸法

(1) 艾炷隔芹菜根灸:每次选 3~5 穴,取鲜芹菜根切成 0.2 厘米薄片置穴上,放艾炷灸 3~5 壮,每晚 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸、艾条温和灸:同心脾不足。

(3) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每晚 1 次，7 次为 1 个疗程。

3. 心胆气虚 心神不安，胆怯惊恐，遇事易惊，夜烦不眠，睡中多梦易惊醒，伴心悸气短，自汗，舌红，脉弦细。

治则 益气镇惊，定志安神。

取穴 百会、神阙、气海、神门、足三里、隐白。

方义 百会、神阙、隐白益气温阳，安神定志；气海、神门、足三里益气镇静安眠。

灸法

(1) 艾条温和灸：同心脾不足。

(2) 珍珠层粉敷灸：取珍珠层粉、丹参粉、硫黄粉、冰片各等量混匀，填满脐窝敷灸，每晚 1 次，7 次为 1 个疗程。

4. 心肝火旺 烦躁不宁，入睡艰难，少寐即醒或彻夜不寐，胸胁胀满，善叹息，急躁易怒，头胀眩晕，口干苦，舌红苔黄，脉弦数。

治则 清肝养血，安神镇静。

取穴 心俞、肝俞、神门、阳陵泉、三阴交、太冲。

方义 心俞、肝俞、阳陵泉、太冲清心肝之火，解郁行气，宁心镇静；神门、三阴交养血安神。

灸法

(1) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每晚 1 次，7 次为 1 个疗程。

(2) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每晚 1 次，7 次为 1 个疗程。

5. 痰热扰心 虚烦不眠，恶梦多，易惊醒，心烦口苦，头重目眩，胸闷脘痞，咳嗽痰多，恶心暖气，或兼精神抑郁，性情急躁，甚则悲喜异常，语无伦次，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治则 清热化痰，养心安神。

取穴 心俞、间使、神门、丰隆、筑宾。

方义 心俞、神门养心安神；间使、丰隆、筑宾清热化痰。

灸法 同心肝火旺。

6. 胃气不和 胃不和则卧不安，失眠兼见脘腹痞胀，恶心呕吐，噯腐吞酸，便溏异臭或便秘腹胀，苔黄腻，脉弦滑。

治则 和胃化滞，消食安神。

取穴 胃俞、中脘、神门、足三里、丰隆、公孙、厉兑。

方义 胃俞、足三里、公孙消积化滞，理气化湿；中脘配丰隆和胃化痰；神门安神治失眠；厉兑治多梦失眠，诸穴为伍，使胃腑安和，则能入睡。恶心加内关。

灸法 同心肝火旺。

7. 预防失眠 经常在神门、三阴交、申脉、太溪施艾炷灸或艾条温和灸，可以预防失眠。

低 血 压

低血压是指成年人肱动脉血压 $<12/8$ 千帕，属中医“眩晕”、“虚劳”、“晕厥”范畴。分为原发性（体质性）低血压、体位性低血压、症状性低血压。

【病因病机】

低血压的病因目前尚不清楚，原发性低血压与体质虚弱及遗传因素有关；体位性低血压可能由于自主神经功能失调，血管舒缩功能障碍及多种疾病和药物引起；症状性低血压是某些疾病的伴随症状之一。中医认为，低血压多由气虚阳虚，阴血亏少或气阴两虚所致。心脾气虚，心脉鼓动无力，气机升降失调，清阳不升或心血不足，血脉不充，心脑失养；脾肾阳虚，脑髓空虚或气阴两虚，阴阳失调，脏腑功能低下，而致头晕

眼花,倦怠乏力等低血压症状。

【辨证施灸】

低血压的主要症状是头晕目眩,头痛健忘,精神不振,倦怠乏力,腰腿酸软,食欲不振,畏寒肢冷,舌淡苔薄,脉虚弱。血压 $<12/8$ 千帕。

治则 益气养阴,健脾补肾。

取穴 百会、脾俞、肾俞、神阙、关元、足三里、涌泉。

方义 百会益气升阳,提升血压;肾俞、神阙、关元温阳培元,益气补肾;脾俞、足三里健脾补后天之本,充气血生化之源;涌泉补肾醒神,诸穴共伍,温补脾肾,振奋阳气,提升血压。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸:每次选2~4穴,各灸3~5壮,隔日1次,10次为1个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸10~15分钟,每日或隔日1次,10次为1个疗程。

(3) 预防低血压:经常在内关、素髌施灸,可预防低血压。

神经衰弱

神经衰弱,是由某些精神因素引起的内脏功能失调及高级神经活动障碍为主要表现的全身性疾病。以精神容易兴奋,脑力减退和体力疲乏,并伴有各种躯体不适及睡眠障碍为特征。是神经症中最为常见的一种,多见于青壮年人及脑力劳动者。可见于中医的“失眠”、“心悸”、“健忘”等病证之中。

【病因病机】

精神因素是诱发神经衰弱的重要原因,病前常有导致大脑功能活动过度紧张的精神因素和躯体因素。凡能引起持续紧张心情和长期内心冲突,使精神活动过程强烈而持久地

于紧张状态,可使精神活动能力减弱而致病;遗传因素,先天和后天形成的个体生理特征,均与发病有关,患者的性格多偏于胆怯、自卑、敏感、多疑、依赖性强,缺乏自信或偏于主观、任性、急躁、好强、自控力差,以及感染、中毒、脑外伤或其它躯体疾病,过度疲劳和营养不佳,均可促使发病。中医认为,本病多由情怀不舒、思虑劳倦、精神过度紧张、内伤心脾、气血不足或体质素虚,久病阴精亏耗,引起脏腑功能失调所致,与心脾肝肾四脏关系密切。

【临床表现】

本病病程较长,涉及脏腑多,症状多较复杂,一般以头痛脑胀,头晕昏眩,多梦失眠,耳鸣健忘,注意力不集中,记忆力减退,工作效力降低,烦躁易怒,肌肉酸痛,神疲乏力,全身不适等为主要表现,可伴心悸心慌,胸闷气急,食欲不振,小便不利,男子遗精阳痿,女子月经不调等。但查体所得大部分与主诉矛盾,往往查不到相应的体征。

【辨证施灸】

中医临床辨证,可见心脾两虚,阴虚阳亢,心肾阴虚,脾肾阳虚,胆虚痰扰等证候。

治则 调和阴阳,养心安神。

取穴 百会、内关、足三里、涌泉。

方义 百会益气升阳醒脑;内关清心宁神;足三里升阳益胃,和中散寒,振奋阳气;涌泉交通心肾,调和阴阳。劳伤心脾者加心俞、脾俞;胃腑不和加中脘、丰隆;心神不宁加合谷、太冲;失眠多梦加魄户、神门、厉兑;耳鸣加听宫、中渚;肾虚遗精阳痿加肾俞、命门、志室、关元。

灸法

(1) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸10~20分钟,每

日1次,10次为1个疗程。亦可采用早灸百会,晚上临睡前灸足三里、涌泉,对振奋精神,消除疲劳,增进食欲,促进睡眠均有佳效。但阴虚阳亢者不宜灸百会。

(2) 温针灸:每次选2~4穴,各灸3壮(或10~15分钟),隔日1次,10次为1个疗程。

按:神经衰弱的病因主要是由精神因素诱发,除药物、针灸等治疗外,关键是排除引起发病的主要精神因素,灸法可以调和阴阳,调整脏腑功能,治疗神经衰弱有较好疗效。

癲 病

癫痫俗称“羊痫风”,属于中医“痫证”,为常见的神经系统慢性发作性疾病。是反复发作的神经原异常放电所致的暂时性突发性脑功能失调。根据神经原异常放电所影响的部位和范围不同,可表现为运动、感觉、意识、行为、自主神经等不同功能障碍或兼而有之,可分为原发性和继发性两大类。前者多见于儿童和青少年;后者可见于先天性脑畸形、脑肿瘤、脑外伤、脑动脉硬化、脑部炎症、脑寄生虫、高热缺氧及妊娠子痫等脑部疾病和引起脑组织代谢障碍的一些全身性疾病。发病以10~19岁最多。

【病因病机】

原发性(特发性)癫痫的病因尚未充分了解,已知与遗传及代谢障碍有关;继发性(症状性)可由于颅内病变或全身性病变引起。精神紧张、饮酒、疲劳、月经等可为两者的诱因。中医认为,主要是由于风痰气逆所致,责之心、肝、脾、肾四脏,多由惊恐郁怒、心肝气郁化火、灼津炼液成痰、气火夹痰、横窜经络、上蒙脑窍,以致阴阳发生一时性逆乱而发病。此外,脑外伤、脑寄生虫等亦可诱发病证,小儿则多与先天因素有关。癲

痫时发时止,反复发作,“痫久必归五脏”,影响五脏功能,导致五脏气血阴阳俱虚。

【临床表现】

癫痫发病形式较多,临床最常见的有大发作、小发作、局限性发作、精神运动性发作、持续状态等。其发病频度因类型、原发病的性质及个体体质不同而有极大差异。有数月、数年才发作1次,也有数日1次或1日数次、数十次者。小发作可表现为1日数十次甚至达上百次者。癫痫发作可在日间或晚上,部分患者常于入睡后发作。

1. 大发作 以意识丧失和全身抽搐为特征。常突然跌仆,发无定时,神志不清,牙关紧闭,两目上视,面色苍白或紫暗,口吐白沫,口鼻发出异常声音,四肢抽搐,二便失禁,移时即醒,醒后如常人,不遗留后遗症。

2. 小发作 以短暂的意识障碍为特征,无四肢抽搐。

3. 局限性发作 以局部肌肉抽搐或感觉异常为特征。

4. 精神运动性发作 以发作性精神状态异常或运动异常为特征。

5. 癫痫持续状态 是大发作在短期内频繁发作,以致意识持续丧失而危及生命。

【辨证施灸】

1. 发作期 可有头痛,头晕,胸闷,打呵欠等先兆症状,眩晕,昏倒仆地,不省人事,口吐白沫,喉中发出似猪羊叫声,分阳痫,阴痫。阳痫者,牙关紧闭,两目上视,四肢抽搐,喉中痰鸣,面色苍白或紫暗,口唇紫绀,脉弦数;阴痫者,神志昏愦,口张目合,抽搐时发,手足冷,亦有的表现为木呆无知,不闻不视,不动不语者,醒后全身疲惫,瘫软,脉沉细或沉迟。

治则 豁痰开窍,平肝熄风,解痉止搐。多选督脉、心及心

包经穴。

取穴 百会、风府、大椎、心俞、腰奇、中脘、内关、神门、后溪、太冲。

方义 百会、风府、内关、神门熄风开窍，醒脑安神；大椎清泄降逆；心俞清心安神；腰奇、后溪为治痫验穴；中脘化湿降浊；太冲平肝熄风，宁心安神。阳痫抽搐重者加风池、合谷、阳陵泉；阴痫痰湿盛者加气海、足三里、丰隆；日间发作，病在阳跷加申脉；夜间发作病在阴跷加照海；小发作配内庭以醒脑安神；局限性发作运用合谷、太冲开四关，佐阳陵泉以缓筋挛急，三阴交以调三阴经气；精神运动性发作配丰隆以畅中降痰，间使以醒神。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~30 壮，每日 1 次。

(2) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次。

(3) 灯火灼灸：小儿癫痫轻症在百会、崇骨、会阴各灼灸 1 次，半月 1 次；重症选百会、神庭、印堂、太阳、哑门、大椎、身柱、崇骨、神道、缩根、脊中、命门、长强、会阴、至阴。每次选 5~7 穴，各灼灸 1 下，半月 1 次。

2. 休止期 休止期一般可见脾虚痰盛，肝火痰热，肝肾阴虚等证候。脾虚痰盛者症见神疲乏力，身体瘦弱，食欲不佳，大便溏薄，痰多或泛吐痰涎，胸部痞闷，苔白腻，脉弦滑；肝火痰热者症见性情急躁易怒，每因焦急郁怒而诱发，烦躁不安，口苦而干，咯痰胶粘，失眠，便秘，苔黄，脉弦数；肝肾阴虚者，痫病频发，神思恍惚，面色晦暗，头晕目眩，两眼干涩，耳轮焦枯不泽，失眠健忘，腰酸腿软，大便干燥，舌红，脉细数。

治则 健脾化痰,补益肝肾,养心安神。

取穴 心俞、肾俞、神阙、气海、足三里、丰隆、三阴交、太溪。

方义 心俞清心安神;神阙、足三里健脾化湿除痰;肾俞、气海补肾益气;丰隆清气化痰浊;三阴交、太溪滋补肝肾。

灸法

(1) 艾炷化脓灸:每次选1~2穴,各灸3~5壮,每月1次,共灸4次。

(2) 灯火灼灸:每次选3~4穴,各灼灸1下,半月1次。

(3) 艾炷隔定痛糊灸:取制马钱子、胆南星、僵蚕、明矾各等份,共研细末,然后取青艾叶、生姜各适量捣汁与上药制成定痛糊,每次取5克~10克,分别置神阙与会阴穴上,用艾炷灸1~12壮(小儿每岁1壮),每日1次。

(4) 阳燧锭灸:取艾叶500克,硫黄120克,麝香6克,西黄、珠粉各0.9克,先将艾叶置铜锅内加水1000毫升煎取浓汁120毫升,依法制成阳燧锭。施灸时每次选1穴,先于穴位上放一圆形薄纸片,再取麦粒大阳燧锭1块置纸片中央穴位上点燃施灸,每次灸1壮,灸后局部起小水疱,敷料包扎固定,让其自然吸收,每月1次。

(5) 苯妥英钠敷灸:取苯妥英钠0.25克,丹参粉、磁石粉各1克,共研匀纳脐中,覆姜片后以胶布固定,每周更换1次。

(6) 芫花敷灸:取芫花(醋泡1天)100克,胆南星20克,明雄黄12克,胡椒10克,共研细末,填满脐窝,覆姜片后以胶布固定,3日更换1次。

3. 预防癫痫发作 经常在申脉施灸可预防癫痫日间发作;灸照海可预防癫痫夜间发作。

按:癫痫发病率很高,据我国某些城市资料报道,约为

0.4%~3%。目前的治疗水平,完全达到根治尚有困难。如能及时采用中西药物,配合针灸等综合疗法,大多数患者可以控制或减少发作次数,缓解或减轻发作症状。

呕 吐

呕吐又称“吐逆”,是指食物或痰涎由胃上逆,从口中吐出的病证。古人认为有声有物谓之呕,有物无声谓之吐,但实际上呕与吐多同时发生,殊难截然分开,故合称呕吐。西医的急性胃炎、慢性胃炎、食管贲门失弛缓症、幽门梗阻、胃神经官能症、病毒性肝炎、胆囊炎、胰腺炎等疾病均可出现呕吐症状,可参照本篇施灸。

【病因病机】

引起呕吐的原因很多,凡外邪犯胃,饮食不节,情志失和,劳倦过度,脾胃虚寒及某些疾病均可引起胃失和降,胃气上逆,迫使胃中之物从口中吐出而发生呕吐。病位主要在胃,与肝脾关系密切。

【辨证施灸】

呕吐宿食痰涎,水液诸物或干呕无物。临证可见外邪犯胃,饮食停滞,痰饮内阻,肝胃不和,脾胃虚弱及虚寒,胃阴不足等证候。艾灸疗法对外邪犯胃,痰饮内阻,脾胃虚弱及虚寒等引起的呕吐,疗效较好。

1. 外邪犯胃 起病较急,突然呕吐,伴胸闷脘胀,头晕纳呆,或兼发热恶寒,头痛无汗或有汗,苔薄白或薄黄,脉浮紧或浮数。

治则 疏解外邪,和胃降逆。

取穴 大椎、中脘、间使、内关、合谷。

方义 大椎、合谷疏解外邪,治恶寒发热;中脘理气和胃,

通腑降逆止呕；间使治呕吐；内关调气畅中。诸穴合用疏邪和胃降逆以止呕吐。

灸法

(1) 艾炷(或隔姜)灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~7 壮，每日 1~2 次。

(2) 艾条温和(或回旋)灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(3) 温盒灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(4) 温针灸：每次选 2~4 穴，各灸 3 壮(或 10~15 分钟)，每日 1 次。

(5) 灯火灼灸：每次选 3~4 穴，每穴灼灸 1 下。

(6) 白矾敷灸：热性呕吐取白矾适量，面粉少许，用醋或清水调成糊膏状，敷灸双涌泉穴，2~4 小时去药。

(7) 田螺敷灸：受暑呕吐，取田螺(去壳)数个，食盐少许，共捣烂敷灸石门穴 1 小时。

2. 痰饮内阻 呕吐清水痰涎，胸膈痞闷，头眩心悸，不思饮食，苔白腻，脉滑。

治则 温化痰饮，和胃降逆。

取穴 脾俞、中脘、章门、足三里、丰隆、公孙。

方义 脾俞、足三里健脾化湿，理气和中，以杜生痰之源；中脘、丰隆和胃化痰，降浊止呕；章门、公孙健脾调饮。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸：每次选 2~3 穴，各灸 5~7 壮，每月 1 次，可灸 3 次。

(2) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~7 壮，7 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸、温针灸：同上。

(4) 蚯蚓敷灸：取蚯蚓数条，洗净捣烂，敷灸涌泉穴，每晚1次。

(5) 甘遂敷灸：取甘遂末10克，水调成糊状，敷灸脐下1.3寸处，每日1次。

3. 脾胃虚寒 平素脾胃虚弱，饮食稍多即吐，时吐时止，吐物清冷，胃纳不佳，食入难化，胸脘痞闷，口干不欲饮，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，倦怠乏力，面色少华，舌淡苔薄，脉虚弱。

治则 温中健脾，和胃降逆。

取穴 脾俞、中脘、神阙、内关、足三里、隐白。

方义 脾俞、中脘、足三里健脾温胃，通降胃气，和中止呕；神阙温运脾胃；内关温中和胃；隐白健脾温胃。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸、艾炷灸、艾炷隔姜灸、艾条温和（回旋）灸：同痰饮内阻。

(2) 艾炷隔盐灸：用食盐填满脐窝，上置艾炷灸5~7壮，以腹部有明显温热感并向腹中扩散为佳，每日1次。

(3) 灯火灸：每次选2~4穴，各灼灸1下，3日1次。

(4) 吴茱萸敷灸：①取吴茱萸末适量，用水或醋调成膏状，敷灸涌泉穴1~4小时，每日1次。②取吴茱萸30克，生姜1块，香葱适量，共捣烂成膏状，敷灸脐腹约1小时，每日1次。

(5) 胡椒敷灸：取胡椒末1克，葱白适量，共捣烂成膏状，制成直径2厘米大小药饼，敷灸足心，每日1次。孕妇忌用。

反 胃

反胃又称“翻胃”，指饮食停留胃中不化，脘腹痞胀，朝食

暮吐，暮食朝吐的一种病证。西医称“幽门梗阻”，多见于消化性溃疡、胃粘膜脱垂、胃癌等引起的幽门或十二指肠梗阻。

【病因病机】

本病多因饮食不节，酒、色过度或长期忧思郁怒，损伤脾胃，导致中焦虚寒，不能消谷化食，饮食停留胃中，形成痰凝气滞血瘀而引起幽门痉挛、梗阻或胃中肿物阻塞所致。如反胃日久，可导致肾阳虚衰，釜底无薪，不能熟腐水谷，病更严重。

【辨证施灸】

反胃临证所见，多属虚证或虚实夹杂证。饮食入胃，宿食不化，脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出宿食痰涎，吐尽始觉舒适，不思纳食，形体消瘦，神疲乏力，大便少，或眩晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，四肢不温；或口燥唇干，大便不行，舌淡苔白或干红苔少，脉细弱或沉细无力。

治则 温运脾肾，益气生津，降逆止吐。除胃中肿物引起者外，灸法均有较好疗效，可作为一种辅助疗法。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、章门、足三里、中魁。

方义 脾俞、胃俞、中脘、章门健脾化湿，和胃降逆，通腑止吐；中魁理气和中，治反胃呕吐有特效。肾阳虚者加肾俞、气海、关元以温肾壮阳，益气培元；气阴两虚加梁门、天枢、三阴交以健脾助运，养阴益气。

灸法

(1)艾炷灸：每次选3~5穴，以中魁为主，各灸3~5壮，每日1~2次。

(2)艾炷隔姜（或附子饼或胡椒饼）灸：每次选3~5穴，各灸5~7壮，每日1次。

(3)艾条温和灸、温盒灸：每次选3~5穴，各灸10~15分钟，每日1次。

(4)温针灸:每次选3~5穴,各灸3壮(或10~15分钟),每日1次。

(5)灯火灼灸:每次选3穴,各灼灸1下,3日1次。

慢性胃炎

慢性胃炎通常是指慢性浅表性胃炎和萎缩性胃炎。是胃粘膜上皮遭受各种致病因子的经常反复侵袭,发生持续性慢性炎症性病变的胃部疾患,以不规则的胃脘疼痛不适为特征。是一种常见多发病,发病率居各种胃病之首,属中医“痞满”、“胃脘痛”范畴。

【病因病机】

慢性胃炎可由急性胃炎迁延而来,病因比较复杂,至今尚未完全明确。一般认为,除引起急性单纯性胃炎的化学、物理因素外,感染尤其是幽门螺旋杆菌感染和自身免疫因素可能是慢性胃炎的主要原因。而饮酒、吸烟、饮食不节、精神不和、全身各种慢性疾病(如右心衰竭、门脉高压、慢性肾炎、慢性肝脏疾病)、可致胃粘膜损伤的药物及胆汁返流等可能是引起慢性胃炎的内在因素或诱因。萎缩性胃炎由于胃粘膜的再生改造,最后导致固有的腺体萎缩,并伴有肠上皮化生及异型增生,或非典型增生的癌前组织学改变。中医认为,饮食不节和脾胃虚弱是慢性胃炎的主要原因,而神志失和、劳逸失度、外邪侵袭则是发病的重要因素或诱因,主要病机是脾胃虚弱。

【临床表现】

慢性胃炎缺少特异性临床症状,甚至在静止期时无任何症状,但大多数患者都有程度不同的长期反复发作的中上腹部胀满疼痛、恶心嗳气、食欲减退等,胃镜检查可见慢性炎症表现,胃粘膜活检可确诊。

【辨证施灸】

临证可见肝胃不和、胃络瘀阻、脾胃虚弱及胃阴不足等证候。以取任脉经穴和背俞穴为主。

治则 调理脾胃。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、章门、气海、足三里。

方义 脾俞、胃俞、中脘、足三里能振奋脾胃阳气，健脾和胃促进消化；配气海以益气助运化，通调胃肠；章门疏肝健脾，化滞利湿。

灸法

(1) 艾炷(或隔姜、附子饼)灸：每次选2~4穴，各灸5~7壮，每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程间休息5日。

(2) 艾条温和灸：每穴灸10~15分钟，每日1次，10次为1个疗程，疗程间休息5日。

(3) 复方大黄乳没敷灸：胃热疼痛取大黄15克，乳香、没药各9克，赤芍6克，共研细末，用食醋调成厚膏敷灸神阙、足三里，以胶布固定，每日1次。

消化性溃疡

消化性溃疡主要指胃和十二指肠等处发生慢性溃疡。因溃疡主要发生在胃和十二指肠，其形成和发展均与胃酸及胃蛋白酶的消化作用有关，故称为消化性溃疡。本病为常见多发病，多发生于青壮年人，男性多于女性，临床上十二指肠溃疡较胃溃疡多见。属中医的“胃脘痛”范畴。

【病因病机】

消化性溃疡的发病原因和机制比较复杂，迄今尚无定论。目前大多将其归纳为胃与十二指肠粘膜的保护因素和损害因素的关系失调所致。胃酸、胃蛋白酶对粘膜的消化作用是基本

因素,还有精神因素、饮食因素、胆汁返流、药物影响及其它因素,如胃酸浓度较高,胃内蛋白质受到胃蛋白酶的水解,胃肠道内抵抗溃疡形成的功能降低,少量激素分泌异常,大脑皮质功能紊乱等。其病理为胃肠壁的粘膜、肌层有溃疡形成。中医认为,常见的病因是在禀赋不足、脾胃虚弱的基础上,复因饮食不节,饥饱、劳逸无度,或暴饮暴食损伤脾胃;或情志不和、肝气郁滞、疏泄失职、横逆犯胃侮脾而致气血壅滞不畅、脾胃升降失常,导致中焦脾胃虚损而发生溃疡。

【临床表现】

消化性溃疡以上腹部剑突下疼痛不适为主要症状。疼痛的性质和表现因人而异,可由压迫感,膨胀感至胀痛,隐痛,灼痛,刺痛和剧痛等。疼痛有节律性的特点,胃溃疡多在餐后0.5~1小时左右发生,持续1~2小时缓解,有进食疼痛缓解的规律。十二指肠溃疡多在餐后2~4小时左右或后半夜发生疼痛,进食后则疼痛可以缓解,有疼痛一进食一缓解的规律。疼痛的部位:胃溃疡多在上腹正中线稍偏左,十二指肠溃疡多在上腹偏右。前壁溃疡,疼痛可放射至胸骨旁;后壁溃疡可放射到脊柱旁相应部位。少数患者可无疼痛或仅感轻度不适,有的直至出血甚至穿孔时才被发现。除疼痛外,常伴恶心呕吐,嗝气反酸,腹泻便秘,贫血,消瘦,失眠等。检查可有上腹部压痛,X线钡餐造影有壁龛,胃镜检查可见溃疡。若防治不当,可引起大出血、急性胃穿孔及幽门梗阻等严重并发症。

【辨证施灸】

临证可见肝胃不和、瘀血阻络、脾胃虚寒、胃阴不足等证候出现。

治则 理气和胃。肝胃不和者助以柔肝护土;瘀血阻络者助以活血化瘀;脾胃虚寒者助以温和健脾;胃阴不足者助以养

阴益胃。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、梁门、足三里。

方义 脾俞、胃俞、中脘健脾和胃，温和止痛，促进溃疡愈合；梁门、足三里健脾胃，促运化。脾胃虚寒者加肾俞、关元、气海从阴引阳，益气壮阳，助脾胃运化；肝胃不和者加肝俞、阳陵泉、太冲以柔肝；胃阴不足者加三阴交、内庭以滋养胃阴；瘀血阻络者加膈俞、公孙以行血破瘀。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 7~9 壮，以局部温热为度，每日 1~2 次，15 日为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 7~9 壮，每日 1 次，15 日为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，以胃脘部发热为佳，每日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸：每次选 2~4 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

胃粘膜脱垂

胃粘膜脱垂是指胃窦部粘膜脱入十二指肠所引起的一系列证候。可单独发病，亦可继发于其它疾病。好发年龄为 40~60 岁，以 30~40 岁的壮年人多见，男性多于女性。中医没有相应的病名，在“呕吐”、“胃脘痛”等病症中可见到类似描述。

【病因病机】

引起胃粘膜脱垂的因素有两种，原发性因素是先天性胃粘膜肥大或胃窦蠕动过度活跃；继发性因素是胃窦部粘膜慢性炎症、消化性溃疡、胃粘膜水肿等，使粘膜皱襞肥大、垂长、松弛，于胃强烈蠕动时滑入幽门管。老年人发病与粘膜肌层弹

力减弱有关。中医认为,本病的发生是由于素体脾胃虚弱,饮食劳倦内伤、久病不愈、药物等损伤脾胃,或情志不畅,肝气犯胃,引起脾胃纳化功能紊乱,气机升降失和,形成气滞、寒凝或湿热中阻而导致粘膜脱入幽门管内。

【临床表现】

本病无特异性症状,因其常与胃炎、消化性溃疡并发,易被这些胃病症状掩盖。一般常见症状为发作性不规则的上腹部疼痛,进食或进食后右卧位加重,服碱性药物无效,左侧卧位可使疼痛缓解。伴上腹部胀满,暖气反酸,恶心呕吐等。发生幽门梗阻时,可突然发生持续性剧痛,恶心呕吐,改变体位后疼痛可突然消失;上消化道出血前有恶心呕吐,出血后多表现为黑便,呕血较少见。体征较少,可有上腹部压痛,X线钡餐检查可明确诊断。

【辨证施灸】

临证所见有饮食积滞,肝胃郁热,脾胃虚寒,瘀血阻胃等证候。艾灸疗法多适用于脾胃虚寒者。

治则 温中健脾,益气和胃。

取穴 中脘、神阙、内关、足三里。

方义 中脘通降胃腑;神阙温阳散寒;内关温中和胃止吐;足三里健脾化湿消滞。

灸法

(1)艾炷灸:每穴灸3~5壮,每日1次。

(2)艾炷隔盐灸:用食盐填满脐窝,上覆盖姜片,灸5~7壮,每日1次。

(3)温针灸:每穴灸3壮(或10~15分钟),每日1次。

(4)暖脐膏敷灸:取暖脐膏(由乳香、没药、小茴香、肉桂、麝香等组成)1张,微火烘化,敷贴脐腹,每日1次。

按:灸灸疗法治疗胃粘膜脱垂有一定效果,可在选用中西药物治疗的同时配合使用。如并发幽门梗阻、上消化道出血,应及时送医院治疗。

呃 逆

呃逆俗称“打嗝”、“打呃”,古称“哕”,即“膈肌痉挛”,是指气逆上冲,喉间呃呃连声,声短而频,不能自制的一种病证。常是某些疾病出现的症状,亦可单独出现。一般预后良好,但如在久病、重病中突然出现呃逆不止,常预示疾病危重,预后不良。

【病因病机】

本病的发生多因寒邪侵袭,饮食不节,情志不和,导致食滞、气郁、胃火,或中焦虚寒,外寒客于胃中,或病后虚羸,下元亏损,导致气不顺行,胃失和降,上逆动膈而发生呃逆。现代医学认为,呃逆的原因很多,中枢性呃逆是由于颅脑疾病如脑外伤、脑出血、脑肿瘤等,直接或间接影响呼吸中枢而造成;反射性呃逆是因某些疾病,如胃肠、肝胆、胸膈疾病使膈神经受到刺激而引起;神经性呃逆多见于膈肌官能症、癔病,属功能性病变;中毒性呃逆常是全身性感染伴显著的毒血症、肾功能衰竭及药物中毒等。

【辨证施灸】

1. 胃中寒冷 呃声有力,遇寒尤甚,得热可减,伴胸脘不适,饮食减少,喜热饮,恶冷食,苔白脉缓。

治则 温中散寒,降逆止呃。

取穴 膈俞、天突、膻中、中脘、梁门、内关、足三里。

方义 膈俞、天突利膈降气止呃;膻中宽胸利膈;中脘、梁门、足三里温中散寒,和胃降气;内关和中利气,为治呃验穴。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每次选 3~4 穴，各灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(2) 艾条雀啄灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(3) 温针灸：每次选 2~3 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次。

2. 气滞痰阻 呃声响亮，夹有痰阻，呼吸不利，胸胁胀满，脘闷暖气，肠鸣矢气，苔薄腻，脉弦滑。

治则 理气化痰，降逆止呃。

取穴 膈俞、巨阙、期门、天枢、内关、丰隆、太冲、内庭。

方义 膈俞理膈宽胸降逆；巨阙、期门、太冲疏肝理气，平肝降逆；天枢、内庭理气和胃消滞；内关利气畅中；丰隆化痰降逆。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸、温针灸：同胃中寒冷。

(2) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 15~20 分钟，每日 1~2 次。

(3) 灯火灼灸：每次选 1~2 穴，各灼灸 1 下，3 日 1 次。

3. 脾肾阳虚 呃声低长或短促而不连续，脘腹不舒，泛吐清水，喜热按，食少倦怠，面色无华，或久泻便溏，神疲气怯，腰膝无力，手足不温，舌淡，苔薄白，脉细数。

治则 温补脾肾，和胃降逆。

取穴 膈俞、肾俞、脾俞、膻中、气海、关元、内关、足三里、太溪。

方义 膈俞、膻中理气宽胸，利膈降逆；肾俞、气海、关元、太溪温补肾阳，益气培元；脾俞、足三里温中健脾；内关止呃。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 2~3 穴，各灸 3~5 壮，隔日 1 次。

(2) 丁香散敷灸：取母丁香、广木香各等份，共研细末，用姜汁、蜂蜜等量调成糊膏状，分别敷灸膈俞、膻中、气海、关元、足三里穴上，胶布固定，每日更换 1 次。

(3) 虚呃散敷灸：取附子、干姜、广木香、母丁香、小茴香、食盐各 10 克，共捣碎烘热布包，熨灸胸膈部，以呃止为度。或上药共研细末，取药末 15 克撒于直径 5 厘米圆形胶布中央，敷灸膈俞、膻中、气海、关元，然后取麦麸适量炒热布包，隔衣熨灸，每穴 30 分钟，每日 1 次。

按：久病、重病突然出现呃逆不止，为元气衰败之象，应采用中西药物治疗原发病为主，同时亦可配合艾灸诸法以温补脾肾，扶助阳气，缓解呃逆。

胃脘痛

胃脘痛古称“心痛”、“胃心痛”、“心腹痛”，是指上腹胃脘部（脐上剑突下）经常反复发作疼痛为特征的病证。西医的急性胃炎、慢性胃炎、消化性溃疡、胃神经官能症、食管裂孔疝、胃粘膜脱垂、胰腺炎等疾病，常出现胃痛症状。

【病因病机】

胃脘痛的发生多因禀赋不足，素体脾胃虚弱，复因外感寒邪，内客于胃；饮食不节，饥饱失度或暴饮暴食，损伤脾胃；忧思郁怒，情怀不畅，肝郁气滞，横逆犯胃；劳倦伤脾，久病延及脾胃，以及用药不当伐伤脾胃等，导致脾胃的纳化功能受到损害，气血运行受阻，遂发生胃痛。

【辨证施灸】

临证可见寒邪客胃、饮食停滞、肝气犯胃、瘀血阻胃、脾胃

虚寒、胃阴不足等证候。艾灸疗法对寒凝气滞及脾胃虚寒疗效较好,以取任脉、足阳明、太阴经穴及背俞穴为主。

1. 寒凝胃痛 胃痛突然发作,疼痛较剧,畏寒喜热,得热痛减,遇寒痛甚,泛吐清水,口不渴喜热饮,舌淡苔白,脉弦紧或沉迟。

治则 温胃散寒,行气止痛。

取穴 中脘、梁门、内关、足三里、公孙。

方义 中脘配足三里疏通胃气,散寒消滞止痛;梁门健脾益胃,消积化滞,止胃痛;内关配公孙宽胸解郁,治脾胃疼痛。

灸法

(1) 艾炷灸:每穴 7~9 壮,每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸:每穴 5~7 壮,每日 1 次。

(3) 艾条温和灸、温盒灸:每穴灸 10~20 分钟,每日 1~2 次。

(4) 温针灸:每次选 2~4 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次。

(5) 威灵仙叶敷灸:取鲜威灵仙叶适量,捣成膏状加少量红糖混匀,制成直径 1.5 厘米圆饼,分别敷灸中脘、足三里,至局部有蚁爬感后去之,每日 1 次。

(6) 吴萸敷灸:①取吴萸末 1.5 克,醋调敷灸脐中或鸠尾穴,每日更换 1 次。②取吴萸、川椒、细辛、公丁香各等量,共研细末,填满脐窝,然后取食盐 250 克炒烫,布包熨灸脐部及疼痛处,疼痛较剧时加灸膻中、气海及相应背俞穴,每日 1 次,以疼痛缓解为度。

(7) 复方高良姜熨灸:取高良姜、干姜各 45 克,荜茇 25 克,枳实 12 克,共捣粗末加酒适量炒烫布包,趁热熨灸中脘、脐中、气海、涌泉,以疼痛缓解为度。

(8) 复方射干敷灸:①取射干、蜘蛛香各 10 克,共捣烂炒烫敷灸鸠尾穴,每日 1 次。②取射干、延胡各 10 克,丁香 3 克,共研细末,姜汁调成糊状敷灸痛处,每日 1 次,以疼痛缓解为度。

(9) 复方生姜熨灸:①取生姜、水菖蒲根、陈酒糟、青盐各适量。②取生姜、大葱、橘皮各适量。③取生姜、生萝卜(捣去汁)、生香附各 15 克,酒少许。任选 1 方,共捣烂炒烫,布包熨灸胃脘部,冷后炒烫再熨,每日 1~2 次,以疼痛缓解为度。

(10) 胃痛膏敷灸:取苍术 200 克,川椒 150 克,生附子、炮姜、檀香各 100 克,共研细末,每次取药末 30 克,用姜汁调成糊膏状,第一日敷中脘、足三里;第二日敷脾俞、胃俞。两组穴位交替使用,每日 1 次,以疼痛缓解为度。

2. 脾胃虚寒 胃脘隐隐作痛,绵绵不休,喜暖喜按,得食痛减,泛吐清水,纳少倦怠,腹胀便溏,手足欠温,舌淡苔薄,脉虚弱,脾俞、胃俞多有压痛。

治则 温中散寒,健脾益气,和胃止痛。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、神阙、足三里。

方义 脾俞、胃俞、中脘、足三里温中散寒,健脾益气,和胃止痛;神阙温阳散寒,补益脾胃。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸:每次选 2 穴,各灸 3~5 壮,每月 1 次,可灸 3 次。

(2) 艾炷隔盐灸:在神阙穴隔盐灸 1~5 壮,以脐部有明显温热感或向腹中扩散为佳,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 5 日。

(3) 艾条温和灸、温盒灸、温针灸:同寒凝胃痛。

(4) 白芥子敷灸:取白芥子末适量,用温水调成膏状,敷

灸神阙穴，胶布固定，每日1次。

(5) 硫朱灸：每次选1~3穴，各灸1壮，灸疮消毒敷料包扎，保持清洁，5日1次，连灸2~3次。

(6) 毛茛根敷灸：取毛茛根末适量，用清水调成糊膏状，敷灸脾俞、胃俞、中脘，约15分钟，待局部出现烧灼感时去之，如起水泡可用敷料包扎，保持清洁让其自然吸收，灸治次数视病情而定。

(7) 舒乐热熨剂熨灸：取市售舒乐热熨剂（由郁加里、红花、生川乌、苍术、独活、姜黄、细辛、樟脑、薄荷、艾叶、油松节、白芥子、乳香、川芎等和化学发热剂配置而成），熨灸胃脘疼痛处，每次1袋，5次为1个疗程。

(8) 健脾膏敷灸：取白术120克，当归、白芍、香附、半夏、枳壳、茯苓、神曲、麦芽各60克，益智仁、白蔻仁、黄芪、山药、吴萸、黄连、山桂、陈皮、甘草各21克，党参、广木香各15克，共研细末。敷灸时取药末适量，用姜汁调成膏状，分别敷灸中脘、上脘等穴，每日1次。

此外，气滞、食滞胃痛，亦可选用复方大黄膏等敷灸。取大黄、香附、郁金、栀子、延胡各30克，黄芩、甘草各15克，滑石60克，共研细末，用姜汁调成糊状，敷灸痛处，每日1次。经常在中脘、内关、足三里施艾炷灸或艾条温和灸，可防治胃脘痛。

腹 痛

腹痛是指胃脘以下，耻骨毛际以上部位发生疼痛而言，可见于内、外、妇、儿等科的多种疾病。因腹中脏腑众多，诸多经脉循行通过，引起腹痛的病因和受累的脏腑、经脉不同，故腹痛的性质、部位及伴随症状和转归也不同。临床属常见的多发病，可见于各种急慢性肝、胆、胃、肠、胰腺、腹膜炎症及胃肠痉

挛、功能紊乱、消化不良、消化道肿瘤、盆腔病变、寄生虫病、阑尾炎、膀胱炎及神经官能症等引起的腹痛。

【病因病机】

凡外感风寒暑湿等外邪，或情志、饮食、虫积所伤及积聚、癥闭、气滞血瘀等影响脏腑、经络功能失调，气血运行不畅，不通则腹痛；或气血亏虚，脏腑、经脉失养，亦致腹痛。

【辨证施灸】

临床根据腹痛的性质，有寒痛，热痛，实痛，虚痛及伤食痛，血瘀痛，急腹痛等，应注意鉴别，特别是急腹痛应及时作相应的处理，以免贻误病机。艾灸疗法对寒痛，虚痛的疗效较好。

1. 寒凝腹痛 腹痛急剧拒按，得热痛减，遇寒加重，口不渴或喜热饮，肠鸣腹泻或大便不通，小便清白，四肢欠温，苔白腻，脉弦紧。

治则 温中散寒，理气止痛。

取穴 中脘、神阙、天枢、合谷、足三里、公孙。

方义 中脘、足三里温中理气；神阙温下元以散寒凝；天枢调理胃肠气机；合谷调理大肠传导功能；公孙治腹痛。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3～5 穴，各灸 3～5 壮，每日 1～2 次。

(2) 艾炷隔盐灸：在神阙穴隔盐灸 3～10 壮，每日 1 次。

(3) 艾炷隔姜(或附子饼)灸：每次选 2～3 穴，各灸 3～5 壮，以肢温痛减为度。

(4) 艾条温和灸：每次选 2～4 穴，各灸 10～15 分钟，每日 1 次。

(5) 温针灸：在足三里、天枢穴各灸 3 壮(或 10～15 分钟)，每日 1 次。

(6) 雷火神针灸：在下脘、大横、气海、足三里、公孙穴施灸，每日1次。

(7) 拍火灸：取高良姜、干姜、乌药各10克，共研细末，铺于中脘、天枢，施灸，每日1次。

(8) 葱白熨灸：阴毒寒厥腹痛，取葱白适量，敷于神阙穴上，覆以厚布以熨斗熨灸，葱烂即换，以痛减为度。

(9) 复方胡椒敷灸：①取胡椒末0.25克，或加白芥子5克，生姜30克，共捣成饼，敷灸神阙。②取胡椒、丁香末各适量，麝香少许，共混匀，填满脐中，胶布固定，再用熨斗隔布熨灸。每次30分钟，每日1~2次，或以痛减为度。

(10) 复方吴萸敷灸：①取吴萸、硫黄各6克，大蒜适量或吴萸、生姜各12克，共捣烂敷灸脐中，以痛减为度。②取吴萸75克，食盐、麸皮各100克，葱头250克，用白酒拌匀，炒烫布包趁热熨灸脐下、足心，每次30分钟或以痛减为度。③取吴萸、川椒、细辛、公丁香各等份，共研细末，填满脐中，再取青盐250克炒烫，熨灸脐部或疼痛处，疼痛较剧时加灸臌中、气海及相应背俞穴，每日1次。

(11) 青盐熨灸：①取青盐500克或青盐、大葱各250克，炒烫布包，熨灸疼痛处，每次30分钟，每日1~2次。②取青盐、生姜、葱白各适量，共捣烂熨灸痛处，灸法同上。③取公丁香7粒，菖蒲根15克，炙甘草、青盐各30克，生姜3片，共捣烂，炒烫布包，熨灸臌中、气海及背部相应俞穴，每次30~60分钟或以痛解为度，每日2次。④取乌药、木香、降香、细辛、砂仁、白芥子各等量，共研细末，取药末填满脐中，然后再取青盐500克，炒烫布包，熨灸痛处或足心，每次30分钟或以痛解为度。

(12) 橘叶敷灸：取橘叶、柚叶各500克，共捣碎炒烫，布

包熨灸痛处，以痛解为度，每日1次。

(13) 香附敷灸：取香附60克，生姜10克，共捣烂，炒烫布包，熨灸痛处，每日1次。

2. 虚寒腹痛 腹部隐痛，时痛时止，喜热按，大便溏泄，面色少华，神倦乏力，腰膝酸软，怯寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟紧。

治则 温中散寒，缓急止痛。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、章门、神阙、气海、关元、足三里、三阴交。

方义 脾俞、胃俞、中脘、足三里健脾益气以生血，温中和胃以散寒；神阙、气海、关元温阳散寒；三阴交健脾和阴。诸穴共用，使气血温煦濡润，经脉通利，脏腑得到温养则腹痛自除。

灸法

(1) 艾炷灸、艾条灸、雷火针灸：同寒凝腹痛。

(2) 温盒灸：每次选3~5穴，各灸10~20分钟，每日1次。

(3) 吴茱萸香敷灸：取吴茱萸、小茴香各等份，共研细末，用热酒调，纳脐中敷灸，每日1次。

(4) 老姜敷灸：取老姜60克，豆豉15克，葱头3茎，共杵药饼，烘热敷灸神阙穴12小时，每日1次。

(5) 复方小茴香熨灸：取小茴香100克，干姜末50克，酒糟500克或小茴香100克，肉豆蔻、木香各30克，加葱须或葱白适量共炒烫，用布包熨灸脐部，每次30分钟，每日1次。

泄 泻

泄泻又称“腹泻”、“下痢”等，是指排便次数增多，粪便稀薄或完谷不化，甚至泻下如水而言。可见于多种疾病，包括肝、

胆、胃、肠、胰腺等疾病,如急慢性肠炎、胃肠官能症、肠结核、食物中毒等。四季均可发生,但以夏秋季节多见。

【病因病机】

泄泻主要是由于湿邪所侵和脾胃功能障碍引起。急性者,常因感受外邪(寒湿或暑湿)或饮食所伤引起,以实证居多;慢性者,多因脾胃虚弱,或肝木侮土,或命门火衰,不能熟腐水谷而成,以虚证为主。主要病位在胃与大小肠。外因以湿邪为主;内因与脾胃虚弱关系密切。湿邪侵入,损伤胃肠,纳化失常,即“湿盛则濡泻”。脾虚不能受纳水谷,运化精微,水谷停滞,清浊混淆,混杂而下,发生泄泻。现代医学认为,泄泻之因有多种,凡因消化器官发生功能性或器质性病变均引起腹泻。如肠道炎症性病变、肠道粘膜性病变、肠道运转功能缺陷、肠道肿瘤、消化酶缺乏、结肠过敏、食物中毒及某些全身性疾病等,而其中最主要的是肠道各种感染。

【临床表现】

急性泄泻:排便次数突然增多,粪便稀薄或呈水样,常伴发热头痛,腹痛呕吐等症状。

慢性泄泻:持续反复地排便次数增多,粪便稀薄,病程超过2个月以上,常伴食欲不振,营养不良,消瘦,贫血等。

【辨证施灸】

临证可见湿热泄泻、寒湿泄泻、食滞泄泻、肝脾不和泄泻、脾虚及肾虚泄泻等证候。艾灸疗法适用于寒湿泄泻和脾虚、肾虚泄泻。

1. 寒湿泄泻 泻下清稀,甚或如水,腹痛肠鸣,胸闷纳少,或兼恶寒发热,头痛,肢体酸痛,苔薄白或白腻,脉濡缓。

治则 温中散寒,化湿止泻。

取穴 大肠俞、神阙、天枢、大横、足三里、上巨虚、阴陵

泉、合谷。

方义 大肠俞配天枢，调理胃肠，理气化湿，消腹中胀气；神阙温阳散寒；大横调理胃肠而止泻；足三里、上巨虚健脾化湿，通腑调气；阴陵泉健脾利湿；合谷疏表散寒。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾条温和灸、温盒灸：每次选 3~5 穴，各灸 15~30 分钟，每日 1~2 次。

(3) 温针灸：每次选 2~4 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次。

(4) 吴萸灸：取吴萸末 3 克，用食醋调成糊状，加热敷灸神阙，包扎固定，早晚各 1 次。

(5) 车桂散敷灸：取车前子、肉桂各等份，共研细末，取药末填满脐窝，胶布固定，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

2. 虚泻 脾虚者，大便时溏，迁延反复，饮食减少，稍进油腻则大便次数增多，脘闷不适，神疲倦怠，面色萎黄，重者完谷不化，水谷不分，手足不温，喜热畏寒，体重下降，消瘦，脉濡弱；肾虚者，五更黎明腹胀作痛，肠鸣即泻，泻后则安，腰膝酸软，足跟痛，形寒肢冷，舌淡，脉沉细。

治则 健脾益气，温肾固涩。

取穴 大肠俞、中脘、天枢、足三里。脾虚加脾俞、胃俞、关元俞、水分；肾虚加百会、肾俞、命门、章门、关元、太溪。

方义 大肠俞、中脘、天枢、足三里调整胃肠功能，消胀止泻；脾俞、胃俞、关元俞、水分健脾化湿，利水止泻；百会升阳益气；肾俞、命门、关元、太溪温肾壮阳，固摄止泻；章门振奋脾阳，健脾止泻。

灸法

(1) 艾炷隔姜(或附子饼、或胡椒饼)灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~7 壮,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 5 日。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 10~20 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 5 日。

(3) 灯火灼灸:在天枢、长强、隐白各灼灸 1 下,3 日 1 次。

(4) 太乙神针灸:每次选 3~5 穴,按灸 5~7 次。

(5) 火针灸:每次选 2~4 穴,施细火针灸。

(6) 拍火敷灸:取煨肉豆蔻、赤石脂各 30 克,罌粟壳、苍术、白术各 20 克,党参、炮姜各 5 克,共研细末,取药末置中脘、天枢、大肠俞、脾俞、肾俞等穴施行拍火敷灸,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(7) 复方五倍子敷灸:取五倍子、枯矾各 30 克,朱砂 15 克,母丁香 10 克,麝香 0.5 克,独头蒜 3 头,共捣成膏,制成黄豆大药丸。再取生姜 200 克置麻油 250 毫升内炸枯后去姜,继续熬油至滴之成珠,徐徐加入炒黄丹 120 克,搅匀收膏备用。敷灸时取药 1 丸置摊成的膏药中央,敷于脾俞、大肠俞、神阙等穴上,3 日更换 1 次。

(8) 经常在中脘、天枢、气海穴施艾炷或艾条温和灸:可预防虚泻,若属虚寒性腹泻可加灸申脉穴。

麻痹性肠梗阻

麻痹性肠梗阻是由于肠壁肌肉因神经反射障碍,使肠管失去蠕动能力,以致肠内容物通过障碍的一种疾病。属中医“肠结”范畴。

【病因病机】

本病常发生于腹部大手术后、急性弥漫性腹膜炎、腹膜后出血等疾病中。中医认为,凡饮食不节、寒邪凝滞、热邪闭阻、湿邪中阻等影响肠腑传导功能,均可导致肠腑气滞血瘀,出现肠结。

【临床表现】

腹部呈持续性胀痛不适,全腹膨胀,定位不明,不排气、排便,溢出样呕吐。检查:肠鸣音消失,X线检查表现为小肠、结肠普遍胀气扩张,严重时出现脱水,电解质紊乱,酸碱平衡失调,甚至发生感染性休克。

【辨证施灸】

按脏腑辨证多为阳明腑实证,临证可见寒热虚实各种证候。多取阳明、太阳经穴为主。

治则 通腑攻下。

取穴 大肠俞、左大横、关元。

方义 大肠俞通肠腑,消腹中气胀;关元温阳益气,推动肠腑传导;左大横调胃肠经气。

灸法

(1)艾炷隔姜灸:用食盐先填满脐中,再覆盖姜片,每次灸3~5壮,每日3次。

(2)按灸:取桂枝、白芷、公丁香、急性子、王不留行各等量,共研细末,伴入适量面粉,调成稀浆糊状,制成药物衬布,铺于穴位上,用艾条点燃按灸3~7次,每日1~2次。注意防止烫伤。

(3)丁香肉桂敷灸:小儿肠麻痹取丁香、肉桂各3克,麝香少许,共研细末,纳脐中,然后取煮熟鸡蛋1个,去壳对半剖开,去蛋黄后覆盖脐上,包扎固定,2小时可闻肠鸣或出矢气,若仍不转气,可重复1次即可见效。

便秘

便秘即大便秘结不通,古称“脾约”、“大便难”。是指大便次数减少,间隔时间延长,粪便性质改变,排便困难而言,是临床常见症状。据报道,我国有35%以上的中、老年人患有不同程度的便秘,国外报道高达40%~50%,是中、老年人常见的多发病。正常人由于生活饮食习惯不同,排便的时间和次数也不同。但大部分健康成年人,1~2日排便1次或1日排便2次,如超过2日以上不排便,且有不适的感觉即称之为便秘。包括排便间隔时间延长,粪便干燥或患者主观排便困难。便秘有功能性和器质性两大类。可见于习惯性便秘;肠神经官能症和肠道炎症恢复期肠蠕动减弱引起的便秘;全身虚弱致排便动力减弱引起的便秘;肛门疾病引起的便秘及药物性便秘等。

【病因病机】

正常排便是直肠粘膜受粪便充盈扩张的机械刺激,产生冲动,经神经反射使直肠收缩,肛门括约肌松弛,腹肌及膈肌收缩,而将粪便排出肛门。因此,凡以上排便过程的任何环节发生障碍均可发生便秘。临床上可以影响这些环节的因素很多,归纳起来大致有食物性、药物性、精神性、内分泌性、机械性、功能性和器质性等。中医认为,便秘之因主要是外感六淫、不良的饮食习惯、过食辛辣厚味、情志不舒、忧思过度等导致肝郁气滞,阴液暗耗;饮食劳倦损伤脾胃、大病、久病、失血、伤津等导致气血亏虚,肠道失于濡润;高年津亏,阳气衰微等多种因素导致脾胃积热、肝脾气滞、脾肺气虚、脾肾阳虚、阴寒凝结等引起。其病机与肺脾肾关系密切。肺主气与大肠相表里,肺移热于大肠则大便燥结,传导失常;脾主纳运,脾虚不运,糟粕内停;肾主五液,司二便,肾精亏耗则大肠干涩,肾阳不足,

命火衰微则阴寒凝结大肠,传导不行,均可形成便秘。

【临床表现】

大便干结不通或排便困难,有时可出现热结旁流而形成假性腹泻,伴腹胀腹痛,恶心嗳气,食欲减退及头痛头昏,肛裂、痔疮疼痛出血,检查可在乙状结肠处触及粪块。

【辨证施灸】

临证可见气秘、热秘、虚秘、冷秘等证候。便秘之治以捷速通下为主,设法首当排出燥屎为先,其寒热虚实,可于施治中随证加减,灸灸疗法对虚秘、冷秘疗效较好,以取任脉经穴为主。

1. 虚秘 大便数日或10数日不行,少腹不适或虽有便意而努责乏力,努责则汗出气短,无力排出大便。粪便干结如羊屎或松散如糟粕,形体消瘦,咽干津少,舌淡苔白或舌红少津,脉细弱或细数无力。

治则 补益气血,润肠通便。

取穴 脾俞、胃俞、大肠俞、天枢、支沟、足三里、三阴交。

方义 脾俞、胃俞、足三里、三阴交为表里配穴法,有培补气血生化之源,鼓舞振奋中气之功;大肠俞配天枢调理肠胃功能以通降腑气;支沟宣通三焦气机。

灸法

(1) 艾炷隔蒜灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次,10次为1个疗程,疗程间休息5日。

(2) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸10~15分钟,10次为1个疗程,疗程间休息5日。

(3) 葱豉膏敷灸:取连须葱头3茎,淡豆豉12粒,生姜10克,食盐3克,共捣烂,制成药饼烘热敷灸神阙穴。

(4) 附子丁香敷灸:取附子、丁香各25克,川乌、白芷、猪

牙皂各 15 克,独头蒜 10 克,胡椒 5 克,共捣粗末,炒热布包敷灸小腹部,以熨斗或热水袋温熨灸之,每次 30 分钟,每日 1~2 次。

2. 冷秘 大便艰涩不易排出,努责则脱肛,腹中冷痛,腰冷酸软,四肢欠温,小便清白频数,面色苍白,舌淡苔白,脉沉迟。

治则 补肾助阳,温润通便。

取穴 肾俞、关元俞、大肠俞、神阙、气海、关元、足三里、太溪。

方义 肾俞、关元俞、太溪补肾益气壮阳,温润大肠;大肠俞能助肠腑传送大便;神阙、气海温阳益气散寒;足三里温中健脾,调理胃肠气机,帮助大肠传送大便。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 5~7 壮,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔盐灸:用食盐填满脐中,再覆盖姜片后,艾炷灸 5~10 壮或灸至皮肤潮红为度,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸:同上。

(4) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(5) 葱灸:①取葱白 250 克,捣烂敷灸神阙穴,用热水袋熨灸,每次 30 分钟,每日 1 次。②取大葱 200 克,白胡椒 100 克,共捣烂如糊状,敷灸左腹结穴,每日 1 次。

(6) 枳实敷灸:取枳实、麸皮、青盐各适量,共炒烫布包,敷灸神阙,每次 30 分钟,每日 1~2 次。

(7) 乌柏树皮敷灸:取乌柏树皮 500 克,石菖蒲 250 克,

共捣烂,炒热喷酒布包,垫坐敷灸肛门,每次 30 分钟,每日 1~2 次。

(8) 复方附子丁香敷灸:取附子 15 克,川乌、丁香、白芷、大蒜各 9 克,胡椒 3 克,共捣烂,炒烫敷灸神阙穴,用热水袋置穴上保温,每次 30 分钟,每日 1~2 次。

3. 对于气秘、热秘亦可选用敷灸治疗

(1) 商陆敷灸:取商陆根 10 克,研细末,水调成糊状敷灸鸠尾穴,每日 1 次。

(2) 皮硝敷灸:取皮硝 9 克,皂莢末 1.5 克,水调成糊状敷灸神阙穴,每日 1 次。

(3) 大戟敷灸:取大戟粉 1.5 克,红枣(去核)5 枚,共捣成膏状敷灸神阙穴,每日 1 次。

(4) 田螺敷灸:取田螺(去壳)3 个,加青盐少许捣烂敷灸下气海穴,每日 1 次。

(5) 复方大黄敷灸:①取大黄 30 克,皂莢 15 克,芒硝 10 克,水煎取浓汁涂擦脐部(重点神阙、关元),然后取青盐 250 克,炒热布包熨灸之。②取大黄 30 克,巴豆 15 克,共研细末,加大葱适量捣烂入酒曲和药末调成软膏状,加麝香少许敷灸脐上。

4. 预防便秘 防治习惯性便秘可在天枢、气海、上巨虚穴采用艾炷或艾条温和灸;防治老年性便秘可在气海、支沟、上巨虚穴采用艾炷或艾条温和灸。

胃下垂

胃下垂与中医的“胃缓”相似,是指在站立位时胃的下缘达盆腔,胃小弯弧线的最低点降至髂脊连线以下。常见于女性和体型瘦长者。

【病因病机】

胃下垂的病因目前不明确,学说多不一致。一般认为,是由于胃膈、胃肝韧带松弛无力,胃张力减退而引起,与体型和体质因素有关。此外,经产妇、卧床少动者及消耗性疾病进行性消瘦者亦可见胃下垂。中医认为,本病多由先天不足,或长期饮食不节,情志失和,劳倦过度及病后失调等损伤脾胃,以致脾虚胃弱,纳运功能紊乱,纳食减少,味不归形而渐致形体消瘦,肌肉不坚,中气下陷,升举无力,遂成胃缓。此外,产后腹壁松弛,托胃无力,亦致胃下垂。病机为脾胃脏腑功能失常,属虚证,但因纳运受碍,亦可兼夹湿饮,瘀血内停而出现本虚标实的证候。

【辨证施灸】

患者多见肌肉瘦削,精神倦怠,面色萎黄,食欲不振,食后脘腹胀满或隐痛,暖气不舒,或脘腹胀坠,站立位更明显,平卧时减轻,或呕吐清水痰涎,舌淡白,脉缓弱。

治则 健脾和胃,益气升陷。多取任脉和手、足阳明经穴。

取穴 百会、脾俞、胃俞、中脘、梁门、气海、关元、足三里。

方义 百会升阳益气,有升提举陷之功;脾俞、胃俞、中脘健脾益胃充腑气,培补后天生化之源;梁门和脾胃,消胀满;气海、关元益气培元,补肾固本;足三里健脾补虚,扶正以滋化源。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选 3~5 穴,各灸 5~7 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 10~20 分钟,10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分

钟),隔日1次,10次为1个疗程。

(4) 火针灸:用细火针点刺中脘、梁门、足三里穴,隔日1次,10次为1个疗程。

(5) 蓖倍膏敷灸:先将百会穴周围之头发剃去,然后取蓖麻子、五倍子各适量,共捣烂成膏状敷灸穴上,包扎固定后将热水袋或盛热水的搪瓷杯熨灸10分钟,每日3次,以感温热不烫为度,隔日换药1次,6次为1个疗程。敷灸期间注意休息,调节饮食,禁忌房事。

按:胃下垂目前尚无特异性治疗,艾灸疗法有温阳益气举陷作用,可改善症状助胃升举。若能配合补益中气药物内服,加强腹肌锻炼则疗效更佳。

溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎是一种原因不明的直、结肠粘膜表浅性非特异性炎症病变。由于本病的特异性诊断指标不易掌握或和一般感染性结肠炎的鉴别不易做到,因此,两者易被混合地诊断为慢性结肠炎或溃疡性结肠炎。发病年龄以20~40岁居多。中医目前对本病的认识不统一,一般认为本病似属“久泻”、“痢疾”,也有认为属“肠风”、“脏毒”者。

【病因病机】

本病的真正原因尚不清楚,但已知其发病与免疫异常、遗传及非特异性感染等因素有关。精神神经因素、饮食因素也影响本病的发生。但只属诱因或附加因素,不能单独致病。病变主要在直肠、乙状结肠,严重者可累及整个结肠。主要侵犯粘膜及粘膜下层,早期仅粘膜浅层弥漫性炎症改变,肠腺底部有微小隐窝脓肿,脓肿融合后产生小浅溃疡,溃疡附近可形成假息肉。中医认为,本病是由于感受暑热、寒湿,或内伤,饮食生

冷,胃肠受损,运化传导失常,湿热蕴结,下注大肠,腑气不利,气血凝滞,夹湿热伤及肠络,为脓为血,里急后重,或脾虚湿从内生,直迫大肠,粪粘质烂,久泻不止。

【临床表现】

本病起病可急可缓,症状可轻可重,主要表现为腹泻、大便性状异常、腹痛、便血、里急后重、发热、贫血、消瘦、水电解质紊乱、低蛋白血症、营养障碍、体质衰弱等。腹泻每日数次至10数次,粪便伴脓血和粘液,腹痛为隐痛或下腹绞痛,左下腹压痛,纤维肠镜检查可见形状不规则、大小深浅不同的溃疡。部分患者有肠道外表现,如结节性红斑、虹膜睫状体炎、慢性活动性肝炎等。

【辨证施灸】

临证可见湿热下注大肠、肝旺脾弱、脾胃虚弱、脾肾虚寒等证候。但由于本病起病缓慢,反复发作,经久不愈,故证候表现多为寒热错杂,本虚标实。

治则 寒热虚实并调,邪正兼顾。

取穴 天枢、气海、关元、足三里、上巨虚。

方义 天枢、足三里调理胃肠气机,健脾化湿导滞;气海、关元益气补虚;上巨虚行气通肠,清泄胃肠湿热。肝旺脾弱者加肝俞、阳陵泉、行间以疏肝理气,平肝护脾;脾胃虚弱者加脾俞、胃俞、公孙以健脾益气;肾虚者加肾俞、命门以温肾补命火。

灸法

(1) 艾炷化脓灸:在足三里、上巨虚各灸5~7壮,每月1次。

(2) 艾炷灸:每穴灸7~9壮,隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息5日。

(3) 艾条温和灸：每穴灸 10~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。

经常在大肠俞、神阙、天枢、阴陵泉施艾炷或艾条温和灸，可防治慢性肠炎。

黄 疸

黄疸是以面目、皮肤黄染，小便黄赤为主要特征的一种疾病。其中尤以目黄为最有意义的诊断依据。可独成一种疾病，也可见某些疾病过程中的一种症状。历代对黄疸的命名和分类极为繁杂，现在临床大多分为阳黄、阴黄两类。此外，尚有急黄，为阳黄的危重证候。西医所论述的黄疸症状与中医之黄疸的含义相同，其所区分的肝细胞性、阻塞性及溶血性黄疸均属中医的黄疸范畴，大致包括病毒性肝炎、肝硬变、胆囊炎、胆石症、溶血性黄疸、败血症及钩端螺旋体病等。

【病因病机】

黄疸的致病原因主要为湿邪，或为湿热蕴结肝胆，阻滞胆道；或为寒湿困阻脾胃，气血亏虚；或瘀血等导致肝脾郁滞，脾失健运，肝胆失疏，胆汁外溢肌肤而发黄。外感湿热、寒湿、疫毒，蕴结脾胃，湿从热化，熏蒸肝胆，气机不畅，胆汁不循常道，浸淫暴溢肌肤，熏染肌肤发为阳黄；如湿夹热毒，或疫毒化火，内传营血，损及肝肾，邪陷心包，蒙闭脑窍，则成急黄；阳黄久延，或饮食失节，劳倦过度，损伤脾胃，中阳不运，湿从寒化而内阻，胆汁为湿邪所遏，浸淫肌肤而成阴黄。此外，情志怫郁，癥瘕积聚，日久不消，瘀血阻滞胆道，胆汁外溢也致黄疸，亦有气血亏虚，血败不华肤而发黄者。现在已知，黄疸是由于血液中胆红素浓度增高所致巩膜、粘膜、皮肤及某些体液的黄染。正常血清总胆红素为 1.7~17 微摩尔/升，当血清总胆红素浓

度 >34 微摩尔/升时,临床上即可出现黄疸,如果浓度在 $17\sim 34$ 微摩尔/升时,则为隐性黄疸。

引起血清胆红素增高的原因主要有:①各类肝炎、肝硬化、钩端螺旋体病等使肝细胞破坏,细胞内胆红素自肝血窦进入血循环。②肝外结石、胆道瘢痕狭窄、肿瘤及某些药物引起变态反应等阻塞肝内毛细胆管或胆管,使肝内胆红素排泄障碍,渗入毛细血管进入血循环。③恶性疟疾、败血症、蚕豆病、输血反应、某些毒蛇咬伤等导致溶血,红细胞被破坏,大量胆红素释入血清。此外,还有较少见的妊娠黄疸、慢性家族性黄疸等。

【临床表现】

临床表现主要为皮肤、巩膜、粘膜、尿液黄染,甚则汗液、精液、乳汁及胸、腹水皆黄染,皮肤瘙痒,因病因不同可伴有相应症状和体征。实验室检查血清胆红素异常。

【辨证施灸】

历代对黄疸的分类很不统一,现在临床一般按阳黄与阴黄论治。

1. 阳黄 面目皮肤发黄,色鲜明如橘子,伴发热口渴、胸闷呕恶、胁痛、脘腹胀满、饮食减退、小便黄赤、大便秘结、苔黄腻、脉滑数或弦数。若热毒化火内陷营血、心包,可出现高热神昏,发斑出血等急黄重症。

治则 疏利肝胆,清热解毒,利湿退黄。以取督脉、足少阳、厥阴经穴为主。

取穴 肝俞、胆俞、至阳、阳陵泉、阴陵泉、太冲。

方义 肝俞、胆俞、阳陵泉疏泄肝胆经气,清热利湿;至阳宣泄经气,为清热退黄经验穴;阴陵泉健脾利湿退黄;太冲疏表里,泻肝胆。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1~2 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 灯火灼灸：每次选 2~4 穴，采用阴灯灼灸法，各灼灸 1 下，每日 1 次，可连续灼灸至退黄。

(3) 栀子敷灸：取栀子 15 克，面粉 3 克，用鸡蛋清调肘饼敷灸脐上，每日 1 次，直至退黄。

(4) 毛茛敷灸：取毛茛 60 克，食盐 4 克，共捣烂，敷灸脐下或臂部约 10 小时，使之发泡。去药后用生理盐水将局部洗净，用消毒针头将水疱挑破敷料包扎，5 日 1 次，3 次为 1 个疗程。

2. 阴黄 面目皮肤发黄，色晦暗如烟熏，脘痞胀满，食欲减退，口淡不渴，神疲乏力，精神困顿，大便溏薄，舌淡苔白腻。若肋下痞积胀痛，腹胀形瘦，蛛丝缕缕，舌有紫点瘀斑，舌红苔薄，脉细涩，多为瘀血积聚，应防恶变。

治则 温化寒湿，健脾利胆，退黄，或行气活血。以取足阳明、太阴经穴及背俞穴为主。

取穴 脾俞、胆俞、至阳、中脘、关元、足三里、三阴交。

方义 脾俞、中脘、足三里温中健脾化湿；胆俞清泄利胆；至阳为退黄验穴；关元温阳散寒；三阴交导湿下行。神疲畏寒加气海、命门；大便溏薄加天枢。

灸法

(1) 艾炷灸：同阳黄。

(2) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 灯火灼灸：每次选 3~5 穴，采用明灯爆灸法，各灼灸 1 次，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

胁 痛

胁痛是指一侧或两侧胁肋部(胸壁两侧从腋下至十一肋肝胆经脉循行部位)发生疼痛而言。属患者常见的自觉症状,主要与肝胆疾病有关。可见于肝、胆、胸膜等急慢性疾病及外伤、肋间神经痛等。

【病因病机】

胁痛的发生多由于情怀不畅,饮食不节,或外邪侵袭而导致肝胆湿热,或失血伤阴,久病体虚,以及外伤等引起肝胆失于疏泄,肝气郁结,气滞血瘀,肝络不通,不通则痛。

【临床表现】

胁痛为临床常见症状之一,有隐痛、胀痛和刺痛的不同。轻者仅表现为胁肋部隐痛、胀痛或窜痛,食后痛甚,疼痛大多可以忍受,伴胸闷不舒,暖气频作,口苦咽干,食欲不振;重者则疼痛如刺如绞,突然发作,阵发性加重,可向胸骨柄下端或右肩背部放射,患者辗转不安,面色苍白,大汗淋漓,恶心呕吐,或伴发热、黄疸等症状。应注意与急腹症、心绞痛、胆绞痛、肾绞痛等鉴别,以免贻误病情。

【辨证施灸】

临证常见湿热胁痛、瘀阻胁痛、肝郁胁痛、阴虚胁痛等证候。

1. 湿热胁痛 右胁肋胀痛或刺痛如灼,或牵引肩背,伴发热恶寒或寒热往来,胸闷心烦,口苦干渴,恶心呕吐,厌油纳呆,黄疸,小便黄赤,大便不畅或秘结,苔黄腻,脉弦数。

治则 疏利肝胆,清热利湿。取足少阳、厥阴经穴为主,可参考阳黄治疗。

取穴 胆俞、期门、日月、阳陵泉、阴陵泉、足三里。

方义 胆俞、期门、阳陵泉疏肝利胆，清热利湿；日月利胆降逆，调理胃气；阴陵泉健脾利湿；足三里调和胃气。腹胀恶心加中脘、内关。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴 3~5 壮，每日 1 次，5 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸：每穴 10~15 分钟，每日 1 次，5 次为 1 个疗程。

(3) 茺花菊花熨灸：取茺花、菊花、羊蹄躅花各等份，用布包后蒸热熨灸痛处，每日 1 次。

(4) 复方龙胆草敷灸：取龙胆草、大黄、皮硝、当归、川芎、栀子、黄连、芦荟、木香、青皮各等份，共研细末，加麝香少许，用姜汁调敷灸胁下疼痛处，每日 1 次。

2. 肝郁胁痛 胁肋胀痛或攻痛，窜无定处，每因情绪变化而增减，伴胸闷脘痞，烦躁易怒，善太息，噯气反酸，头晕目眩，不思纳食，妇女经期乳胀，苔黄脉弦。

治则 疏肝解郁，理气止痛。

取穴 肝俞、期门、支沟、阳陵泉、少阳。

方义 肝俞、期门疏肝理气；支沟、阳陵泉和少阳，解胁痛。噯气反酸加足三里、公孙。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 3~5 壮，每日 1~2 次，灸至疼痛缓解为度。

(2) 艾条灸：每穴灸 10~15 分钟，每日 2 次，灸至疼痛缓解为度。

(3) 灯火灼灸：采用阴灯灼灸法，每穴灼灸 1 下，每日或隔日 1 次，灸至疼痛缓解为度。

(4) 柴胡青皮熨灸：柴胡、青皮各 15 克，川芎、丹皮各 10

克，共捣粗末，同麦麸适量加醋少许炒热布包，熨灸痛处，每日1次。

3. 阴虚胁痛 胁肋隐痛，劳累时加重，头晕目眩，夜寐不安，心中烦热，口干咽燥，面色无华或晦暗，舌红苔少，脉细弦数。

治则 滋阴柔肝，养血活络。取手少阴、足太阴经穴为主。

取穴 膏肓、肝俞、肾俞、阴郄、支沟、三阴交。

方义 肝俞、肾俞调补肝肾之阴；膏肓清虚热；支沟通络止痛；阴郄、三阴交养血柔肝。头晕目眩加百会、风池；隐痛甚加章门、京门。

灸法

(1) 艾条灸：每穴灸10～15分钟，每日1次。

(2) 太乙神针灸：在期门、阳陵泉、三阴交等穴各灼灸10～15分钟。

4. 瘀阻胁痛 胁肋刺痛，固定拒按，肋下有痞块，面色黧黑，形体消瘦，舌有瘀点瘀斑，脉弦或细涩。

治则 活血化瘀，通络止痛。取足厥阴、太阴经穴为主。

取穴 肝俞、膈俞、血海、大包、行间。

方义 肝俞、行间疏肝理气止痛；膈俞、血海活血化瘀，和络止痛；大包通络止痛。气滞加膻中以行气止痛；刺痛甚加内关。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸3～5壮，每日1次，10次为1个疗程。

(2) 艾炷隔王不留行灸：肋间神经痛，取王不留行末适量，用青皮浸液调制成厚约0.2厘米小圆饼放在肝俞及疼痛处，上置艾炷灸7～9壮，隔日1次。

(3) 艾炷隔蒜灸：在肝俞或疼痛处灸 3~5 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 艾条灸：每穴熏灸 10~15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸：每穴灸 3 壮(或 10~15 分钟)，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(6) 阿魏敷灸：取阿魏 3 克，置大膏药上，微火烘软，敷灸痛处，3 日更换 1 次。

(7) 硫黄大蒜敷灸：取硫黄 30 克、红皮大蒜(去皮)1 头，共捣烂敷灸胁下痞块处，每日 1 次。

(8) 复方三棱莪术敷灸：取三棱、莪术、当归、川芎、赤芍各 6 克，共研细末，醋调敷灸胁下或痞块处，每日 1 次。

(9) 复方马兰根敷灸：取马兰根 30 克，凤仙子 10 克，白芥子 5 克，麝香少许，共捣烂敷灸胁下痞块处，每日 1 次。

按：胁痛是患者自觉的常见症状，多与情志不和及肝胆疾病有关。艾灸有较好的止痛效果，可单独使用或配合中西医药物治疗。但临证应注意与胆绞痛、肾绞痛及各种急腹症相鉴别，以免耽误治疗。

肝 硬 变

肝硬化是一种以肝脏损害为主要表现的慢性全身性疾病。中医无此病名，但从其症状和转归来看，可归于“胁痛”、“单腹胀”、“鼓胀”、“积聚”范畴。

【病因病机】

肝硬变的病因不一，大体有慢性肝炎、血吸虫病、酒精中毒，以及胆汁性、心源性、代谢性、毒性和其它原因等。其病理特点是各种致病因子持久或反复作用于肝脏组织，引起肝

细胞变性、坏死、再生和纤维组织增生等一系列病理变化,结果扰乱了肝组织正常结构,导致肝脏形体异常、质地变硬,故名肝硬变。中医认为,本病多由情志所伤,饮食失节,饮酒过度,房室劳倦,时疫蛊毒外染及其它脏腑疾病传变等因素所致。病机主要是肝、脾、肾等脏受病,气郁或血、水等郁积腹内,以致腹胀大如鼓。迁延日久,传变多端,病邪相互纠缠,千头万绪,各期病机不一,但总以五脏虚损,气血、痰湿、蛊毒及水液结聚为主,病变本质为血瘀。

【临床表现】

肝硬变起病缓慢,病程长,临床主要表现为肝功能损害与门脉高压等所引起的-一系列症状和体征。在肝功能代偿良好期可无症状或症状较轻,缺乏特异性,仅有食欲减退、消化不良、恶心呕吐、腹痛腹胀、大便不规则、全身乏力等,肝功能检查正常或轻度异常;肝功能失代偿期,除上述症状加重、体征明显外,水肿、腹水、黄疸、腹壁静脉怒张、肝脾肿大质硬、血管痣、肝掌、发热、出血、显著营养不良、肝昏迷等肝功能减退、门静脉高压症状、肝脾肿大硬变及各种并发症的发生均可先后出现。实验室检查多有轻度贫血、白细胞及血小板减少、肝功能异常、白蛋白降低,而球蛋白升高,两者之比例倒置,B超、CT检查肝脏可有相应改变,肝活组织检查即可确诊。

【辨证施灸】

肝硬变的实质属正虚邪实,但因其病因复杂,证候多变,在病程中可表现为气、血、水湿、火热、风痰等各个阶段。治疗可按初、中、晚三期进行。

1. 初期(相当于气鼓) 胸闷胁痛,脘腹胀满,腹部膨隆,叩之如鼓,纳呆神疲,大便不畅或便秘,小便黄赤,苔薄白,脉弦细。

治则 疏肝和胃，行气消胀。取足厥阴、阳明、任脉经穴及背俞穴为主。

取穴 肝俞、脾俞、大肠俞、中脘、气海、足三里、太冲。

方义 肝俞、脾俞疏肝理气，健脾消胀；大肠俞行气导滞消胀；中脘、气海调理中焦气机，行气消胀；足三里配太冲疏肝和胃。胸闷气短加膻中；便秘加大横、支沟；尿黄加阴陵泉。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 5~7 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。

(2) 艾条温和灸：每穴灸 10~15 分钟，每日 2 次，20 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。

(3) 温针灸：每穴灸 3 壮（或 10~30 分钟），每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。

2. 中期（相当于水鼓） 胁痛渐重，积块增大变硬，腹部膨胀如蛙，下肢水肿，脘腹臌胀，面色晦暗或黧黑，神疲怯寒或寒热时作，肌肤甲错，皮肤出现红点或有血管痣，大便溏薄，小便不利，妇女闭经，苔白腻，脉沉弦。

治则 补益脾肾，化湿利水。取足太阴、少阴及任脉经穴为主。

取穴 脾俞、肾俞、水分、水道、阴陵泉、复溜。

方义 脾俞、肾俞补益脾肾以运化水湿，开阖水道，脾肾健旺则水湿自化，腹水得消；水分为消腹水验穴；水道通调三焦膀胱气化；阴陵泉化湿，三穴合用化湿利水，以加强消除腹水的作用；复溜温肾开水道。畏寒加命门、关元；腹胀加大肠俞、小肠俞、上髂、次髂。

灸法

(1) 艾炷灸、温针灸：同初期。

(2) 艾条温和灸:腹胀甚同时灸命门、关元、上髎、次髎,每穴灸 20~30 分钟,每日 1~2 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 艾火针衬垫灸:取桂枝、白芷、急性子、王不留行、公丁香各等份,共研细末,加面粉适量拌匀调成薄浆糊状,制成药物衬布。施灸时每次选 3~5 穴,用点燃艾条隔药物衬布对准穴位各按灸 3~7 次,每日或隔日 1 次。按灸时防止烫伤。

(4) 田螺敷灸:取活大田螺(去壳)4 只,大蒜(去皮)5 瓣,车前子(研细)10 克,共捣烂敷灸神阙,包扎固定 8 小时后去药,每日 1 次,3 次为 1 个疗程。

(5) 商陆敷灸:取商陆末 1 克,生姜 2 片,共捣烂敷灸脐上,包扎固定,早晚各 1 次,7 次为 1 个疗程。

(6) 复方川椒敷灸:取川椒 100 克,阿魏、三棱、白术、炙鳖甲各 15 克,共研细末,加白酒适量炒烫布包,敷灸肝区、神阙(腹水者),上加热水袋保温,每次 30~60 分钟,每日 1 次。

(7) 复方水红花子敷灸:腹水者取水红花子 6 克,大黄、朴硝、山栀、石灰各 3 克,酒曲 1 块,共捣烂纳神阙穴上,覆盖厚布数层,用热水袋熨灸,每次 30 分钟,每日 2~3 次。

3. 晚期(相当于血鼓) 腹胀如鼓,肿块坚硬,痛如针刺,脐周青筋暴露,脐突阴肿,四肢瘦削,甚则潮热黄疸,呕血便血,神昏谵语,肝昏迷,舌质紫暗或有瘀斑,脉细弦涩。

治则 活血化瘀,软坚散结,滋养肝肾。取任、督脉经穴及肝脾俞募穴为主。

取穴 至阳、肝俞、脾俞、期门、章门、石门、痞根、三阴交。

方义 至阳健脾调中,理气利水;肝俞、脾俞、章门、期门属肝脾俞募相交,阴阳相配,疏二脏气血,统治肝脾诸疾;石门配痞根活血化瘀,通络散结;三阴交为足三阴经交会穴,循经治疗直达病所。腹胀甚加中脘、梁门;便溏加神阙、大横。

灸法

(1) 瘢痕灸：每次选 1~2 穴，各灸 7~9 壮，每日 1 次，5 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~9 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 15~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 20~30 分钟），每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(5) 太乙神针（或百发神针灸、消癰神火针）灸：在中脘、神阙、天枢、气海、足三里各施灸约 10~15 分钟，每灸 5~7 次为度。

按：肝硬变目前临床尚无特异性治疗，大多采用中西医结合对症治疗。治疗所能达到的目的是最大限度地恢复和保持肝脏功能，减轻症状，预防并发症，促使失代偿期向代偿期转化，从而延长生命和提高生活质量。艾灸疗法也只能起到这种辅助治疗作用。

眩 晕

眩即眼花，晕即头晕，是指视物模糊昏花或眼前发黑，头晕旋转，站立不稳而言，因二者常同时出现，故合称眩晕。可单独出现也可出现于各种疾病过程中。常见于成年人，多属肝经疾病，可见于西医的中枢性（脑性）、周围性（耳性）、眼源性、中毒性、外伤性等各种眩晕，以及贫血、高血压、低血压、颈椎病、心血管疾病、神经官能症等疾病所引起的眩晕。

【病因病机】

眩晕的病因复杂，可由风、火、痰、瘀、虚等多种因素引起，

与情志、饮食、外伤、虚损等因素有关。凡情志失调、饮食不节、思虑劳倦、纵欲无度、年老体衰,以及头脑外伤等原因损伤肝、脾、肾、脑等导致肝肾阴虚,肝阳上亢、肾精亏耗、心脾两虚、气血不足,或痰浊内蕴、瘀血内阻等均可引起眩晕。若病情发展,肝风入脑,肝阳爆亢,可发生中风昏厥。

【临床表现】

患者自觉头晕眼花,视物模糊,旋转或眼前发黑,轻者闭目或卧床休息可止;重者视物旋转或自觉头身动摇如坐舟车,站立不稳或天旋地转,伴恶心呕吐,耳鸣,汗出懈怠,肢体震颤,甚则昏倒。

【辨证施灸】

临证可见肝阳上亢、肾精不足、心脾两虚、痰浊中阻等证候。多取足厥阴、少阴、阳明、少阳及任脉经穴为主。

1. 肝阳上亢 眩晕耳鸣,心烦易怒,失眠多梦,或兼面红耳赤,口干苦,便秘尿赤,舌红苔黄,脉弦细数,甚则眩晕欲仆,头痛呕吐,肢麻震颤,语言不利,步履不稳。

治则 滋阴潜阳,平肝熄风。

取穴 风池、肝俞、肾俞、侠溪、行间、太冲。

方义 风池清头明目,散风平肝;肝俞平肝熄风,疏风清热;肾俞滋水涵木;侠溪、行间、太冲平肝潜阳,清头目。

灸法

(1) 艾炷隔芹菜根灸:每次选3~5穴,用鲜芹菜根切成0.2厘米的薄片,置穴上,再放艾炷灸3~5壮,每日1次。

(2) 艾条温和灸:每穴灸15~30分钟,每日或隔日1次,10次为1个疗程。

(3) 温针灸:每穴灸3壮(或10~20分钟),每日或隔日1次,10次为1个疗程。

(4) 大蒜敷灸：取独头大蒜、马铃薯(去皮)各等量，共捣烂，每晚临睡时敷灸涌泉(双)，次晨除去，10次为1个疗程。

(5) 盐附子敷灸：取盐附子、生地各等量，共捣烂，于每晚临睡时，用水调成糊膏状敷灸涌泉(双)，次晨除去，10次为1个疗程。

(6) 复方吴萸敷灸：取猪胆汁制吴萸100克，龙胆草50克，明矾30克，硫黄20克，朱砂15克，共研细末，用小蓟根汁调成糊状敷灸神阙、三阴交、涌泉，胶布固定，2日更换1次，10次为1个疗程。

2. 肾精不足 脑转耳鸣，多梦健忘，记忆力减退，精神萎靡，腰膝酸软，不耐劳作，或遗精滑泄，齿摇发落，舌微红，脉弦细或细数。

治则 滋补肾精，充养脑髓。

取穴 百会、肾俞、命门、太溪、三阴交、涌泉。

方义 百会升阳益气，治虚性眩晕；肾俞、命门、太溪、三阴交、涌泉滋肾益精，充养脑髓。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸3~5壮，隔日1次，5次为1个疗程。

(2) 艾条温和灸、温盒灸：每穴灸10~30分钟，每日或隔日1次，10次为1个疗程。

(3) 复方桃仁敷灸：取桃仁、杏仁各12克，栀子3克，胡椒3粒，糯米适量，共捣烂，每晚临睡时敷灸涌泉(双)，次晨除去，10次为1个疗程。

3. 心脾两虚 头晕眼花，甚则晕倒，劳累即发，动则加剧，伴心悸气短，失眠困倦，饮食减少，神疲懒言，动则汗出，面色无华，舌淡嫩，脉细弱。

治则 调养心脾，补益气血。

取穴 百会、膈俞、脾俞、肾俞、关元、足三里。

方义 百会升阳益气；膈俞补血；肾俞、关元补肾益精充脑；脾俞、足三里补中益气。气血精髓充盛，脑髓得养，眩晕自平。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每穴灸 5~7 壮，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸、温盒灸：同肾精不足。

(3) 复方附子膏敷灸：取附子、吴萸、肉桂、木香、马蔺子、蛇床子各等份，共研细末，用姜汁调成糊膏状，分别敷灸气海、关元，胶布固定，12 小时除去，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 生姜萝卜敷灸：取生姜、萝卜（捣去汁）、大葱各适量，共捣烂敷灸百会，每日 2 次。

4. 痰浊中阻 眩晕头重如蒙，胸脘痞满，呕吐痰涎，思卧嗜睡，神疲困倦，舌淡嫩，苔白腻，脉滑。若寒饮凌心，则心下逆满，心悸怔忡，脉结代；若痰火上扰，则兼见头晕胀痛，心烦而悸，口苦尿赤，苔黄腻，脉弦滑数。

治则 健脾燥湿，涤痰化浊。

取穴 中脘、内关、太渊、足三里、阴陵泉、丰隆。

方义 中脘、内关调理脾胃气机；太渊宣通肺气以化痰浊；足三里、阴陵泉、丰隆健脾化湿，祛痰化浊。诸穴合用使湿除痰化而不作眩晕。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸、艾条温和灸：同心脾两虚。

(2) 复方吴萸敷灸：取猪胆汁制吴萸 500 克，醋制白矾 100 克，硫黄、朱砂各 50 克，龙胆草醇提取物 6 克，环戊甲噻

喉 175 毫克,共研细末,每次取 250 毫克纳脐中(纳药前用生理盐水将脐窝洗净擦干),覆盖棉球,胶布固定,每周换药 1 次。

中 风

中风又称“卒中”,因起病急骤,变化多端,与风性善行数变的特性相似,故以中风名之。是中、老年人常见的急性脑血管疾病,主要包括脑出血和脑梗塞,发病率和死亡率都很高,发病经救治脱险后常留有不同程度的后遗症。

【病因病机】

中风之因主要是患者平素气血亏虚,心肝肾三脏阴阳平衡失调,复因忧思恼怒、情志内伤,或嗜酒饱食、饮食不节,或外邪侵袭、房室劳倦等诱发,以致气血阴阳逆乱,运行受阻,痰浊瘀血阻滞经络,出现肢体麻木不遂,口歪语涩等中风证候。若阴亏于下,肝阳暴张,阳化风动,与痰火相夹,血随气逆,迫使血气并走于上,横窜经络,蒙闭脑窍,呈现肢体瘫痪,神昏失语等下虚上实,阴阳不相维系的中脏腑证候。病机归纳起来不外虚、风、火、痰、气、血,其中尤以肝肾阴虚为其根本。现代医学的高血压病、动脉粥样硬化是最常见的病因,血流动力学及血液粘稠度的改变为其病理基础。

【辨证施灸】

临证所见以突然昏仆,不省人事,口眼喎斜,半身不遂为主要症状,常伴高热,眩晕,吞咽困难,失语,失明,心悸胸痛,咳嗽喘促,呕血便血,便秘或失禁等,可分为中脏腑和中经络两种情况。

(一) 中脏腑

指突然中风神志不清者,多见于脑出血,有闭证和脱证之

别。

1. 闭证 突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，肢体强痉，大便秘结。阳闭者呼吸迫促，鼻鼾气粗，喉中痰鸣，躁扰不宁，身热面赤，舌卷囊缩，苔黄腻，脉弦滑而数；阴闭者面白唇黯，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，苔白腻，脉沉滑。

治则 清热豁痰，启闭开窍。

取穴 人中、内关、劳宫、足三里、丰隆、太冲。

方义 人中可改善督脉气血运行，收启闭开窍之效；内关清心调神，醒脑开窍；劳宫降心火，安心神；足三里配丰隆可振奋脾胃气机，蠲浊化痰；太冲镇肝降逆，潜阳熄风。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 5~7 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔巴豆糊灸：取巴豆末适量，用醋调成糊状，纳满脐窝，上放姜片，再置艾炷施灸，壮数不限，灸至苏醒为止。

(3) 艾条温和灸：每穴灸 20~30 分钟，每日 1~2 次。

(4) 温针灸：每穴灸 3 壮（或 15~20 分钟），每日 1 次。

(5) 桃仁敷灸：取桃仁、栀子各 7 枚，麝香少许，共研细末，用白酒调成膏状敷灸劳宫穴，胶布固定，每日 1 次。

(6) 苈麻菟大蒜敷灸：取苈麻菟、大蒜各适量，共捣烂敷灸后颈，每日 1 次。

2. 脱证 突然昏倒，不省人事，目合口张，瞳孔散大或两侧不对称，鼻鼾色微，肢体瘫软，手撒肢冷，汗出，面色苍白，苔白滑，细微欲绝脉。

治则 益气固脱，回阳救逆，醒脑调神。

取穴 百会、肾俞、命门、神阙、气海、关元、足三里。

方义 百会益气回阳，升陷固脱；肾俞、命门温肾壮阳以

救虚脱；神阙为真气所系，灸之能挽回阳气之厥脱；气海益气培元固本；关元为任脉与足三阴之交会穴，为三焦元气所出，联系命门真阳，是阴中寓阳之穴，灸之从阴引阳；足三里补中益气。虚汗不止加阴郄；虚阳浮越，重灸命门、气海俞、涌泉以补益肾阳，摄纳浮阳。

灸法

(1) 艾炷隔盐灸：在神阙、关元，大艾炷隔盐灸之，壮数不限，以阳回厥苏为度。

(2) 艾炷隔姜(或附子饼)灸：每次选3~5穴，采用大面积灸法，持续4~8小时，壮数不限，每日1~2次，以苏醒为度。

(3) 雷火针灸：在气海、关元各按灸9次，每日2次。

(二) 中经络

指中风后仅有半身不遂，四肢瘫痪，口眼喎斜，语言不利，而无神志不清者，多见于脑梗塞。

1. 半身不遂 突然一侧肢体不能自主活动，半身麻木，重则感觉丧失，或肢体强痉，屈伸不利，或瘫软无力，口眼喎斜，伸舌偏歪，舌有瘀点或瘀斑，脉缓或弦滑。

治则 通经活络，调畅气血。

取穴 以循经取穴为主。上肢瘫痪取肩髃、肩髃、曲池、外关、阳池、后溪、合谷等；下肢瘫痪取环跳、髀关、伏兔、风市、阴市、阳陵泉、足三里、绝骨、解溪、昆仑等。

方义 风中经络，尊“治痿独取阳明”之古训，以取多气多血之阳明经穴为主，太阳、少阳经穴为辅。上述诸穴系宗循经取穴之旨，意在疏通经络，调畅气血，促进肢体康复。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选3~6穴，各灸5~7壮，每日1次，5

次为 1 个疗程,疗程间休息 3 日。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~6 穴,各灸 15~20 分钟,10 次为 1 个疗程。

(3) 太乙神针、百发神针灸:每次选 3~6 穴,各灸 10~15 分钟,每灸 5~7 次为度。

(4) 蚕砂熨灸:取晚蚕砂 100 克,分装数布袋,蒸热后熨灸患肢,每次 1 小时,每日 1 次。

(5) 复方穿山甲敷灸:取穿山甲、川乌头、红海蛤各 60 克,共研细末,用葱汁调制成 5 分硬币大小药饼,分别敷灸上述诸穴,胶布固定,然后将双足浸泡于热水中,至微汗出为度,每日 1 次,3 日更换药饼 1 次,5 次为 1 个疗程。

2. 口眼喎斜 取皂角末适量,用食醋调制成小圆饼,置神阙、颊车上,放艾炷灸 5~10 壮,每日 1~2 次。余参照面神经麻痹治疗。

(三) 预防中风灸法

取穴 百会、神阙、气海、关元、中脘、三阳络、尺泽、足三里、绝骨、涌泉。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸:每次选 2~4 穴,各灸 5~7 壮,灸后以起小水疱为度,待灸疮愈后再行复灸,每年可灸 1~2 次。

(2) 艾炷隔盐(或隔姜)灸:用食盐填满脐窝或再覆盖姜片,灸 5~7 壮,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 5 日。

(3) 艾条温和灸:①从冬至起灸关元,每次灸 15~20 分钟,以局部温热舒适为度,每日 1 次,连续灸 100 日。②选足三里、绝骨、涌泉,各灸 10~20 分钟,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 5 日。

(4) 附子敷灸：①高血压者取附子切薄片，浸泡于盐水中，每晚临睡前敷灸涌泉(双)，胶布固定，次晨取下，每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程间休息10日。②取附子、木香、肉桂、吴萸、马蔺子、蛇床子各等份，共研细末，加面粉适量，用姜汁调制成药饼，分别敷灸气海、关元6~8小时除去，隔日1次，10次为1个疗程，疗程间休息10日。

按：中风是目前世界上死亡率最高的疾病之一，一旦发病经救治脱险后，大多留有不同程度的后遗症，医学上对这些后遗症尚无满意疗法，针灸一直是治疗这些后遗症的主要手段之一，并有较好的疗效。

面神经麻痹

面神经麻痹是以口眼喎斜为特征的一种疾病。有中枢性和周围性两类。本节只讨论周围性面神经麻痹。多见于成年人，男性多于女性，以冬春发病较多。中医称“面瘫”，古称“口僻”，俗称“吊线风”。

【病因病机】

本病的确切病因尚未明确。临床最常见的是茎乳突孔内急性非化脓性面神经炎所引起的面瘫。一部分患者因局部受风着凉后而发病，但多数患者找不到确切的病因，通常认为是局部营养神经的血管因受风寒而发生痉挛，引起神经缺氧、水肿、受压迫，使血液循环障碍而致病，或附近组织有炎症病变使神经受压而引起面部肌肉运动障碍。病理变化主要是面神经水肿，髓鞘或轴突有不同程度的变性，以乳突孔及面神经管内部分尤为显著。中医认为，本病是在人体气血不足的情况下，面部、耳部手阳明经脉遭受风寒侵袭，邪气阻塞，气血痹阻于经络，经气郁滞，筋脉失于濡养，导致纵缓不收而致病。

【临床表现】

起病迅速,常于数小时内症状就可达高峰。发病前多有受风寒或感冒史,部分患者起病前或发病时可有同侧耳后乳突区或面部疼痛。患者常在早晨洗脸漱口时发现口眼喎斜,患侧面部表情肌动作有不同程度的丧失。额纹变浅或消失,眼裂增大,眼睑闭合不全,鼻唇沟变浅,口角下垂,并被牵引向健侧。面部有木僵感。患侧不能作蹙额皱眉、闭眼露齿、鼓腮噉嘴、吹口哨等动作。常有流泪、流涎,液体从病侧口角流出,食物留滞于患侧齿颊之间。少数患者可能出现味觉减退或听觉过敏,甚至外耳道出现疱疹等。病久可出现患侧面肌痉挛。

【辨证施灸】

突然发生口眼喎斜,或伴发热恶寒,项后耳下压痛,肢体拘紧,肌肉关节酸痛,苔薄白或薄黄,脉浮紧或细弦。

治则 祛风通络,养血和营,以取阳明经穴为主,足太阳经穴为辅。

取穴 地仓、颊车、下关、翳风、阳白、外关、养老、合谷、足三里、昆仑、内庭。

方义 地仓、颊车、阳白疏调局部经气,通经活络;翳风、下关、外关、养老、昆仑、内庭疏解风邪,通经活络;足三里健脾益气养血。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次,7次为1个疗程。

(2) 艾炷隔姜灸:每次选4~6穴,各灸5~7壮,每日1次,7次为1个疗程。

(3) 艾炷隔蒜泥灸:每次选3~5穴,将大蒜泥涂于穴位上,再置艾炷施灸,每次灸1壮,每日1次,7次为1个疗程。

如掺入麝香少许效果更佳。

(4) 艾条温和灸:每次选 4~6 穴,各灸 10~15 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(6) 黑鱼头敷灸:取黑鱼头 1 个,南星、草乌、天麻各 5 克,后 3 药研细末后与黑鱼头共捣烂,敷灸患侧腿部,每日 1 次。

(7) 鳝鱼血涂灸:①取活鳝鱼血调白芷末涂灸患侧面颊部,每日 1 次。②鳝鱼血适量,冰片、麝香各少许,调匀涂灸患侧面颊部,3 日 1 次。

(8) 药蒸气熏灸:取巴豆(去壳)5~10 粒,加 50~60 度白酒 250 毫升,置蒸气吹壶内煮沸,用蒸气热吹患部及太阳、下关、颊车、地仓、合谷等穴,每穴 5~10 分钟,每日 2~4 次。

(9) 苇管器灸:取巴豆皮、生川乌、白芷、薄荷、细辛各 0.6 克,白附子、炙全蝎、炙蜈蚣各 0.3 克,共研细末,均匀地撒于 30 克艾绒中,制成 7 个艾炷,在患侧耳朵施苇管器灸,每次 7 壮,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(10) 天(发疱)灸:取斑蝥 3 只,巴豆 3 粒,共研细末,用麻油调成糊状涂于无菌纱布上,分别敷灸地仓、颊车、下关穴,夏天敷 5 小时,冬天敷 8 小时,每次敷灸 2 个穴,7 日 1 次,4 次为 1 个疗程。敷灸后局部可出现水疱,用敷料包扎保持清洁,待其自行吸收。

(11) 马钱子敷灸:①取生马钱子(去皮)泡软切薄片,或取马钱子末 0.2 克置胶布中央,敷灸患侧穴位,胶布固定,7 日更换 1 次,4 次为 1 个疗程。②取马钱子 100 克,天南星 50 克,蜂蜡 135 克,木香 450 克,花生油 150 毫升,如法炼制成膏

药。敷灸时取膏药烘软,分别敷灸翳风及下关至颊车区域,7日更换1次,4次为1个疗程。

(12) 蓖麻叶敷灸:取鲜蓖麻叶适量,捣烂敷灸患侧劳官穴上,隔日1次,15次为1个疗程。

(13) 蓖麻仁敷灸:①取蓖麻仁50克(或加朱砂2克)捣烂,用姜汁调成糊膏状,敷灸患侧面颊部或颊车、地仓穴,胶布固定,每次敷7~10小时,每日1次。②取蓖麻仁30克,冰片2克(冬季加生姜、附子各3克),共捣烂,稍加醋调成膏状,分别敷灸患侧太阳、牵正、劳官穴,胶布固定,每日1次。③取蓖麻仁30克,松香90克,分别研细,先用清水100毫升置锅煮沸入蓖麻末煮5分钟,再入松香小火煮5分钟后倒入冷水中收膏,切成3克大小药块备用。敷灸时取药块用热水烫软后敷灸患侧下关(或颊车)穴上,5日更换1次。

(14) 鲜鹅不食草敷灸:取鲜鹅不食草适量,捣烂敷灸患侧面颊部,隔日更换1次。

(15) 木鳖子敷灸:取木鳖子末适量,用麻油调成糊状,敷灸患侧牵正穴,每日1次。

(16) 白芥子敷灸:取白芥子末适量,用蜂蜜调成糊状,制成蚕豆大药饼分别敷灸于患侧太阳、下关、地仓穴上,待有烧灼感时除去,每日1次。

(17) 天南星敷灸:取天南星末适量,用姜汁调成膏状,敷灸患侧面颊部,胶布固定,3日更换1次。

(18) 皂角敷灸:取皂角50克,田三七3克,共研细末,每次取2匙药末置铜勺内,用米醋调成稀糊状,用小火熬成膏状摊于布上,趁热敷灸患侧面颊部,3~7日除去,不愈可敷灸第二次。

(19) 复方川草乌敷灸:取生川乌、生草乌、威灵仙、白及、

全蝎、蜈蚣、陈皮各等份，共研细末，每次取药末 15 克，用姜汁调成糊状摊于胶布中央，敷灸患侧面颊部，3~5 日更换 1 次。

(20) 艾条温和灸：经常在颧髻、地仓、下关、颊车、翳风施灸，可预防口眼喎斜和面肌痉挛。

水 肿

水肿是指体内水液代谢障碍，水液潴留泛溢于肌肤引起局部或全身肿胀的病证。严重者还可出现胸水、腹水。西医的肾性、肝性、心性、营养不良性水肿，均可参照本节辨证施灸。

【病因病机】

水肿的发生与肺、脾、肾、心等脏功能障碍有关。外邪侵袭、饮食不节、劳倦内伤或正气虚弱等均可影响上述诸脏及其它脏腑的功能失调，导致肺失宣降、脾失输转、肾失蒸化、心气不足、心阳虚衰，推动气血运行无力，以致三焦决渎无权，膀胱气化不利，津液输布失常，引起水液潴留，泛溢肌肤而发生水肿。现代医学的心、肝、肾等疾病，内分泌功能失调，营养不良等均可引起水肿。

【辨证施灸】

临证可分阳水和阴水两大类。

1. 阳水 头面水肿渐及全身，腰以上肿甚，按之凹陷回复较快，皮色光泽，尿少。肺气不宣者可伴有恶寒发热，肢节酸痛，咳嗽气喘，苔薄白或薄黄，脉浮紧或浮数；水湿困脾者，兼见身重体倦，纳呆腹胀，苔白腻，脉沉缓。多属新病、急病、热证、实证。可见于急性肾炎、变态反应性水肿、血清病水肿等。

治则 宣肺利水，健脾祛湿。

取穴 肺俞、膀胱俞、三焦俞、水道、水分、阴陵泉、三阴交。

方义 肺俞宣肺气，通水道；膀胱俞、三焦俞、水道、水分调整膀胱，三焦气化功能，利小便；阴陵泉健脾利水；三阴交通小便。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔赤小豆灸：下肢水肿，每次选 3~5 穴，用赤小豆研末，以淡盐水调制成小圆饼置穴上，上面再放艾炷各灸 6~8 壮，每日 1 次。

(3) 艾条灸：每次选 3~5 穴，各灸 15~20 分钟，每日 1 次。

(4) 灯火灼灸：每次选 2~4 穴，用明灯爆灸法，各灼灸 1 下，每日 1 次，可直灸至肿消。

(5) 蓖麻仁敷灸：取蓖麻仁 10 粒，石蒜 1 个，共捣烂，每晚睡前敷灸涌泉穴，次晨除去，7 次为 1 个疗程。

(6) 田螺敷灸：取田螺（去壳）4 只，大蒜 5 瓣，车前子末 10 克，共捣烂敷灸脐部，8 小时除去，每日 1 次，3 次可见效。

(7) 巴豆硫黄敷灸：小儿肾炎水肿，取巴豆、硫黄各 3 克，滑石 9 克，共研细末，用清水调敷脐上，每日 1 次。

2. 阴水 下肢水肿渐及全身，腰以下肿甚，按之凹陷回复较慢，皮色晦暗，尿少。脾虚者兼脘痞纳呆，便溏肢倦，苔白腻，脉濡数；肾虚者腰膝酸软，畏寒肢冷，神疲乏力，舌淡，脉沉细，多属久病。常为虚寒证或虚中夹实证，可见于慢性肾炎、肝病性水肿、心性水肿、粘液性水肿、特发性水肿及营养不良性水肿等。

治则 健脾化湿，温肾行水。

取穴 脾俞、肾俞、命门、气海、水分、足三里、复溜。

方义 脾俞配足三里健脾化湿；肾俞配命门补肾温阳以蒸化水液；气海益气助阳行水；水分配复溜分利水湿。尿少加膀胱俞、三阴交。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 灯火灼灸：每次选 2~4 穴，用阴灯灼灸法，各灼灸 1 下，每日 1 次，可连灸至肿消为止。

(5) 太乙神针灸：在脾俞、小肠俞、天枢、丹田、水分、足三里施灸，每穴约灸 10~15 分钟，每灸 5~7 次为度。

(6) 蝼蛄敷灸：取活蝼蛄 5 只，捣烂敷灸脐上，每日 1 次。

(7) 复方商陆敷灸：腹水取商陆、芫花、甘遂、黑白丑、冰片各 6 克，共研细末，加葱白适量捣烂敷灸脐上，每日 1 次。

(8) 酒精敷灸：取酒精 1500 克蒸热，包裹敷灸双脚，以汗出为度，每日 1~3 次。

泌尿系感染

泌尿系感染是指致病菌在尿路内繁殖而引起尿道、膀胱、输尿管、肾盂感染所致的疾病。发病率很高，女性发病更多，临床以膀胱炎和肾盂肾炎较常见，属中医“淋证”范畴。

【病因病机】

致病菌通过尿路上行感染或血源性感染和淋巴管感染而引起。中医认为，发病与湿热邪毒侵袭及脏腑功能失调有关。

外邪侵袭,湿热蕴结下焦,膀胱气化失常为发病主要病因,病位在肾与膀胱。

【临床表现】

急性尿路感染可有尿频、尿急、尿痛等尿道刺激症状,男性患者尿道多出现粘液性或脓性分泌物,女性则少见。部分患者可出现血尿。慢性尿路炎症可无自觉症状或症状不明显。急性膀胱炎尿痛在排尿时出现,排尿终末较重,伴小腹胀痛,膀胱区压痛。单纯膀胱炎全身症状不明显,若兼寒战高热、腰痛、肾区扣击痛者,则可能是急性肾盂肾炎。尿检可有不同程度的脓细胞、红细胞,甚至为血尿,尿培养可找到致病菌。慢性者可有少量蛋白尿,后期可出现管型。

【辨证施灸】

本病初起证属湿热下注,蕴结膀胱或肝郁气滞,以小便频急、淋沥涩痛,赤热混浊或有粘液,小腹胀痛,舌红苔黄,脉实为特征。发病急,病程短,邪气实;病程久延、湿热留恋,可形成正虚邪实之候;若反复发作,正气耗伤,致脾肾亏虚则小便淋沥不尽,排尿无力,时发时止,遇劳即发,精神困惫,面色苍白,舌淡,脉无力。

治则 实证宜疏导膀胱气化,清利下焦湿热;虚证宜补益脾肾,佐以清利。艾灸以治疗虚证效果较好。多适用于慢性膀胱炎、慢性肾盂肾炎。

取穴 百会、脾俞、肾俞、膀胱俞、气海、关元、水道、中极、血海、阴陵泉、三阴交、太溪、京门。

方义 百会、肾俞、气海补肾升阳固涩;脾俞、阴陵泉健脾利水;膀胱俞利小便;气海、关元、中极补肾培元,益气利膀胱;水道治排尿无力;血海止尿血;三阴交、太溪、京门滋肾降虚火,化气利水。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~10 壮，每日或隔日 1 次，7 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 日。多用于膏淋、劳淋、冷淋。

(2) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，7 次为 1 个疗程。

(3) 艾炷隔附子饼灸：乳糜尿可在肾俞、关元、足三里、太溪穴施灸，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(4) 艾炷隔盐灸：冷淋用食盐填满脐窝，灸 5~10 壮，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(5) 艾炷隔知柏地黄丸灸：血淋取知柏地黄丸切成薄片，用针刺数孔。每次选 2~4 穴，将药片置穴上，各灸 3~5 壮，每日或隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(6) 艾炷隔补中益气丸灸：适用于气淋，灸法同(5)。

(7) 艾炷隔山药灸：每次选 3~5 穴，取鲜山药用盐水浸泡 10 分钟后，取出切成 0.2 厘米薄片置穴上，上面再放艾炷各灸 4~8 壮，每日 1 次。

(8) 艾条温和灸：①急情尿路感染，每次选 3~5 穴，各灸 10~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。②前列腺肥大，在关元、会阴、足三里穴各灸 20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(9) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮(或 10~15 分钟)，每日或隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(10) 地龙敷灸：热淋取地龙 7 条，蜗牛(去壳)2 只，车前子 2 克，共捣烂敷脐上，包扎固定，每日 2 次。

(11) 复方田螺敷灸：取田螺(去壳)7 只，淡豆豉 10 粒，鲜车前草 30 克，连须葱头 3 个，食盐 1 克，共捣烂敷灸脐上，包

扎固定,每日1次。

(12) 预防泌尿系感染:取曲泉、阴陵泉、三阴交穴施艾炷灸或艾条灸。

按:艾灸对慢性尿路感染有改善症状的良好效果,但单用艾灸则较难控制炎症,故应采用中西药物综合治疗,再配合针灸,以迅速解除症状和根治。

癃 闭

癃指小便不利,点滴短少,病势较缓;闭指小便不通,病势较急,两者均指排尿困难,只是轻重缓急不同而已。且有初始小便涓滴细少,继则闭而不通者,故合称癃闭。通指小便量少,点滴而出,甚至尿闭不通的病证。包括西医的各种尿潴留及无尿症,如神经性尿闭、膀胱括约肌痉挛等。

【病因病机】

本病可由外感六淫、内伤七情、饮食不节、房劳过度、外伤等因素引起湿热、气结、瘀血阻碍气化,尿路阻塞或中气不足,或肾阴、肾阳亏虚,导致气化不行而排尿困难。病位在膀胱,但与三焦、肺、脾、肝、肾有关。上焦之气不化,肺失宣肃则不能通调水道,下输膀胱;中焦之气不化,脾气虚弱则不能升清降浊;下焦之气不化,肾气不足则不能化水,肾阴亏虚则阴不化阳,均能引起膀胱气化失常形成癃闭。此外,肝气郁滞导致三焦气机不利,也会发生癃闭。

【辨证施灸】

癃闭一证,有虚有实,实者为湿热、气结、瘀血阻碍气机,尿路阻塞;虚者为中气不足、肾气衰惫或肾阴亏耗。

1. 实证 水热互结则尿少短赤或尿闭不通,小腹胀满,口干不欲饮,大便不畅,舌红苔黄,脉数;膀胱瘀血则小便滴沥

不畅，尿如细丝或阻滞不通，小腹胀痛，舌紫暗或有瘀点，脉涩或细数。

治则 清利湿热，行气活血，通窍排尿。多取太阴、膀胱经穴，俞募相配。

取穴 三焦俞、小肠俞、水道、中极、阴陵泉、三阴交、太冲、涌泉。

方义 三焦俞通调气机以利尿；小肠俞配水道通窍利尿；中极助阳行水；阴陵泉清热利湿；太冲行气利尿；涌泉滋肾通关，开窍利尿。肺气壅滞加尺泽；瘀血阻滞加次髎、委中。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 2～3 穴，各灸 5～7 壮，每日 1～2 次。

(2) 艾条雀啄灸：每次选 3～5 穴，各灸 3 壮（或 10～20 分钟），每日 1～2 次。

(3) 温针灸：每次选 2～3 穴，各灸 3 壮（或 10～20 分钟），每日 1 次。

(4) 栀子敷灸：取栀子 10 个，大蒜 1 头，食盐少许，共捣烂敷灸神阙穴，每日 1 次。

(5) 青蒿敷灸：取鲜青蒿 30 克，捣烂敷灸神阙穴至排尿除去，每日 1 次。

(6) 小茴香敷灸：取小茴香粉 10 克，用生姜汁调成糊状敷灸脐部，同时内服益元散，每日 1 次。

(7) 白芥子敷灸：取白芥子末 5 克，用温水调成糊状涂在纱布上，敷贴脐上，覆盖毛巾 1 块，用热水袋敷灸，每次 10～15 分钟。

(8) 甘遂敷灸：①取甘遂末 10 克，用水调成糊状，敷灸脐下 1.3 寸处，另取甘草 10 克，煎汤内服。②取甘遂 30 克，苡仁

15 克,共研细末,水调成糊状敷灸脐窝,以排尿为度。③取甘遂末 9 克,加麝香(或冰片代)少许,面粉适量,用温水调成糊状敷灸中极,每日 1~2 次。

(9) 复方商陆敷灸:①先取麝香少许纳入脐窝后,上面盖 1 层薄纸,然后取商陆粉 15 克敷在脐窝中,胶布固定至排尿。②产后尿闭:取商陆、磁石各 5 克,共研细末,加麝香少许调匀,分别敷灸神阙、关元穴,胶布固定,排尿后取下,每日 1 次。

(10) 田螺敷灸:①取大田螺(去壳)3 只,食盐 6 克,共捣烂,加麝香少许拌匀,敷灸气海穴,至排尿为度,每日 1 次。②取田螺(去壳)5 只,葱白 60 克,麝香(或冰片代)少许,面粉适量,先将田螺与葱白共捣烂和面粉制成药饼,再加入麝香敷灸脐窝,覆盖纱布,然后取食盐适量炒热布包,趁热熨灸 40 分钟,以尿通为度。

(11) 葱敷灸:①取生葱 250 克,切碎喷酒炒热,布包趁热熨灸神阙及小腹,反复多次,以排尿为度。②取连须葱、车前草各 60 克,共捣烂敷灸神阙穴,覆盖厚布 1 块,用热水袋熨至尿通为止,每日 1~2 次。③取葱白、鲜藕茎各 500 克,切碎捣烂炒热后加麝香少许炒至极热,布包趁热熨灸小腹,反复多次,以尿通为度。④取大葱适量,白矾 25 克,共捣烂敷灸神阙穴,每日 1~2 次。⑤取葱白 500 克,切碎加麝香少许拌匀分装 2 袋,先用 1 袋置脐上,用热熨斗熨灸 60 分钟后,另换 1 袋,改用冷熨斗熨灸至排尿为度,每日 1 次。

2. 虚证 中气下陷者则小腹胀坠,小便难出或尿少不畅,食欲不振,声低气短,精神萎靡,舌淡苔薄,脉弱;肾阳衰惫者则小便不通或点滴不爽,排尿无力,气怯畏寒,腰膝清冷,软弱无力,面色苍白,舌淡苔薄,脉沉细;肾阴亏耗者则欲尿难出,烦热咽干,手足心热,舌红,脉细数。

治则 温补脾肾，益气利尿。多取任、督脉及膀胱经穴。

取穴 脾俞、肾俞、三焦俞、气海、委阳、阴谷。

方义 脾俞、肾俞配阴谷以振奋脾肾气机；三焦俞配委阳以通调三焦气机；气海温补下焦元气，以鼓舞膀胱气化，启闭通尿。肾阳衰惫加命门；中气不足加足三里；肾阴亏耗加太溪、涌泉；心烦加内关。

灸法

(1) 艾炷灸：关格吐逆而小便不利，先灸气海、天枢各 3～7 壮，然后口服六一散等以利小便，每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜（或葱、附子饼）灸：①癃闭，每穴灸 3～5 壮，每日 1～2 次。②慢性肾功能衰竭，在大椎、肾俞、命门、膻中、中脘、气海（每次选 3～5 穴）隔附子饼各灸 3～5 壮，每日或隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(3) 艾条灸：①癃闭，每穴灸 10～30 分钟，每日 1 次。②前列腺肥大小便不利，在关元、会阴、足三里穴各灸 20 分钟。③膀胱炎，在命门、关元穴各灸 5～10 分钟，每日 2 次。

(4) 温盒灸：每穴灸 10～30 分钟，每日 1 次。

(5) 葱椒敷灸：取连须葱白 250 克，花椒末 15 克，共捣烂炒热，布包趁热敷灸中极或关元穴，每日 1～2 次，排尿后取下。

(6) 芒硝敷灸：①取芒硝适量，用醋调敷小腹，每日 4～6 次。②取芒硝 60 克，大蒜 120 克，共捣烂敷灸肾区和肋脊角，每日换药 1 次。

(7) 芫花敷灸：急性肾功能衰竭，取芫花 90 克，水煎热敷肾区，每日 4～6 次。

(8) 复方吴萸敷灸：取吴萸、干姜、丁香各 50 克，小茴香 75 克，肉桂、硫黄各 30 克，萆薢 25 克，梔子 20 克，胡椒 5 克，

共研细末，每次取药末 25 克，加等量面粉，用清水调成糊状，敷灸脐部，覆盖纱布，上面用热水袋热敷，每日 1 次，排尿后取下。

遗精、早泄

遗精是指在无性生活时的射精；早泄是指性交时间极短或性交前即泄精。未婚男青年，绝大多数都有遗精现象，半月或更长时间遗精 1 次，属正常生理现象。如 1 周数次甚至 1 夜数次，或在有正常性生活以后还经常遗精，甚至清醒时精液流出，并伴有全身症状者，均属病理现象。有梦遗和滑精两种情况。可见于西医的性神经衰弱、前列腺炎、精囊炎等疾病。

【病因病机】

遗精和早泄主要由肾功能失调引起，无梦滑精是禀赋不足，下元衰惫或肾虚不藏，精关不固所致；有梦而遗多系恣情纵欲，劳心过度，妄想不遂，导致心肾火旺，心肾不交，或饮食不节，湿热下注，扰动精室引起。西医认为，遗精是男子性功能障碍的表现，大多数属非器质性改变，是由大脑皮质功能或脊髓的性功能中枢紊乱所致；因生殖器官、神经系统或其它器质性改变所致者甚少。

【临床表现】

成年男子频发遗精，每周数次或每夜数次，甚至在清醒时仅因性兴奋精液即流出，并伴有失眠多梦、头晕耳鸣、记忆力减退、精神不振等症状。

【辨证施灸】

遗精有梦遗与滑精之分，有梦而遗称梦遗，无梦而遗或清醒时精液流出称滑精。一般认为滑精比遗精严重。

1. 遗精 夜不安寐，阴茎易举，梦扰遗精频作，伴头晕耳

鸣,腰酸神疲,体倦无力,尿黄赤,舌红,脉细滑数。

治则 滋阴降火,交通心肾,安神固精。多取任、督脉,足太阴、厥阴经穴为主,俞募相配。

取穴 心俞、肾俞、次髎、关元、大赫、内关、神门、阴陵泉、三阴交、太溪、然谷。

方义 心俞、内关、神门清心降火安神;肾俞、太溪、然谷滋阴补肾泻火;关元培元固精;大赫、次髎清热固精;阴陵泉、三阴交健脾清热。诸穴合用使心肾得交,神安精固。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:遗精、早泄在肾俞、次髎、关元、大赫穴各灸 5~10 壮,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼灸:早泄在内关、阴陵泉、三阴交穴各灸 2~3 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~20 分钟),每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~20 分钟),隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间休息 7 日。

(5) 按灸:每次选 2~4 穴,每穴 5~10 壮,每日 1 次,7 次为 1 个疗程,疗程间休息 7 日。

(6) 甘遂敷灸:取甘遂、甘草各等份,共研细末,每晚临睡前取药末 1 克纳脐窝内,上贴黑膏药,次晨除去。

(7) 五倍子敷灸:取五倍子、女贞子各 30 克,共研细末,用食醋调成糊状,敷灸神阙穴,每日 1 次。

2. 滑精 无梦而遗,滑精频作,甚则不分昼夜,阳动则有精液滑出,腰酸肢冷,头晕脑胀,神疲乏力,面色苍白,或兼阳痿,自汗气短,舌淡苔白,脉沉细无力。

治则 补肾固精。

取穴 肾俞、命门、至室、气海、关元、大赫、中极、足三里、太溪、三阴交。

方义 肾俞、命门、至室温肾固精；气海、关元、大赫补肾培元，益气固精；中极壮元阳；足三里扶正培元；太溪补肾壮水；三阴交补三阴，安神固精。

灸法

(1) 艾炷灸：在关元穴灸 20～30 壮，5 日 1 次，3 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔盐灸：用食盐填满脐窝（或覆盖姜片），用艾炷灸 3～5 壮（或艾条灸 10～20 分钟），每日 1 次。

(3) 艾炷隔姜灸：每次选 3～5 穴，各灸 3～5 壮，每日 1 次。

(4) 艾条温和灸、温盒灸：每次选 3～5 穴，各灸 10～30 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(5) 滑精膏敷灸：取硫黄 18 克，母丁香 15 克，麝香少许，独头蒜（去皮）2 头，先将前 2 药研细与大蒜共捣烂，加麝香调匀制成黑豆大小药丸，以朱砂为衣。然后取川椒 50 克，肉桂、附片、韭菜子、蛇床子各 20 克，独头蒜 300 克，置锅内加麻油 500 毫升，将药炸枯，滤去药渣，继续熬至滴之成珠时加入广丹 250 克，搅拌收膏制成黑膏药。敷灸时取药丸 1 粒研碎置黑膏药中央，分别敷灸神阙、关元、曲骨等穴，3 日更换 1 次。

3. 预防遗精 取关元、足三里、三阴交穴，施艾炷灸或艾条温和灸。

按：艾灸治疗遗精有较好疗效，但遗精与精神因素关系密切，故除了采用药物、针灸等治疗外，更重要的是对患者进行解释，消除思想障碍，采用清心寡欲的精神疗法，往往能收到不用治疗而自愈的效果。

阳 痿

阳痿是指成年男子未到性功能衰退年龄出现性交时阴茎不能勃起或勃起不坚的病证。中医称“阴痿”，可见于西医的神经衰弱、睾丸疾病和某些慢性疾病表现为阳痿为主症者。

【病因病机】

阳痿的发生多由色欲房劳过度或手淫斲伤导致肾精虚损，命门火衰，或思虑过度，心脾受损，神气耗伤，或惊恐伤肾，肾气不振，肝气不达，或湿热下注，宗筋弛纵而发生。临床所见除极少数为器质性病变引起者外，绝大多数是精神心理因素所致的功能性疾病。以命门火衰多见，湿热下注引起者较少。

【临床表现】

临房阴茎不能勃起或勃起不坚，进入阴道后很快松软，多伴性欲低下或排精障碍。平时情绪低落，焦虑疲惫等。

【辨证施灸】

1. 命门火衰 临房阴茎萎软不举或举而不坚，精液清冷或射精障碍，伴头晕目眩，腰酸耳鸣，畏寒肢冷，面色眼圈黯黑，精神萎靡不振，舌淡脉细。

治则 温补下元，补肾壮阳。多取任、督脉，少阴、厥阴经穴，俞募相配。

取穴 心俞、肾俞、命门、腰阳关、神阙、关元、中极、三阴交、太溪。

方义 心俞清心宁神；肾俞、关元益肾精壮元阳，配三阴交益气添精，养血固下；命门、腰阳关温肾培元；神阙温阳益脾胃；中极壮元阳，理下焦；太溪滋肾固精。气血两虚加脾俞、足三里。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸：每次选 2 穴，各灸 3~5 壮，每月 1 次，3 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷灸：在关元、中极穴各灸 3 壮，每周 1 次，3 次为 1 个疗程，疗程间休息 7 日。灸后小腹内温暖感可持续数日，灸的次数越多越有效。

(3) 艾炷隔附子饼(或姜)灸：在肾俞、命门、关元、大赫、三阴交穴各灸 3~5 壮，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 艾炷隔盐灸：用食盐填满脐窝(或再覆盖姜片)，灸 5~30 壮(或艾条熏灸 10~30 分钟)，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(5) 艾条温和灸、温盒灸：每次选 4~6 穴，各灸 15~20 分钟，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(6) 火针灸：在肾俞、命门、八髎、关元、三阴交，每次选 2~3 穴，用细火针点刺，隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(7) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮(或 10~20 分钟)，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 10 日。

(8) 艾火针衬垫灸：每次选 2~4 穴，每穴灸 5~10 壮，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(9) 拍火疗法：取附子、肉桂各 6 克，淫羊藿、巴戟天、葫芦巴、石菖蒲、柴胡、泽泻各 10 克，山萸肉、茯神各 12 克，共研细末，在下腹部施拍火疗法。

(10) 小茴香敷灸：取小茴香、炮姜各 5 克，共研细末，加食盐少许，以乳汁调和(或用鸡血、蜂蜜代)敷灸神阙穴，5~7 日 1 次。

(11) 阳痿膏敷灸：取大附子 1 枚，挖成空壳，再取阿片 1.5 克，穿山甲 3 克，硫黄 6 克或炮山甲、硫黄各 3 克，炙黄芪、五味子各 6 克，与挖出的附子末共研细后，填回附子壳内，

用好酒 250 毫升小火煎熬至酒干,取出捣烂成膏状。敷灸时先取麝香少许纳脐窝内,再贴上膏药,亦可加敷曲骨穴,胶布固定,3 日更换 1 次。

2. 心脾受损 阳事不举,夜寐多梦不安,心烦神疲,饮食不香,面色无华,舌淡胖,脉细。

治则 补益心脾。

取穴 心俞、脾俞、肾俞、气海、关元、内关、足三里。

方义 心俞和内关养心安神;脾俞、足三里健脾生血,扶正培元;肾俞、气海、关元益气培元,补肾固精。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每穴灸 5~10 壮,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每穴灸 10~30 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

3. 湿热下注 阴茎萎软,阴囊潮湿,腰膝无力,小便黄赤臊臭,苔黄,脉濡数。

治则 清利下焦湿热。

取穴 膀胱俞、关元、曲泉、阴陵泉、三阴交、然谷。

方义 膀胱俞合阴陵泉利水渗湿,使湿热从小便排出;关元培元固精,调冲任;曲泉、三阴交、然谷益肾清化湿热。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 2~3 穴,各灸 3~5 壮,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 10~15 分钟,每日 1 次。

4. 预防阳痿遗精 取肾俞、命门、志室、腰阳关、归来、中极、然谷穴,施艾炷灸或艾条灸。

按：艾灸治疗阳痿有较好疗效，若配合针刺则疗效更好。因临证所见阳痿绝大多数属精神心理因素造成，故应配合解释以消除不必要的紧张心理。治愈之后，应节制性生活，不能纵欲。

男性不育症

男性不育，中医称“无嗣”，系指凡婚后夫妻同居2年以上，有正常性生活，未采取避孕措施，女方生育功能正常，因男方原因未能使女方怀孕者，称男性不育症。是精子的产生、成熟、运输和射精能力缺陷等因素引起的女方不能生育的总称。可见于性功能障碍、性功能不全及死精、无精、少精、不射精等症和精液不化、男性高泌素血症等。

【病因病机】

男性不育症与脾肾亏虚及冲任二脉、精血不足有关。先天禀赋不足，肾阴亏乏或房劳纵欲，耗损肾气，命火衰微，皆能造成肾气与阴精衰竭，是引起不育的直接原因。其次是七情、六淫、饮食、劳倦、诸虚、外伤、瘀血、痰湿等因素耗伤肾气肾精，扰乱精室或阻塞精窍，使阴阳不和，精血不足，气虚精乏而致不育。现代医学认为，影响男性生育能力的因素主要有生殖细胞成熟障碍、内分泌功能紊乱、精子抗体形成、精索静脉曲张、输送精子管道阻塞和外生殖器畸形等。大多数是精子生成障碍，精子数量不足，质量差，活动力低并出现畸形等引起。

【辨证施灸】

肾气不足者则性欲低下或伴阳痿，性交时射精量少或无精射出，精液清冷，头晕目眩，腰膝酸软，困倦乏力，畏寒肢冷，面色苍白，小便清长，舌淡胖，脉沉细弱；肾精亏乏者则性交时射精量少或无精，伴头晕耳鸣，夜寐欠佳，烦热盗汗，形瘦神

疲,舌红少津,脉细数。

治则 补肾益气,取任脉、少阴经穴为主。

取穴 肾俞、命门、次髎、气海、关元、中极、会阴、足三里、三阴交、复溜、太溪。

方义 肾俞、命门、复溜、太溪补肾精,益肾气,壮命火;次髎滋肾强腰,调气行血;气海、关元、中极益气温阳,培元补肾;会阴强肾通精,分泌清浊;足三里、三阴交健脾益气,滋阴补肾,协调阴阳。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次,30次为1个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼(或姜)灸:在肾俞、气海、关元、中极各灸3~5壮,每日1~2次,30次为1个疗程。

(3) 艾条灸:每次选3~5穴,各灸10~30分钟,每日1~2次,30次为1个疗程。

糖尿病

糖尿病是一组由胰岛素绝对或相对不足,或靶细胞对胰岛素敏感性降低而引起糖代谢紊乱为主的慢性内分泌疾病。可发生于任何年龄。根据其有多食、多饮、多尿、消瘦的特点,属中医的“消渴”、“消瘴”范畴。

【病因病机】

糖尿病分原发和继发两类。原发性占绝大多数,原因不明。目前多认为与遗传、自身免疫、病毒感染、升血糖素过高等因素有关;继发性占极少数,原因是由于胰岛本身的疾病,如慢性胰腺病的胰全部或次全切除,或抗胰岛素分泌过多,如垂体性、类固醇性糖尿病,嗜铬细胞瘤,妊娠期糖尿病及医源性

疾病等。基本病理是胰岛素绝对或相对分泌不足,对抗胰岛素作用的激素分泌过旺,引起糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱。中医认为,五志过极,精神烦劳,气极郁结,心火偏亢,消烁肺胃津液;或饮食偏嗜肥甘酒辛,脾胃运化失职,积热内蕴,耗液伤津;或恣情纵欲,房劳伤肾,封藏失职,引起阴虚火旺,上蒸肺胃等均可发生消渴。此外,尚有过服温燥药物、热病火燥或先天禀赋不足、五脏虚弱而引起消渴者。病机可概括为燥热和阴虚两方面。阴虚为本,燥热为标。病变可涉及肺、脾、肾,遍及三焦。消渴日久,阴液极度耗损,阴损及阳,终至阴阳两虚。

【临床表现】

糖尿病一般发病缓慢,早期或轻症者可无症状或症状不明显,只在检查尿液时偶尔发现。当出现典型症状后,则见多食善饥、神疲乏力、口渴多饮、多尿、消瘦、组织修复和抵抗力降低,可有皮肤、外阴瘙痒,四肢麻木,女性月经紊乱等。青春前期患病可影响发育。严重者出现酮症酸中毒,可并发心血管、肾脏、眼底、神经等病变,空腹血糖 ≥ 7.8 毫摩尔/升,绝对血糖 ≥ 11.1 毫摩尔/升。临床根据症状表现不同可有隐性糖尿病及分轻、中、重3型。

【辨证施灸】

临证根据三多症状的偏重情况分为上、中、下三消。上消以咽干、口渴多饮为主,属肺热津伤;中消以多食善饥,形体消瘦为主,属胃热炽盛;下消以尿频量多,混浊如膏脂或尿甜,口干唇燥为主,属肾阴亏虚或阴阳两虚。病久阴损及阳,出现腰膝酸软、形寒肢冷、面色黧黑、耳轮焦枯等,但临床实际三多症状常多互见,很难截然分开。

治则 清热润燥、滋阴生津。艾灸对阴阳两虚者效果尤佳。

取穴 胰俞、肺俞、脾俞、肾俞、命门、关元、中脘、足三里、三阴交、复溜、太溪。

方义 胰俞为治疗糖尿病的经验穴，有调节胰腺功能的作用；肺俞、脾俞、肾俞滋补三阴，清泄三焦燥热；命门、关元补肾中真元，合复溜摄纳肾气；中脘、足三里健脾调气，清胃热而治消谷善饥；三阴交调肝肾，健脾胃，和气血；太溪滋肾阴而降虚火。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔姜灸：①中脘、足三里。②身柱、脾俞、命门。③气海、关元。④脊中、肾俞。⑤华盖、梁门。⑥大椎、肝俞。⑦腹哀、关元、中极。⑧肺俞、膈俞、肾俞。每次选 1 组穴位，各灸 10~30 壮，隔日 1 次，交替运用。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~10 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 温盒灸：每日灸关元 10~30 分钟，10 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸：在肺热、肾俞、胃气、关元、行间各灸 3 壮（或 5~10 分钟），隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

按：艾灸治疗消渴以轻症或早期疗效较好，但因糖尿病病因未明，难以根治和速愈，故灸治疗程要长才能收效，切勿过早收治。同时还要配合中西药物、饮食疗法，才能达到更好控制病情。此外，糖尿病由于肌肤焦枯，一旦损伤易发痈疽，故灸治时要小心，防止烫伤，勿出灸疮。

甲状腺功能减退症

甲状腺功能减退症（简称甲减）是由甲状腺合成或分泌甲

甲状腺素不足,循环血中缺乏甲状腺激素引起以人体代谢过程降低为特征的疾病。因发病年龄及甲减程度不同而对患者产生不同影响,甲减始于胎儿期或新生儿期可成为呆小症;病发于儿童期称幼儿期甲减症;病在成人期称成年型甲减;病程严重者可产生粘液性水肿。本节重点讨论成年型甲减。中医无相应病名,归属于“虚劳”、“水肿”范畴。

【病因病机】

病因可分为甲状腺激素缺乏和促甲状腺激素缺乏两类。可能与饮食中长期缺碘或含有致甲状腺肿的物质;或甲状腺切除,¹³¹碘过度治疗,以及其它药物引起甲状腺功能减退和甲状腺炎;或先天性甲状腺发育异常,甲状腺激素合成缺乏;或由下丘脑-垂体病变引起的继发性甲状腺功能减退等有关。中医认为,本病的发生与饮食、环境和情志因素有关。病机为脾肾阳气不足,脏腑功能减退。

【临床表现】

成年型甲减以中年女性多见,起病隐匿,病情缓慢。早期仅有畏寒乏力、少汗、纳差、便秘、水肿、记忆力下降等。以后逐渐出现面色萎黄虚肿、表情淡漠呆钝、皮肤干燥、粗糙增厚,出现非凹陷性水肿等典型症状和面容。指甲脆裂、毛发干枯脱落、体重增加、肌肉软弱无力、弛缩延迟、关节僵直疼痛;食欲减退、腹胀便秘,甚至出现肠麻痹;血压偏低、心率缓慢、心脏扩大、心音低远、心包积液、动脉硬化,并发冠心病;可出现嗜睡、智力和记忆力减退、头晕耳鸣、眼球震颤、共济失调、腱反射迟钝,甚至痴呆木僵、幻觉昏睡等精神神经症状;月经过多或闭经、阳痿、肾上腺皮质功能减退及胰岛素依赖型糖尿病等内分泌症候群。最严重者出现粘液性水肿、昏迷。

【辨证施灸】

本病属脏腑功能减退病证,临床所见以脾肾阳虚证候为主,尚有心肾阳虚,肾精亏损等。脾阳虚者以面色苍白、厌食、腹胀、便秘、腹水为特点;肾阳虚者以腰冷肢凉、耳鸣耳聋、记忆力减退、反应迟钝、发枯脱落、阳痿、月经不调为特点;心阳不足者以胸闷憋痛、心悸不宁、脉沉结代为主要症状。

治则 益气温阳,扶正培元,振奋阳气。取任、督脉,足阳明经穴为主。

取穴 大椎、风池、肾俞、命门、天突、膻中、气海、关元、丰隆。精神症状明显者加百会、四神聪、神门;脾阳虚突出者加脾俞、胃俞、中脘;水肿者加肺俞、脾俞、三焦俞。

方义 大椎、肾俞、命门、气海、关元温阳益气,培本固元;风池、天突、膻中、丰隆疏风理气,化痰消癭散结;百会升举阳气,合神门、四神聪宁神开窍;脾俞、胃俞、中脘健脾和胃;肺俞、三焦俞通调水道,促进三焦气化,调节体内水液输布排泄。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。

按:艾灸能调整免疫功能和甲状腺功能,治疗甲减有较好效果。对缺碘引起的甲减在艾灸的同时应补充碘。甲减严重者应配合中西药物治疗才能收效。甲减患者皮肤修复功能较差,施灸时应小心,防止烫伤及出现灸疮。

内伤发热

内伤发热是指非感染因素所致,由内伤原因引起脏腑功能、阴阳气血平衡失调出现的发热。一般多为低热,起病缓慢,病程较长。可见于西医的功能性低热、肿瘤、血液病、结核病、结缔组织病、慢性感染性疾病、内分泌疾病出现的发热及原因不明的发热。

【病因病机】

内伤发热的原因主要是由于劳倦过度、饮食失调、情志抑郁、瘀血内停、湿热滞留等因素引起脏腑、气血、阴阳失调所致,也可能是许多慢性疾病过程中的症状之一。

【辨证施灸】

临床以慢性低热为主要症状,少数表现为高热,但不伴恶寒,虽感怯冷,但得衣被即可减轻或消失,低热缠绵或时作时止,或发热定时,可伴头晕神疲、自汗盗汗、脉弱无力等症状。临证可见阴虚、血虚、气虚、阳虚、气郁、湿郁、瘀血等情况,气血阴阳虚损属虚证,气郁、湿郁、瘀血引起的低热属实证,或正虚邪实、虚实夹杂证。艾灸对虚证效果较好。阴虚发热可参考肺结核的治疗。

1. 气血虚发热 低热缠绵不退,热势或高或低,劳累后发作或加剧,神疲乏力,舌淡苔薄,脉细弱。气虚为主者兼见短气懒言,食少便溏,自汗,易患感冒;血虚为主者兼见头晕眼花,心悸不宁,面色无华,唇甲色淡。

治则 健脾益气,养血除热。取阳明经穴为主。

取穴 脾俞、气海、足三里。气虚者加百会、神阙、关元;血虚者加膏肓俞、膈俞、合谷、绝骨。

方义 脾俞、足三里健脾益气,以培补气血生化之源;气

海、关元益气补肾，培元益精；百会升阳清热；神阙补益脾胃，温阳益气；膏肓俞补虚益损，退虚热；膈俞补血，调和营卫；合谷、绝骨清热。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~7 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条温和灸、温盒灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，以局部红润温热为度，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 10~20 分钟），隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

2. 气郁发热 低热或潮热，热势常随情绪变化而起伏，精神抑郁，烦躁易怒，胸胁闷胀，口干苦，饮食减少，大便秘结，舌红苔薄黄，脉弦滑或数。

治则 疏肝解郁，清肝泄热。

取穴 肝俞、期门、三阴交、行间、太冲。

方义 肝俞、期门俞募相配，疏肝理气；三阴交滋阴解郁；行间理气清热；太冲泄肝清热。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾条灸：每穴灸 5~15 分钟，每日 1 次。

按：艾灸退虚热效果较好。但低热病因复杂，在施灸的同时必须查明原因，针对病因进行治疗，疗效才能巩固。

白细胞减少症

外周血液中的白细胞计数持续 $<4.0 \times 10^9/\text{升}$ ，中性粒细胞百分数正常或稍低，称为白细胞减少症。中医无相应的病名，可归于“虚劳”中之气血虚范畴。

【病因病机】

引起白细胞减少的原因主要有药物,如苯、抗肿瘤药物及化学品种和多种放射性物质,如X线、放射性核素等化学物理因素直接毒害造血细胞;细菌、病毒、立克次体和原虫等病原体或毒素抑制骨髓造成大量破坏周围血液中的白细胞;血液病,如再生障碍性贫血、白血病、脾功能亢进;结缔组织病,如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等;恶性肿瘤转移;营养不良和异体蛋白反应,以及遗传因素所致。中医认为,本病的发生乃由先天禀赋不足,素体亏虚,或外感病邪,或久病误治,或气滞血瘀、癥瘕积聚,或药物所伤,导致气血耗损,阴阳失和,脏腑亏虚。病机为脾胃虚弱,气血生化乏源,而至元气不足,气虚血亏引起五脏虚损。

【临床表现】

白细胞减少症的主要表现是容易疲劳、头晕乏力、四肢酸软、食欲减退、低热盗汗、睡眠不佳,少数轻症患者可无症状,部分患者容易发生反复感染。外周血白细胞计数一般在 $(2.0 \sim 4.0) \times 10^9/\text{升}$ 之间。

治则 健脾,补益气血。取足太阴、阳明经穴为主。

取穴 大椎、膈俞、脾俞、足三里、气海、关元、肾俞、血海。

方义 大椎、膈俞通阳解毒,祛瘀养血;脾俞、足三里健脾益气,扶正培元,以促气血生化之源;气海、关元益气温阳,补肾益精;肾俞、血海补肾益精生血。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选1组穴,各灸3~5壮,隔日1次,10次为1个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选1组穴,各灸15~30分钟,每日1次,10次为1个疗程。

(3) 艾炷隔补中益气丸(或归脾丸)灸:每次选 1 组穴,取补中益气丸切成薄片置穴位上,再放艾炷各灸 3~5 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

此外,预防白细胞减少症,取大椎、脾俞、足三里、三阴交,施艾炷灸或艾条灸。

按:艾灸可以提高白细胞,但对原因不明的白细胞减少症应配合营养疗法及补充维生素 C。对继发性白细胞减少症,除采用艾灸治疗外,应积极治疗原发病以去除病因。

特发性血小板减少性紫癜

特发性血小板减少性紫癜又称免疫性血小板减少性紫癜,是指外周血中血小板的数量减少,皮肤出现瘀点瘀斑,粘膜及内脏出血为特征的一种疾病。好发于儿童和青年,女性多于男性,属中医的“血证”范畴。

【病因病机】

特发性血小板减少性紫癜的病因至今尚未阐明,一般认为与自身免疫功能异常有关,与体液免疫的关系尤为密切。中医认为,外感、内伤都可以引起本病,其发病与脾胃及血脉有密切关系。主要是由于热病阴津耗伤,导致热盛迫血,阴虚火旺,迫血妄行,或气虚,血失气摄,致血溢脉外而发病。

【临床表现】

临床分为急性和慢性两型。病程 6 个月以内为急性型,6 个月以上为慢性型。急性型多见于儿童,发病前常有呼吸道感染史,起病急,发病后突然出现广泛性皮肤出血,全身皮肤、粘膜可见大片瘀斑、血肿,鼻、牙龈和眼结合膜出血及便血、尿血,血小板减少,多在 $20 \times 10^9/\text{升}$,多数患者能痊愈或自行缓解,部分转为慢性。

慢性型多见于成人,起病慢,出血轻,皮肤持续或反复发作性出血,不易查到诱因。皮肤可见瘀点或瘀斑,鼻及齿龈出血,妇女月经过多,可伴贫血、血小板减少,常波动在 $(30\sim 80)\times 10^9/\text{升}$ 之间,常迁延不愈,少数患者最终可转变为再生障碍性贫血或白血病。

【辨证施灸】

1. 热盛迫血 皮肤、粘膜出现青紫瘀点或瘀斑,以四肢较多,或伴发热,口渴,便秘,尿黄,常有鼻、齿龈出血,或腹痛,便血,尿血,舌红,苔黄,脉弦数。

治则 清热解毒,凉血散瘀。

取穴 大椎、风门、膈俞、曲池、血海、筑宾。

方义 大椎、风门、曲池清热解毒;膈俞、血海调和营卫,凉血散瘀;筑宾清热化痰瘀。

灸法

(1) 艾条灸:每次选3~5穴,各灸10~20分钟,每日1次,10次为1个疗程。

(2) 温针灸:每次选3~5穴,各灸3壮(或15分钟),每日1次,10次为1个疗程。

2. 阴虚火旺 皮肤出现青紫瘀点或瘀斑,时发时止,时重时轻,常伴鼻、齿龈出血,头晕乏力,心烦口渴,手足心热,潮热盗汗,妇女月经不调,舌红少苔,脉细数。

治则 滋阴降火,宁络止血。

取穴 肝俞、肾俞、上髎、次髎、三阴交。

方义 肝俞、肾俞配三阴交滋阴降火;上髎、次髎调经宁络止血。

灸法 艾条灸,每穴10~20分钟,每日1次,10次为1个疗程。

3. 气不摄血 皮下反复出现散在瘀点、瘀斑,色暗淡,经久不愈,劳则加重。头晕目眩,心悸气短,食欲不振,神疲乏力,面色苍白或萎黄,舌淡,脉细弱。

治则 温中健脾,益气摄血。

取穴 腰阳关、中脘、神阙、气海、关元、足三里。

方义 腰阳关强腰脊,温下元;中脘、神阙、足三里温中健脾,扶正培元;气海、关元补肾培元,益气摄血。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(2) 复方吴萸灸:取吴萸、干姜、丁香各 50 克,小茴香 75 克,肉桂、生硫黄各 30 克,萆薢 25 克,栀子 20 克,胡椒 5 克,共研细末,取药末 25 克,加等量面粉调成糊状敷灸神阙,再用热水袋热敷或覆盖纱布,包扎固定,每次 3~6 小时,每日 1 次。

按:艾灸主要用于治疗慢性紫癜,对改善出血症状,提高血小板均有一定疗效,但需配合中西药物治疗,才能达到治愈的目的。

头 痛

头痛是临床常见的自觉症状,可单独出现,也可在各种急慢性疾病的过程中出现。头部器官、五脏六腑及经络的疾病、头部外伤及后遗症均可引起头痛。本篇只讨论外感或内伤所引起的以头痛为主证者。

【病因病机】

头为“诸阳之会”、“清阳之府”,又为脑髓所在,五脏精华之血,六腑清阳之气,皆上注于头。故凡外邪侵袭、上犯巅顶、

邪气稽留、阻抑清阳；或内伤诸疾、导致气血逆乱、瘀阻经络；或肝阳、肝火上扰清空；或气虚清阳不升、血虚脑髓失养，均可发生头痛。此外，外伤跌仆、络脉瘀阻、不通则痛，亦可引起头痛。但概括起来，头痛之因不外乎外感、内伤两大类。外感头痛以感受外邪引起；内伤头痛与肝脾肾等脏腑阴阳平衡有关。此外，手足三阳经脉皆循行于头面，厥阴经脉上会于巅顶，故头痛还可根据发病部位的不同，参考经脉循行路线综合判断。现代医学认为引起头痛之因有二：一是来自头部引起疼痛的刺激病灶；一是颅内疼痛敏感结构受累。除原因不明的功能性头痛外，常见的器质性头痛有全身感染性疾病、颅骨骨膜的感染、高血压病、外伤、肿瘤、脑血管病及原发于五官科的眼源性、耳源性、鼻源性、牙源性头痛。盖因颅内外各种结构对疼痛刺激十分敏感，局部刺激灶由于神经元兴奋的中枢扩散作用或颅内血管的扩张，使这些结构受到牵引或炎性刺激而至头部不同部位的疼痛。

【辨证施灸】

外感头痛起病较急，常伴外感表证。风寒者头痛连项背或有紧束感；风热者头痛如胀，甚则如裂；风湿者头痛如裹。

内伤头痛，时重时轻，反复发作，常伴内伤虚损诸证。气血虚者，头部绵绵作痛，时发时止，遇劳则重；肾虚者，头脑空痛，摇晃加重，以后脑痛为主；肝阳上亢者，头掣痛且眩，以两侧为甚；痰浊者，头痛昏蒙而沉重，胸闷痰多；瘀血者，头痛如锥刺，痛有定处。此外，头痛剧烈，经久不愈，反复发作即为头风。

头痛按经络辨证有三阳头痛和厥阴头痛。痛在脑后下连项背为太阳头痛；痛在前额下连面颊为阳明头痛；痛在两侧上及头角为少阳头痛；痛在巅顶连及目系为厥阴头痛；颅内疼痛属足少阴肾；头痛如裹属足太阴脾经。

治则 通经活络止痛,辨证取穴与辨经取穴相结合。

取穴 百会、太阳、头维、上星、列缺、合谷、阿是穴。

方义 百会、太阳、头维、上星、阿是穴疏通经络,调和气血,止痛;列缺、合谷为止头痛经验穴,通治头面五官之疾。诸穴合用通治一切头痛。风寒者加风池、风门;风热者加大椎、曲池、外关;风湿者加风府、足三里;气虚加脾俞、气海、足三里;血虚加膈俞、血海、三阴交;肾虚加肾俞、太溪;肝阳上亢加阳辅、太溪、太冲;痰浊加中脘、丰隆、足三里;瘀血加血海、三阴交、行间。

灸法

(1) 艾炷灸:寒性、虚证头痛,每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次,头部穴位用小艾炷。

(2) 艾炷隔附片(或姜片、或艾叶)灸:寒性、虚证头痛,每次选 3~5 穴,各灸 5~10 壮,每日 1 次。

(3) 艾炷隔蜂房灸:三叉神经痛,每次选 3~5 穴,取炒蜂房末适量,用黄酒调制成厚约 0.2 厘米的小圆饼,放穴上各灸 3~5 壮,每日或隔日 1 次。

(4) 艾条灸:①各种头痛,每次选 3~5 穴,各灸 5~10 分钟,寒性、虚证头痛可灸 20 分钟。②气血不足头痛,可在百会、肝俞、脾俞、肾俞、气海、合谷、足三里各熏灸 5~10 分钟,每日 1 次。

(5) 温针灸:①各种头痛,每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 5~10 分钟),每日 1 次。②偏头痛,可在太阳、外关或风府、哑门、风池各灸 3 壮(或 10~15 分钟),3 日 1 次。

(6) 灯火灼灸:①各种头痛,在印堂、前发际、阳白、后发际、百劳各灼灸 1 下,3 日 1 次。②偏头痛,在太阳、悬颅各灼灸 1 下,每日 1 次。③三叉神经痛,在太阳、悬颅,第一支加攒

竹、阳白；第二支加颞髁、耳门；第三支加承浆、颊车、翳风；反复发作者加肝俞、胆俞，各灼灸1下，每日或隔日1次。④眉棱骨痛，在攒竹、鱼腰、阳白、耳后小静脉各灼灸1下，每日1次，均灼患侧。

(7) 太乙神针灸：寒性、虚证头痛，在神庭施灸10~15分钟。

(8) 风寒头痛：①生姜敷灸，取生姜切片（或内夹雄黄），煨热后敷灸太阳穴60分钟，每日1次。②烟叶敷灸，取烟叶1张加水煮透，趁热敷灸头额部及太阳穴60分钟，每日1次。③白芷敷灸，取白芷（或加细辛）30克，研细末加适量面粉调制成药饼烘热，趁热敷灸痛处；或取白芷、川芎（或加麻黄）各3克，共研细末，加葱白1段共捣烂敷灸太阳穴，每次60分钟，每日1次。④附子饼灸，取生附子、青盐各15克，共研碎，炒烫布包熨灸痛处，每次30分钟，每日2次；或取白附子、川芎各3克，共研细末，加葱白1段共捣烂，敷灸太阳穴，每次60分钟，每日1次。⑤川乌、南星敷灸，取生川乌、生南星各等份，共研细末，用生姜汁或大蒜汁调成糊状，敷灸太阳穴60分钟，每日1次。⑥白芥子敷灸，取白芥子末适量，用温水调成糊状纳脐窝内，上面覆盖厚布1块，用热水袋热敷至汗出为度。⑦皂角敷灸，取皂角适量研末，加麝香（或冰片代）少许，用绵纸包裹置头顶，然后取青盐250克，炒烫布包放头顶上敷灸20~30分钟，每日2次。

(9) 虚寒头痛：取藜蘆3克，细辛6克，干姜10克，共研细末，用酒调成糊状敷灸头痛处，每日1次。

(10) 热盛头痛：①大黄敷灸，取大黄、朴硝各等份，共研细末，与井底泥调制成膏状敷灸太阳穴；或取大黄、芒硝各9克，与生石膏共研细末，用醋调成糊状敷灸前额，每次60分

钟,每日1次。②石膏敷灸,取生石膏60克,栀子仁15克,白芷、薄荷各10克,共研细末,用浓茶汁调成糊状敷灸前额60分钟,每日1次。

(11) 风火头痛:①蚕砂敷灸,取蚕砂15克,生石膏60克,共研细末,用盐水或醋调,炒烫布包,敷灸痛处60分钟,每日1次。②萝卜叶冰片敷灸,取鲜萝卜叶适量,加冰片少许,共捣烂焙热敷灸痛处60分钟,每日1次。

(12) 肝风头痛:取炒决明子末适量,用温水调成糊状敷灸囟会穴;或取决明子60克,石决明10克,共研细末,浓茶汁调成糊状敷灸太阳穴,每日1次。

(13) 气郁头痛:取蓖麻子、乳香各3克,食盐0.3克,共捣烂敷灸太阳穴,每日1次。

(14) 偏头痛:①荞麦粉熨灸,取荞麦粉适量,炒烫布包,趁热熨灸太阳穴及痛处至疼痛缓解为度,每日1次。②复方石膏敷灸,取石膏12克,川乌、草乌各6克,薄荷、细辛、胡椒各1克,共研细末,用白酒调成糊状敷灸太阳穴,每日1次。

(15) 头风痛:取麻黄、栀子(或加草乌)各等份,共研细末,葱汁调成糊状敷灸太阳穴,每日1次。防治头风痛可选用艾炷或艾条灸足临泣。

(16) 高血压头痛:取吴萸末30克,醋调成糊状;或吴萸末5克,生姜30克,共捣烂炒烫摊在纱布上,喷白酒少许,于每晚临睡时敷灸涌泉穴上,次晨除去。

(17) 三叉神经痛:复方白附子敷灸:取白附子、生半夏、生南星各30克,五倍子15克,全蝎、地龙、木香各9克,蝼蛄3只,共研细末,每次取药末适量,用白酒调制成两个药饼敷灸太阳穴,每日1次。

按:艾灸治疗头痛有灸到痛止之效,配合针刺则疗效更

佳。但头痛病因复杂，艾灸对非器质性头痛疗效满意。对器质性头痛，只能起临时止痛效果，必须消除病因才能彻底治愈。如果艾灸多次无效或头痛继续加重，应及时到医院诊治，查明原因，采取综合措施治疗，以免贻误病情。

腰 腿 痛

腰腿痛是腰痛和腿痛的合称，是以腰、腿部疼痛为主证的疾病。内、外、骨、妇科疾病均可出现腰腿痛症状。大概包括脊柱疾病，如风湿性、类风湿性、肥大性、结核性、化脓性脊柱炎；脊柱旁组织病，如腰扭伤、腰肌劳损、纤维组织炎等；脊神经根受刺激，如脊髓压迫症、急性脊髓炎等；内脏疾病，如肾脏病、慢性前列腺炎等；妇科疾病，如月经不调、盆腔疾病等。其中以外邪侵袭及内脏疾病为内科常见腰痛范畴。

【病因病机】

腰腿痛的病因虽多，但概括起来不外为不通则痛和不荣则痛两大类。前者属实，后者属虚。凡风寒湿热等外邪侵袭、劳累外伤等致经络阻滞，气血循环不畅，不通而痛，其中以湿邪引起者为多见；因禀赋不足，久病体虚，年老体衰，纵欲伤肾等致肾脏精血亏损，经脉失于濡养，造成不荣而痛，其中以肾虚为多见。在整个发病机制中，肾虚精亏为本，外邪、外伤、劳累、纵欲均为标，病位在肾和经络。

【临床表现】

腰部一侧或双侧的脊柱正中胀痛、隐痛、灼痛、刺痛，或伴腰酸胀、僵硬发板感，或影响屈伸转侧，亦可痛连骶髂，牵引及腿，也可仅表现为腰痛或腿痛。

【辨证施灸】

1. 风寒湿腰腿痛 腰部冷痛重着,僵硬发板感,转侧不利,或痛连髋髂及下肢腿部,得热痛减,遇阴寒及气候变化加剧,苔白腻,脉沉紧或沉缓。

治则 祛风胜湿,温经散寒,通络止痛。

取穴 肾俞、命门、志室、腰阳关、气海俞、大肠俞、委中、阳陵泉。

方义 肾俞、命门、志室健利腰肌,治腰腿僵直;腰阳关、气海俞、大肠俞助阳,散寒化湿,壮腰舒筋;委中通经活络;阳陵泉舒筋散滞。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,肾俞可灸 10 壮,每日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼灸:每次选 3~5 穴,各灸 5 壮,肾俞、腰阳关可灸 10~15 壮,每日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸:①每次选 3~5 穴,各灸 10~15 分钟,肾俞、腰阳关可灸 20~30 分钟,每日 1 次。②急性腰扭伤、踝关节扭伤、趾管综合征等,可在局部痛点灸 10~15 分钟,以局部热透为度,每日或隔日 1 次。注意急性损伤 24 小时内用冷敷以加强止血作用,24 小时后才用艾条灸以活血化瘀。

(4) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次。

(5) 拍火灸:取荆芥、防风、胡椒各 10 克,共研细末,撒于痛处施拍火灸。

(6) 磨火灸:在腰腿部压痛点施磨火灸,每日 1 次,一般不超过 10 次。

(7) 荆防蒸气灸:取荆芥、防风、艾叶、去皮大蒜各等份,

置药液发生器中产生蒸气热吹肾俞、腰阳关、环跳、梁丘、犊鼻、阳陵泉、绝骨，每日1次。

(8) 青盐熨灸：取青盐500克，或青盐、大葱（切碎）各250克，炒烫布包趁热熨灸痛处，每次60分钟，每日1~2次。

(9) 艾叶或辣椒叶敷灸：取艾叶或辣椒叶各适量，加酒炒热，趁热敷灸痛处，每次30分钟。

(10) 复方天麻敷灸：取天麻、半夏、细辛各等份，装入布袋蒸热后趁热熨灸痛处，每次30分钟，每日2~3次。

(11) 草乌熨灸：取草乌1个，生姜1块，青盐少许，共捣烂加酒少许炒烫，布包趁热熨灸痛处，亦可用热水袋放在药包上保温，每次60分钟，每日1~2次。

(12) 铁砂熨灸：取细铁砂100克炒烫，然后取千年健、白芷各20克，肉桂、陈艾叶各15克，加水、醋各500毫升共煮沸10分钟后，把药汁倒入炒烫的铁砂内装入布袋，先在痛处垫1块毛巾，用药袋趁热熨灸痛处至药冷为止，每日1~2次。

2. 腰肌劳损腿痛 陈伤劳损，腰腿部僵直酸痛，俯仰不利，痛有定处，或刺痛，劳累加剧；新伤剧痛，不能俯仰转侧，行走不便，痛处拒按，舌紫暗或舌底静脉怒张，苔薄，脉弦或沉涩。

治则 理气活血，祛瘀止痛。

取穴 阿是穴、膈俞、志室、气海俞、委中、承山、绝骨。

方义 膈俞、气海俞行气活络和营；志室补骨强腰；阿是穴、委中、承山、绝骨疏通经络止痛。

灸法

(1) 艾炷（或隔附子饼）灸：慢性腰肌劳损，每次选3~5穴，各灸3~5壮，阿是穴、志室各灸10壮，每日1次。

(2) 艾条温和灸：慢性腰肌劳损，髂骨下脂肪垫劳损，足

底痛,每次选3~5穴,各灸5~10分钟,志室、阿是穴各灸20~30分钟,每日1次。

(3) 温针灸:腰肌劳损可在肾俞、大肠俞、气海俞、委中各灸3壮(或15分钟),隔日1次。

(4) 雷火针灸、百发神针灸:腰腿痛,在压痛点施雷火针灸至疼痛缓解为度,每日1次。

3. 肾虚腰腿痛 腰腿酸痛、隐痛、胀痛,反复发作,腰肌无力,静卧减轻,劳累更甚,偏阳虚者腰冷肢凉,舌淡,脉沉细滑;偏阴虚者伴头晕耳鸣,心烦失眠,手足心热,舌红,脉细数。

治则 补肾活络止痛。

取穴 肾俞、命门、环跳、关元、委中、太溪、然谷。

方义 肾俞、命门、关元强腰肌,补肾虚;环跳、委中舒筋活络,利腰腿;太溪、然谷滋阴补肾。

灸法

(1) 艾炷隔附子灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,肾俞、关元及痛点各灸15壮,每日或隔日1次,15次为1个疗程。

(2) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸10~15分钟,肾俞灸20~30分钟,每日1~2次。

(3) 复方吴萸熨灸:取吴萸90克,生姜120克,肉桂、葱头各30克,花椒60克,共炒热布包,趁热熨灸痛处30分钟,每日1次。

4. 预防腰腿痛 ①艾灸肾俞、志室、腰阳关穴可防治肾虚腰痛。②艾灸绝骨、丘墟、昆仑穴可防治腿痛,均可选用艾炷灸或艾条灸。

按:艾灸治疗腰腿痛有良好的止痛作用,与针刺同用疗效更好。

痹 证

痹证是指风寒湿热等外邪侵袭人体，闭阻经络，气血运行不畅而引起肢体关节酸痛、麻木重着，屈伸不利，甚至关节红肿热痛、肿胀畸形、活动障碍等为主要症状的一类病证。一般而言，可包括西医的风湿病、各类关节炎、痛风、肌纤维组织炎、神经根炎、骨质增生等多种疾病。

【病因病机】

痹证的病因是由于起居失常、劳伤气血、正气不足、腠理空虚、卫外不固，或居处潮湿，或劳汗当风、涉水冒寒、久坐卧湿地，以致风寒湿热之邪乘虚侵入，流注经络关节，经脉阻滞，气血运行不畅而发病。此外，痹之发生还与体质禀赋及气候条件、生活环境等因素有关。

【临床表现】

主要症状有肢体关节疼痛，酸楚麻木重着，屈伸不利，或关节红肿灼热，痛不可触，肿胀畸形，活动障碍，行走困难等。其中不同程度疼痛和功能障碍是各种痹证的共同特点。发病缓慢，病程较长，往往呈渐进性和不规则的反复发作。

【辨证施灸】

痹证初起病在肌表、皮肉、经络，久则留连关节，深入脏腑引起全身病变。由于体质个体差异和病邪性质的偏胜而有风寒湿痹、风湿热痹及顽痹等不同证候。

风寒湿痹：肢体关节酸楚疼痛，重着不利。偏于风盛（行痹）则以肘、腕、膝、踝等大关节多见，疼痛呈游走性；偏于寒盛（痛痹）则疼痛剧烈，痛处固定不移，骨节寒冷，得热痛减，遇寒加剧，屈伸痛甚，活动受限；偏于湿胜（着痹）则肢体关节重着、肿胀、酸痛、麻木，阴雨天更甚，伴肢体困重，胸闷泛恶。

风湿热痹：发病急，肢体关节红肿灼热，痛不可触按，筋脉拘急，不能屈伸，可涉及1个或多个关节，得冷痛减，遇热加剧，或伴发热口渴，心烦不安，皮肤红斑，皮下结节，尿短赤，舌红苔黄，脉滑数。甚则壮热不退，神昏烦乱，舌红绛，脉弦数。

顽痹（久痹、尪痹）：诸痹日久不愈，反复发作，遂成顽痹。关节肿大，僵硬畸形，疼痛剧烈，停着不移，肌肤麻木不仁，功能障碍，行走举动困难，阴雨及寒冷季节尤甚，形体瘦削，舌有瘀点瘀斑，脉沉细涩。

治则 通经活络，宣痹止痛。以取局部痛点阿是穴及循经取穴为主。艾灸对风寒湿痹及顽痹效果较好。

取穴 肩部取肩髃、肩髃、秉风；肘部取曲池、天井、尺泽、小海、手三里；腕部取外关、阳溪、阳池、腕骨、合谷、中渚；背部取身柱、腰阳关、华佗夹脊；臀部取环跳、秩边、居髎、承扶；膝部取梁丘、鹤顶、犊鼻、膝阳关、阳陵泉、足三里；踝部取解溪、申脉、照海、丘墟、昆仑、太溪、阳交。

方义 方中诸穴均有疏通经络，流畅气血，蠲痹止痛的作用。若为行痹加风门、膈俞；痛痹加肾俞、关元；着痹加阴陵泉；热痹加大椎（慎用局部阿是穴）。

灸法

（1）艾炷化脓灸：寒痹、顽痹每次选1~2穴，灸至起疱成灸疮，每月1次。

（2）艾炷灸：风寒湿及顽痹，每次选3~5穴，各灸3~5壮，每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程间休息7日。

（3）艾炷隔附子饼（或姜）灸：①风寒湿痹，每次选3~5穴，各灸5~7壮，每日或隔日1次，10次为1个疗程，疗程间休息7日。②类风湿性关节炎，选膻中、中脘、气海、足三里；膈俞、肝俞、脾俞、命门。每次选1组穴位，每日或隔日1次，50

次为1个疗程,两组穴位交替使用。③肱骨外、内上髁炎(网球肘、学生肘)、狭窄性腱鞘炎,可在局部隔姜灸3~5壮,每日1~2次。

(4) 艾条温和灸:①风寒湿及顽痹、膝关节炎,每次选4~6穴,各灸10~20分钟,每日1~2次,15次为1个疗程。②肱骨外、内上髁炎(网球肘、学生肘),腕管综合征,可在压痛点灸15~20分钟,每日1~2次,10次为1个疗程,疗程间休息7日。

(5) 温针灸:①风寒湿及顽痹,每次选3~5穴,各灸3壮(或10~15分钟),隔日1次,10次为1个疗程,疗程间休息7日。②颈椎综合征,在相对应夹脊穴、阿是穴、风池、天柱、大椎、曲池、列缺、合谷,每次选3~5穴,各灸3壮(或10~15分钟),隔日1次,10次为1个疗程。③肱骨外、内上髁炎(网球肘、学生肘),在局部压痛点行温针灸3壮(或10~15分钟),每日或隔日1次,10次为1个疗程。

(6) 灯火灼灸:每次选3~5穴,采用明灯暴灸法,每穴灼灸1下,隔日1次,7次为1个疗程,疗程间休息7日。

(7) 火针灸:风寒湿及顽痹,每次选3~5穴,用细火针深速刺,隔日1次,7次为1个疗程。

(8) 雷火针灸、太乙神针灸:可根据风寒湿及顽痹的具体部位,选用相关穴位施灸,使药气深入穴位深部。

(9) 麝火灸:风寒湿及顽痹,在疼痛部位按烧、贴、发、饮顺序施灸。

(10) 拍火灸:风寒湿痹可在局部施行拍火灸或抓火灸。

(11) 硫朱灸:风寒湿痹,每次选2~3穴,各灸1壮。灸后如起水疱,可用消毒针刺破放出疱液,消毒包扎,防止感染。

(12) 硫黄隔姜灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1

次,10次为1个疗程。

(13) 发疱灸:顽痹取斑蝥3克,腰黄5克,共研细末备用。每次选1~2穴,取药末0.3克~0.6克,置小胶布中央敷灸穴上24小时,待局部起疱后除去,用消毒针放出疱液,消毒包扎,防止感染,10日1次,3次为1个疗程。

(14) 长蛇灸:顽痹(肥大性脊柱炎),让患者俯卧,取斑蝥粉(组成:麝香50%,斑蝥20%,丁香、肉桂各15%)1克~1.8克,撒于大椎至腰俞之脊中线上,再铺上宽5厘米、厚2.5厘米蒜泥一层,然后在蒜泥上放宽3厘米、高2.5厘米的长条艾炷,从头、中、尾三处同时点燃艾炷施灸,此为1壮,每次可灸2~3壮。灸毕除去蒜泥,用生理盐水洗净皮肤,如出现水疱,待3日后刺破放出疱液,消毒包扎静养,灸治时间于夏天,每伏施灸1次,共3次。

(15) 青盐熨灸:风寒湿痹,取青盐500克;或青盐、大葱(切碎)各250克,小茴香120克。任选1方炒烫布包,趁热熨灸痛处,每次30~60分钟,每日1~2次。

(16) 麦麸熨灸:寒痹取麸皮、川椒、细辛各等份;或苍术、木香各30克,乳香、没药各15克,共研细末,加麦麸500克,喷酒少许,任选1方炒烫布包,趁热熨灸痛处,每次30~60分钟,每日2次。

(17) 复方附子熨灸:寒痹,取生附子、生川乌、北细辛、肉桂、川椒、羌活各30克,共研碎,加白酒适量,炒烫布包,趁热熨灸痛处,每次30~60分钟,每日2次;或取生附子、海螵蛸、川牛膝、茜草根、海桐皮、全当归、透骨草、肉桂、杜仲、羌活、赤芍、防风、续断、川芎、乳香、没药、桃仁各25克,川椒、血竭、红花各15克,青盐12克,共捣碎,加黄酒800毫升拌匀,装布袋蒸热,先在患部垫毛巾1块,再取热药包熨灸痛处,每次30~

60 分钟,每晚 1 次。

(18) 复方川草乌敷灸:①风寒湿痹,取生川乌、生草乌、生附子、生南星各 30 克,炮姜、赤芍各 90 克,肉桂、白芷、细辛各 15 克,共研细末,用热酒调成糊状敷灸痛处,每晚 1 次,10 次为 1 个疗程;或取生川乌、生草乌、生南星、生半夏各 15 克,肉桂、樟脑各 10 克,用 40%酒精调成糊状,敷灸痛处至发热为止,每日 1 次。②强直性类风湿性关节炎,取川乌、草乌、茅术、当归、红牛膝、生香附各 10 克,郁金、独活、鸡血藤各 6 克,木瓜、川芎各 20 克,细辛 3 克,共研细末,再取生姜 250 克捣烂与药末拌匀,用 70%酒精调成糊状,加热后敷灸患处。敷灸前先在患处涂一层薄凡士林。每次敷灸 2~4 小时,每日或隔日 1 次。

(19) 复方麻黄熨灸:风寒湿痹取生麻黄、北细辛、苍术、皂角、菖蒲、乳香、没药各 10 克,共研细末,加晚蚕砂 150 克,黄酒适量,共炒烫熨灸痛处,每次 30~60 分钟,每日 1 次。

(20) 复方芫花熨灸:寒痹,取芫花、桑皮、肉桂、川椒、麦麸、柳蛀屑各 20 克,或芫花、黑豆、生姜各适量,共捣碎,加醋适量炒烫,布包趁热熨灸痛处,每次 30~60 分钟,每日 2 次。

(21) 复方山梔敷灸:热痹取生梔仁 60 克,生半夏 30 克,生大黄 15 克,桃仁、红花各 10 克,共研细末,用醋调成糊状,敷灸患处,每日 1 次。

(22) 葛根、防风、蚕砂、复方水菖蒲、复方川乌熨(敷)灸:均可治风湿性、类风湿性关节炎。具体灸法如下:

①葛根防风熨灸:取葛根、防风各 25 克,桂枝 45 克,生姜 120 克,青葱 150 克,共捣碎,装布袋蒸热,趁热熨灸痛处,每次 30 分钟,每日 2~3 次。

②蚕砂熨灸:取蚕砂 500 克,加酒 100 毫升,炒烫布包,趁

热熨灸患处，每次 30～60 分钟，每日 1～2 次。

③复方水菖蒲敷灸：取水菖蒲 120 克，小茴香 60 克，干姜 12 克，松香 300 克，樟脑 90 克，前 3 药共研细末，再将松香熔化，加入樟脑和药末，拌匀制成膏药备用。敷灸时将膏药烘软贴敷患处，每日在膏药上热敷 1～2 次，每次 15～30 分钟，3 日更换 1 次。

④复方川乌熨灸：取生川乌、生草乌各 30 克，白芷、姜黄、防风各 10 克，络石藤 60 克，共捣碎，加酒、醋各适量；或川乌、附子、干姜、桂枝各 15 克，川芎、赤芍、乳香、没药、姜黄各 10 克，海桐皮、忍冬藤各 20 克，共捣碎。任选 1 方，装药袋蒸热，趁热熨灸患处，每次 30～60 分钟，每日 1～2 次。

按：本病属较难治的疾病，艾灸治疗只对减轻疼痛、肿胀等症状的疗效较为显著。因此，除采用艾灸治疗外，还应配合针刺、中西药物等综合治疗以提高疗效。

肢端动脉痉挛病(雷诺病)

肢端动脉痉挛病，是指血管神经功能紊乱引起的阵发性肢端小动脉痉挛性疾病。以阵发性四肢肢端(多发于手指)对称性的间歇发白，继则紫绀、潮红，甚至发生坏疽为特征。多发于 20～30 岁之间的女性，尤以神经过敏者多见，临床有原发性和继发性两种。中医无相应病名，可归入“痹证”和“厥逆”范畴。

【病因病机】

病因未明，主要是由于血管神经功能紊乱引起肢端小动脉痉挛所致，寒冷刺激和情绪激动是主要激发因素，感染和劳累也是诱发因素之一。原发性多发于 40 岁以下的女性，可有内分泌障碍及家族史；继发性称雷诺现象，继发于某些疾病，

如结缔组织病、慢性阻塞性动脉病变、血液异常等。此外，尚与某些职业，如机械工人、钢琴师、打字员等有一定关系。中医认为，本病与先天禀赋不足、后天失养、阳气虚弱、卫外不固有关。寒湿之邪乘虚侵袭、寒凝血滞、脉络闭阻、气血运行不畅、阳气不能通达四末；或寒湿困脾、运化失职、脾气不能散精、气血难达四末，均可发生四肢厥逆。

【临床表现】

常因寒冷刺激或精神紧张而诱发，好发于手指，有明显的对称性，但较少累及足趾。典型发病首先自小指和无名指指尖开始发白，随后扩展到整个手指，继而波及其它手指，甚至手掌，然后继发紫绀，数分钟后变为潮红，伴局部发凉、麻木、轻度刺痛感。缓解后出现反应性肿胀，有烧灼刺痛感，皮色转为正常。不发病时除手足寒冷感外，无其它不适。发作过程中如果局部加温、揉擦等可使发作停止。个别严重者，可持续发作，紫绀和疼痛变成持久性，若发作时间过长，出现指（趾）营养改变，指（趾）甲变薄、起脊，手指萎缩变硬、溃疡或坏疽。雷诺病发作时，手发冷，但桡动脉一般不减弱。甲皱循环检查有助本病的诊断。

【辨证施灸】

临证所见主要有阳虚寒凝及血瘀、湿热等证候。阳虚寒凝者可见患肢发凉，遇冷诱发，冬季加重，肢端皮肤苍白、紫绀、潮红、麻木、刺痛，得温则皮肤恢复正常，疼痛消失，舌淡苔薄，脉沉迟。如兼血瘀则肢端紫绀或紫红、麻木、疼痛时间较长或指甲畸形，舌质紫暗或有瘀点瘀斑，脉沉细涩；如湿郁化热，则患肢肿胀，肢端出现小溃疡或坏疽，疼痛剧烈，舌红，苔黄腻，脉弦滑而数。

治则 温经补肾，通经散寒。

取穴 肾俞、命门、少泽、合谷、阳池、腕骨、液门、前谷、劳宫、关冲、中冲、足临泣、束骨、至阴、阿是穴。

方义 肾俞、命门温振阳气；阳池温阳散寒，开拓脉道；其余诸穴温散寒邪，通经活络。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸：在肾俞、命门各灸 3~5 壮，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 艾条熏灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~10 分钟，以局部皮肤温热为宜，但不能烧伤皮肤，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 复方透骨草熏灸：取透骨草 30 克，当归、赤芍、苏木、川椒各 15 克，生南星、生半夏、生甘草、海桐皮、川牛膝、白芷各 9 克，水煎用蒸气熏洗患指，每日 1~2 次。

痿 证

痿证是指肢体筋脉松弛，手足痿软无力，日久肌肉萎缩或运动障碍，甚则肌肉瘦削为主要病证。因以下肢不能随意运动及行走者多见，故又称“痿痹”。可见于脊髓前角灰质炎（小儿麻痹）、急性感染性神经炎、脊髓炎、侧索硬化症、进行性肌萎缩、重症肌无力、周期性麻痹、瘧病性瘫痪等运动神经疾病及周围神经损伤引起机体瘫痪，如睑下垂、足下垂等疾病。

【病因病机】

本病多见于温热病后期邪热灼伤阴液，筋脉失养；或因湿热浸淫筋脉、肌肉，弛纵不用；或因体虚久病、肝肾亏损、精血不足，不能濡养肌肉筋脉；或瘀阻脉络等原因而形成。其中以阴虚热伤津液及湿热浸淫阳明为多，以正虚为本，邪热为标。病位与肺、脾、肝、肾等关系密切。

【辨证施灸】

临证可见邪热熏肺、湿热浸淫、脾胃虚弱、肝肾亏损、络脉瘀阻等证候。以一侧或双侧上肢或下肢筋脉弛缓，痿软无力，甚至瘫痪，患肢肌肉瘦削等为主要症状。邪热熏肺而致者，多发生在温热病中或病后突然肢体痿弱不用；湿热浸淫者，多见四肢困倦，痿弱无力；由肝肾亏损引起者，起病缓慢，渐见下肢痿弱不用；由络脉瘀阻引起者，多见手足不仁或痿弱不用。艾灸治疗对脾胃虚弱、肝肾亏损及络脉瘀阻引起者疗效较好。

治则 补益肝肾，健脾益气，活血化瘀。多取足阳明、太阴、少阴、厥阴经穴为主。

取穴 脾胃虚弱：脾俞、气海、足三里、解溪；肝肾亏损：肝俞、肾俞、阳陵泉、足三里、绝骨；络脉瘀阻：肾俞、曲池、血海、梁丘。

方义 肾俞、气海、足三里益气健脾以培补气血生化之源；解溪通经活络，治下肢痿弱；肝俞、肾俞调补肝肾经气；阳陵泉、绝骨强骨健筋；血海活血行瘀；曲池治上肢痿；梁丘治下肢痿。

灸法

(1) 艾炷灸：脾胃虚弱、瘀阻脉络而痿者，各选相应穴位，每穴灸3~5壮，每日1次，15次为1个疗程。脊髓和延髓空洞症，在肝俞、脾俞、肾俞、命门、足三里，每次选1~2穴，各灸5~7壮，每日1次，每月连续灸10次。

(2) 艾炷隔山药灸：进行性肌萎缩，每次选3~5穴，取生山药用淡盐水浸泡10分钟，切成0.2厘米薄片，置穴上或肌肉萎缩处，上放艾炷灸4~8壮，每日1次，10次为1个疗程。

(3) 艾条灸：①肝肾亏损、瘀阻脉络而痿者，各选相应穴位，每穴灸10~15分钟，每日1次，10~20次为1个疗程。②

重症肌无力,在百会、气海、关元、足三里穴各灸 10~20 分钟,每日 1 次,15 次为 1 个疗程。③侧索硬化症,在百会、天窗穴各灸 5~10 分钟,每日 1 次,15 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸:①脾胃虚弱、瘀阻脉络而痿者,各选相应穴位 3~5 穴,每穴灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次,10 次为 1 个疗程。②脊髓压迫症,取病损脊髓上下各 1~2 节段的夹脊穴及病变所影响的肢体局部穴位,各灸 20 分钟,隔日 1 次,15 次为 1 个疗程,疗程间休息 7 日。

(5) 雷火针灸:每次选 3~5 穴,各按灸 5~7 次,使药气深入穴位深部,每日或隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。

二、妇科疾病

月经不调

月经不调是妇科最常见的疾病,泛指月经的周期、经量、经色和经质发生异常的病证。包括以月经周期改变为主的经行先期、经行后期、经行先后不定期、经期延长和以经量改变为主的经量过多、经量过少等。

妇女正常月经大体 28~30 日来潮 1 次,行经 3~7 日,经量约 50 毫升~100 毫升,色暗红而不凝结、不稀不稠、无臭味。如月经提前 7 日以上,周期短于 21 日,甚至 1 个月两潮者,称为经行先期;月经周期延后 7 日以上者,甚至 40~50 日行经 1 次,连续两个月以上者,称为经行后期;经行有时提早,有时错后,均超过 7 日以上者,称经行先后无定期;经行超过 7 日或出血量超过正常 1 倍以上者,为月经过多;行经期少于 3 日,经量少于正常量一半以下者,为月经过少。

【病因病机】

妇女以血为本，血充气顺，则月经通调。而维持气血调和又与心、脾、肝、肾及冲、任二脉关系极为密切。凡情志不畅、久病体虚、经产期感受风寒暑湿等外邪、房事不节、孕育过多等，均可使脏腑功能失调和冲、任二脉损伤，引起气血失和，导致月经不调。

【辨证施灸】

月经不调有寒热虚实诸证，以经行先后分析，经行先期多为热证、气虚；经行后期多为肝肾不足、冲任不调。以经量多少分析，经量过多为热证、气虚；经量过少为寒证、血虚或气血郁滞。以经色深浅分析，深红多为热证；淡红多为虚证；紫暗为实证；暗淡为寒证。以经质稀稠分析，稀薄多为寒证、虚证；粘稠多为热证；有血块多为气滞血瘀。临证可根据以上分析，再结合作有症状综合分析判断。

1. 寒伤冲脉 经行后期，量少色暗淡，质稀薄，小腹冷痛，喜温喜按，形寒肢冷，便溏溲清，舌淡苔白，脉沉弦。

治则 温经散寒，调养冲任。

取穴 气海、血海、三阴交。实寒加天枢、归来；虚寒加命门、关元。

方义 气海调补元气，温通下元；血海调养营血；三阴交补益足三阴。诸穴合用调补冲脉，养血和血。天枢、归来温通胞脉，活血通经；命门、关元温补肾阳，阳气得振，寒凝自散。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 3~5 壮，腹部穴位可灸 10 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸：每穴灸 5~10 壮，每日 1 次。

(3) 艾条灸：每穴灸 15~20 分钟，每日 1 次。

(4) 温针灸：每穴灸 3 壮(或 10~15 分钟)，隔日 1 次。

2. 血热先期 经行先期。实热者经量多，色鲜红或深红，质粘稠，伴烦热面赤，口干渴，尿黄，舌红苔黄，脉滑数；虚热者经量少色红，质稀薄，腰酸腿软，颧红潮热，手足心热，舌红苔少，脉细数。常见于青春期女性。

治则 清热凉血，养血调经。

取穴 关元、血海、三阴交。实热加行间、太冲；虚热加复溜、太溪、然谷。

方义 关元、血海、三阴交益气血，调冲任；行间、太冲泻肝清热；复溜、太溪、然谷滋肾阴，清虚热。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每穴 5~10 壮，每日 1 次。

(2) 温针灸：复溜采用补法，余穴采用泻法，每穴灸 3 壮(或 10~15 分钟)，每日 1 次。

(3) 温盒灸：每穴灸 10~15 分钟，每日 1 次。

(4) 拍火灸：取当归、大黄、益母草各 15 克，川芎、丹皮各 12 克，赤芍、桂枝各 10 克，柴胡 6 克，共研细末，在气海、关元穴施灸。

3. 气虚先期 经行先期，量多色淡，质稀薄，小腹空坠或腰部发胀，神疲乏力，气短懒言，纳少便溏，面色萎黄，舌胖有齿痕，脉细弱。

治则 益气摄血，调理冲任。

取穴 脾俞、气海、关元、足三里。

方义 脾俞、足三里健脾益气；气海、关元益气补肾调血。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 5~10 壮，脾俞可灸 10~15 壮，以局部皮肤潮红为度，于两次月经中间开始施灸，每日 1 次。

(2) 艾条灸：每穴灸 15 分钟，余法同上。

(3) 温针灸：采用补法，每穴灸 3 壮（或 10～15 分钟），隔日 1 次。

4. 血虚后期 经行后期，量少色淡，质稀薄，小腹绵绵作痛，喜按揉，头晕眼花，心悸少寐，困倦疲乏，面色无华，舌淡苔薄，脉细弱。

治则 益气养血，调补冲任。

取穴 膈俞、脾俞、气海、归来、血海、足三里、三阴交。

方义 膈俞补血，统理血分之虚；脾俞、足三里健脾调冲，以充气血生化之源；气海、归来、血海、三阴交理气活血，补血调冲。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 5～7 壮，于两次月经中间连续施灸 3～5 日。

(2) 艾条灸：每穴灸 5～10 分钟，灸至皮肤潮红能忍受为度，于两次月经中间连灸 3～5 日。

(3) 温针灸：每穴灸 3 壮（或 10～15 分钟），于两次月经中间连灸 3～5 日。

5. 肝郁气滞 经行后期或先后不定期，经行不畅，经量少，色暗红有小血块，经前胸胁、乳房、少腹胀痛，舌暗红，苔薄，脉弦。

治则 疏肝解郁，理气调经。

取穴 肝俞、期门、气穴、中极、三阴交、蠡沟、行间、太冲。

方义 肝俞、期门俞募相配，合太冲疏理肝气解郁；气穴配三阴交养肝阴；中极助三阴交养肝之阴而顺肝之性，令其疏泄调达；蠡沟、行间泻肝调经，疏达肝郁。

灸法

(1) 艾条灸：每次选 3~5 穴，各灸 10 分钟，每日 1 次。

(2) 温针灸：每次选 3~5 穴，采用泻法，各灸 3 壮（或 5~10 分钟），每日 1 次。

6. 肾气不足 经行先后无定期，经来断续，经量或多或少，色暗淡，质稀薄，头晕耳鸣，腰膝无力，小腹空坠，小便清长，舌红苔少，脉细数。

治则 补肾培本，养血调经。

取穴 肾俞、关元、水泉、三阴交、太溪。

方义 肾俞、关元培补先天之本，合水泉、三阴交、太溪滋补肾精而益冲任之脉。

灸法

(1) 艾条灸：每穴灸 10~20 分钟，每日 2 次，于经后 3 周连灸 3~5 日。

(2) 温针灸：每穴灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次，于经后 3 周连灸 3~5 日。

7. 防治月经不调 经常在肾俞、中极、合谷、三阴交穴，采用艾炷或艾条温和灸，可防治月经不调。

痛 经

妇女在行经期间或经期前后发生周期性下腹部疼痛、腰骶酸痛等症状，以致影响工作和日常生活者称痛经。西医分原发性和继发性痛经两种。原发性痛经指有痛经症状而生殖器官无明显异常者，多见于未婚女青年；继发性痛经指痛经是由盆腔内的疾病引起，如子宫内膜异位、盆腔炎、子宫颈管狭窄等，多见于生育年龄妇女。

【病因病机】

痛经的原因虽多，但总离不了气血运行不畅的因素。经由

血化,血随气行,气顺则血和,运行顺畅,经来自安。倘若气血郁滞,经行不畅,不通则痛。凡情志不舒,郁怒伤肝,忧思伤脾,引起气机郁结不利,血行受阻,瘀滞胞宫而痛;或素体肾虚,久病体弱,气血不足,经行滞涩或经行血海空虚,胞脉失养,故行经期及经后小腹绵绵作痛;或者经期产后,受寒饮冷,损伤冲任,寒湿凝滞胞宫,经行不畅,亦可作痛。西医认为,引起痛经的直接原因是子宫的异常收缩、经血排出不畅和盆腔充血。原发性痛经与子宫、卵巢内分泌及精神等因素有关。近年来研究证明,子宫内膜和血中前列腺素含量的增高,是引起痛经的一个决定性因素,在孕激素作用下的分泌期子宫内膜合成并释放更多前列腺素 F_{22} ,作用于子宫肌内血管,引起痉挛性收缩而疼痛;继发性痛经是生殖器官器质性病变引起,与盆腔疾病有关。

【临床表现】

经期或经期前后下腹部呈阵发性或持续性剧烈疼痛,一般发生在月经来潮前 1~2 日,经行前数小时逐渐或迅速加剧,历时数小时到 2~3 日不等,疼痛剧烈时可向大腿内侧放散,多数患者自觉小腹发凉,喜热按。随着经血增多,外流通畅或排出血块、膜样组织后,疼痛可缓解或消失。部分患者经期小腹绵绵作痛,经后疼痛反重,数日才能停止,常伴恶心呕吐,头晕头痛,心烦乏力等全身症状。痛经剧烈者可出现面色苍白,出冷汗,手足厥逆,甚至抽搐,以致晕厥虚脱。

【辨证施灸】

痛经可根据疼痛发生的时间、性质、部位、程度,结合月经的期、量、色、质及兼症、舌脉,参合素体情况,以辨寒热虚实。从疼痛的时间分析,痛在经前多为气滞血瘀、寒湿凝滞;痛在经后多为气血虚弱。从疼痛的性质分析,刺痛为血瘀,绞痛为

寒湿凝滞，胀痛为气滞，隐痛多属虚证。从疼痛的喜按、拒按分析，痛时喜热喜按为寒证、虚证；痛时恶热拒按为热证、实证，临证应全面分析。

1. 气滞血瘀 经前或经期小腹胀痛，经行不畅，量少，色紫暗夹有血块，经畅或瘀块排出后疼痛减轻，伴胸胁、乳房胀痛，面色晦暗，舌红，有瘀点或瘀斑，脉弦。

治则 理气活血，化瘀止痛。取任脉、足厥阴肝经穴为主。

取穴 气海、中极、血海、三阴交、行间。

方义 气海、血海调气行血；中极通调冲任；三阴交柔肝调畅经气；行间调达肝气。诸穴合用使冲任气机和调畅达，瘀血可化，疼痛自止。

灸法

(1) 艾炷或艾条灸：痛经即时可针刺次髎穴，待经净痛止后，于两次月经中间各灸 3～5 壮（或 10～15 分钟），每日 1 次，连灸 5～7 日。

(2) 艾炷隔药灸：取五灵脂 15 克，炒蒲黄 10 克，白芷（或川楝子）9 克，青盐 5 克，共研细末，每次取 3 克纳脐中，覆盖姜片，施灸 3～5 壮，以脐腹内有温热感为度。在经前 5～7 日施灸，每日 1 次，灸至经净为止。

(3) 拍火灸：取当归、香附、益母草、五灵脂各 15 克，川芎、白芍、丹皮各 12 克，炒蒲黄、延胡、乌药、红花各 10 克，共研细末，在腹部或腰骶部施灸。

(4) 复方香附熨灸：取香附、桃仁各 30 克，苏木 60 克，共研细末，喷黄酒适量，炒热布包，趁热熨灸少腹痛处，每次 30 分钟，以痛解为度，每日 1～2 次。

(5) 复方延胡当归熨灸：取延胡 20 克，当归 12 克，红花 10 克，蚕砂、胡椒各 6 克，共研细末，喷醋适量，炒烫布包，趁

热熨灸痛处，每次 30 分钟，以痛解为度。

(6) 王不留行敷灸：取王不留行子置香桂活血膏上，于经前 2~3 日敷灸关元、气海、三阴交，每日用手按压数次。

(7) 痛经散敷灸：经前 3 日，取当归、吴茱萸、乳香、没药、肉桂、细辛、樟脑各等量，共研细末，每次取 3 克，用黄酒调成糊状敷灸神阙，用胶布固定，每日 1 次，经行 3 日后停敷。

2. 寒湿凝滞 经前或经期小腹冷痛或绞痛，甚则痛连腰骶，得热痛减，按之痛甚，经血量少，色暗质稀或如黑豆汁或夹有小血块，面色青白，四肢不温，舌暗淡，苔白腻，脉沉紧。

治则 温经散寒，利湿止痛。取任脉，足太阴、阳明经穴为主。

取穴 次髎、中极、水道、子宫、地机。

方义 次髎调经血，为治痛经要穴；中极、水道通调胞宫，温经和营；子宫理气调经，暖宫止痛；地机扶土化湿，通经止痛。

灸法

(1) 艾炷灸：在至阴穴灸 3~5 壮，以痛解为度。

(2) 艾炷隔姜（或附子饼）灸：每穴灸 10~15 壮，以痛解为度。

(3) 艾条悬（或雀啄）灸：选用艾条（或雷火针），每穴施灸 10~15 分钟，以痛解为度。

(4) 温针灸：采用泻法在中极、水道穴各灸 5~10 分钟，以痛解为度。

(5) 舒乐热敷剂熨灸：取市售舒乐热敷剂 1 袋，撕去外层包装，稍加揉搓即自行发热，趁热熨灸少腹痛处，每日 1~2 次。

(6) 大葱熨灸：取大葱 500 克，切碎敷灸少腹疼痛处，覆

以厚布,用熨斗熨灸 30 分钟,每日 2 次。

(7) 青盐熨灸:取青盐 250 克,炒烫后再洒陈醋 150 毫升,边洒边炒至极烫,用布包趁热熨灸少腹、腰骶痛处,以痛解为度。

(8) 吴萸敷灸:取吴萸适量加黄酒少许,炒热布包,趁热敷灸少腹或腰骶疼痛处,每日 1 次。

3. 气血虚弱 经期或经后小腹或腰骶部绵绵作痛或经净后疼痛反重,数日后才停止,按之痛减,经量少,色淡质稀,可伴头晕目眩,心慌气短,精神不振,纳少便溏,身倦无力,面色萎黄或苍白,舌淡苔薄,脉细数。

治则 益气养血,温经止痛。取任脉,足太阴、阳明、少阴、厥阴经穴为主。

取穴 肝俞、脾俞、肾俞、关元、命门、次髎、水道、子宫、曲骨、血海、足三里、三阴交。

方义 肝俞、肾俞、关元滋肝肾,培补下焦胞宫;脾俞、足三里健脾益气,培补气血生化之源,利湿散寒;命门温阳补火;次髎调经止痛;曲骨、血海、三阴交补肾调经,养血止痛;水道、子宫通调胞宫,理气止痛。

灸法

(1) 艾炷灸、艾炷隔姜灸:每次选 3~5 穴,各灸 5~10 壮,每日 1 次,以痛解为度。

(2) 艾炷隔盐灸:在神阙或腹部穴位各灸 5~10 壮,以痛解为度。

(3) 艾条温和灸、温盒灸:在关元、水道、曲骨、子宫等穴各灸 10~20 分钟,每日 1~2 次,以痛解为度。

(4) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),每日 1 次,以痛解为度。

(5) 复方当归敷灸：取全当归、吴萸、川椒各等份，共研细末，炒烫后喷酒少许，布包趁热敷灸少腹痛处，每日 1 次，以痛解为度。

此外，凡遇痛经剧烈，面唇苍白或紫绀，出冷汗，手足厥冷，恶心呕吐，头晕目眩，抽搐甚至晕厥、虚脱者可采用以下灸法：

(1) 艾炷灸：在百会、神阙、关元施灸，不计壮数，以痛解为度。

(2) 发泡灸：取斑蝥、白芥子各等份，共研细末，用 50% 二甲基亚砷调成软膏，每次取麦粒大 1 块，敷灸关元或中极（两穴交替应用），3 小时后除去。经前 5 日敷灸第一次，月经来潮时敷灸第二次，敷灸两个月经周期为 1 个疗程，1 个疗程后多可显效。

按：灸法治疗痛经，调经镇痛作用明显，疗效持久，且能改善全身症状和调整月经周期。为了取得更好的疗效，应掌握有利的治疗时机，最宜在经前 3~5 日开始艾灸，在次髎、关元、阴交、大赫、横骨、中极、曲池、三阴交等穴施艾炷灸或艾条温和灸，每日 1 次，可起到预防作用。亦可于经净痛止后隔日 1 次，灸至下次月经来潮前停止。灸法对内分泌功能具有双向调节作用。因此，对内分泌功能失调引起的痛经，疗效更为突出。临床研究提示，关元、中极、水道、三阴交穴是治疗痛经的有效腧穴，如属继发性痛经，除临时艾灸止痛外，应以治疗原发病为主。

功能失调性子宫出血

功能失调性子宫出血（简称功血）是指内分泌系统功能失调所致的月经周期紊乱和出血异常。临床根据卵巢有无排卵

分为有排卵性功血和无排卵性功血。前者多见育龄妇女,后者多发生于青春期和更年期。以月经周期紊乱、阴道大量出血和淋漓不断为主要特征。属中医“崩漏”范畴。经血暴下量多称为“崩”,淋漓不尽称为“漏”,两者常交替出现。

【病因病机】

功血与卵巢功能及性腺内分泌失调有关。凡精神紧张、恐惧、劳累、环境和气候变化、营养不良或代谢紊乱等因素干扰了下丘脑-垂体-卵巢系统的相互调节和制约机制,以致失去其正常有规律的周期性变化,导致卵巢功能失调,性激素分泌失常,使性腺的靶细胞器官——子宫内膜不规则剥脱出血。中医认为,崩漏之因是由于血热、血瘀、气虚诸因素导致冲任损伤,脾失统摄,不能制约经血所致。病机多虚实夹杂,气血同病,多脏受累,与肝、脾、肾等脏关系密切。虚者多因脾气虚血失统摄,肾阴虚精血失守;实者多为热盛外感,迫血妄行,瘀阻热结,血不归经,或肝经有热,血失所藏等引起。

【临床表现】

月经周期紊乱,经期延长,出血量多,突然出血如暴注或淋漓不尽,持续不断。常在阴道不规则出血前有时间长短不等的停经史,继之大量出血或淋漓不断,周期性血量增多,然后转变为不规则或持续性子宫出血,一般不伴腹痛,可有头晕目眩,心悸气短,腰膝酸软,形瘦神疲,面色萎黄或苍白。如突然大量出血可引起出血性休克,长期出血可造成继发性贫血及生殖器官感染。宫颈粘液涂片、阴道细菌学检查,基础体温测定及诊断性刮宫有助于诊断。

【辨证施灸】

本病主证是阴道不规则出血,故辨证应根据出血的期、量、色、质及久暂等参合舌脉和并发症状以区别寒热虚实。但

一般而言,本病虚多实少,热多寒少,久崩多虚,久漏多瘀。临证多见气虚、血热和血瘀诸证。虚者经血暴下非时,量多势急,继而淋漓不止,色淡质稀,伴腰膝酸软,头晕耳鸣者多为肾虚;伴神疲气短,纳呆便溏者多为脾虚。血热者经血非时暴下,或先期量多,色红质稠,若口渴面赤,舌红苔黄,脉弦数则为实热;心烦潮热,脉细数则为虚热。血瘀者经来无期,时闭时崩或漏下不止,色紫黑或夹有血块,或小腹有瘀块,胀痛拒按,舌紫暗或有瘀斑。

治则 由于崩漏发病缓急不同,出血量多少各异,故治疗应遵循急则治标,缓则治本的原则,灵活掌握塞流、澄源、复旧三法。艾灸的目的是理血培元,调补冲任。

取穴 血崩选百会、肝俞、脾俞、肾俞、命门、关元、血海、三阴交、隐白;漏下选脾俞、气海、中极、血海、地机、三阴交。属热者加太冲、大敦;属瘀者加气冲、冲门、支沟;气虚者加膏肓俞、足三里、阴交;阴虚者加太溪、阴谷、然谷。

方义 百会升阳益气,血随气升,崩漏可止;膏肓俞益损补虚;脾俞配三阴交、足三里健脾益气摄血;肝俞可复藏血之功以止崩漏;肾俞、命门、关元温肾培元,固本止崩;气海、血海调气血;地机、隐白健脾摄血,为治功血经验穴;中极温阳散胞宫之寒;太冲、大敦泻肝泄热;气冲、冲门、支沟助行气化瘀;阴交温肾益精调冲任;太溪、阴谷、然谷调补脾肾止崩漏。

灸法 属虚寒者用补法,施重灸;属瘀偏热者用泻法,施轻灸。

(1) 艾炷灸:①小艾炷灸隐白或大敦穴 5~10 壮,出血量即可减少。②血崩在百会、气海、隐白穴各灸 10~20 壮,肝俞、脾俞、肾俞穴各灸 10 壮,血海、三阴交、地机穴各灸 5 壮。虚寒加灸命门、中极穴各 20 壮;血热加灸太冲、大敦穴各 5 壮(采

用泻法);血瘀加灸气冲、冲门穴各 3 壮,支沟 5~7 壮,每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸:在气海、关元、中极、隐白穴各灸 5~7 壮,每日 1 次。

(3) 艾条灸:①在神阙悬灸 20 分钟,出血量即可减少。②重点灸气海、关元、中极、隐白穴各 15~20 分钟,以局部潮红为度,每日 1~2 次。

(4) 温针灸:每次选 3~5 穴(隐白不针),各灸 5~10 分钟,每日 1 次。

(5) 温盒灸:在中极、子宫穴各灸 20~30 分钟,每日 1~2 次。

(6) 灯火灼灸:在隐白、大敦穴各灼灸 1 下,崩漏有立止之效。

(7) 蓖麻仁(或叶)敷灸:取蓖麻仁(或叶适量)15 克,捣烂敷灸百会穴,每日更换 2 次。

按:灸法治疗功血有益气摄血、凉血止血的良好效果。平时在血海、三阴交、隐白穴施艾炷或艾条温和灸,有预防功血的作用,特别是艾灸隐白穴,有艾到血止之功,待出血停止后,再进一步明确诊断,对因治疗以巩固疗效。如果出现大出血,需采用综合措施及时止血,以免发生出血性休克。

闭 经

发育正常女子一般 12~14 岁月经来潮,凡年逾 18 周岁,月经尚未来潮或以往已有过月经,现又非生理性中断 3 个月以上者称为闭经。西医称前者为原发性闭经,后者为继发性闭经。青春期、妊娠期、哺乳期的暂时停经,气候变化,地域迁徙或其它生活条件改变,偶发一二次停经,更年期的停经及绝

经,以及居经、避年、暗经等均属生理性闭经,不作病论。至于先天性生殖器官发育异常及后天器质性损伤而至无月经者,非针药所宜,不属本节讨论范畴。

【病因病机】

闭经之因较为复杂,凡精神不舒、饮食不节、劳倦过度、房劳多产,以及失血、寒邪湿浊侵袭均可导致心、肝、脾、肾及冲任失调而引起闭经。病机有血枯和血滞两方面。血枯者多因肝肾不足,精血亏损,血海空虚,无血可下,因虚至闭;血滞者由气滞血瘀、痰浊阻滞、冲任不通,经血不得下行,因实滞而闭。西医认为,闭经常与全身疾病,内分泌失调,神经精神诸因素有关。全身疾病如严重贫血、结核病、肾脏病、心脏病、营养不良等及下丘脑-垂体发育异常或功能不全,肾上腺皮质、甲状腺等内分泌功能失调和子宫内膜的病理改变皆可引起闭经。此外,精神过度持久紧张也可引起闭经。

【临床表现】

初潮年龄已过仍未行经,或月经稀少而至停经,或以往月经正常而突然停经。临床可随不同病因而伴有相应表现,一般常伴内分泌功能减弱的症状。阴道涂片、诊断性刮宫、雌激素试验、黄体酮试验、基础体温测定均有助诊断。

【辨证施灸】

1. 血虚经闭 年逾18周岁尚未行经,或月经稀少渐至闭经,体质虚弱,面色萎黄或苍白,腰膝酸软,头晕耳鸣,心悸气短,神疲乏力,食少便溏,舌淡,脉细弱,或五心烦热,潮热盗汗,舌红,脉细数。

治则 补气血,益肝肾,调冲任,通经血。取任脉,足太阴、少阴经穴及背俞穴为主。

取穴 膈俞、肝俞、脾俞、肾俞、气海、关元、归来、足三里、

三阴交。

方义 膈俞、肝俞、脾俞、肾俞调补气血冲任，补益肝肾之精；气海、关元填精培元；归来调冲任；足三里、三阴交健脾益气，调补肝肾。脾胃虚弱加胃俞、中脘；肝肾不足加命门、阴谷、腰夹脊；潮热盗汗加膏肓俞；心悸怔忡加内关、神门。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔姜(或胡椒饼)灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日或隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮(或 10~15 分钟)，隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(5) 生地木香敷灸：取生地、木香各等份，共捣烂敷灸气海、关元穴上，覆盖厚布，用熨斗熨灸 30 分钟，每日 2 次。

2. 血瘀闭经 既往行经正常，突然闭止，烦躁易怒，胸胁胀满，小腹胀痛拒按，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉沉涩；或形体肥胖，胸闷泛恶，神疲乏力，白带多，苔白腻，脉沉滑。

治则 祛瘀化痰，理气活血，行气通经。取任脉，足太阴、厥阴经穴为主。

取穴 中极、合谷、血海、丰隆、三阴交、地机、太冲。

方义 中极合血海化痰通络，配合谷、太冲开四关，舒肝理气，活血通经，佐地机、三阴交健脾化湿，行气活血，加丰隆豁痰降逆。胸胁胀满加期门、支沟；小腹胀痛加归来、水道；呕恶加内关；神疲乏力加足三里。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：采用泻法在中极灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 温针灸：采用泻法在血海、三阴交穴各灸 3 壮（或 5~10 分钟），每日 1 次。

(3) 益母草蚕砂熨灸：取益母草（切碎）120 克，蚕砂 100 克，共炒烫布包，趁热熨灸小腹 30 分钟，每日 2 次。

按：艾灸治疗闭经有良好疗效，尤其治疗精神因素引起的闭经效果更好。

带下病

随着女子发育成熟，阴道内分泌少量白色或淡黄色粘性液体称为白带。一般青春期、经前期、妊娠期分泌量相对增多，无其它症状，属生理现象。若带下量明显增多，或夹有其它颜色和异味，并伴有全身及局部刺激症状即称带下病。常见于阴道炎、宫颈炎、盆腔炎及宫颈癌等疾病，临床以白带、黄带、赤白带较多见。

【病因病机】

带下病之因，责之脾虚湿盛，与脾、肾及冲、任、带脉关系密切。多由于饮食、劳倦、外感湿毒；或肝郁犯脾，脾胃损伤，脾虚湿盛，湿郁化热，湿热下注，损伤任脉；或素体肾虚，及房劳、多产，伤及下元，肾虚不固，任带失约所致。西医认为，白带病有炎症和非炎症、异物刺激及全身性疾病等多种因素引起。

【临床表现】

阴道分泌物明显增多，绵绵如带，颜色、性状、气味异常，有白带、黄带、赤白带多种，或粘稠如脓，或稀薄如水，或有特异臭味，可伴腰酸、腹痛及外阴瘙痒的局部刺激症状。

【辨证施灸】

1. 白带 脾肾阳虚，带下清稀，小腹冷坠，腰膝酸软，便

溏溲清，舌淡苔薄，脉沉迟；若肾阴虚火旺则带下赤白，粘稠无臭秽，五心烦热，失眠多梦，舌红苔少，脉细数。

治则 益气健脾，除湿止带。

取穴 脾俞、肾俞、白环俞、次髎、气海、关元、带脉、足三里、三阴交、地机。肾阴虚加中极、太溪。

方义 脾俞、足三里、三阴交、地机健脾益气，升清降浊；肾俞、气海、关元、带脉、中极补肾固本，益气止带；白环俞、次髎治赤白带下；太溪滋阴清热。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选3~5穴，各灸3~5壮，每日1次，10次为1个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼灸：在气海穴灸10~20壮，每日1次，10次为1个疗程。

(3) 艾条温和灸：每次选3~5穴，各灸20~30分钟，每日1次，15次为1个疗程。

(4) 温盒灸：在脾俞、命门、气海、关元、三阴交穴各灸10~20分钟，每日1次，10次为1个疗程。

(5) 温针灸：每次选3~5穴，各灸3壮（或10~15分钟），每日或隔日1次，10次为1个疗程。

(6) 太乙神针灸：在脾俞、肾俞、气海、关元、中极、三阴交穴各灸10~15分钟，隔日1次，7次为1个疗程。

(7) 艾叶食盐熨灸：取艾叶、食盐适量，喷醋少许，炒热布包，趁热熨灸脐腹、小腹部，每日1次。

2. 黄带 带下色黄量多，质粘有异味，甚则状如腐渣或赤白相兼，或黄绿如脓，或混浊如米泔，或有血液，阴部瘙痒，伴胸闷纳呆，小腹痛，尿黄赤，口干苦，舌红苔黄，脉滑数。

治则 清热利湿，化浊止带。

取穴 中极、带脉、阴陵泉、三阴交、行间。

方义 中极、带脉止带；阴陵泉、三阴交健脾清热利湿；行间清下焦热毒。

灸法

(1) 艾炷隔黄柏细辛饼灸：采用泻法，每穴灸 5~7 壮，每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(2) 温针灸：采用泻法，每穴灸 3 壮（或 5~10 分钟），每日 1 次，7 次为 1 个疗程。

按：临证所见，带下病以炎症性白带最为多见，由于灸法具有抗炎、调节免疫反应，促进机体免疫功能等作用，故艾灸治疗各种白带病效果较好，但其确切机制尚不清楚。平时艾灸带脉、次髎，有防治白带过多的作用。

盆腔炎

盆腔炎系指妇女盆腔内器官（子宫、卵巢、输卵管、宫旁结缔组织及盆腹膜）的炎症。可局限于某部位，也可涉及整个内生殖器。分急性和慢性两种。多发生于 30~40 岁之间，属中医的“带下”、“癥瘕”等范畴。

【病因病机】

盆腔炎的发生是由多种化脓菌感染所致，临床报道以淋球菌感染居多。中医认为是由于素体虚弱，或经期、产后胞脉空虚，邪毒乘虚侵袭，湿浊热毒蕴结于胞宫脉络，与气血相搏，导致气血运行不畅，进而损伤冲任而发病。其初期一般表现为实热证，若邪热滞留，日久不愈，损伤正气则出现气滞血瘀或脾肾不足的虚实夹杂证和虚证。

【临床表现】

急性期可见发热恶寒，头痛，下腹痛，拒按，甚至全腹剧

痛,带下黄浊臭秽,尿黄赤,触诊可有腹膜刺激征;如治疗不彻底可转为慢性,经常下腹部坠胀钝痛,腰骶酸痛,白带多,月经失调,继发性不孕,可触及盆腔炎症病灶。参合感染史和细菌培养、B超及X线检查结果均有助诊断。

【辨证施灸】

艾灸多适用于慢性盆腔炎。症见少腹胀坠隐痛,白带多,质稀薄,腰酸楚,月经不调,经色紫暗有血块,头晕神疲,纳呆便溏,或五心烦热,舌淡,苔白或腻,脉弦细或细数。

治则 调理脾胃,活血化瘀,通调冲任带三脉。

取穴 大肠俞、次髎、神阙、气海、归来、中极。

方义 大肠俞、次髎强腰脊,通经活血,利肠腑,治赤白带下;神阙补益脾胃,温阳固本;气海益肾固精,调理冲任,升阳止带;归来理气活血,调理冲任;中极清利湿热,调经止带。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次,10次为1个疗程。

(2) 艾炷隔姜灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次,10次为1个疗程。

(3) 复方大黄敷灸:取大黄、黄柏、姜黄、苍术、红藤、枳壳、赤芍、三棱、莪术、白芷、厚朴、防风、红花、香附、没药、丹参、花粉、艾叶、泽兰叶、全当归、生川乌、生草乌、败酱草各10克,共研细末,加白酒适量用温水调成糊状,纱布包裹,敷灸腹部病变处,药包上面可用热水袋保持温度,每次60分钟,每晚1次。

妊娠呕吐

妇女妊娠早期(2~3月),常有嗜酸择食,轻度恶心呕吐,

一般3个月后即可自行消失。如出现恶闻食味,呕吐严重,甚则食入即吐,妨碍饮食,使孕妇产生营养不良及脱水现象,称为妊娠呕吐。

【病因病机】

妊娠呕吐的原因尚不明确,可能与孕妇体内绒毛膜促性腺激素增高及精神因素有关。中医认为,是由于胎气阻逆,胃失和降所致。受孕之后经血聚以养胎,冲任气盛,冲脉隶属于阳明,冲气循经上逆犯胃,胃气随之上逆而呕吐或阴血不足,肝气偏旺,肝气侮胃,引起肝胃不和而呕吐。亦有脾胃虚弱,素有痰饮停滞,孕后血壅气盛,痰饮随冲气上逆而呕吐痰涎者。

【临床表现】

临床症状轻重不一,轻者仅恶心,食欲不振,嗜酸择食,厌食或晨起偶有呕吐,神疲乏力,为妊娠初期生理反应,一般3个月左右即可自行恢复正常,不需要治疗。重者呕吐剧烈而频繁,不能进食、饮水,食入即吐,甚至呕吐胃液、胆汁和夹有血样物,可引起脱水及电解质紊乱,体重下降,形体消瘦等。

【辨证施灸】

根据呕吐症状,呕吐物的性质等情况辨治,脾虚痰盛者,呕吐清水痰涎,胸闷纳呆,口淡无味,乏力嗜卧,舌淡苔白或白腻,脉缓滑无力;肝胃不和者则呕吐酸水或苦水,口臭便秘,胸胁胀痛,心烦少寐,舌红苔黄,脉弦滑;气阴两虚者,呕吐剧烈,呕吐物常带血或血渣状,双目无神,眼眶凹陷,舌红苔光或剥,脉细数。

治则 调冲降逆,佐以健脾化痰,或疏肝清热,或益气养阴。

取穴 中脘、建里、幽门、内关、足三里、三阴交。

方义 中脘、建里、幽门、足三里健脾化痰,和胃降逆;内

关和中降逆；三阴交调肝肾，和脾胃化湿。脾虚痰盛加脾俞、阴陵泉、丰隆；肝胃不和加内庭、太冲、公孙。

灸法

(1) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，临睡前施灸效佳。

(2) 药物艾条熏灸：取苏叶、苍术、艾叶各等份，依法制成药物艾条，点燃熏灸上穴，每穴 5~10 分钟，每日 1 次。

(3) 刀豆壳敷灸：取刀豆壳 10 克，烧灰存性，研细用姜汁、米醋调成膏状，敷灸神阙穴，胶布固定，每日更换 2 次。

按：艾灸治疗妊娠呕吐有良好的效果，尤其是近年来采用药物艾条温和灸，功效卓著，很受患者欢迎。但如果呕吐剧烈，出现脱水、酸中毒、黄疸等严重证情时，应配合中西药物治疗。

胎位不正

胎位不正是指妊娠 28 周后，胎儿在子宫体内的位置不正（包括枕后位、臀位、横位、斜位）而言，又称胎位异常，常见于经产妇或腹壁松弛的孕妇。是引起难产的重要原因，其中以臀位最为常见，横位对母婴的危害最大。中医根据胎位不正的情况有“倒生”、“逆产”、“横生”、“坐生”等名称。

【病因病机】

胎位不正除与孕妇腹壁松弛有关外，尚与骨盆狭窄、子宫畸形、肿瘤及胎儿成长异常等有关。古代中医由于缺乏必要的产前检查，故往往不能早期诊断胎位不正，以至临产时才发现。对其病因的认识，多从虚实两方面考虑。因虚者，系产妇气血虚弱，胎气难盛，欲转不能而致横位、倒产；因实者，是由于孕妇嗜食肥甘，胎儿过大，兼产妇脏气郁滞，不能推动胎儿正位所致。

【辨证施灸】

临床无自觉症状,经产前检查发现子宫内胎儿胎位不正。除肿瘤、子宫畸形等器质性病变引起外,使用艾灸治疗,可收到极好效果。

治则 调整足太阳、足少阴经气,以转胎位。

取穴 至阴。

方义 至阴为足太阳的终末穴,经气自本穴斜走足心而联系涌泉与肾经相通,有正胎位及催产的作用。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸:灸 3~5 壮,以局部灼热或起小水疱为度,灸毕以膝胸卧位休息 20 分钟,隔日 1 次,至胎位转正为止。

(2) 艾条温和灸:灸 30 分钟后,取膝胸位,臀部抬高休息 20 分钟,每日 1 次,至胎位转正为止。

(3) 热吹疗法:用热吹器热吹至阴穴,每次 10 分钟,每日 1 次,至胎位转正为止。

按:艾灸转胎效果极好,绝大多数经数次治疗后,胎位都能转正,转正后如再发生复变,继续施灸,仍可转正,且对母体损害极少,对胎儿无损害,较膝胸位倒转法和外倒术等转胎优越。但因胎位不正的原因很多,如因骨盆狭窄、子宫畸形等引起者,需采用其它方法治疗。除至阴穴能转胎外,京骨、飞扬、隐白、太白、三阴交、少商、鱼际、尺泽、少泽、后溪、腕骨等穴,也有不同程度的转胎效应,可以试用。

产后乳汁不足(附:退乳)

产后乳汁不足是指产后及哺乳期乳汁分泌甚少,不能满足婴儿需要,甚至无乳汁分泌。中医称“产后缺乳”、“乳少”。

【病因病机】

产后乳汁不足与产妇体弱、急性和慢性疾病和乳房病变，以及哺乳方法不当、精神影响等因素有关。中医认为，多因产妇体质素弱，产后气血耗损，或脾胃失于健运，生化乏源，不能化生乳汁；或因情志不舒，肝失疏泄，气机不畅，以至经脉阻滞，乳汁分泌障碍。

【临床表现】

产后2~10日内乳汁分泌极少，甚至无乳汁分泌，或在哺乳期内乳汁逐渐减少，亦有突然无乳者。

【辨证施灸】

1. 气血虚弱 产后乳汁极少，甚至全无，乳汁清稀，乳房虚软，无胀痛感，纳呆食少，神疲气短，面色少华，舌淡苔薄白，脉沉细弱。

治则 补益气血，生乳通络。

取穴 脾俞、膻中、乳根、少泽、足三里。

方义 脾俞、足三里健脾，补益气血；膻中、乳根宣畅宗气而通乳络，有催乳作用；少泽为生乳通经之经验穴。

灸法

(1) 艾炷灸：选膻中、少泽各灸3~5壮，每日1次，一般2~3次可通乳。

(2) 艾条温和灸：在脾俞、少泽各灸10~15分钟，每日1次，以通乳为度。

(3) 温盒灸：在膻中、乳根各灸10~20分钟，每日1次。

(4) 温针灸：在膻中、乳根、足三里各灸3壮（或10~15分钟），施补法，每日1次。

2. 肝郁气滞 产后乳少，或因恼怒使乳汁顿无，胸胁胀满，乳房胀痛，按之饱满，烦躁易怒，舌红苔薄黄，脉弦细有力。

治则 疏肝解郁,通络下乳。

取穴 膻中、少泽、大陵、太冲。

方义 膻中、少泽疏调气机,通乳;大陵、太冲疏肝调血。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:在大陵、太冲采用泻法各灸 3~5 壮,每日 1 次,以乳通为度。

(2) 艾条温和灸:每穴灸 10~15 分钟,每日 1 次,以乳通为度。

(3) 温针灸:在膻中、少泽各灸 3 壮,每日 1 次,以乳通为度。

附:退乳 正常中止哺乳,或因某些特殊情况必须中止哺乳时,乳汁积聚,乳房胀痛,甚则结块不退,除采用药物退乳外,亦可选用艾灸退乳。

(1) 艾条悬灸:在光明、足临泣各灸 10~15 分钟,每日 1 次,以退乳为度。

(2) 皮硝敷灸:取皮硝 250 克,研细,用纱布包裹分装布袋,敷灸膻窗穴或乳房上,用胸罩固定,24 小时后取下,可连敷数次。

按:灸法能使垂体前叶分泌生乳激素,使缺乳妇血液中生乳激素增加,故采用艾灸催乳有较明显效果,且对母乳的质量和婴儿的喂养无不良影响。除了应用艾灸治疗外,还必须针对病因治疗,并保持心情舒畅,营养充足,定时哺乳,建立吸吮反射。

子宫脱垂

子宫脱垂是指子宫从正常位置沿阴道下移,子宫颈外口达坐骨棘水平以下,或脱出阴道口而言。甚至子宫同阴道前后

壁一起脱出阴道口外。古人根据子宫脱出的形状不同而有很多不同名称,总称“阴挺”。

【病因病机】

子宫脱垂是由于子宫的主韧带及子宫旁组织受损引起,与分娩损伤、卵巢功能衰退、先天性子宫和盆腔组织发育不良或异常、某些慢性疾病使腹内压力增加及营养不良引起全身器官退行性变、肌肉松弛等因素有关。中医认为,是因体质虚弱,中气下陷,或房劳多产,胞络损伤,不能提摄子宫所致。临床所见,大多是由于房劳多产,产后劳逸失宜,过早参加重体力劳动,或慢性咳嗽、便秘等使腹内压力增高,从而导致子宫脱垂。

【临床表现】

阴道有物下坠,轻者仅站立、行走过久,或劳动负重时,子宫颈脱出阴道口外,平卧时多可自行回复,伴下腹、会阴部胀坠,腰尻酸痛;重者则宫体脱出,回复困难,甚至终日外露,宫颈红肿溃烂,分泌物增多。

【辨证施灸】

子宫下脱阴道口外,劳则加剧。脾虚者面色苍白,神疲懒言,带下量多;肾虚者腰酸腿软,头晕耳鸣,小便频数,舌淡苔白,脉虚弱或沉弱。

治则 益气举陷,补肾固脱,提摄胞宫。取任脉,足太阴、少阴、阳明经穴为主。

取穴 百会、脾俞、肾俞、气海俞、关元、气海、维胞、足三里。

方义 百会、气海、关元培补元气,益气升阳;脾俞、肾俞、气海俞、足三里培补先后天之本,温壮下元而固脱;维胞为治疗阴挺经验穴。

灸法

(1) 艾炷灸：在气海、关元、维胞穴各灸 5 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。艾炷或艾条灸维胞穴有预防子宫脱垂的作用。

(2) 艾炷隔附子饼(或姜)灸：每次选 3~5 穴，各灸 10 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 日。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 10~15 分钟，每日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(4) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮(或 10~15 分钟)，隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

(5) 药物蒸气熏灸：取乌梅 60 克，石榴皮、五味子各 10 克，加水煮沸后倒入盆内令患者坐盆上对准患部，用蒸气熏灸，每日 1 次。

(6) 蓖麻仁敷灸：①取醋炒蓖麻仁 10 克，捣烂作饼敷灸脐部，每日 1 次，直至子宫复位。②取蓖麻仁 30 克，捣烂，临睡时敷灸百会穴，次晨除去，每晚 1 次，直至病愈为度。

(7) 五倍子敷灸：①取五倍子 10 克，升麻 6 克，共研细末，撒黑膏药中敷灸脐部，每日 1 次，直至子宫复位。②取五倍子、五味子、生龙骨、生牡蛎、生石决明各等份，共研细末分装数袋，烤热熨灸或坐灸局部，每日 1 次，直至病愈，一般数次见效。③取五倍子 12 克，硫黄、乌贼骨各 30 克，共研细末，填满脐部，上盖毛巾，以熨斗熨灸，每次 30 分钟，每日 2 次。

外阴瘙痒症

外阴瘙痒症是指妇女外阴或阴道内瘙痒，甚则瘙痒难忍的疾病。婴幼儿、青年及老年均可发生，但绝大多数发生于更年期妇女。中医称“阴痒”或“阴门瘙痒”。

【病因病机】

引起外阴瘙痒的病因复杂,有长期阴道排出液和尿液的慢性局部刺激,原发于外阴的皮肤病变及全身因素等。常见于各种阴道炎和外阴白斑病。中医认为,发病与肝、脾、肾功能失调有关。肝脉绕阴器,主藏血;肾藏精,主生殖,开窍于二阴;脾主运化水湿,湿热互结随经下注,蕴聚于阴器;或因生活不洁,感染虫蛭,侵蚀阴部,发为阴痒。亦有肝肾不足,精血耗损,化燥生风,阴器失于濡养而发病者。

【临床表现】

外阴瘙痒或烧灼样疼痛,难以忍受,其痒常发生于阴蒂及小阴唇区,严重者大阴唇、整个阴道口、会阴部及肛周,甚至大腿内侧均可波及,轻者间歇性瘙痒,一般以夜间加剧,可因食用刺激性食物,精神紧张,劳累等诱发加重;重者瘙痒持续难忍,因搔抓、摩擦,可引起局部皮肤肥厚、皲裂、粗糙、苔癣化或色素减退,常伴精神疲惫,情绪急躁等。

【辨证施灸】

外阴瘙痒或灼热疼痛,坐卧不安。肝经湿热者,兼见带下量多,黄稠臭秽,心烦少寐,胸闷不适,口干苦,尿黄赤,苔黄腻,脉滑数或弦数;肝肾阴虚者,兼见带下量少,色黄腥臭,头晕目眩,腰酸耳鸣,五心烦热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数。

治则 疏肝清热,利湿止痒或滋阴清热,养血润燥。取任脉,足太阴、少阴、厥阴经穴为主。

取穴 气海俞、中膂、大肠俞、中极、曲骨、会阴、阴廉、血海、三阴交。肝经湿热加阴陵泉、蠡沟、太冲;肝肾阴虚加阴交、太溪。

方义 气海俞益气壮阳;中膂、大肠俞、中极配阴陵泉清利下焦湿热,配血海、三阴交健脾化湿杀虫,配蠡沟疏肝行气,

通络止痒；曲骨、会阴清热利湿；阴廉疏肝止痒；太冲疏肝泻热；阴交、太冲补肾益精，调理冲任。

灸法

(1) 艾炷化脓灸：外阴白斑在大肠俞、中膻俞、中极、曲骨、足三里、三阴交(每次选2穴)，各灸5~7壮，每月1次，3次为1个疗程。

(2) 艾炷(或隔姜)灸：每次选3~5穴，各灸3~5壮，隔日1次，15次为1个疗程。

(3) 艾条温和灸：每次选3~5穴或在会阴部熏灸5~10分钟，每日1次，15日为1个疗程。

按：灸法在止痒止痛，白斑转化方面有较好的效果，部分外阴瘙痒症可为外阴白斑病的前期表现，应引起重视，注意观察，及时治疗。

不孕症

女子婚后，夫妻同居2年以上，有正常性生活，配偶生殖功能正常，未采用避孕措施而未怀孕者，称为原发性不孕；若曾有过孕育，而2年以上未怀孕者，称为继发性不孕，两者统称不孕症。中医又称“无嗣”、“全不产”、“绝产”等，名称较多。不孕又有因女子先天性生理缺陷导致者，古称“五不女”，非针药所能治愈；亦有因男子方面的原因引起女方不孕者，均不属本篇讨论范畴。

【病因病机】

受孕是一个极其复杂的生理过程，必须具备有正常的生殖细胞；卵子和精子结合；受精卵着床等三大环节，凡各种因素影响任何一个环节不正常，均能阻碍受孕。阻碍的因素可能在女方，也可能在男方或男女双方。原因在女方者有卵巢、输

卵管、子宫、子宫颈、外阴阴道、免疫及精神等因素,还有性器官以外因素及部分妇女血清中富含抗精子抗体而不孕者。临床所见由于卵巢功能低下,以及下丘脑-垂体-卵巢系统功能紊乱引起月经异常、无排卵月经或黄体功能不全所致的不孕占很大比例。中医认为,不孕的发生除了先天缺陷外,主要与肾及冲任关系密切,肾藏精,为先天之本,主生殖,主冲任,冲为血海,任主胞胎,冲任相资,方能有子。故凡肾虚失养,肝郁气结,气血亏虚,痰湿阻胞,血瘀宫寒诸因素,均可导致肾精亏损,肾气虚弱或冲任失调而不能摄精成孕。

【临床表现】

女子婚后2年,未能成孕,月经不调,不同原因的不孕症可伴相应的兼症。妇科检查,测量基础体温、基础代谢和体内雌、孕激素,以及诊断性刮宫、输卵管通畅试验、宫颈粘液检查等有助诊断。

【辨证施灸】

1. 肾精亏虚,血虚宫寒 婚后不孕,月经后期,量少色淡。肾阳虚者兼面色晦暗,腰脊酸软,小腹冷坠,性欲冷漠,大便不实,小便清长,舌淡苔白,脉沉细;若肾阴不足,则月经先期,量少色赤,头晕耳鸣,心悸失眠,五心烦热,咽干口渴,舌红少苔,脉细数;血虚者,兼面色萎黄,形体消瘦,头目昏晕,神疲乏力,舌淡,脉细弱。

治则 温肾填精,补益气血,调养冲任。取任脉,足阳明、少阴、太阴经穴为主。

取穴 命门、气户、神阙、阴交、关元、中极、子宫、足三里、三阴交。

方义 命门配关元,温肾阳,补肾精,助气化;气户、子宫为种子经验穴;神阙健脾温阳;阴交、中极调冲任胞脉;足三

里、三阴交健脾胃，理气血。

灸法

(1) 艾炷发疱灸：每次选腹部及下肢各 1 穴，于每月经期第 12 日施发疱灸，每穴灸 3~5 壮，每个月经周期 1 次。

(2) 艾炷隔附子饼灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 艾炷隔盐灸：用食盐填满脐窝，灸 3~5 壮，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(4) 艾条温和灸：在气海或中极穴灸 15~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸：宫寒不孕在命门、阴交、气海、曲骨穴，于月经期开始，采用补法各灸 3 壮（或 10~15 分钟），隔日 1 次，15 次为 1 个疗程。

2. 气结痰浊，瘀阻胞脉 婚后多年不孕。肝气郁结者，经行先后无定期，经行不畅腹痛，量少色暗或有血块，经前胸胁、乳房胀痛，精神抑郁，烦躁而怒，舌红，脉弦细；瘀阻胞脉者，月经后期，量少色紫夹有血块，小腹胀坠隐痛，舌紫暗有瘀点，脉弦涩；痰浊者，形体肥胖，月经不调或闭经，带下量多质粘，面色苍白，头晕心悸，胸闷泛恶，舌淡胖有齿痕，苔白厚腻，脉滑。

治则 疏肝理气，燥湿化痰，活血调经。

取穴 中极、合谷、三阴交。

方义 中极调冲任，通经化瘀；合谷配三阴交理气血，调月经；合谷配太冲开四关，可行气化瘀，燥湿除痰。气结加气户、阴廉；痰湿加阴陵泉、丰隆；血瘀加归来、次髎、子宫、太冲。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸：选中极、太冲穴为主，每穴灸 3~5 壮，隔日 1 次。

(2) 温针灸:选中极穴,采用泻法,灸1壮(或5~10分钟),隔日1次。

按:引起不孕的原因复杂,应查明原因作针对性治疗。对功能性不孕,目前大多治疗方法都注重调经及补益脾肾,促排卵为主。艾灸作为一种调整排卵,促受孕的治疗手段,有良好的效果,但须坚持较长时间治疗才能显效。

三、儿科疾病

惊 风

惊风又称“惊厥”,俗称“抽风”。凡症见频繁抽搐和意识不清者均属惊风范畴。以婴幼儿多见,为儿科常见急症,古属痧、痘、惊、疳四大儿科病症之一。临床以外感高热及大病、久病之后出现者多见,有急惊风和慢惊风两类。凡突然抽搐,病势较急,表现为实证者称急惊风;而发病缓慢,抽搐时发时止,缓而无力,表现为虚证者称慢惊风。

【病因病机】

急惊风是由于外感六淫邪气,内伤宿食,生痰化热,热极生风或热盛伤阴,肝风内动所致。此外,由于小儿神气怯弱,元气未充,惊吓时也可发生惊风。主要责之手、足少阴,足厥阴,涉及心、心包、肝、肾。病机是热、痰、风、惊,且互相影响。

慢惊风多因久吐久泻或攻伐太过,脾胃受损,肝旺侮土,脾虚生风;或脾胃素弱,气血生化乏源;或热病伤阴,肾阴不足,肝血亏损,木失濡养,虚风内动;或由急惊风迁延而来。主要责之足三阴经,涉及肝、脾、肾。

现代医学认为,惊厥乃中枢神经系统功能暂时紊乱而出

现突发性短暂的意识丧失,伴有局部或全身肌肉痉挛,可见于多种疾病,分为发热惊厥和无热惊厥两类。发热惊厥多为高热或中枢神经系统感染,如多种脑炎、脑膜炎及中毒性菌痢、中毒性肺炎、破伤风等引起;无热惊厥多为中枢神经系统非感染性疾病,如新生儿颅内血肿、婴儿抽搐症、脑发育不全、脑萎缩、脑瘤、脑血管意外、癔病、癫痫,以及重度营养不良,病毒性、结核性脑膜炎后遗症等引起。

【临床表现】

发病突然,呈现短时间的意识丧失,手足抽动,两目上翻或斜视,牙关紧闭,口角掣动,口吐白沫,有时大小便失禁。发作严重时,可引起呼吸、循环功能障碍,如呼吸浅促,口唇紫绀,并可窒息死亡。如属一般感染引起的高热惊厥,仅发作1次,抽搐时间短,热退则惊止,不伴全身中毒症状,如惊止仍昏迷或伴剧烈头痛、呕吐等脑膜刺激征,应考虑中枢系统感染。

【辨证施灸】

1. 急惊风 发病急骤,意识不清,两目直视,牙关紧闭,四肢抽搐,颈项强直,角弓反张,口唇紫绀,口角掣动,舌红绛,苔黄厚,脉弦数或滑数,指纹紫绀。

治则 清热豁痰,开窍熄风。

取穴 发作时选人中、百会、十宣、合谷、太冲;缓解时加大椎、中脘、丰隆。

方义 人中醒神;十宣清热泄火;合谷、太冲开四关,调阴阳;百会益气复元神;大椎通阳泻热止痉;中脘、丰隆畅中豁痰降浊。

灸法

(1) 艾炷灸:惊厥抽搐时,先用毫针刺十宣穴出血,后灸人中、百会(或前顶、印堂)穴各3~5壮,不愈加灸大椎、关元、

合谷、足三里穴，以局部温热红润痒止为度。

(2) 灯火灼灸：每次选 2~3 穴，各灼灸 1 下。

(3) 温针灸：缓解期，每次选 2~3 穴，各灸 1 壮（或 5 分钟），每日 1 次。

(4) 蚯蚓敷灸：取活蚯蚓洗净捣烂，用蜂蜜调敷灸囟门穴处。

(5) 皂角敷灸：取皂角数条，放童便中浸泡后，取出烘干研末，用乳汁调敷灸囟门穴上。

(6) 代赭石敷灸：取代赭石粉适量，用醋调成糊状，每晚敷灸手、足心，包扎固定，次晨除去。

(7) 芙蓉花敷灸：取鲜芙蓉花叶适量捣烂，用鸡蛋清调敷灸脐部。

(8) 梔子敷灸：①取生梔子仁适量，加面粉少许，用鸡蛋清调成糊状，敷灸囟门穴处。②取梔子仁、桃仁、杏仁、胡椒各等份，糯米少许，共捣烂，加面粉少许，用鸡蛋清调成糊状，每晚敷灸手、足心，包扎固定，次晨除去。③取梔子、冰片、雄黄各等份，共研细末，鸡蛋清调敷灸脐部。

(9) 复方吴萸黄连敷灸：取吴萸 10 克，黄连 6 克，附子 3 克，共研细末，醋调成糊状，敷灸两足心涌泉穴。

(10) 菖蒲熨灸：取生菖蒲、生艾叶各等份，加姜汁、葱汁、麻油、醋适量，炒烫布包，热熨头顶、胸背、四肢。

(11) 复方麻黄锭熨灸：取麻黄 40 克，甘草 20 克，白僵蚕、蝉蜕、全蝎各 7 只，陈胆星 10 克，白附子、防风、川芎、天麻、白芷、木香各 5 克，干姜 4 克，水煎取汁，加蜂蜜收膏后再加朱砂、雄黄各 8 克，牛黄、冰片、轻粉各 2 克，麝香 1 克，共和匀制成药锭子备用。用时以淡姜汤抹锭上，温熨小儿前胸、后背。

2. 慢惊风 发病缓慢,抽搐无力,时发时止,手足瘈瘲(痉挛)或震颤,形神疲惫,嗜睡露睛,面色萎黄,纳呆便溏或完谷不化,四肢不温或厥冷,息冷唇青,舌淡,脉沉细微弱,指纹隐而淡红。

治则 温补脾胃,育阴潜阳。

取穴 发作时取穴同急惊风;间歇期加肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门、气海、关元、章门、神阙、足三里、行间。

方义 肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门温补脏气;气海、关元益气温补元阳;章门疏肝健脾;神阙补益脾胃,培元救逆;足三里健脾温阳;行间疏肝清热熄风。

灸法

(1) 艾炷灸:在中脘、章门、天枢、气海、足三里、行间,每次选 2~3 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次。

(2) 艾炷隔盐灸:用食盐填满脐窝,灸 3~5 壮,每日 1 次。

(3) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 5 分钟,每日 2 次。

(4) 温针灸:同急惊风。

(5) 蚯蚓白糖敷灸:①取蚯蚓 7 条,白糖适量,共捣烂敷灸囟门,24 小时换药 1 次。②取活蚯蚓 1 条,吴茱萸末 6 克,白芥子末 3 克,用米醋调成膏状,敷灸神阙穴及足心,胶布固定。

(6) 复方公丁香敷灸:取公丁香、生梔仁、胡椒各 7 粒,连须葱 7 根,白糖少许,先将前 3 药研细后,与葱共捣烂,加面粉少许,用鸡蛋清调匀摊布上,烘温热后敷灸剑突处 24 小时,效果不显可再敷 1 次。

(7) 复方吴茱敷灸:取吴茱、全蝎、白矾、白芥子各 3 克,共研细末,然后取附桂紫金膏 1 张剪成 4 小块,每块放药末

1/4,将药膏烘热后敷灸涌泉和劳宫穴上,待四肢转温后即除去。

(8) 复方车前子敷灸:取车前子 15 克,炙黄芪、炒白芍各 9 克,炮附子、肉豆蔻、丁香各 6 克,炮姜炭、炙甘草各 3 克,共研细末,用蜂蜜调成糊状敷灸脐部。

按:针灸治疗惊风是应急对症措施,苏醒后要进一步查找原因,采取对因治疗。对于危重患儿,必须与退热剂、镇静剂、强心剂等配合使用。小儿施灸,为了掌握热度,操作者可用左手食、中指分开按在灸治部位两旁,右手持艾条在穴位上方回旋施灸,给予适当温热刺激。

流行性腮腺炎

流行性腮腺炎,中医称为“痄腮”,俗称“蛤蟆瘟”,是由腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病。以非化脓性腮腺肿痛为特征。多发生于学龄前儿童,冬春季节容易流行,大龄儿童可并发睾丸肿痛(睾丸炎)。

【病因病机】

腮腺炎病毒通过患者的飞沫传染,首先侵犯腮腺,以后随血液循环,可使其它腺体及中枢神经系统也受累。中医认为,时行毒气夹风热之邪侵袭阳明、少阳经脉,邪毒痰火壅滞颊腮而发病,足少阳与足厥阴互为表里,厥阴经脉环绕阴器,少阳移热厥阴,则睾丸肿痛。

【临床表现】

本病潜伏期约 2 周,多数患者无前驱症状,首先发现一侧或双侧耳下颊腮漫肿酸痛,咀嚼困难,吃酸性食物或咀嚼时局部疼痛加重,部分患者有发热恶寒,头痛呕吐,食欲不振,全身乏力。少数患儿可并发睾丸炎、卵巢炎、脑膜炎。

【辨证施灸】

腮部硬肿，咀嚼困难，或伴发热恶寒，苔黄脉滑数，若温毒炽盛，可并发睾丸肿痛，亦可出现壮热、惊厥、神昏等。

治则 疏风散热，清热解毒。取少阳、阳明经穴为主。

取穴 翳风、角孙、颊车、曲池、合谷、外关。

方义 翳风、颊车宣通局部壅滞的气血，散邪解毒，消肿止痛；角孙、曲池宣通少阳、阳明气机，疏风泄热，解毒消肿；外关、合谷疏风解表，清热解毒。高热加大椎；并发睾丸炎加血海、曲泉。

灸法

(1) 艾炷隔蒜(或仙人掌)灸：每穴灸 5~10 壮，每日 1 次。

(2) 艾条温和(或雀啄)灸：每穴灸 5~10 分钟，每日 2 次。

(3) 灯火(或火柴)灼灸：①在同侧角孙或光彩穴(耳尖直上 0.2 寸，向前 0.1 寸处)灼灸 1 下，也可灼对侧阳溪穴。②在同侧颊车、曲池、外关、合谷穴各灼灸 1 下，每日 1 次。一般 1~2 次即可消肿。

(4) 大蒜敷灸：取去皮大蒜适量，捣烂用醋调成糊状敷灸患处，每日换 1~2 次。

(5) 青黛敷灸：①取青黛 6 克，皮硝 3 克，用鸭蛋清或水调，敷灸患处，每日 1 次。②取青黛、活蚯蚓、鲜侧柏叶各等份，共捣烂，加梅片(或薄荷末)少许，拌匀敷灸患处，每日 1 次。

(6) 蒲公英敷灸：取鲜蒲公英洗净捣烂加醋调敷灸患处，干后换新药，每日数次，连敷 3~4 日。

(7) 仙人掌敷灸：取仙人掌 1 块(去皮刺)对半剖开或捣烂敷灸患处，每日 1 次。

(8) 黄柏石膏敷灸:取黄柏末 9 克,生石膏粉 6 克,用醋调成糊状,敷灸患处,每日 1 次。

(9) 复方大黄敷灸:①取大黄 60 克,白及、赤小豆各 30 克,共研细末,用米醋煮沸,调成糊状敷灸患处。②取大黄、连翘各等份,共研细末,用黄酒调,敷灸患处。③取大黄、胆星各 3 克,吴萸 4.5 克,共研细末,用醋调成糊状敷灸涌泉,包扎固定,24 小时换药 1 次,连用 3~4 日。

按:艾灸治疗腮腺炎有较好的消肿止痛作用,疗程短,痛苦少。

百日咳

百日咳中医称“顿咳”、“鹭鸶咳”、“疫咳”等,是感染百日咳杆菌引起的一种呼吸道传染病。以阵发性痉挛性咳嗽,咳后伴有鸡鸣样吸气吼声为特征。因病程可达 2~3 个月之久,故称百日咳。多发于冬春两季,以 5 岁以下儿童发病较多,发病后可获持久免疫力。

【病因病机】

百日咳是感染百日咳杆菌引起。中医认为,先天禀赋不足,后天调养失宜,肺脾气虚,伏痰内蕴,复感时行疫毒,自口鼻侵犯肺卫,内外相引,痰浊阻滞,肺失宣肃,胃失和降,气逆痰涌,痉咳阵作。

【临床表现】

本病初起类似感冒,但舌下两侧可见“重舌样”肿起,随后咳嗽逐渐加重进入痉咳期,咳嗽呈阵发性痉挛样,夜间尤甚,服镇咳药无效。发作时连续短促阵咳,涕泪俱下,面红耳赤,颈静脉怒张,弓背弯腰。咳后吸气急速深长,声门痉挛,发出鸡鸣样哮吼吸气声。如此反复发作,直至吐出大量粘液及吐出胃内

异物后才能暂时停止。每日发作数次、数十次不等，一般夜间较多。剧咳可引起舌系带溃疡、眼睑水肿、球结膜出血、鼻出血等。严重者可引起百日咳脑病，出现惊厥。发病年龄越小，病情越严重，乳儿症状多不典型，常表现为阵发性憋气而面唇紫绀及窒息。恢复期痉咳逐渐消退，哮喘样吸气声消失，咳嗽无力，不伴呕吐。

【辨证施灸】

1. 初咳期 类似感冒，咳嗽夜剧，发热恶寒，喷嚏流涕。偏风寒者，咳声重浊，痰稀白，畏寒无汗，苔白，脉浮；偏风热者，发热汗出，咽红痛，痰黄，苔薄黄，脉浮数，指纹浮露而紫。

治则 宣肺化痰止咳。

取穴 大椎、风门、肺俞、列缺、合谷。

方义 大椎解表清热；风门、肺俞疏表肃肺；列缺、合谷解表清热，化痰止咳。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：在大椎、风门、肺俞穴各灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 温针灸：在列缺、合谷穴，采用泻法，各灸 1 壮（或 5 分钟），每日 1 次。

(3) 刺络拔罐疗法：用三棱针点刺大椎、风门、肺俞穴后，闪火拔罐，每穴放血 1 毫升~2 毫升。

2. 痉咳期 痉挛性咳嗽间歇发作，日轻夜重，反复发作，咳时面红憋气，涕泪俱出，引颈伸舌，颈脉怒张，弯腰弓背，咳出或呕吐大量痰液后才能暂时缓解，咳甚则大小便失禁，眼睑水肿，球结膜充血，鼻出血或咯血，便秘尿赤，舌红苔黄腻，脉数有力，指纹紫绀至气关。

治则 清热化痰，降逆镇咳。

取穴 大椎、身柱、尺泽、丰隆。

方义 大椎通阳泻热；身柱理气降逆平喘；尺泽止咳止血；丰隆豁痰降逆。

灸法

(1) 艾炷(或隔姜)灸：每穴灸1~3壮，每日1~2次。若点刺出血后再隔蒜灸，效果更好。

(2) 艾条温和灸：每穴灸5分钟，每日2~3次。

(3) 温针灸：针后不留针，于身柱穴施隔姜灸，每日1次。

(4) 麻黄敷灸：取麻黄末1.5克，面粉10克，用甜酒调成糊状，敷灸第三胸椎处，每日1次。

(5) 阿魏敷灸：取阿魏少许，研细置膏药中央，敷灸天突穴，每日1次。

(6) 五倍子敷灸：取五倍子末适量，水调成糊状，敷灸神阙穴，每日1次。

(7) 大蒜敷灸：取大蒜适量捣烂，每晚睡前先在涌泉穴上涂一薄层猪油或凡士林后，用大蒜泥敷灸穴位上，包扎固定，次晨除去。

(8) 威灵仙叶敷灸：取威灵仙嫩叶适量捣烂，加少量红糖拌匀，敷灸身柱穴，每日1次。

3. 恢复期 顿咳渐减，哮鸣样吼声渐消，咳嗽声低无力，痰量减少或干咳，形体虚弱，神疲体倦，面色少华，食少便溏，苔薄，脉沉细弱。

治则 健中扶正，温养肺脾。

取穴 肺俞、脾俞、太渊、足三里、太白。

方义 肺俞、脾俞益气健脾，合足三里健中培土生金；太渊、太白补益肺脾。

灸法

(1) 艾炷灸：每穴灸 3~5 壮，灸至皮肤局部温热红润为度，灸毕用手按压穴上片刻，每日 1 次。

(2) 艾条温和灸：每穴 5 分钟，每日 1~2 次。

小儿腹泻

小儿腹泻是指大便次数增多，粪便稀薄或完谷不化，或如水样为主要表现的胃肠道疾病。以 2 岁以下婴幼儿，夏秋季节多见，年龄越小发病率愈高，多发生于人工喂养婴儿。包括西医的消化不良，急、慢性肠炎等疾病。

【病因病机】

小儿腹泻多因饮食不节，喂养不当，或感受寒湿暑热等外邪，损伤脾胃，引起运化功能失常，清浊不分，并走大肠而发生腹泻。此外，小儿受惊后亦引起腹泻。西医把小儿腹泻概括为感染性和非感染性两类。各种病原体，如细菌、病毒、真菌随饮食进入体内，引起胃肠道感染而腹泻；饮食物的质或量不当、环境温度剧变、食物过敏、药物反应等亦可引起腹泻。在这些因素中，尤以细菌感染，特别是致病性大肠杆菌及病毒感染最为常见。腹泻可引起水和电解质丢失，严重时可导致水、电解质和酸碱代谢紊乱，循环障碍及肾功能紊乱等危重证候。

【临床表现】

临床症状可因腹泻轻重而异，轻者表现为大便次数增多，每日数次至十余次，大便呈黄色或黄绿色，稀糊状或蛋花汤样，混有少量粘液及奶块、味酸，伴呕吐溢乳，食欲减退，无脱水症状；重者腹泻急骤，或由腹泻轻症逐渐变成严重腹泻，大便每天十数次或数十次，水样便且量多，或呕吐频繁，小便短少，可有不规则热或高热，中度以上脱水或代谢性酸中毒。如腹泻迁延不愈，可表现为精神萎靡，食欲低下，消瘦贫血，水

肿,可继发呼吸道、泌尿道、皮肤等感染。

【辨证施灸】

临床辨证可分为风寒泻、湿热泻、伤食泻、脾虚泻、脾肾阳虚泻等证型。艾灸疗法适用于寒泻及虚泻。风寒泄泻:便稀泡沫多,兼恶寒发热等表证;脾虚泄泻:腹泻久延,时泻时止,腹胀便溏或完谷不化,面色萎黄,形瘦神疲,四肢不温,舌淡苔薄,脉虚弱;脾肾阳虚泄泻:久泻不止或五更泄泻,便溏或完谷不化,面目虚浮,畏寒肢冷,面色苍白,舌淡苔薄,脉沉细。

治则 新病急暴宜治标,久病缓泻应理本。寒泻者宜散寒解表和中;脾虚泄泻宜健中止泻;脾肾阳虚宜温补脾肾,补火生土。

取穴 大肠俞、中脘、天枢、神阙、足三里、上巨虚。

方义 大肠俞、上巨虚清泄大肠湿热;中脘、天枢调理胃肠;神阙温阳健脾;足三里健脾补土止泻。表邪未解加大椎、合谷;伤食加建里、四缝;湿热加曲池、阴陵泉;脾虚加脾俞、胃俞、三阴交;肾虚加肾俞、命门、关元、气海。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,每日1次。

(2) 艾炷隔盐灸:用食盐填满脐窝,灸3~5壮,每日1次。

(3) 艾条回旋灸:每次选3~5穴,各灸5分钟,每日1次,以局部皮肤温热潮红为度,不可过灸。

(4) 温针灸:每次选2~3穴,各灸5分钟,每日1次。

(5) 食盐熨灸:取食盐250克,炒烫布包熨灸肾俞、命门穴及脐腹部,每日1次。

(6) 生姜敷灸:寒泻取生姜1大片,敷灸脐部,每日1次。

(7) 大蒜敷灸：寒泻取大蒜(或加炮姜粉 3 克)适量，煨热捣烂，趁热敷灸脐部，每日 1 次。

(8) 石榴皮敷灸：取鲜石榴皮 30 克，捣烂敷灸脐部，每日 1 次。

(9) 酒糟敷灸：新生儿腹泻，取酒糟 1 杯，食盐少许，共炒热，布包敷灸脐部，注意温度适宜，防止烫伤，每日 1 次。

(10) 复方车前子敷灸：脾虚泄泻，取车前子 3 份，肉桂 2 份，丁香 1 份，共研细末，每次取 2 克纳脐中，以胶布固定，2 日换 1 次，一般 1 次即可有效。

(11) 苦参木香敷灸：取苦参、木香各等份，共研细末，每次取 2 克，用温开水或淡盐水调成膏状敷灸脐中，包扎固定，24 小时换 1 次。

(12) 白胡椒敷灸：寒泻、伤食泻、久泻，取白胡椒末(或加白芷末少许)纳满脐窝，以胶布固定，用手按脐部 5 分钟，2~3 日更换 1 次。

(13) 丁香散敷灸：取丁香、肉桂各等份，共研细末，取药末填满脐窝，胶布固定，2~3 日换 1 次。

(14) 复方五倍子敷灸：①虚寒泄泻，取五倍子、五味子各等份，共研细末，用温开水调成糊状，敷灸神阙穴，每日 1 次，一般 1~3 次即可止泻。②小儿秋季腹泻，取五倍子 12 克，肉桂 9 克，冰片 6 克，共研细末，用温开水调成糊状敷灸脐部，每日 1 次。③脾虚泄泻，取五倍子、公丁香、木香、吴茱萸、干姜、川椒各等份，共研细末，用酒调成糊状敷灸脐部，每日 1 次。

(15) 附子敷灸：①虚寒腹泻，取附子 15 克，炮姜 30 克，共研细末，每次取 2 克纳脐孔，然后再取盐、葱各适量，炒烫布包熨灸脐腹，每日 1 次。②久泻取盐附子适量，捣烂加肉桂末少许调匀，敷灸手、足心，包扎固定，以感肢暖为度，每日 1 次。

(16) 复方吴萸敷灸:①取吴萸 9 克,丁香、胡椒各 6 克,共研细末,麻油或陈醋调,敷灸脐部,每日 1 次。②取吴萸、公丁香、灵磁石、白芥子各等份,共研细末,加麝香、冰片各少许,蒸饼糊丸如绿豆大小,把药丸放小胶布中央,敷灸中脘、天枢、关元穴,3 日更换 1 次。③取吴萸、砂仁、炒艾叶、肉豆蔻霜各 6 克,炮姜 3 克,共研细末,醋调成糊状,敷灸脐部,每日 1 次。

(17) 复方苍术敷灸:①取苍术、胡椒各 30 克,砂仁、公丁香各 10 克,吴萸、肉桂各 5 克,共研细末,每次取 2 克,用热醋调敷灸脐部,以纱布覆盖固定,再用热水袋保温,每次 6 小时。②取土炒苍术、土炒白术、茯苓各 15 克,吴萸、陈皮各 10 克,草果 5 克,丁香、泽泻各 3 克,白胡椒 2 克,共研细末,每次取药末 5 克,用温热水调匀敷灸脐部,包扎固定,24 小时取下。

(18) 枯矾敷灸:小儿久泻不止,取枯矾末 30 克,面粉适量,用醋调成糊状,敷灸脐部,胶布固定,每日换药 1~2 次。

小儿厌食

小儿厌食又称“恶食”,是指小儿不因疾病而较长时间食欲不振或减退,甚至拒食的一种病证。以往认为厌食不是一个独立疾病,而是发生在其它疾病中的一个症状,但近年来随着以厌食为主诉而经检查未发现其它疾病的患儿日益增多,故列为专篇讨论。厌食多见于学龄前儿童,以城市儿童为主。与西医的“精神厌食”相似。

【病因病机】

厌食与不良的饮食习惯、微量元素缺乏及精神因素有关。平素饮食不节,喂养不当,追求高营养,或长期偏食、零食过多等损伤脾胃,使脾胃不和,受纳运化失职,不能正常熟腐水谷,胃不思纳而厌食,或病后脾胃虚弱,虫积痰滞使胃气受伤而厌

食。此外，小儿进食时挨打受气，情绪低落，亦可致脾胃不和而厌食。

【临床表现】

纳呆厌食而无其它急、慢性疾病影响，严重拒食者，可见消瘦疲乏，面色萎黄，毛发不泽；病程长者，可并发中度以上贫血、营养不良、佝偻病、抗病力下降而反复感染，甚至影响生长发育、智力低下。

【辨证施灸】

厌食有虚实，实者多见乳食，痰湿阻滞，腹痛拒按，呕吐乳食痰涎，大便臭秽，苔腻；虚者多见脾胃虚弱或胃阴不足，消瘦神疲，面色萎黄，毛发干枯，便溏或干，舌淡或红，苔薄。

治则 健脾和胃，燥湿化痰，消食导滞。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、梁门、足三里、公孙。

方义 脾俞、胃俞、中脘、梁门和胃益气，消食化滞；足三里、公孙健脾理气，化湿消食。

灸法

(1) 艾条温和灸：每穴灸 5~10 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(2) 复方焦三仙敷灸：①取焦山楂、焦神曲、焦麦芽、炒莱菔子、鸡内金各等份，共研细末，用温水调成糊状，每晚临睡前敷灸腹部，次晨除去，5 次为 1 个疗程。②食滞厌食，取焦山楂、焦神曲、焦麦芽、白豆蔻各 4 克，高良姜、陈皮各 5 克，大黄、白丑各 6 克，共研细末，用麻油调成膏状，取适量敷灸脐窝，胶布固定，每晚 1 次，10 次为 1 个疗程，连敷 3~5 个疗程。敷灸后少数患儿有轻度腹泻或短暂轻微腹痛现象，属药物正常反应，一般不必治疗。

疳 积

疳积是指小儿食欲不振而面黄肌瘦,毛发干枯,头大颈细,肚腹胀大,青筋暴露,皮肤皱瘪,貌似老人,大便不调等症状而言。古籍中名目繁多,现以“疳证”、“疳积”统之。多发生于3岁左右小儿,属营养障碍的慢性虚损性疾病。可见于西医的单纯性、中毒性消化不良,婴幼儿腹泻等所引起的营养不良,各种维生素、微量元素缺乏症等婴幼儿消化系统疾病。

【病因病机】

凡先天禀赋或后天母乳不足,断乳过早及喂养不当,长期饮食失调,积食化热,或长期腹泻,病后失于调养,虫积及药物误投等因素导致脾胃损伤,运化失调,积浊内停,消化吸收功能长期障碍,气血生化不足,不能濡养脏腑肌肉,营养物质不能满足小儿发育需求,渐至形体羸瘦,终成疳证。西医认为营养不良是由于小儿摄入食物绝对量不足,或食物营养不能吸收利用及消耗增加,以致皮下脂肪减少,肌肉消瘦,体重不增,生长发育停滞,甚至并发其它营养缺乏性或感染性疾病。

【临床表现】

根据病情轻重不同,临床把营养不良分为三度,Ⅰ度为患儿体重<正常体重10%~25%,表现为腹部脂肪变薄;Ⅱ度<25%~40%,臀部脂肪也明显变薄;Ⅲ度<40%以上,除腹部脂肪外,面部和臀部脂肪均接近消失。这时患儿全身羸瘦,体温低下,活动减少,精神萎靡,食欲减退,容易并发全身感染。严重腹泻,出现脱水、酸中毒及各种维生素缺乏症等严重后果。

【辨证施灸】

1. 食滞伤脾(疳气) 患儿体重不增或减轻,形体瘦弱,

面色不泽,毛发稀疏,食欲不振或厌食,精神欠佳,性情急躁,好发脾气,夜寐不安,齲齿,头汗多,便溏或秘,苔薄黄,脉弦细,指纹淡滞。

治则 健脾和胃,消食导滞。

取穴 脾俞、胃俞、中脘、天枢、足三里。

方义 脾俞、胃俞健脾化湿,理气和胃;中脘、足三里健脾益胃,化湿降逆,消食导滞;天枢通导大肠积滞。

灸法

(1) 艾炷灸:每穴灸 3~5 壮,每日 1 次。

(2) 艾条温和灸:每穴灸 5~10 分钟,每日 1 次。

(3) 艾炷隔吴萸丁香苏叶灸:取吴萸、丁香、苏叶各等份,共研细末,加冰片少许调匀,取药末适量平铺于穴位上,施艾炷麦粒灸,每穴 3~5 壮,每日 1 次。

(4) 复方梔子敷灸:各种疳证取梔子、皮硝各 9 克,杏仁 12 克,酒糟、白飞罗面各 15 克,葱头 6 克,红枣 30 克,共捣烂,敷灸脐部,每日 1 次。

(5) 蓖麻子敷灸:取蓖麻子 2 粒,杏仁 1 粒,朱砂少许,共捣烂,敷灸印堂穴,每日 1 次。

(6) 巴豆敷灸:取巴豆 1 粒,甜瓜子 7 粒,朱砂 1.5 克,共研细末,用麻油调成糊状,敷灸印堂穴,每日 1 次。

(7) 复方桃仁敷灸:取桃仁、杏仁、山梔各等份,共研细末,加冰片、樟脑各少许调匀,用鸡蛋清调成糊状,敷灸神阙、内关,24 小时除去。

(8) 复方槟榔敷灸:疳积食滞腹痛取槟榔 12 克,枳实、莱菔子各 10 克,共研细末,用醋调成糊状,敷灸脐腹部,每日 1 次。

(9) 复方吴萸敷灸:取吴萸、五倍子、公丁香、灵磁石各等

份，广木香、冰片各少许，共研细末，用麻油调成膏状，敷灸中脘、关元、足三里穴，包扎固定，每日1次。

(10) 苍术荞麦粉敷灸：小儿消化不良取苍术末30克，荞麦粉60克，用米醋调炒热，制成5分硬币大小药饼，敷灸神阙穴，胶布固定，2~3日更换1次。

2. 脾虚夹积(疳证) 形体明显消瘦，腹大脐突，青筋暴露，面色无华或苍白，面容憔悴，目无光彩，毛发干枯，稀黄结穗，精神不振，困倦嗜睡，懒动少语或睡眠不安，烦躁夜啼，哭声不扬，腹痛，纳呆厌食或不知饥饱，多食多便，便溏溲清，舌淡苔薄腻，脉沉缓，指纹紫滞。

治则 健脾化积消痞。

取穴 膏肓俞、脾俞、胃俞、章门、中脘、关元、公孙、足三里、四缝。

方义 膏肓俞、关元补肺健脾，益肾培元，扶正化积；脾俞、胃俞、章门、足三里健脾益气，疏肝化滞利湿；公孙健脾和胃，理气化湿，合中脘、足三里消积导滞；四缝为治疳经验穴。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选2~3穴，各灸3~5壮，每日1次。

(2) 白矾敷灸：取白矾末30克，陈醋调敷灸涌泉穴，每晚1次。

(3) 阿魏敷灸：取阿魏10克，杏仁7粒，蜈蚣(去头足)1条，连须葱白3根，共捣烂敷灸脐部，每日1次。

(4) 半夏香附敷灸：取生半夏、香附各等份，共研细末，用鸡蛋清调，敷灸涌泉穴，包扎固定，每晚1次。

(5) 复方木香敷灸：取木香、陈皮、莱菔子各12克，三棱、莪术、槟榔各10克，姜黄3克，共研细末，用麻油调成膏状，敷灸中脘穴，每日1次。

(6)芒硝敷灸：①取皮硝 60 克，用纱布包裹敷灸脐部，包扎固定，每日 1 次。②取芒硝 18 克，炒莱菔子 10 克，共研细末，用纱布包裹，敷灸中脘穴，每日 1 次。③取芒硝 30 克，生山楂、生栀子、桃仁、大枣(去核)各 7 枚，葱头 9 茎，共捣烂，加面粉适量，用酒调制成饼敷灸脐部，包扎固定，每日 1 次。④虫积疳证取芒硝、栀子各 6 克，杏仁 10 克，使君子肉 7 粒，甜酒曲 1 个，共研细末，用浓茶水调成糊状，每晚睡前敷灸脐部，包扎固定，次晨除去，连敷三晚。

(7)复方石膏敷灸：虫积疳证取石膏 30 克，党参、白术各 10 克，当归、三棱、莪术、山栀、黑白丑、龙胆草各 9 克，胡黄连、大黄、槟榔、木香、陈皮各 6 克，巴豆、雄黄各 3 克，共研细末，蜂蜜调成膏状敷灸脐部，每日 1 次。

(8)复方使君子敷灸：虫积疳证取使君子 30 克，黄芪、生麦芽各 15 克，白术、茺莢各 12 克，厚朴、槟榔各 9 克，胡黄连 6 克，共研细末，醋调敷灸脐部，每日 1 次。

3. 气血亏耗(疳干) 极度消瘦，大骨枯槁，大肉陷下，形瘦骨立，头大颈细，骨瘦如柴，面部呈老人貌，皮肤干瘪起皱，精神萎靡，啼哭无力，毛发干枯，嗜卧露睛，腹凹如舟，不思饮食，大便稀溏或秘结，时有低热，口唇干燥，舌红无苔，脉沉细涩，指纹紫绀，甚则全身出现紫斑，突然暴脱。

治则 培补脾胃，补益气血，回阳固脱。灸法可作辅助治疗。

取穴 脾俞、胃俞、章门、神阙、关元、长强。

方义 脾俞、胃俞、神阙补益脾胃，调气暖中；章门疏肝理脾，化湿消滞；关元温肾壮阳，壮火暖土；长强回阳固脱。

灸法

(1)艾炷灸：每次选 2～3 穴，各灸 5～10 分钟，每日 1

次。

(2) 艾炷隔盐灸：用食盐填满脐窝，灸 20～30 壮，每日 1 次。

小儿遗尿

小儿遗尿是指 3 岁以上儿童夜间不能控制排尿，在睡眠中小便自遗，醒后方知的一种病证，又称“遗溺”，俗称“尿床”。多见于 10 岁以下儿童，少数可延长到 12～18 岁，偶见于成年人，学龄前儿童的发病率为 5%～12%，男孩较女孩多见。

【病因病机】

尿液的正常排泄，主要与肾和膀胱的开合有关，肾司固藏，主气化，膀胱有贮藏和排泄尿液的作用，若先天不足，下元虚冷，肾气不能固摄，每至膀胱约束无权，开阖失度；或肺脾气虚，上虚不能制下，水液下输失常，均能发生遗尿。此外，下焦湿热，扰动膀胱，气化失常亦致遗尿。现代医学认为，正常排尿活动需在大脑皮质和皮质下等排尿中枢及膀胱功能完善的前提下才能完成。绝大多数小儿遗尿与大脑皮质及皮质下排尿中枢功能失调，或尚未建立起排尿反射，功能发育尚不成熟（如膀胱肌肉控制排尿功能差，膀胱容量较小）有关，属功能性。常见原因有受惊紧张、过度疲劳、初换环境、不正确教养习惯、睡眠过深不易觉醒、病后体虚等精神及体质因素；部分患儿有遗传因素影响。少数患儿可因泌尿生殖系统畸形、隐性脊柱裂、大脑发育不良等器质性疾病引起。

【临床表现】

睡眠中遗尿，轻者隔日或数日 1 次；重者每夜遗尿，甚或每夜数次。遗尿时间多数在半夜或清晨，遗尿后患儿能继续入睡，病程可长达 10 多年，也有极少数延至成人。

【辨证施灸】

肾阳虚者，遗尿量多，每夜1次或数次，呼之不易醒，兼见面色苍白，小便清长而频数，形寒肢冷，舌淡，脉沉细无力；脾肺气虚者，多发生于病后或体弱者，遗尿量少而次数多，兼见神疲体倦，纳呆便溏，面色萎黄或淡白无华，舌淡，脉缓或弱。

治则 温补脾肾，益气固脬。艾灸疗法只适用于功能性遗尿。

取穴 百会、命门、脾俞、肾俞、膀胱俞、次髎、气海、关元、中极、神门、足三里、三阴交、太溪。

方义 百会升气益阳；命门、肾俞、脾俞、气海、关元培补先后天之本，温阳益气，固摄；膀胱俞、中极益气固脬，约束膀胱；次髎为治遗尿经验穴；神门、太溪交通心肾；足三里、三阴交健脾益气止遗。

灸法

(1) 艾炷(或隔姜、隔蒜)灸：每次选3~5穴，各灸3~5壮，每日1次，7次为1个疗程。

(2) 艾条温和灸：每次选3~5穴，各灸5~10分钟，每日1次，7次为1个疗程。

(3) 温盒灸：在命门、关元穴各灸15~20分钟，每日1次。

(4) 温针灸：每次选2~4穴，各灸1壮(或5分钟)，隔日1次。

(5) 热吹疗法：用热吹器吹关元、中极、三阴交穴，每穴10分钟，每日1次。

(6) 补骨脂敷灸：取补骨脂末0.3克，纳脐中，包扎固定，2日更换1次。

(7) 雄黄敷灸：取雄黄(或硫黄)30克，大葱2根，共捣烂，

每晚临睡前敷灸脐部，次晨取下，共用 2~3 次。

(8) 丁香敷灸：取丁香 3 粒，研细末，米饭调制成饼敷灸脐部，每晚 1 次。

(9) 复方五倍子敷灸：取五倍子、首乌各等份；或五倍子 6 克，五味子 3 克，菟丝子 9 克。任选 1 方，共研细末，用醋调，敷灸脐部，包扎固定，每晚 1 次，连敷灸 3~5 次可控制遗尿。

(10) 复方麻黄敷灸：①取麻黄 6 克，肉桂、益智仁各 3 克，共研细末，每次取药末 3 克，用食醋制饼敷灸脐部，包扎固定，36 小时后取下，隔 12 小时后再敷灸，连用 3 次后，每周 1 次，连用 2 周。②取麻黄、桂枝、乳香、没药、雄黄、蟾酥各 5 克，麝香 3 克，共研细末，用酒精调成糊状，敷灸内关、气海、中极、三阴交、肾俞、膀胱俞、复溜等穴，3~4 日换药 1 次。

按：预防小儿遗尿的发生，应从幼儿期开始，培养其按时排尿及有规律的生活习惯，勿使其过度疲劳，避免受惊吓刺激。对已患遗尿的小儿不要羞辱、斥责和惩罚，解除患儿精神负担和引起情绪不安的因素。晚餐少喝水，临睡前嘱患儿排空小便，夜里定时叫醒患儿排尿。同时应解除引起遗尿的因素，积极防治引起遗尿的原发病。经常在百会、命门、气海、关元、三阴交穴施艾炷灸或艾条温和灸，亦有预防遗尿的作用。

鹅口疮

鹅口疮，又称“口疮”、“口疳”、“口糜”、“雪口”等，是初生儿、体弱婴幼儿最常见的一种口腔疾病。因为小儿口腔舌上满布白屑，状如鹅口故名。西医亦称鹅口疮，即小儿口腔炎。

【病因病机】

鹅口疮的病因是由先天胎热内留，或口腔不洁，感染秽毒之邪所致。与孕妇过食辛辣炙煿，胎热内蕴，遗患胎儿，心脾积

热有关。因舌为心之苗，口为脾之窍，脾脉络于舌，故鹅口疮的发病与心脾有关。小儿出生后，心脾之热循经上炎，熏灼口舌而致病。此外，亦有因先天禀赋不足，后天失调，或久病久泻之后，肾阴亏虚，虚火上浮而致病者。西医认为，病因是由于口腔不洁，感染单纯疱疹病毒或白色念珠菌所致。

【临床表现】

口腔舌上或两颊内侧出现白屑，渐次蔓延于牙龈、口唇、软腭等处，白屑状如凝乳，略为突起不易清除。轻者除口腔舌上出现白屑外，无其它症状；重者白屑可蔓延至鼻道、咽喉、食管等处，并伴吞咽困难及呼吸不畅等症状。

【辨证施灸】

临床以心脾积热引起者较多，症见口舌白屑堆积，周围红晕焮痛，伴发热，面赤唇红，烦躁哭扰，流涎，口臭，拒食，大便干结，小便短赤，脉滑；若为虚火上浮引起，则白屑稀散较淡，周围红晕不著，面白颧红，形瘦神疲，食欲不振，便溏溲清，舌红，脉细数。艾灸疗法多用于心脾积热者。

治则 清心健脾利湿。

取穴 地仓、合谷、劳宫、足三里、三阴交、涌泉。

方义 地仓疏调局部经气；合谷疏调阳明经气，祛风散邪；劳宫清心凉血泄热；足三里调脾胃清泄心脾积热；三阴交滋阴清热；涌泉滋肾清热，引热下行。

灸法

(1) 艾条温和(或雀啄)灸：每次选 2~3 穴，各灸 5~10 分钟，每日 1~2 次。

(2) 南星敷灸：取南星 1 个，去皮研末，用米醋调成糊状敷灸足心，包扎固定，3 日后除去。

(3) 五倍子敷灸：取五倍子 30 克，炒黄后入白糖 2 克，再

炒至糖完全溶化,取出晾干,加枯矾 20 克,共研细末,用香油调成糊状涂敷患处,每日 2~3 次。

(4) 细辛敷灸:取细辛末 3 克,纳满脐窝,包扎固定,每日 1 次,一般 1~2 次见效。

(5) 吴萸敷灸:①取吴萸末 10 克,用鸡蛋清(或醋)调成糊膏状,敷灸双涌泉穴,包扎固定,每日 1 次。②取吴萸 3 克,黄连 5 克,共研细末,用米醋调成稠糊状,每晚敷灸涌泉穴,次晨除去。

(6) 大黄硝矾敷灸:取大黄、硝石、白矾各等量,共研细末,加面粉少许,用醋调成膏状,取药膏敷灸神阙及足心涌泉穴,胶布固定,每日 1 次,3~4 次可见效。

四、外科疾病

疔 病

疔是一种发生于皮肤浅表的急性化脓性疾病。好发于夏暑季节,以小儿及青壮年多见,随处可生,但以头面、项背及臀部等部位多见。多发或反复发作,此愈彼起,且经久不愈者称为疔病,发于项后发际处者称“发际疮”,生于臀部者称“坐板疮”。

【病因病机】

疔病的发生主要是火毒之邪为患。恣食高粱厚味,辛辣炙煨,脏腑内郁蕴热,火毒结聚,复感风邪热毒,内外相引,蕴阻皮肤;或禀赋不耐,感受沥青、日光热毒,结聚肌肤,或抓破染毒,蕴郁肌肤,以至气血凝滞引起。亦有因患糖尿病、肾病、贫血、习惯性便秘、长期服用激素类药物等导致阴虚内热,易于

染毒而发病。西医认为,疖病是化脓球菌(金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌)感染毛囊及毛囊周围组织的化脓性炎症,皮肤不洁、皮脂溢出也是重要的诱发因素。

【临床表现】

疖好发于项背、臀等部位或泛发全身,少则几个、十几个,多则数十个,初起为圆形红色小丘疹,逐渐增大形成坚硬结节,红肿热痛,小结节逐渐肿大,呈锥形隆起,数日化脓,出现黄白色小脓头,溃后脓栓脱落,排出脓液,肿痛渐消而愈。但此愈彼起,或疖肿在某一部位反复发作,缠绵经年不愈。轻者无全身症状,重者可伴发热,全身不适,附近淋巴结肿大压痛。

【辨证施灸】

疖由湿火风邪相搏引起者,多发生在项、背、臀等部位。常在原发病灶附近继续延生,缠绵不休。伴便秘尿黄,苔薄黄,脉滑数;感受沥青毒引起者,多发生在暴露部位,疖肿成块,常呈脓肿形,触之较硬,压痛明显;由阴虚内热染毒而生者,散发全身,易发展成痈。伴口渴唇燥,消谷善饥,尿多,舌红苔薄,脉细数等全身症状。

治则 祛风清热,利湿解毒。

取穴 局部阿是穴、曲池下2寸、尺骨小头后缘。

方义 阿是穴疏通局部气血。曲池下2寸、尺骨小头后缘为治疗疖病经验穴。

灸法

(1) 艾炷麦粒灸:毛囊炎,在手三里、养老穴各灸至局部灼热为度,每日1次,连灸3日。

(2) 艾炷隔附子片(或豉药饼)灸:疖病初起或久溃不愈,在患处隔附子片灸2~3壮,每日1次,1~3次可愈。

(3) 艾炷隔蜂房灸:取炒蜂房末适量,用黄酒调制成厚约

0.2 厘米小饼,各灸 3~5 壮,隔日 1 次。

(4) 艾炷隔蒜灸:慢性毛囊炎,在患处隔蒜片灸 10 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。轻者 1 个疗程,重者 2~3 个疗程即愈。

(5) 艾条温和灸:在曲池下 2 寸及尺骨小头后缘各灸 5~10 分钟,每日 1 次。

(6) 火针:①疖肿初起用细火针从疖顶尖点刺到根部,对疖肿范围大者,再从左右向中央斜刺 2 针,速进疾出,出针后令其出血适量,大多数 1 次即愈。不愈可施行第二次。②疖肿成脓未溃,用火针从疖肿下部或顶端快速刺入脓腔,速进疾出,立即闪火拔罐吸出脓液。

(7) 芙蓉叶敷灸:疖肿初起,取芙蓉叶末适量,用蜂蜜调,敷灸患处,每日 1 次。

(8) 蜈蚣草敷灸:疖肿初起,取鲜蜈蚣草适量,和蜜捣烂敷灸患处,每日 1 次。

(9) 复方五倍子敷灸:疖肿初起,取五倍子、野菊花、马齿苋各等份,共研细末,用蜂蜜调,敷灸患处,每日 1 次。

(10) 花粉川乌敷灸:疖肿初起,取花粉 2 份、生川乌 1 份,共研细末,用蜂蜜调,敷灸患处,每日 1 次。

(11) 藤黄皮硝敷灸:疖肿初起,取生藤黄 6 克,皮硝 10 克,共研细末,用开水调,敷灸患处,每日 1 次。

(12) 复方蜂房敷灸:疖肿初起,取蜂房 1 个,黄连、黄柏各 2 克,共研细末,茶油调,敷灸患处,每日 1 次。

(13) 复方大黄敷灸:①疖肿初起,取大黄、硫黄各 15 克,黄连 6 克,共研细末,香油调,敷灸患处,每日 1 次。②重症疖肿初期,取大黄、黄连、黄柏、芙蓉叶、泽兰叶各 25 克,冰片 0.6 克,共研细末,用凡士林调,敷灸患处,每日 1 次。

(14) 复方麻仁敷灸:疖肿溃后流脓不尽,取大麻仁、松

香、黄丹各等份，共捣烂，敷灸疮口，每日1次。

(15) 复方鱼腥草敷灸：疔肿溃后流脓不尽，取鱼腥草、犁头草、天胡荽各30克，共捣烂，敷灸患处，每日1次。

疔 疮

疔疮是指发病迅速而危险性较大的急性化脓性疾病。因其初起形小根深，根脚坚硬如钉，故名疔疮。随处可生，但好发于头面和手足等部位。古称繁多，现按其发病部位和性质的不同，分为颜面疔、手足疔、红丝疔、烂疔、疫疔5种。包括范围很广，西医的多种化脓性感染，如疖、痈、癰疽、坏疽的一部分，皮肤炭疽及急性淋巴管炎等疾病，均属疔疮范畴。

【病因病机】

疔疮的发生主要由火热毒邪引起。平素恣食高粱厚味，辛辣炙煨，导致脏腑蕴热，火毒结聚，复因感受火热之气、昆虫咬伤、抓破皮肤感染疫毒，热毒相搏，蕴蒸肌肤，流注经络，气血凝滞而成。

【辨证施灸】

初起疮头如粟粒，或痒或麻，继而红肿热痛，根深坚硬如钉，肿势逐渐增大，四周浸润明显，疼痛加剧。伴发热口渴，便干溲赤，苔黄或黄腻，脉弦滑数。待化脓排出脓栓后，肿消痛减而愈。发于头面的疔疮，若处理不当或热毒炽盛，内攻脏腑，容易发生“疔疮走黄”（脓毒血症或败血症），出现壮热烦躁，眩晕呕吐，神昏谵语而成危候；发生于手足的疔疮容易损伤筋骨影响患肢功能。

治则 清热解毒。多取手阳明经穴。

取穴 身柱、灵台、合谷、委中、阿是穴。

方义 灵台为治疗经验穴，配身柱疏泄阳明邪火郁热；合

谷泄阳明火毒；委中泄血中蕴热；阿是穴疏泄局部经气，清热解毒。脏腑郁热，火毒结聚者，加足三里、阳陵泉；感受火热疫毒，结聚肌肤者，加大椎、曲池、商阳。

灸法

(1) 艾炷隔蒜(或姜)灸：将蒜(或姜)片置患处，用艾炷灸3~10壮，每日1次。

(2) 艾条温和灸或香烟灸：将点燃的艾条或香烟对准初起的疔疮灸10~15分钟，热度以患者能耐受为度，每日1次。

(3) 灯火灼灸：颜面疔疮可在耳后肿大的淋巴结上或瘰脉穴施灯火灼灸1下，5日重复1次。

(4) 刺血熏灸：化脓性甲沟炎，局部清洁排脓后；无脓者先在红肿疼痛处点刺放血；嵌甲者剪除嵌入肉内的指(趾)甲，然后取艾绒60克放入熏灸器内，点燃以烟对准患处熏灸，每次20~30分钟，每日1次，治愈为止。

(5) 蜈蚣草敷灸：疔疮初起，取鲜蜈蚣草适量，和蜜捣烂，敷灸患处，每日1次。

(6) 五倍子敷灸：疔疮初起，取五倍子粉适量，用蜂蜜和原醋各半调成糊状，敷灸患处，每日1次。

(7) 复方花粉敷灸：疔疮未化脓，取花粉150克，大黄、黄柏、姜黄、白芷各75克，南星、苍术、厚朴、陈皮、甘草各30克，共研细末，用蜂蜜或麻油调成糊状，敷灸患处，每日1次。

(8) 复方大黄敷灸：颜面疔疮，取大黄、白芷、地龙、僵蚕、公丁香、金蝉脚、土鳖虫各6克，五谷虫4.5克，全蝎3克，共研细末，用冬蜜调成糊状，敷灸患处，每日1次。

(9) 复方蒲黄敷灸：口唇疔疮取生蒲黄6克，黄连、冰片各3克，共研细末，用麻油调，敷灸患处，每日1次。

(10) 吴萸雄黄敷灸：对口疔取吴萸30克，雄黄3克，共

研细末，用熟麻油调成糊状，敷灸患处，每日 1 次。

(11) 猪蹄甲明矾敷灸：肩疔取猪蹄甲 1 只，明矾 9 克，将明矾放入猪蹄甲内煅枯后，共研细末，用茶油调，敷灸患处，每日 1 次。

(12) 芙蓉叶敷灸：指疔初起，取芙蓉叶末适量，用蜂蜜（或醋）调成糊状包敷患指，每日 1 次。

(13) 蜈蚣雄黄敷灸：指疔初起，取蜈蚣 1 条，雄黄 6 克，共研细末，用鸡蛋清调，敷灸患指。如患指发热甚，可将调好的药物装入原蛋壳内，将患指插入蛋壳中，待药物发热后，抽出患指，待药冷后再插入。

(14) 泥鳅敷灸：指疔取泥鳅 1 条，鲜毛草龙叶 100 克，加红糖少许共捣烂，敷灸患指，每日 1 次。

(15) 半边莲雄黄敷灸：指疔取干半边莲末 3 克（鲜者加倍，捣烂），雄黄粉 0.6 克，另取鸡蛋清 1 个，与上药调匀，装入大塑料指套内，插入手指，每日数次。

按：疔疮属发病迅速，危险性较大的疮疡，灸法可作辅助治疗，运用得当，有消散止痛的作用。但因发于头面的疔疮易引起“走黄”（脓毒血症、败血症），发于手足的疔疮易损伤筋骨影响功能，故在采用灸疗的同时，还必须配合其它有效的疗法，以提高疗效，并禁服发散药物，忌食辛辣荤腥发物和挤压。

急性淋巴管炎

急性淋巴管炎是淋巴管的急性化脓性感染。中医称“红丝疔”。好发于四肢远端，皮肤上出现 1 条或数条红线，压痛并迅速向上走窜。

【病因病机】

本病多由溶血性链球菌或金黄色葡萄球菌，从破损的皮肤

肤或其它感染灶蔓延到局部引流区域的淋巴管引起。中医认为,红丝疔的病因是内有火毒凝聚,外有感染性病灶或皮肤破损感染毒邪,向上流窜经脉,气血凝滞而继发。

【辨证施灸】

浅表淋巴管炎,病变部位有1条或数条红线向肢体近心端延伸,红肿热痛,局部发硬压痛;深层淋巴管炎,皮色暗红,可触及条索状肿物并有压痛,但一般不出现红线,局部淋巴结肿大压痛。轻者红线较细,一般无全身症状;重者红线较粗,并伴发热恶寒,头痛乏力,食欲不振,苔黄,脉数,白细胞增高;严重者可发生脓毒血症或败血症。检查可发现患侧肢体有损伤或手足癣继发感染等病灶。

治则 清热解毒,凉血化瘀。一般取局部阿是穴为主。

取穴 曲池、合谷、梁丘、委中、三阴交、局部阿是穴。

方义 曲池、合谷清热解毒,合委中泄血中热毒;梁丘活血化瘀;三阴交清热凉血;阿是穴疏通局部经气,清热化瘀。

灸法

(1) 艾条温和灸:从红线的头向根部缓慢移动熏灸15~20分钟,然后每穴再灸5分钟,每日1次。

(2) 灯火灼灸:用灯心蘸麻油点燃,在红线尽头爆灼灸1下,可出现红线慢慢缩短,然后再在红线缩短处的头上爆灼灸1下,经过几次爆灼,红线可缩短至根部,最后在开始爆灼处再灼灸1次。

按:急性淋巴管炎轻症,用灸法治疗有明显的消炎止痛作用。病情较重者可配合其它疗法,或以外科治疗为主,配合灸疗。

急性乳腺炎

急性乳腺炎是乳房部的急性化脓性感染,中医称“乳痈”。绝大部分发生于产后哺乳期的妇女,尤以未满月(3~4周)的初产妇为多,称“外吹乳痈”,也偶见于孕期,称“内吹乳痈”,非哺乳期乳痈则极少见。

【病因病机】

急性乳腺炎的病因是乳汁淤积,细菌侵入引起。乳头破损、畸形、内陷,哺乳时疼痛,影响充分哺乳,或乳汁多哺乳少,或小儿热毒之气熏蒸,或外邪火毒侵入乳房,均可使乳汁淤滞,乳络不畅,乳管阻塞,败乳蓄积有利于细菌繁殖而成乳痈。中医认为,情志不畅,肝气郁结,厥阴肝经上行,经络阻塞,气滞血瘀,结于乳房而成痈。

【临床表现】

患乳排乳不畅,结块胀痛,腋下淋巴结肿大压痛。伴恶寒发热,白细胞增多。继而高热不退,乳房肿胀加重,局部出现持续性跳痛,脓肿形成。破溃后一般热退肿消而愈。如溃后脓出不畅,高热肿痛不减,病灶扩大,可波及其它乳叶;如溃脓后形成瘻管,往往长期不愈。

【辨证施灸】

1. 肝郁气滞(多属乳痈初起) 患乳排乳不畅,乳汁壅滞,结块胀痛,局部红肿不明显,全身不适,胸闷,烦躁易怒,食欲不振,或恶寒发热,头痛身楚,舌红苔薄,脉弦滑数。

治则 疏肝解郁,通乳泄热,消肿散结。

取穴 肩井、天池、期门、内关、行间、阿是穴。

方义 肩井通调诸经之气,为治乳痈经验穴;天池疏通厥阴经气,消散患处气血阻遏;期门疏肝调气,化痰消结,佐内

关、行间可宣泄厥阴壅滞，宽胸理气；局部阿是穴，清热散结，消肿止痛。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸：每次选患处或邻近经穴 2~4 个，各灸 5~7 壮，每日 1~2 次。

(2) 艾炷隔豆豉饼灸：将豆豉饼置患处，灸 5~7 壮，每日 1~2 次。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~15 分钟，或选用葱白捣烂铺患处，然后再用艾条熏灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(4) 葱白蒸气熏灸：乳痈早期未化脓者，取葱白（切碎）500 克，蒲公英末 60 克，牙皂末 15 克，共置锅内水煎，取液倒入茶杯中，杯口对准患处，用蒸气熏灸，每次 30 分钟，每日 1~2 次。

(5) 葱白敷灸：乳痈早期，取葱白适量，捣烂敷灸患处，包扎固定，每日 1 次；或取大葱适量，捣烂加麝香少许调匀铺患处，覆以厚布，用熨斗熨烫，以汗出为度。

(6) 仙人掌敷灸：乳痈初起，取仙人掌（去皮、刺）1 块，捣烂（或加食盐 10 克，鸡蛋清适量调匀）敷灸患处，包扎固定。亦可将仙人掌去皮、刺后对半剖成两片，用剖面直接敷灸患处，每日 1 次。

(7) 芙蓉花（或蒲公英）敷灸：乳痈初起，取鲜芙蓉花（或鲜蒲公英）适量，捣烂敷灸患处，每日 1 次。

(8) 生侧柏叶敷灸：乳痈初起，取生侧柏叶适量，捣烂用蜂蜜调，敷灸患处，每日 1 次。

(9) 白敛敷灸：乳痈初起，取鲜白敛 200 克，蜂蜜少量，共捣烂加热后敷灸患处，每日 1 次。

(10) 山慈姑麦芽敷灸：乳痈初起，取山慈姑、麦芽各 10 克，共研细末，用茶水调，敷灸患处，每日 1 次。

(11) 复方大黄敷灸：乳痈初起，取大黄、黄柏、白芷各等量，共研细末，用陈醋调；或取大黄、黄芩、黄柏各 30 克，黄连 10 克，共研细末，用蜂蜜调，敷灸患处，每日 1 次。

(12) 复方蒲公英敷灸：①取鲜蒲公英、鲜野菊花各 30 克，葱白头 10 枚，共捣烂，加蜂蜜或红糖少量调匀敷灸患处。②取蒲公英、紫花地丁、芙蓉叶、银花各 50 克（均用鲜品），共捣烂敷灸患处，每日 1 次。③取蒲公英、连翘各 10 克，乳香 30 克，共研细末，用热米醋调，趁热敷灸患处，6 小时 1 次。④取蒲公英、瓜蒌实、麦芽各 10 克，公丁香 15 克，共研细末，用红糖水调成糊状，敷灸患处，每日 1 次。

2. 胃热壅滞（多属乳痈脓肿期或重症） 乳房肿块增大疼痛，患侧淋巴结肿大压痛。伴壮热恶寒，头痛，全身酸痛，口苦咽干，口渴欲饮，口臭，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数。如起病 5 天后，发热不退，局部跳痛则脓肿已成。

治则 清热解毒，祛瘀散结。多取手阳明经穴。

取穴 膻窗、膻中、乳根、肩井、天宗、少泽、丰隆、下巨虚、温溜、局部阿是穴。

方义 膻窗疏通阳明经气，配乳根、下巨虚以泻阳明胃火，佐丰隆化痰降浊；膻中、少泽行气通经络，可散乳汁壅胀；肩井、天宗化痰通络消肿，为治乳痈经验穴；温溜消肿散结；局部阿是穴清热散结。

灸法

(1) 艾炷隔蒜灸：乳痈初起未化脓，在天宗、膻中各灸 5～7 壮，至局部潮红后再用右手拇指指尖作分筋推压拨动天宗穴，手法宜重，反复拨动多次，每日 2 次。

(2) 艾炷隔附子饼灸：乳痈溃后久不收口，取附子饼置疮口上施灸，每次 3~7 壮，每日 1 次。

(3) 艾条温和灸：①在膻窗、乳根、肩井、天宗穴各灸 5~15 分钟，每日 1~2 次。②用蒜泥铺患处，然后用艾条熏灸 10~20 分钟，每日 1~2 次。

(4) 温盒灸：在局部穴位，每穴灸 10~15 分钟，每日 1~2 次。亦可先用葱白或蒜泥铺患处后，再施温盒灸。

(5) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 3 壮（或 10~15 分钟），每日 1 次。

(6) 玄明粉敷灸：取玄明粉适量，用食醋调成糊状，敷灸患处，每日 2~3 次。

(7) 大蒜敷灸：取大蒜适量，捣烂敷灸患处，中间留一小孔，包扎固定，每日 1 次。

(8) 泥鳅土豆敷灸：取土豆 1 个，泥鳅 1 条，共捣烂，敷灸患处（中间留一小孔），如乳痈溃后有口，可用纱布条填塞，外敷纱布一层再敷灸，每日换 1 次。

(9) 复方五倍子敷灸：乳痈溃后久不收口，取五倍子、黄蜂窝各 25 克，桑木炭 50 克，共研细末，香油调敷灸患处，每日 1 次。

(10) 复方地黄敷灸：乳痈溃后久不收口，取地黄炭、乌梅炭、熟石膏各 6 克，轻粉 1.2 克，共研细末，用香油调，敷灸患处，每日 1 次。

按：乳痈初起未化脓者，采用灸法治疗，效果很好，治疗得当，大多在 3~5 日内消退。如已成脓则应切开排脓，并配合其它疗法，以促进疮口愈合。在天宗、膻中、少泽穴施艾炷或艾条温和灸可预防乳腺炎。

急性阑尾炎

急性阑尾炎是阑尾管腔梗阻和多种细菌引起的急性化脓性感染,以转移性腹痛为特征,是外科急腹症中最常见的一种疾病。可发生于任何年龄,但以青壮年发病率最高,男多于女。属中医“肠痈”范畴。

【病因病机】

阑尾是与盲肠相通的盲管,管腔细长,开口狭小,系带较短,常使阑尾扭曲,故易被粪石、寄生虫等异物梗阻,引起局部组织缺血、肿胀,以致阑尾粘膜产生的分泌物和管腔内原来存在的细菌淤滞,有利于细菌繁殖,形成炎症而引起急性阑尾炎。中医认为,肠道的功能为受纳水谷,分清化浊,吸收精微,化生气血,排泄废物,肠道气机由上而下为顺。如果饮食不节,寒温失调,劳累过度,食后剧烈运动,致使胃肠运化功能失常,气机不顺,肠中湿热壅滞,气血瘀阻而发为肠痈。初期为气滞血瘀,继而瘀久化热,热腐成脓,进而热毒炽盛,侵入营血,则发生各种变证。

【临床表现】

转移性腹痛是本病的典型特点。初起在上腹部或脐周围阵发性腹痛并逐渐加重,若干小时后 80% 以上患者向下腹阑尾部位转移,呈持续性疼痛,阵发性加重。也有少数不典型患者开始即表现为右下腹或其它部位固定性疼痛,无转移特征。多伴恶心呕吐,食欲减退,腹泻或胃肠道炎症。炎症发展可出现高热寒战,汗出口渴,尿黄,脉数等中毒症状。多数患者腹痛程度和特征与阑尾病变有一定关系,单纯性阑尾炎呈持续性钝痛;化脓性或坏疽性阑尾炎则为持续性钝痛并有阵发性剧痛或跳痛,病程中腹痛突然减轻可能为阑尾梗阻解除,炎症消

退的表现,也可能是阑尾穿孔所致。右下腹阑尾点(麦氏点)有固定压痛。当阑尾化脓坏死时,压痛范围扩大并出现反跳痛及腹直肌紧张;当炎症波及腰大肌时,腰大肌体征阳性。白细胞及中性粒细胞增多。如并发阑尾穿孔,可引起局限性腹膜炎并可发展为弥漫性腹膜炎,此时腹痛扩展至全腹,出现全腹压痛,反跳痛,腹肌紧张,高热,腹胀,脉细数等全身感染、中毒和脱水等严重病象,白细胞可高达 20×10^9 /升以上。

【辨证施灸】

急性阑尾炎属里、热、实证,辨证可分为瘀滞、蕴热、毒热三期。一般前二期可采用艾灸及其它保守治疗,毒热期应首选手术治疗。瘀滞期见于急性阑尾炎初期及脓肿消散后期,表现为腹部钝痛或隐痛而热象不显著,气滞重者,腹痛可绕脐走窜;血瘀重者,腹痛局限于右下腹,按之加剧,无明显腹肌紧张,或可触及局限性包块,脘腹胀闷,暖气纳呆,恶心呕吐,便秘或伴发热,苔薄白或薄黄,脉弦紧;若病程继续发展至蕴热期(相当于酿脓期),腹痛加剧拒按,右下腹压痛明显,反跳痛,腹皮绷紧,可扪及包块,壮热汗出不退,恶心呕吐,便秘尿赤,舌红,苔黄糙,脉弦数,或胸脘痞闷,腹胀,便溏不爽,苔黄厚腻,脉滑数。

治则 清热解毒,通腑导滞,活血散结。多取手阳明、任脉及足厥阴肝经穴为主,且宜多灸。

取穴 大肠俞、天枢、阑尾穴、上巨虚、地机、局部阿是穴。

方义 大肠俞调肠腑,化积滞;天枢利气止痛,配上巨虚通腑化滞,二穴合用可疏通大肠气血,清热导滞散结;阑尾穴调阳明胃腑,为治疗阑尾炎经验穴;地机主腹中痛;阿是穴清热散结,消肿止痛。气滞重呕剧者加中脘、内关;腹胀重加气海、足三里;蕴热明显加腹结、阳陵泉。

灸法

(1) 艾炷着肤灸:①化脓灸,每次选 2 穴,各灸 3~5 壮,灸后敷贴淡膏药,使之化脓,隔日另选 2 穴,再灸 1 次。②非化脓灸,每次选 3~4 穴,各灸 3~7 壮,以局部皮肤红润不起疱为度,每日 1 次。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 15~20 分钟,每日 1~2 次。

(3) 金黄散(或玉露散、双柏散)敷灸:阑尾炎各期均可选用金黄散、玉露散、双柏散适量,用水蜜调成糊状,敷灸右下腹疼痛处,每日 2 次。亦可用金黄膏或玉露膏敷灸。

(4) 大蒜芒硝糊合大黄敷灸:取大蒜 60 克,芒硝 20 克,共捣烂,敷灸右下腹最痛处,敷药前先在局部皮肤涂凡士林或放 1 层凡士林纱布,以减轻药物对皮肤的刺激,2 小时后除去,改用大黄粉 30 克以醋调成糊状,敷灸同一部位 6~8 小时(保持药物潮湿),必要时隔数小时后重复应用。

(5) 芒硝敷灸:①取芒硝 60 克,研细装小纱布袋内压平放在右下腹疼痛处,包扎固定,待药粉吸收水分变硬后再换敷新药。②取芒硝 10 克,冰片 1 克,共研细末,撒在右下腹疼痛处,包扎固定,每日 1 次。

(6) 石膏桐油敷灸:单纯性阑尾炎、阑尾脓肿,取石膏、桐油各等份,共捣成糊膏状,敷灸右下腹疼痛处,包扎固定,每日 1 次。

(7) 复方大黄敷灸:①阑尾炎重症或阑尾脓肿早期并发轻型腹膜炎,取大黄、芙蓉叶各 30 克,黄芩、黄连、黄柏、泽兰叶各 25 克,冰片 1 克,共研细末,用黄酒或葱酒煎液调成糊状,敷灸右下腹疼痛处(保持药物湿润),包扎固定,每日 1 次。②阑尾炎恢复期或慢性期,取大黄、生半夏、生南星、生川乌、

猪牙皂、土贝母、姜黄各 30 克,白芷、穿山甲各 45 克,芙蓉叶、败酱草、黄柏各 60 克,共研细末,按 3:7 的比例,用凡士林或蜂蜜调成糊膏状,敷灸右下腹疼痛处,每日 1 次。

(8) 食盐敷灸:阑尾周围脓肿,取粗盐 500 克炒热布包,趁热敷灸右下腹疼痛处,每日 1~2 次。

按:急性阑尾炎如能早期诊断并及时处理,治疗得当,患者可在短期内康复,但若延误诊治,有时可产生严重并发症,甚至危及生命。艾灸对单纯性阑尾炎初起未化脓者疗效较好。如炎症发展可配合其它疗法,如无效,症状继续加重应改手术治疗。

血栓性闭塞性脉管炎

血栓性闭塞性脉管炎是一种慢性进行性的周围血管疾患。主要发生在四肢中、小动脉和静脉,以累及下肢多见,好发于男性青壮年,寒湿地区发病率高。四肢远端小动脉血栓形成,血管闭塞导致肢体严重缺血,最后发生肢体坏死,趾(指)关节脱落,故中医称为“脱疽”。

【病因病机】

目前病因未明,可能与肢体骤然受到寒湿侵袭、感染、创伤、吸烟、营养不良、自身免疫功能紊乱、血管神经调节障碍及激素等因素有关。中医认为,本病多因素体脾肾阳气不足,不能温养四肢,复因过度寒冷潮湿侵袭,客于脉道,以致血管长期痉挛,管壁增厚,使管腔变窄,气血凝滞,血流不畅,四肢气血不充,肢末无血供养;或寒湿郁久化热蕴毒,湿毒浸淫,热盛肉腐,则形成坏疽,坏死脱落。

【临床表现】

临床按病情轻重和病变发展过程分早(局部缺血)、中(营

养障碍)、晚(组织坏死)三期。早期患肢对外界寒冷十分敏感,发凉怕冷,皮肤苍白,沉重酸胀,易疲劳,间歇性跛行,并有麻木奇痒、针刺烧灼等异常感觉,小腿和足底有胀痛和肌肉抽搐痛现象。可反复出现游走性浅静脉炎,受累肢体动脉搏动减弱。随着病情进展,疼痛加剧呈持续性,夜间尤甚,间歇跛行加重,患肢出现营养障碍,皮肤由苍白转为潮红、紫绀,不出汗,干燥,汗毛脱落,趾(指)甲增厚脆裂,小腿肌肉萎缩,动脉搏动极微或消失,当病情发展至局部血管阻塞,血流供应停止时则肢端发生干性坏疽。若继发感染则转为湿性坏疽,局部疼痛剧烈,红肿紫绀,溃烂腐臭,甚则趾(指)脱落。

【辨证施灸】

中医辨证应分清寒热虚实和气滞血瘀。早期为寒湿凝滞,经络阻塞,舌淡苔薄白,脉沉迟细;中期为气滞血瘀,血流不畅,四肢气血不充,舌质紫暗或有瘀斑,苔薄白,脉沉细而涩或不显;后期为寒凝瘀滞,郁久化热蕴毒,热盛肉腐,舌红绛,苔黄腻或黄燥,脉细数。病久气血耗伤,疮口不敛难愈,面容憔悴萎黄,疲惫不堪,心悸气短,纳食减少,舌淡,脉沉细无力。

治则 温阳通脉,散寒化湿;活血化瘀,清热解毒;疏通经络,补益气血。

取穴 下肢主穴取足三里、三阴交。累及拇趾加阴陵泉、地机、太白、太冲;第二趾加丰隆、解溪、陷谷;第四指及小腿后侧加承山、昆仑、地五会;病变广泛加委中、血海、大陵。上肢主穴取曲池、郄门、合谷。累及拇、食指加手三里;中指加内关;无名指加外关;小指加通里;病变广泛加孔最、中渚、后溪;阴寒型加阳关;湿热型加阳陵泉、复溜;热毒型加曲池、合谷、血海、委中;气滞血瘀型加膻中、膈俞、血海;气血两虚加关元、血海、太溪。

方义 膻中、膈俞活血祛瘀；曲池、委中清泄热毒；关元、血海益气养血。其余局部穴位有疏通经络，化瘀止痛的作用。用温补法可温散寒邪，益气养血；用清泻法能疏通经脉，清热解毒。

灸法

(1) 艾炷灸：早期施骑竹马灸；中期先针神门后施隔附片灸；后期在冲阳、太溪及疮口周围施隔蒜片灸，每穴 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾条温和灸：每穴灸 5~10 分钟，以局部皮肤发热潮红为度，每日 1 次。

按：血栓性闭塞性脉管炎病因未明，无特异性治疗。艾灸疗法可作为辅助治疗，有促进血液循环，温散寒凝和缓解疼痛的作用。主要适用于未溃烂者，若已溃烂应采用外科治疗。平时注意防寒保暖、戒烟、防止过度疲劳，可减少发病或减轻症状。

颈淋巴结结核

颈淋巴结结核是好发于颈项及耳后最常见的结核病。多见于儿童和青年，因其结核累累如贯珠状，故中医称为“瘰癧”。瘰癧溃后，俗名“鼠疮”。

【病因病机】

本病的发生是结核杆菌经口、咽部侵入，少数继发于肺或支气管的结核病变经淋巴或血路传播，侵入淋巴结而引起的慢性炎症。人体营养失调，免疫力削弱也是发病的重要因素。中医认为，本病多因情志不畅，肝气郁结，气郁化火，炼液为痰；或脾失健运，痰热内生；或肺肾阴虚，阴虚火旺，灼津为痰，痰火互结，凝于颈项而成。

【临床表现】

颈部一侧或两侧胸锁乳突肌附近出现单个或多个淋巴结肿大,皮色不变,不热不痛,按之较硬,界线清楚,可被推动,日久发生淋巴结周围炎症,肿大淋巴结相互融合成块,与皮肤及深部组织粘连而不能被推动,渐感疼痛,后期肿大的淋巴结发生干酪样坏死,液化形成寒性脓肿。破溃后流出清稀脓水,夹有败絮样物质。疮口潜行成空壳,四周紫暗,此愈彼溃形成窦道。病程缓慢,一般全身症状较少,有时可见胸胁胀满窜痛,或低热盗汗,纳差消瘦,神疲乏力,脉细弱。

【辨证施灸】

1. 气郁痰结 颈淋巴结结核肿大,兼精神抑郁,胸胁胀满,脘胀纳呆,口苦,神疲,舌红,苔薄腻,脉弦细。

治则 疏肝解郁,健脾化痰。取少阳、厥阴经穴为主。

取穴 主穴:①天池、章门、天井、外关、足临泣。②百劳、脾俞、肾俞、天井、丘墟、太冲。③百劳、天井、少海。配穴:翳风、肩井、肺俞、膈俞、肝俞、脾俞。

方义 百劳、天井、少海为治疗瘰癧经验穴;翳风通经散结;肩井泻阳明、少阳之火;肺俞益气化痰;膈俞理血;肝俞平肝解郁;脾俞、章门健脾化痰湿;肾俞滋阴潜肝火,佐百劳为治瘰癧奇穴;天池配外关调达全身气血,养血柔肝;丘墟、太冲疏肝郁之火,行颈项之痰结;足临泣配天井有促进消瘰癧的功能。胸胁胀满加阳陵泉、内关;脘痞纳少便溏加中脘、足三里。

灸法

(1) 艾炷灸:选①组穴位,或选②组天井、丘墟、太冲,用泻法,每穴灸3~5壮;脾俞、肾俞各灸5~7壮,每日1次;或每次选③组穴位中之2~3穴,各灸3~5壮,每日1~2次,10次为1个疗程。亦可用艾条悬灸。

(2) 艾条隔蒜灸:在患处灸 3~5 壮,每日 1 次。

(3) 艾炷隔荸苳(或香附)饼灸:在患处局部灸 3 壮,3 日 1 次,3 次为 1 个疗程。

(4) 药捻灸:每次选②组穴中之 3~5 穴,各灸 5~10 分钟,隔日 1 次,20 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸:选①组穴,各灸 1 壮(或 3~5 分钟)或有温热感即拔针,隔日 1 次。

(6) 火针:瘰癧未溃脓时,用细火针自核正中刺入核心,每日 1 针,3~5 日 1 次。

(7) 桑枝灸:每次选②组穴中之 2~3 穴,各点灸 5~10 次,交替取穴施灸,3~5 日 1 次。

(8) 侧柏叶熨灸:取侧柏叶、食盐各适量,共炒烫装布袋熨灸患处,药袋冷后即更换,每日 2 次,每次 20~30 分钟。

(9) 复方木鳖子敷灸:取木鳖子、蓖麻子、大风子、没药、松香各 9 克;或木鳖子 2 个、草头乌 1 个、葱头 1 个、蚯蚓泥少许,共捣烂,敷灸患处,每日 1 次。

(10) 半夏南星敷灸:取生半夏、生南星各等份,共捣烂,敷灸患处,每日换 1 次。

2. 痰郁化火 肿块肿大与皮肤粘连,相互融合成块,逐渐软化成脓。可伴颧红,低热盗汗,腰膝酸软,舌红少苔,脉弦数。

治则 清热化痰,托毒透脓。

取穴 ①百劳、脾俞、三焦俞、中脘、期门、大包、丰隆。②百劳、肘尖、天井、瘰癧局部阿是穴。

方义 百劳、天井、肘尖为治瘰癧经验穴;脾俞、中脘健脾和胃,祛湿化痰;三焦俞调理三焦气机,以加强祛痰化湿作用;大包调理全身气血,促进痰浊排除;期门疏肝理气,行气化痰;

丰隆化痰托毒排脓；局部阿是穴破瘰排脓托毒。瘰癧生于颈部加大迎、臂臑、手三里；生于项部加翳风、足临泣。

灸法

(1) 艾炷灸：选①组穴，各灸 3~5 壮。亦可用艾条悬灸；或在百劳、肘尖各灸 3~5 壮（患在左灸右，患在右灸左），每日 1 次，同时用泻法在成脓的肿块上灸 2~3 壮，每日 1 次，直至破溃出脓为止。

(2) 艾炷隔附子灸：选②组穴，各灸 5 分钟，至局部有温热感为度，每日 1 次，溃脓后停灸阿是穴。

(3) 艾炷隔桃树皮灸：在患处灸 10~15 壮，每日 1 次。

(4) 温针灸：每次选①组穴中之 3~5 穴，各灸 3~5 分钟，丰隆重灸，每次 10~15 分钟，每日 1 次，溃脓后改用艾炷灸。

(5) 桑枝灸：选②组穴，各点灸 5~10 次，以不烧伤皮肤为度，隔日 1 次。

(6) 山慈姑敷灸：取山慈姑适量，捣烂醋调成糊状，敷灸患处，每日 2~3 次。

(7) 猪胆汁敷灸：用猪胆 10 个，取汁加陈醋 500 毫升，用文火熬成膏状，先用花椒水洗患处后，再敷上药膏，每日换 1 次。

3. 肺肾阴亏 瘰癧破溃后流清稀脓水夹败絮样物质，形成空壳窦道，久不收口，伴潮热骨蒸，咳嗽盗汗，消瘦乏力，舌红少苔，脉细数。

治则 滋阴降火，扶正固本。取手少阳、少阴经穴为主。

取穴 百劳、膏肓、肩井、肺俞、脾俞、肾俞、天井、少海、阿是穴。

方义 百劳、天井、少海为治瘰癧经验穴；膏肓补益气血，

滋补肺肾；肩井治诸虚百损，泻少阴之火；肺俞补益肺气除痰；脾俞健脾益气化痰湿；肾俞滋阴降火；阿是穴腐痿生肌。潮热加鱼际；盗汗加阴郄；肢冷加关元。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，用补法，各灸 5~7 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔附子灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，每日 1 次。

(3) 艾炷隔商陆(或蓖苰根)灸：瘰癧、痿管久治不愈，在患处灸 3~5 壮，每日 1 次。

(4) 文蛤蜈蚣敷灸：取文蛤 1 个，金头蜈蚣 1 条，先将文蛤钻 1 孔，蜈蚣研末纳入文蛤内，纸糊封口后用麦麸拌炒至纸焦，去纸研细末，加麝香少许调匀，用食醋调成糊状，敷灸患处，每日换 1 次。

脱 肛

直肠粘膜或直肠全层脱出于肛门者称脱肛，相当于西医的肛管直肠脱垂。多见于小儿、经产妇及老弱久病者。

【病因病机】

本病病位在大肠，病因较为复杂，但主要原因是中气不足或湿热下注所致。多因小儿气血未旺，发育不全；妇女分娩过多，气血亏虚；或老年气血衰退，中气不足，气虚下陷，以及慢性腹泻、长期咳嗽等引起气虚下陷，不能提举内脏，肛门固摄无力，以至排便或腹压增加时直肠脱出。亦有因便秘、痢疾使湿热郁滞于直肠，排便努责，肛门约束无权而致脱肛者。此外，手术、外伤损及肛门，使肛门失于禁固也可导致脱肛。西医认为，脱肛的病因主要与解剖缺陷、组织软弱及腹压增加有关。

【临床表现】

肛门脱出为本病的主要症状。轻者排便时直肠粘膜脱出，便后可自行还纳；若身体虚弱，日久失治，可逐渐发展为直肠全层脱出。除大便时脱出外，久站、下蹲、行走、咳嗽时也脱出，并须用手托入或卧床休息，才能回纳。如脱出未能及时还纳，局部水肿，再加肛门括约肌痉挛，可引起嵌顿绞窄，疼痛严重，有水样或血性分泌物，甚至还可出现坏死。若反复脱垂，粘膜磨擦损伤，粘膜面呈现充血、水肿、糜烂、出血与溃疡，可有粘冻样或血性分泌物经常从肛门流出。伴肛周皮肤潮湿、瘙痒，大便不畅，里急后重，肛门、腰骶及下腹部坠胀酸痛，体温升高等。临床可分为粘膜脱垂（不完全脱垂）及直肠全层脱垂（完全脱垂）两类。粘膜脱垂称Ⅰ度脱垂；全层脱垂又分为直肠全层脱出的Ⅰ度脱垂及直肠肛管翻出于肛门处的Ⅲ度脱垂。

【辨证施灸】

艾灸疗法对气虚脱肛的效果较好。每当久站、下蹲、行走、咳嗽或稍一用力，直肠粘膜或全层即脱出，须用手推托才能复位，粘膜淡红，粘液不多，里急后重及肛门坠胀，疼痛不明显。伴食欲不振，神疲乏力，头晕心悸，面色萎黄，舌淡苔薄白，脉细弱。

治则 补中益气，固摄升提。

取穴 百会、大肠俞、气海、足三里、承山。

方义 百会升提固摄；大肠俞配承山可促进直肠回收；气海合足三里补气健脾，扶正培元。脾虚为主者加脾俞；兼肾虚者加命门、关元。

灸法

（1）艾炷麦粒灸：在气海、足三里穴各灸7~9壮，每日1次。

(2) 艾炷隔姜灸：每穴灸 3~5 壮，每日 1 次。

(3) 艾炷隔酱灸：将百会穴上的头发剪去指甲大 1 块，敷上千面酱 5 克，上置艾炷施灸，每次 5 壮，隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(4) 艾炷隔蓖麻仁灸：先将百会穴上的头发剪去，再取蓖麻仁适量，捣烂如膏状敷穴上，上置艾炷施灸，每次 5~7 壮，隔日 1 次；或取蓖麻仁适量，捣烂敷灸百会穴，包扎固定，2 日后去掉，3 日 1 次。

(5) 艾条温和灸：每穴灸 15~20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(6) 火针：选百会、大肠俞、长强、承山穴，用细火针点刺，速进疾出，百会宜浅刺，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(7) 太乙神针灸：在百会、命门穴各灸 10~15 分钟，每灸 5~7 次为度，每日 1 次。

(8) 复方黄芪敷灸：①取生黄芪、生南星各 15 克，共研细末，用姜汁调，敷灸肛门，待脱肛回缩后除去，每日 1 次。②取黄芪、升麻、枳壳、五倍子各等量，共研细末，用米醋调成糊状，敷灸神阙穴，保持潮湿，每日换 3~4 次。

(9) 参芦升麻敷灸：取参芦 3 枚，升麻 6 克，共研细末，醋调敷灸百会穴，肛门回缩后除去，每日 1 次。

(10) 蓖麻五倍子熨灸：小儿脱肛，取蓖麻子 100 克，五倍子 20 克，共捣烂炒热，布包熨灸百会穴，并从尾骶骨处向上熨灸，每日 1 次。

(11) 复方枳壳熨灸：取麸炒枳壳、防风各 30 克，枯矾 7.5 克，共捣烂，装入布袋蒸透后趁热坐灸，药袋冷后更换，每次 30~60 分钟，每日 1~3 次。

(12) 药蒸气熏灸：取五倍子 250 克，白矾 10 克，加水煮

沸后倒入桶中,让患者坐桶上,以蒸气熏灸,每日1次。

(13) 五倍子烟熏灸:小儿脱肛,取五倍子末30克,艾绒适量,共混匀,放桶内燃烧生烟,令患儿坐桶上熏灸,待肛门回缩后,再用明矾揉擦,每日1次。

按:灸法治疗脱肛,疗效满意,尤以早期更佳。对晚期重度脱肛,可配合药物或外科治疗。对直肠脱出不能回纳者,必须及时处理,将脱垂粘膜送纳肛内,以防止感染而引起不良后果。经常在百会、长强穴施艾炷或艾条熏灸有预防脱肛的作用。

痔 疮

痔疮是指直肠末端粘膜下和肛管皮下痔静脉丛发生扩张,迂曲形成的柔软肿块(静脉团)。是一种最常见的肛门疾病,民间有“十人九痔”之说,多见于成年人,男性略多于女性。由于发病部位不同而有内痔、外痔和混合痔之分。

【病因病机】

痔疮的发生与解剖因素及静脉回流受阻、感染、损伤等有关。中医认为,多因久坐久立、负重远行、妊娠多产、长期便秘,以及七情郁结,气机失宣,引起气血瘀结于肛门;或泻痢日久,体质亏耗及年老体弱,中气不足,气虚下陷;或饮食失调,嗜酒辛辣,湿热内生,下注大肠,湿热与瘀血结滞于肛门而形成痔疮。

【临床表现】

1. 内痔 生于肛门齿线以上,临床以便血和痔核脱出为主要症状,可分为四期。Ⅰ期:仅排便时带血,无其它明显症状。Ⅱ期:痔核较大,排便时脱出,便后可自行还纳,便血或多或少。Ⅲ期:痔核除排便时脱出不能自行复位外,有时因咳嗽

等引起腹内压增高时亦脱出,便血较少。Ⅳ期:痔核表面覆盖以皮肤,长期脱出于肛门外,不能回复或回复后又立即脱出。如痔核脱出发生嵌顿时,可出现肿痛、糜烂、坏死;长期便血可引起贫血。

2. 外痔 生于肛管齿线以下,平时自觉肛门有异物感,并发炎症时出现瘙痒、坠胀、灼痛等。根据发病过程可分为血栓外痔、静脉曲张外痔、结缔组织外痔和炎症外痔。

3. 混合痔 兼有内外痔的共有症状。

【辨证施灸】

临床可分为湿热瘀滞和气虚下陷两型。湿热瘀滞者,排便时痔核脱出,滴血,肛门坠胀或灼热,排便不畅,里急后重,伴腹胀纳呆,身重困倦,苔黄腻,脉滑数;气虚下陷者,排便时痔核脱出不能自行还纳或不能还纳,肛门下坠,排便无力,出血或不出血。伴气短倦怠,食少懒言,面色苍白,舌淡苔白,脉虚。

治则 疏经散瘀。

取穴 大肠俞、次髂、长强、会阴、承山、二白。

方义 大肠俞通经活络,调理肠腑;次髂、长强、会阴疏泄肛门局部气血郁滞;承山清泄肛肠湿热瘀滞;二白为治痔疮经验穴。内痔偏气虚加气海、足三里;痔核脱出不收加百会、关元、神阙;外痔炎症较重者,重灸承山;便秘加支沟、上巨虚;便血加脾俞、血海;湿热偏重加阴陵泉。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸:气虚下陷者,每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次。

(3) 艾炷隔盐灸:每穴灸 3~5 壮,每日 1 次。

(4) 艾炷隔荸荠饼灸:每穴灸 3 壮,3 日 1 次,3 次为 1 个

疗程。

(5) 艾炷隔矾灸：外痔、瘻管取煅皂矾 500 克，煅木鳖子 8 克，炮山甲 3 克，共研细末，取适量用冷水调制成小圆饼，置患处，上放艾炷灸 3~4 壮，每日 1 次。

(6) 艾条熏灸：每穴灸 10~15 分钟，以局部皮肤潮红为度，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(7) 灯火灼灸：每次选 2~3 穴，各灼灸 1 下。

(8) 烟熏灸：痔疮瘙痒，取柏树锯末适量，全蝎 1 只（研碎），艾叶 31 克，共混匀，放桶内点燃生烟，令患者坐桶上熏灸，每日 1~2 次。

(9) 药蒸气熏灸：取枸杞根适量，捣烂后加水煮沸；或马齿苋适量加陈醋煎沸倒入盆中，对准患部熏灸，每日 1 次。

按：灸法有镇痛、消炎、止血的功效，对痔疮坠痛、出血、发炎等疗效较好，可配合其它方法综合治疗。在长强、承山施艾炷灸或艾条温和灸可防治痔疮发病。痔疮患者平时应少吃辛辣刺激食物，并养成定时大便的习惯，保持大便通畅。

肩关节周围炎

肩关节周围炎（简称肩周炎）又称“肩凝症”、“冻结肩”、“五十肩”。中医称“漏肩风”或“露肩风”，属痹证范畴，是以单侧或双侧肩关节酸重疼痛和活动受限的疾病。以 50 岁以上老年人发病率高，尤多见于老年女性。

【病因病机】

肩关节是全身各关节活动范围最大的关节。随着年龄的增长、长期的活动而发生退行性改变，以及劳损、外伤等均可导致疼痛和活动障碍。中医认为，人到中、老年，气血不足，肾气渐衰，致使筋失濡养，关节失于滑利。若汗出当风，夜卧露肩

受凉,风寒湿邪乘虚侵入,寒凝筋膜、经络,气血运行不畅,筋脉拘急。或外伤治疗不当,或积劳成疾,以致经络阻滞,气血不和,筋屈不伸,遂致肩关节疼痛,关节活动功能障碍。

【临床表现】

初起肩部经常发生弥漫性疼痛,局部畏寒,日轻夜重,活动不利,有僵硬感。疼痛可向颈项和手部放射,手指麻胀,但无感觉障碍。早期以疼痛为主,局部有广泛性压痛,肩部活动如上举、后伸、内收、外展、内旋等动作受限,以致洗脸、梳头、穿衣、摸背等均受影响。晚期肩关节周围组织广泛粘连形成冻结肩。疼痛可减轻,但功能障碍加重。严重者,肩部肌肉可以发生萎缩,最后导致肩关节功能丧失。

【辨证施灸】

肩周炎以肩部酸痛和活动受限为主要症状。偏风盛者多伤筋,肩痛可牵涉项背及手指;寒重者多伤骨,肩痛较剧而固定不移,得热则舒;湿盛者多伤肉,肩痛肿胀拒按。

治则 祛风散寒,化湿通络,疏调气血。以取手三阳、足太阴经穴为主。

取穴 肩髃、肩髃、肩贞、臑会、臂臑、肩内陵、巨骨、天宗、曲池、外关、抬肩。

方义 肩关节局部穴位祛风散寒,活血通络;曲池、外关疏导阳明、少阳经气,清热化湿。偏风盛加风池;寒盛加合谷;肩内廉痛加尺泽、太渊;肩外廉痛加后溪、小海;肩前廉痛加列缺。

灸法

(1) 艾炷瘢痕灸:每次选1~2穴,各灸3~5壮,每月1次,并发灸疮。

(2) 艾炷隔姜灸:每次选3~5穴,各灸5~10壮,隔日1次,7次为1个疗程。

(3) 艾炷隔盐灸:取食盐填平脐窝,灸 5~10 壮,隔日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(4) 艾条温和灸:在肩部疼痛处灸 10~20 分钟,每日 1~2 次,10 次为 1 个疗程。

(5) 温针灸:每次选 3~5 穴,各灸 3 壮(或 10~15 分钟),隔日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(6) 温盒灸:在肩部压痛点灸 15~30 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(7) 灯火灼灸:每次选 3~4 穴,各灼灸 1 下,3 日 1 次,5 次为 1 个疗程。

(8) 艾火针衬垫灸:在肩痛局部灸 5~7 壮,以局部皮肤出现红晕为度,隔日 1 次,7 次为 1 个疗程。

(9) 斑蝥发疱灸:每次选局部穴位 3 个,敷灸前先用 3 厘米圆形胶布中间剪 1 黄豆大圆孔,对准穴位贴好,然后取斑蝥末少许放在圆孔穴位上,再用胶布封贴,敷灸 30~120 分钟,待局部起疱后除去,并可发灸疮。

(10) 阳燧锭敷灸:取硫黄 5 克,蟾酥、朱砂各 3 克,冰片、麝香各 0.6 克,白砒 1.6 克,依法制成阳燧锭。每次选局部穴位 2~3 个,施阳燧锭灸,每穴灸 1~3 壮,3 日 1 次,5 次为 1 个疗程。

(11) 复方白凤仙根敷灸:取白凤仙根、臭梧桐、生姜、大蒜、韭菜各 200 克,共捣烂,用文火煎熬成膏状,敷灸患处,每日 1 次。

(12) 复方川草乌敷灸:取生川乌、生草乌、生南星、生半夏、姜黄、羌活、苍术各 20 克,白附子、白芷、乳香、没药各 15 克,红花、细辛各 10 克,共研细末,加食醋、蜂蜜、白酒、葱头、鲜姜各适量,共捣烂,再用白胡椒 30 粒研细末,拌入上药混

匀,炒烫后装入布袋热熨患部,冷后更换,每次 30 分钟,每日 2 次,连用 5~7 日。

按:肩周炎的治疗,常采用综合疗法,且要坚持治疗较长时间才能收效。灸法是有效疗法之一,可配合手法理筋、练功活动、内外用药等,并注意局部保暖,避免受寒方能取效。

扭 伤

扭伤是指肢体因受外力扭挫牵拉后,关节超越正常活动范围而引起关节周围软组织损伤的疾患,俗称“伤筋”。即西医的急、慢性软组织损伤。

【病因病机】

多由剧烈运动或持重姿势不当、撞击、过度扭挫、牵拉压迫、长期固定体位等原因,使受外力作用的关节超越正常活动范围,引起关节周围软组织损伤,气血瘀滞于局部,经气运行受阻而发生肿痛,甚至关节活动受限。

【临床表现】

扭挫伤多发生在腕、踝、腰、膝、肘、颈等关节,其次肩、髋关节。扭伤局部疼痛,或肿胀压痛,皮下瘀血紫绀,或关节活动障碍,但无骨折、破损等情况。

【辨证施灸】

临床有新伤和陈伤两种情况。新伤者局部疼痛,或肿胀,皮肤紫绀,压痛明显,关节屈伸不利。严重者,肿痛剧烈,关节活动障碍;陈伤者局部疼痛较轻,肿胀不明显,或因风寒湿邪侵袭而疼痛复发,严重者舌质紫暗,脉涩或弦涩。

治则 舒筋通络,活血化瘀。以取局部穴位和阿是穴为主。

取穴 颈部取风池、天柱、后溪、绝骨;肩部取肩髃、肩髃、

肩贞、臑会、条口、阳陵泉；肘部取天井、曲池、小海；腕部取外关、液门、阳溪、阳池；腰部取人中、肾俞、腰阳关、后溪、委中；髋部取环跳、秩边、承扶；膝部取膝阳关、膝眼、梁丘、阴陵泉、足三里；踝部取解溪、昆仑、丘墟。

方义 上述各组穴位均有疏调局部气血，消瘀散结，通经活络，使损伤组织功能恢复正常的作用。新伤重灸阿是穴；陈伤结合诱因酌加祛风、散寒、胜湿的辅助穴。

灸法

(1) 艾炷灸：选扭伤局部穴位，各灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔姜灸：选扭伤局部穴位，各灸 3~5 壮，每日 1~2 次，或在姜片上再置预制的硫黄灸料，用艾炷灸至局部灼热时压灭未燃尽的艾炷，每日 1 次。

(3) 艾条温和灸：选扭伤局部穴位，各灸 5~10 分钟，阿是穴灸 20~30 分钟，每日 1~2 次。

(4) 雷火针灸：闪挫肿痛，选局部穴位，各按灸 5~7 次，每日 1 次。

(5) 铁落敷灸：取铁落 500 克，加醋 200 毫升（第二次以后加 150 毫升即可）拌匀，按治疗部位大小，取适量铁落装入布袋，外包 2 层毛巾，待温度升至 60℃ 时敷灸患处，每次 30~45 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(6) 复方鹅不食草敷灸：取鹅不食草、酢酱草、韭菜根各等量，共捣烂，敷灸患处，每日 1 次。

(7) 复方大黄敷灸：取生大黄、生栀子、乳香各等量，共研细末，新伤用蜂蜜或蛋清调；陈伤用热酒调，敷灸患处，每日或隔日 1 次。

(8) 复方川草乌敷灸：新伤取川乌、草乌、南星、半夏、当归、川芎、乌药、白芷、牛膝、黄柏、补骨脂、刘寄奴、紫荆皮、桑

白皮各等量,共研细末,用饴糖调成糊状,敷灸肿痛处,每日或隔日换1次。

(9) 复方透骨草熨灸:取透骨草 60 克,当归、香附、独活各 30 克,草乌 15 克,青盐 500 克,先将前 5 味研细末,与盐共炒烫,用布包,趁热熨灸患处。

按:急性扭伤 24 小时内应用冷敷以加强止血作用,24 小时后用热敷及艾灸以活血化瘀。休息时适当抬高患肢以促进回流。若韧带断裂,则应由外科处理。

五、皮肤科疾病

带状疱疹

带状疱疹是一种病毒性呈带状分布的疱疹性皮肤病。常发生于单侧胸肋、腰肋及头面部。在红斑上出现密集成簇的水疱,伴较重的神经痛为特征。多发生于春秋季节,以成人多见。中医称“缠腰火丹”、“缠腰龙”、“蛇串疮”、“蜘蛛疮”等。

【病因病机】

本病是由水痘-带状疱疹病毒从呼吸道侵入感染引起。多数人被病毒感染后并不立即发生临床症状,而是潜伏在脊髓后根神经节中,当机体免疫功能下降,或感冒、过度疲劳时发病,出现该神经分布区的带状疱疹。中医认为,本病是由于情志内伤,肝气郁滞,日久化火而致肝胆火盛,或因湿热内蕴,外感毒邪诱发,湿热火毒熏蒸皮肤而发疹;毒邪与肝火,湿热相搏,经络受阻,气血不通而灼痛。

【临床表现】

发疹前常有轻度发热,倦怠不适等。患部皮肤先有烧灼

感,带状刺痛,随后出现不规则的红斑,接着在红斑上发生密集成簇的丘疱疹,渐成绿豆或黄豆大的血疱疹,以后变成清澈透明的水疱,疱壁紧张透亮,周围可见红晕,数个聚集成群,沿周围神经排成带状。数日后水疱变成混浊,可破溃、糜烂、渗液,如无继发感染可逐渐吸收,干燥结痂,痂脱而愈,愈后极少复发。皮疹常发生于一侧胸肋、腰肋及面部,以肋间神经及三叉神经分布区较多,一般不超过身体中线,发于面部者,疼痛剧烈,并可损及眼睛,甚至引起失明。

【辨证施灸】

临床可见肝火和湿热两型。肝经火盛者多发生于腰肋部,疱壁紧张,基底潮红,痛如针扎,兼头痛口苦,烦躁易怒,便秘溲赤,舌红苔薄黄或黄腻,脉弦数;脾经湿热者多发生于胸肋或面部,疱壁松弛易破,破后渗液糜烂或化脓,伴纳呆疲乏,苔黄腻,脉滑数;久病或年老体弱者,多见气滞血瘀,疱疹消退后仍剧痛不止,舌暗红,脉弦细。

治则 疏肝解郁,清热祛湿。以取厥阴、阳明经穴为主。

取穴 大椎、夹脊、肝俞、曲池、太冲、阿是穴。

方义 大椎疏风清热解毒;夹脊疏调局部经气,清热止痒;肝俞、太冲疏调肝气,利胆泻火;曲池活血调气,清热利湿;阿是穴调和局部气血,疏经止痛。火盛者加合谷,重灸大椎、曲池;湿盛者加阴陵泉、公孙。疹发于胸肋加支沟、期门或阴陵泉;发于腰肋加合谷、足三里;疼痛剧烈加内关、阳辅。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选3~5穴,各灸3~5壮,或在先发疱的皮疹上及水疱密集处各放小艾炷,点燃灸至灼痛时即除去未燃尽的艾炷,再在远端各灸1壮,每日1次,皮疹面积较大者,可适当增加壮数。

(2) 艾条温和灸：每穴灸 5~10 分钟，在疱疹及周围皮肤、相应的夹脊穴，用雀啄法重点灸 20~30 分钟，灸至局部皮肤红润，痒痛消失或明显减轻为度，每日 1 次。于灸后水疱逐渐吸收结痂而愈。

(3) 灯火灼灸：每穴爆灼灸 1 下，亦可直接爆灼疱疹顶端，每日 1 次。

(4) 火针灸：局部消毒后，用细火针点刺疱疹，速进疾出，每疱 1 针，点刺后可涂以龙胆紫药水。

按：灸法治疗带状疱疹，镇痛效果明显，并可缩短疗程，愈后多不后遗神经痛。

疣

疣是一种常见的生于皮肤浅表的小赘生物。临床常见有寻常疣、扁平疣、丝状疣、传染性软疣、尖锐湿疣等。中医分别称之为“千日疮”(刺瘊、瘰子)、“扁瘊”、“线瘊”、“鼠乳”(水瘊)、“臊瘊”。

【病因病机】

疣是各种疣病毒引起的皮肤浅表的赘生物。中医认为，本病多由风热湿毒侵犯肌肤，或因情志不畅，内动肝火，肝旺血燥，血不荣筋而致腠理不密，复感邪毒，蕴结肌肤而成疣。

【临床表现】

寻常疣好发于青少年的指背、手背、足缘及甲周，也可发生在其它部位。皮疹初起如粟粒，渐长至豌豆大的半圆形隆起的赘生物。质硬，表面干燥粗糙，顶端分叉成花蕊或刺状，呈灰白、污黄、污褐色或正常肤色。数目多少不定，初发为 1 个或数个，可长期不变或不断增多，簇状群集一处或成条状。一般无自觉症状，偶有压痛，撞击、摩擦可出血。发生在甲缘时可向甲

下蔓延,有压痛,易裂隙继发感染。有时自愈,愈后不留痕迹。

扁平疣主要侵犯青少年的颜面、手背及前臂,大多骤然出现,对称而生。疣体为粟米或稍大的隆起扁平丘疹,呈圆形或不规则形,略高出皮面,表面光滑,界线清楚,淡浅色或正常肤色,密集或散在分布,偶因搔抓后可沿表面剥蚀处扩散形成串珠排列或簇集成群。无自觉症状,病程缓慢,有时可自行消退,亦可复发,愈后不留痕迹。

丝状疣多发于老年人的颈、面部及眼睑。疣体为单个细软的丝状突起,形似小刺倒立于皮肤上,呈皮色或淡褐色,多散在发生,一般无自觉症状。

传染性软疣以儿童多见,有接触传染性。皮疹好发于躯干、面颈和四肢,初起为米粒大,逐渐增大至豌豆大的半球形隆起,表面光滑,有蜡样光泽,外形似珍珠,中央微凹如脐窝,形如鼠乳,挑破顶端可挤出白色乳酪样物质。皮疹数目不等,群集或散在分布,常因搔抓或自身传染而扩散,除痒感外无其它症状。

尖锐湿疣常发生于外阴及肛门周围潮湿处,如冠状沟、大小阴唇内侧等部位,属性接触传播性疾病。皮疹初起为淡红色、污灰或浅褐色,呈乳头状隆起,逐渐增大融合,表面凹凸不平,顶端尖锐,湿润柔软,大小不等,易发生糜烂如菜花,渗液恶臭,一般无自觉症状或仅有轻度瘙痒不适。糜烂者可疼痛,病程缓慢,约有半数能自愈,极少数可发生恶变。

【辨证施灸】

患处出现单个或数个粟米至黄豆大的赘生物,表面光滑,色泽正常或淡褐色,界限清楚,随着病情的发展,有的蓬松枯槁,或如倒刺。一般无自觉症状或仅有轻微痒感,病程缓慢,愈后不留瘢痕。

治则 疏风清热,除湿解毒,活血化瘀。依疣体所在部位,按循经取穴相结合,以取阳明经穴为主,重点灸阿是穴。

取穴 阿是穴、曲池、外关、养老、支正、中渚、鱼际、丘墟、外踝点。

方义 阿是穴泄热解毒,祛瘀软坚,散结除疣;曲池合鱼际清热解毒;外关、丘墟疏解少阳、阳明气机,以清泄三焦之火;养老、支正清利湿热,通经活络;中渚配丘墟可促进全身气机调达,气血调和;外踝点为治疣经验穴。肝气郁滞加肝俞、血海;偏风热加风池、商阳;郁火加行间、侠溪。

灸法

(1) 艾炷灸:在外关、养老、丘墟、外踝点穴各灸 3~5 壮,每日 1~2 次,或在支正及疣体上各灸 7~9 壮,以局部温热灼痛时即将未燃尽的艾炷移去,每日 1 次,直灸至疣体全部脱落为止。灸后用敷料包扎,避免着水,防止感染。

(2) 艾条熏灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 分钟,或在患处熏灸 15 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 温针灸:扁平疣,在疣体局部视疣体大小针刺 3~5 针,每针灸 2~3 壮(或 10~15 分钟),隔日 1 次。

(4) 火针灸:扁平疣,用细火针对准疣体轻浅点刺,速进疾出,刺后 3 日勿用水洗患处,以防感染,1 周内疣可脱落。

(5) 桑枝灸:点燃桑枝,然后灭火,直灸疣上,至局部黄焦。

(6) 鸭胆子敷灸:取鸭胆子适量,捣烂敷灸疣体上,包扎固定,3 日更换 1 次。

按:艾灸治疗皮肤疣有一定疗效,治疗寻常疣时,以母疣为主,母疣治愈后周围继发的子疣有时能自行脱落。

手足癣

手足癣是致病性真菌感染手足部引起的皮肤病。以水疱、糜烂、鳞屑等多种损害为特征。手癣属中医的“鹅掌风”范畴；甲癣又称“灰指甲”、“鹅爪风”；足癣称“臭田螺”、“田螺疮”，俗称“脚湿气”、“香港脚”。

【病因病机】

手足癣均为致病性丝状真菌引起。常见的致病真菌有红色毛癣菌、石膏样毛癣菌、絮状表皮癣菌、玫瑰色毛癣菌等。其发病与密切接触传染源有关，但发病与否又取决于个体对真菌的易感性。中医认为，本病是由于外感风毒，内为血燥，或因久居湿地，水湿浸渍，以及脾胃湿热，风湿热蕴生虫，郁于手部、爪甲，或下注于足部肌肤所致，也可由接触染毒而发。足癣又是手癣的重要传染源，甲癣常继发于手足癣之后，由其蔓延及传染而致。

【临床表现】

1. 足癣 常于夏季发病或加重。好发于趾间或趾下，足底及足缘。其形态有水疱、糜烂及鳞屑3种类型。各型可单独出现，互相转化或同时存在，但某一时期常以某一类型表现为主。水疱型多发于足底和趾侧，呈现群集或散在的较深的小水疱，疱壁厚不易自行破溃，瘙痒，破溃吸收后有少许鳞屑；糜烂型多发生于趾间，局部皮肤潮湿，浸渍发白，剧痒，常因搔抓、摩擦表面破溃剥脱而露出鲜红的糜烂面，灼热疼痛，分泌物有特异臭味，很容易并发感染；鳞屑型多发生于足底、足缘，表现为皮肤角化过度，干燥粗糙，脱屑，基底淡红，冬季发生皸裂疼痛。病程缓慢，常多年不愈。

2. 手癣 常由足癣传染而致。好发于手指侧面、屈侧、指

间及掌心、掌缘,临床表现类似足癣,亦可表现为水疱、糜烂、脱屑及皮肤粗糙,皮纹处可发生皲裂而形成慢性湿疹。

3. 甲癣 常由手、足癣蔓延感染而发。损害常从指(趾)甲的游离缘或侧缘向甲板、甲根蔓延,甲板逐渐失去光泽,混浊不透明,呈灰白、灰褐、污秽色,指(趾)甲变脆、增厚、变形,表面凹凸不平,边缘残缺不齐,呈虫蚀状,甲板翘起,严重者甲板与甲床分离,一般无自觉症状,病程十分缓慢,很少自愈。

【辨证施灸】

手、足部可见丘疹、水疱、瘙痒,或手、足掌趾角化脱屑,甚至皲裂。因搔抓、摩擦或治疗不当而出现红肿、脓疱、糜烂、渗液、灼热疼痛,可伴患侧淋巴结肿大、恶寒发热等。

治则 清热解毒利湿。

取穴 手、足病损区,甲癣区,曲池,合谷。

方义 上穴均有清热利湿解毒作用。

灸法

(1) 艾炷隔莱菔根灸:足癣,取鲜莱菔根切 0.2 厘米厚片,用针刺数孔,置足癣区灸 5~7 壮,隔日 1 次。

(2) 艾条或香烟灸:甲癣选用小艾条或香烟点燃后移近病甲缘及中心进行熏灸,每次 10~15 分钟,每日 2~3 次,连灸 15 日。

(3) 火柴灸:将火柴划着燃烧后吹灭,迅速按灸病损区灸点上,待冷却后移去,每个灸点灸 1 壮,由外向内,灸点间隔 5 毫米,并与曲池、合谷穴交替灸治,每日 1 次,灸 2 次后改用隔日 1 次,一般 10 次可愈。

(4) 药蒸气熏灸:鹅掌风取艾叶 120 克或鲜侧柏叶 300 克,加水煮沸后将热药液倒入广口瓶中,将手掌置瓶口熏灸,冷后再热,每次 10 分钟,每日 1~2 次。

(5) 热烘疗法:鹅掌风取风油膏或雄黄膏涂患处后,用电吹风热吹,每次 15~20 分钟,每日 1~2 次,10 次为 1 个疗程,一般 3~4 个疗程可愈。

(6) 食盐熨灸:脚气肿痛取食盐 1500 克,或加白槐树皮(切碎)500 克,炒烫分装数袋,裹灸患部,另取 1 袋踏在脚底熨灸,冷后更换,以脚心热透微汗为度,每日 1~2 次。

(7) 热砂熨灸:脚湿气取干净细砂 1 盆,置太阳下晒热或炒热,将双足埋于砂内熨灸,每次 30 分钟,每日 1~2 次。

(8) 苦参热敷:脚气取苦参 30 克,水煎,取热药液浸湿纱布,趁热敷灸患部,每日 1~2 次。

(9) 复方皂矾热敷:鹅掌风取皂矾、白矾各 30 克,儿茶 15 克,水煎,取热药液浸湿纱布,趁热敷灸患处后,用桐油涂擦患处,每日 2 次。

荨 麻 疹

荨麻疹是由多种原因引起皮肤、粘膜小血管扩张及通透性增强而出现的一种瘙痒性暂时性的表皮或粘膜水肿反应的变态反应性皮肤病。临床常以大小不等的皮肤风团样损害,剧烈瘙痒,骤然发生,迅速消退,不留痕迹为特征。中医称之为“隐疹”、“痞瘤”,俗称“风疹块”、“鬼风疙瘩”。

【病因病机】

荨麻疹的发病原因比较复杂,许多患者找不到确切的原因。常由食物、药物、感染、寄生虫、吸入物及精神紧张等多种原因引起。此外,接触某些植物,或某些内脏及系统疾病,内分泌改变也可发病,还有少数病人与遗传因素有关。在致敏物的作用下,机体出现变态反应;或非变态反应性的刺激因素,使肥大细胞释放组胺。其发病机制目前尚未完全明了,一般认为

可分为变态反应和非变态反应两种。前者大多数通过Ⅰ型变态反应,使肥大细胞释放组胺,引起微血管扩张,血管通透性增强,导致血清蛋白和液体外渗形成风团;后者各种诱发因素本身可直接作用于肥大细胞和嗜碱细胞,使其释放组胺或其它递质如激肽、补体等。直接作用于毛细血管而发病。中医认为,本病的发生多因素体禀赋不耐或虚弱,腠理疏松,风邪(或夹寒夹热)侵袭肌表,或饮食荤腥异物,燥热动风,或胃肠积热,复感外邪,郁于肌肤而发病。病久耗伤气血,气虚卫外不固,血虚生风,或冲任不调,或虫积血瘀等均可引起发病。

【临床表现】

常见皮肤瘙痒,搔抓后即出现大小不等、形态不一的淡红色或苍白色风团,并可迅速蔓延及融合成片,亦可泛发全身,此起彼伏。如侵犯胃肠道粘膜,可伴恶心呕吐,腹痛腹泻;累及咽喉、呼吸道粘膜可引起喉头水肿,出现哮喘,呼吸困难,甚至胸闷窒息。个别严重者可出现休克状态。急性发作持续数小时至数日后多可自行消退,不留痕迹;慢性反复发作可历数月至经久不愈。

【辨证施灸】

外感风邪或夹寒夹热引起者,起病急骤,瘙痒遇寒或吹风则发病或加剧,疹连成片,伴身热口渴,苔薄白,脉濡数;胃肠积热引起者,多因饮食荤腥异物而反复发作,皮疹色红,瘙痒剧烈,伴腹痛腹泻或便秘,苔黄腻,脉濡滑。

治则 祛风和营,清热通腑。取阳明、太阴及督脉经穴为主。

取穴 风门、身柱、膈俞、神阙、曲池、手三里、风市、血海、足三里、筑宾。

方义 风门、身柱祛风清热;膈俞、血海祛风除湿,理气化

瘀；神阙理气和肠；曲池、足三里解表清热，疏风化湿，调和气血；手三里、筑宾疏通经络，清肠和胃；风市散风祛湿。

灸法

(1) 艾炷麦粒(或隔姜)灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~7 壮，以局部皮肤红晕为度，每日 1 次。

(2) 艾炷隔徐长卿灸：每次选 3~5 穴，取徐长卿鲜根捣成糊状，置患处或穴上，灸 5~10 壮，每日 1 次。

(3) 艾条温和灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~10 分钟，以局部皮肤红晕为度，每日 1~2 次。

(4) 灯火灼灸：在百会、长强穴各灼灸 1 下，每日 1 次。

(5) 多虑平乳膏敷灸：取 2.5% 多虑平乳膏纳满脐窝敷灸，10 日 1 次，3 次为 1 个疗程。

(6) 乌梅膏敷灸：慢性荨麻疹取乌梅 10 枚(去核)，扑尔敏 40 毫克，甘草 6 克，共研细末，用米醋调成膏状，敷灸神阙穴，胶布固定，每日换药 1~2 次，10 次为 1 个疗程。

(7) 荆芥穗熨灸：取荆芥穗适量，切碎炒热，布包熨灸患处。

按：实验研究显示，艾灸能提高人体免疫功能，故可用于治疗荨麻疹。如累及呼吸道和胃肠道粘膜，出现哮喘、呼吸困难及呕吐、腹痛、腹泻等症状时，应配合中西药物治疗，并注意寻找过敏原，针对病因治疗。

湿 疹

湿疹是一种常见的变态反应性炎症性皮肤病。临床以多形性皮损，对称性分布，剧烈瘙痒，渗出明显和反复发作，易演变成慢性为特征。男女老幼皆可发病，而以先天禀赋敏感者为多。无明显季节性，但多有冬季复发或加重的现象，亦有相反

者。中医依其发病部位不同及皮疹的性质特点而有不同名称，皮疹泛发浸淫周身，滋水较多者称“浸淫疮”；皮疹肥厚，抓破后渗血者称“血风疮”；以丘疹为主者称“粟疮”；局限性的分别称为“旋耳疮”、“肾囊风”、“四湾风”、“乳头风”、“脐疮”等；发于婴儿面部称“乳癣”。

【病因病机】

湿疹的病因复杂，往往是多种内、外因素同时相互作用而致病。内在因素与基因遗传有一定关系，为一种迟发性变态反应，此类人对各种致敏因子较敏感。此外，某些全身性疾病、精神神经因素、过度疲劳、慢性感染病灶、新陈代谢障碍和内分泌失调等均可产生湿疹和加重病情；外在所处生活、工作环境的各种物理、化学物质刺激及食物过敏亦可诱发湿疹。中医认为，湿疹发病多为禀赋不耐，风湿热邪侵袭肌肤，或血虚有热，生风化燥，肌肤失于濡养所致。急性者一般以湿热为主，亚急性者多为风热，而慢性湿疹多为血虚风燥。

【临床表现】

临床可分为急性、亚急性和慢性3类。急性湿疹发病较快，常对称发生。可发生于身体任何部位，亦可泛发全身，但以面部的前额、眼皮、颊部、耳部、口周以及肘窝、腘窝、手、小腿、外阴和肛门周围多见。皮损多形性，同时可见潮红、丘疹、水疱、糜烂渗液、结痂、鳞屑并存。初起局部皮肤出现边界不清的水肿性红斑、瘙痒，红斑不断向四周扩展，同时出现较多的红色小丘疹，很快演变成丘疱疹。如继发感染，可成脓疱，破溃后形成红色糜烂面并有浆液或脓液渗出。瘙痒难忍，影响睡眠。一般经2~3周皮疹减退，渗液减少，结痂脱屑而趋于痊愈。亚急性湿疹为急性湿疹迁延而来，症状较为缓和，炎症有消退倾向，表现为红肿减退，渗液减少，出现鳞屑结痂，仍可见小丘

疹、丘疱疹、小水疱及轻度糜烂。病程可经数周而愈或转为慢性湿疹。慢性湿疹多为急性湿疹迁延而来或一开始就表现为慢性，患部皮肤增厚，粗糙，触之较硬，苔癣化；常见抓痕，色素沉着，间有糜烂、渗液、血痂及鳞屑，阵发性瘙痒，病程较长，可迁延数月或数年之久。

【辨证施灸】

急性湿疹多表现为湿热证，丘疹红肿浸淫成片，糜烂渗液，瘙痒剧烈，或伴发热，便秘，溲赤，苔黄腻，脉弦滑；慢性湿疹多见血虚风燥证，病程迁延，反复发作，皮疹增厚粗糙脱屑，呈苔癣样变，间见抓痕血痂，色素沉着，伴头昏乏力，舌淡，脉细弦。

治则 清热利湿，祛风止痒，养血润燥。多取阳明、太阴和督脉经穴为主。

取穴 阿是穴、大椎、曲池、神门、血海、足三里、三阴交。湿热证加陶道、肺俞、阴陵泉；血虚证加郄门、大都。

方义 阿是穴调和气血，祛风利湿止痒；大椎、陶道、曲池疏风清热化湿，配肺俞可疗皮肤之疮疡，配神门、郄门宁神止痒；血海、三阴交、足三里养血活血润燥；大都、阴陵泉清化湿热。急性期宜重灸阴陵泉、三阴交；慢性期宜重灸血海、足三里。偏湿热者加合谷、水分；偏虚者加膈俞。

灸法

(1) 艾炷灸：每次选 3~5 穴，各灸 3~5 壮，阿是穴可用小艾炷在皮损边缘围灸，皮损范围大者可于中心灸 3~5 壮，每日 1 次。

(2) 艾炷隔蒜(或黄土)灸：每穴灸 5~7 壮，隔日 1 次。

(3) 艾条熏灸：在皮损局部用艾条熏灸 5~10 分钟，使局部皮肤出现红晕为度，每日 1~2 次。

(4) 灯火灼灸：每次选 3~5 穴，各爆灼灸 1 下，并可沿皮损边缘自外向内，采用梅花灯火灸，每日 1 次。

(5) 温盒灸：慢性湿疹可在皮损局部灸至皮肤发红为度，每日 1 次。

(6) 药蒸气熏灸：取地肤子、蛇床子各 30 克，白鲜皮、苦参各 15 克，川椒 9 克，白矾 3 克，加水煮沸，对准患处，用蒸气熏灸，每日 1 次。

(7) 烟熏灸：慢性湿疹取大风子、白鲜皮各 30 克，五倍子 15 克，木香、鹤虱草各 12 克，苍术、黄柏、苦参、防风各 10 克，共研细末，用棉纸卷成药捻，点燃烟熏皮损局部，每次 15~30 分钟，每日 1~2 次。

(8) 热烘疗法：慢性湿疹取青黛膏、皮枯膏或皮脂膏涂皮损上，然后用电吹风热烘，每次 15~20 分钟，每日 1~2 次，7 次为 1 个疗程，一般 3~4 个疗程可望治愈。

(9) 热蜡疗法：慢性湿疹皮损局部可选用蜡布敷贴法、蜡液喷洒法和蜡饼敷贴法，每次 30 分钟，每日 1 次。

(10) 龙胆草(或马齿苋)敷灸：急性湿疹取龙胆草或马齿苋适量，捣烂烘热敷灸患处，每日 1 次。

(11) 复方石膏敷灸：①取煅石膏、滑石各 12 克，青黛 6 克，黄柏 3 克，共研细末，用麻油调，敷灸患处，每日 1 次。②取煅石膏 20 克，雄黄 7 克，冰片 1 克，共研细末，用凡士林调成膏状敷灸患处，每日 1 次。

(12) 复方一见喜敷灸：慢性湿疹取一见喜 6 份，枯矾 4 份，黄连、雄黄各 2 份，冰片 1 份，共研细末，用凡士林调成膏状敷灸患处，每日 1 次。

(13) 复方密陀僧敷灸：顽固性湿疹取密陀僧、黄柏各 10 克，冰片、轻粉各 3 克，共研细末，用猪油调成膏状敷灸患处，

每日 1 次(对轻粉过敏者忌用)。

按:艾灸治疗湿疹有效。皮损切勿搔抓和用热水烫洗及肥皂等刺激物洗涤。

神经性皮炎

神经性皮炎又称慢性苔藓,是以阵发性皮肤瘙痒和肥厚呈苔藓样变为特征的慢性皮肤炎症。多见于成年人。因其好发于颈项部,故中医称之为“摄领疮”,又因皮肤增厚发生苔藓样变,如牛颈之皮,厚而坚硬,故又称“牛皮癣”、“顽癣”,但与西医所说的“牛皮癣”(银屑病)不同。

【病因病机】

神经性皮炎的病因尚未完全明了,可能是自主神经系统发生紊乱而引起的一种疾病。目前认为,发病与神经因素及某些外在刺激因素有关。胃肠道功能障碍、内分泌功能失调和感染性病灶都可变成致病因素。此外,亦可继发于其它皮肤病。中医认为,本病初起多由风湿热之邪郁滞肌肤,耗血伤阴,血虚生风,或情志紧张不安,素体血虚肝旺,耗伤阴液,营阴不足,肌肤失于濡养而发病,或硬领等外来机械摩擦刺激,搔抓而引起。

【临床表现】

神经性皮炎可分为局限性和泛发性两种,临床以局限性多见。绝大多数发于颈后和侧面,其次是骶部、四肢伸侧、前臂、股内侧、阴囊和会阴等部位,泛发者还可见于眼睑、肘窝、腘窝、头皮、躯干等处。分布广泛,阵发性瘙痒,搔抓或摩擦后形成圆形或多角形扁平丘疹,淡褐色或正常肤色。日久皮肤增厚,皮纹变深,呈苇席状,苔藓样变,皮损干燥,边界清楚,有细小鳞屑。由于瘙痒搔抓,局部可见抓痕血痂,或继发感染。皮

疹久之融合成片，症状时轻时重，常多年不愈，愈后极易复发。

【辨证施灸】

临床可分为风湿热型和血虚风燥型。前者病程较短，皮损潮红湿润，糜烂或有血痂，苔薄白或黄腻，脉濡数；后者多见于年老体弱者，病程较长，皮损色淡或灰白，干燥肥厚，粗糙脱屑，状如牛颈之皮，伴头晕目眩，失眠神疲，舌淡苔薄，脉细弱。

治则 疏风清热利湿，养血祛风润燥。取阳明、太阴经穴为主。

取穴 阿是穴、膈俞、风池、曲池、合谷、血海、三阴交、行间。

方义 阿是穴疏通局部经络，止痒退癣；膈俞、血海活血养血润燥；风池、曲池、合谷疏风清热；三阴交调补三阴以祛湿止痒；行间疏风清热行气。风湿热证加太渊、太白、阴陵泉；偏血虚风燥加足三里，重灸膈俞；瘙痒难眠者加神门、照海。

灸法

(1) 艾炷灸：先在皮损处涂上蒜汁，放置艾炷，每炷间隔 1.5 厘米。点燃施灸，灸后覆盖消毒敷料，每日 1 次，灸至皮损正常为止，怕痛者可于艾炷未燃尽前压灭。灸后灸点处的皮肤变焦黄，结痂后 2~3 日脱落，如形成灸疮可行局部处理，一般不留瘢痕。

(2) 艾炷隔莱菔根灸：取鲜莱菔根切成 0.2 厘米薄片，用针刺数孔，置患处上放艾炷灸 5~7 壮，隔日 1 次。

(3) 艾炷隔蜂房灸：每次选 3~5 穴，取炒蜂房末适量，用黄酒调制成厚约 0.5 厘米小圆饼，放穴位上，上置艾炷灸 3~5 壮，隔日 1 次。

(4) 艾灸熏灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~10 分钟，局部可围绕皮损区从周围向中心直接熏灸或隔姜灸，每次 30 分钟，30 次为 1 个疗程。

(5) 丹药灸:取硫黄 15 克,水飞朱砂、樟脑各 4.5 克,麝香 1.5 克,依法制成丹药,直径 0.2 厘米~0.3 厘米,将药粒置皮损上点燃施灸,待火熄灭后连灰罨在皮损上,每点只灸 1 壮,如皮损面积较大,可连排药粒数枚(间隔 0.5 厘米~1.0 厘米),1 次点燃施灸,灸后注意保护灸疮,每 10 日 1 次。

(6) 烟熏灸:①同湿疹。②取艾绒、白芷、苍术各 15 克,银杏、苦参各 12 克,硫黄 6 克,共研细末,用棉纸卷成药捻点燃熏患部,每次 15~20 分钟,以皮肤有温热感为度,每日 1 次。

(7) 热烘疗法:在皮损上均匀涂以极薄风油膏后,用电吹风热烘,每次 15~20 分钟,每日 2 次,10 次为 1 个疗程,3~4 个疗程可治愈。

(8) 热蜡疗法:同湿疹。

(9) 轻陀散敷灸:取密陀僧 15 克,冰片 9 克,轻粉 5 克,共研细末,用茶油调成糊状,敷灸患处,每日 1 次(对轻粉过敏者忌用)。

按:艾灸治疗神经性皮炎,近期疗效较好。皮损治愈后仍需治疗一段时间,以巩固疗效,并应保持情绪稳定,心情舒畅,避衣领摩擦,切忌搔抓及用热水烫洗,勿乱用刺激性强的药物外涂,忌食辛辣荤腥发物,多食水果。

硬 皮 病

硬皮病是一种结缔组织疾病,以局部皮肤硬化、萎缩为特点的疾病。好发年龄为 20~50 岁,女性多于男性。可归属于中医的痹症中之“皮痹”、“肌痹”范畴。临床所见有局限性和系统性硬皮病两种,本节主要讨论局限性硬皮病。

【病因病机】

病因未明,目前认为与感染或感染诱发自身免疫功能异

常,血管、结缔组织代谢异常及遗传等因素有关。中医认为,本病的发生多由素体阳气衰微,气血不足,卫外不固,风寒湿邪侵袭,寒凝肌腠,以致营卫不和,气滞血瘀,血行不畅,络道闭塞不通所致。

【临床表现】

本病多见于青年女性,病变主要侵犯皮肤某一部位,好发于面颈部、躯干及臂部。皮损形态不一,可呈点状、片状或带状,其发病过程可分为局限性肿胀、硬化和萎缩3个阶段。初起为大小不等的淡红色或紫红色略带水肿的斑片,边缘略高于皮面,渐向周围扩大,以后自中心开始变硬,呈淡黄色,表面光滑发亮,皱纹消失,可有毛细血管扩张,界痕显著,周围有时绕以紫红色红晕,中间凹陷,与皮下组织紧紧相连,触之韧硬,表面干燥无汗,毳毛脱落,皮损逐渐萎缩变薄,常发生色素沉着。一般无自觉症状,有时仅有轻微痒感或刺痛感。

【辨证施灸】

临床可见气血瘀阻和肾阳衰微两型。前者以局部皮肤硬化,表面光滑发紧,不易捏起,日久硬化之皮肤萎缩变薄,呈黄白色,肌肤甲错,舌淡苔白,脉细滑或沉迟;后者皮肤顽硬而肿,继之变形,光亮如蜡,多见于指端,重者泛发全身,手足紫绀、厥冷,关节酸痛,活动不利,畏寒疲惫,胸满气急,吞咽困难,舌淡胖嫩,脉沉伏或沉紧。

治则 祛风散寒除湿,温补肾阳,活血化瘀。

取穴 皮损区、大椎、肺俞、膈俞、脾俞、肾俞、命门、神阙、气海、关元、血海、足三里、阴陵泉、三阴交。

方义 皮损区疏通局部气血;大椎通阳活络;肺俞、脾俞、肾俞益气除湿,温阳散寒;膈俞、血海和营活血化瘀;命门、关元、神阙温肾培元,壮阳散寒;气海益气和血祛寒湿;足三里调

和气血,通经活络,疏风化湿;阴陵泉健脾化湿,通利三焦气机;三阴交调气血,通经络。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日或隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。

(2) 艾炷隔附子饼灸:每次选 3~5 壮,各灸 3 壮,每周 2 次,30 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 10~20 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(4) 丁香桂散敷灸:取丁香散(丁香、肉桂各等份)填平脐窝,上置艾炷灸 3 壮,每日 1 次。

(5) 复方桃柳桑槐榆枝膏敷灸:取桃、柳、桑、槐、榆枝各 33 厘米(切碎),三七、乳香、没药、羌活、千年健、鸡内金各 15 克,共置 500 毫升麻油中炸枯去渣,对入黄丹适量调成膏状敷灸患处,每日更换 1 次。

按:艾灸可使甲皱循环明显改善,并可使低于正常值的淋巴细胞转换率明显提高,故通过艾灸温肾助阳、祛风散寒、活血化瘀的作用,促进机体血液循环和改善免疫功能,这对硬化的皮肤恢复是很有益的。

外阴白斑病

外阴白斑病是指妇女外阴部呈现白色斑块,或增厚发硬萎缩为特征的疾病。中医无本病记载,某些症状类似于“阴疳”、“阴蚀”和“阴痒”。多见于中、老年妇女,常发生在绝经期前后。

【病因病机】

本病的病因目前尚不清楚。多继发于原发性外阴萎缩和

硬化萎缩性苔藓，与女性内分泌变化如绝经等也有关系，外阴的局部环境如潮湿、热等物理刺激也可引起女阴白斑。中医认为，本病是由于年老体弱，肝肾不足，或久病不愈，阴血虚耗，或情志不和，肝郁气结，血燥化风，复兼湿热下注损伤冲任而发病。

【临床表现】

外阴及肛门处皮肤变白增厚，病变皮肤与正常皮肤分界明显，局部瘙痒，因痒而搔抓后可引起湿疹样变、苔癣化、皲裂、糜烂和继发感染，并有隐痛或烧灼样痛。患者常有性生活困难。

【辨证施灸】

临床可分湿热和阴虚两型。前者外阴瘙痒，甚则痒痛，坐卧不安，阴部皮肤变白增厚，带下量多色黄，伴胸闷纳少，苔黄腻，脉濡数；后者阴部灼热痒痛，皮肤萎缩色白，带下量少，伴烦热口干，腰酸痛，舌红少津，脉细数。

治则 清热利湿，祛风润燥，调理肝肾。

取穴 白斑局部、大肠俞、中膂俞、中极、曲骨、足三里、三阴交。

方义 白斑局部可疏通经络气血；大肠俞、中膂俞通肠利腑，清利湿热；中极、曲骨调经止带，清热利湿；足三里、三阴交健脾滋阴，调和气血。

灸法

(1) 艾炷化脓灸：每次选 1~2 穴，各灸 5~7 壮，每月 1 次，3 次为 1 个疗程，灸后发疱化脓，形成灸疮，注意保护灸疮。

(2) 艾炷(或隔姜)灸：每次选 3~5 穴，各灸 5~7 壮，隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

(3) 艾条温和灸：每穴灸 10 分钟，白斑局部可灸 20~30 分钟，以局部有温热感为度，每日 1 次。

(4) 温针灸:在肾俞灸2壮(或10分钟),每日1次,10次为1个疗程。

按:艾灸治疗白斑病,在止痒、止痛及白斑转化方面均有较好疗效,但病变严重时需配合中西药物治疗,并注意保持外阴部清洁干燥,切勿搔抓。因本病有恶变倾向,应注意观察。

六、健 美

单纯性肥胖症

肥胖是由于人体代谢失调而造成脂肪组织过多。单纯性肥胖多由于摄入食物的热能大于人体活动需要的热能,体内脂肪积聚过多,体重超过正常标准20%以上者称肥胖症。成人标准体重=[身高(厘米)-100]×0.9(身高在150厘米以上者);儿童标准体重=年龄×2+8;肥胖度(%)=(实际体重-标准体重)×100/标准体重。肥胖症可发生于任何年龄,但以40岁以上多见,且女性多于男性。近年来随着人们生活水平的提高,肥胖的人日益增多,尤以儿童发病率增多较快。目前研究表明,肥胖症是多种疾病的预兆,成人过于肥胖则易患冠心病等多种疾病;小儿患肥胖症可不同程度地影响大脑的发育。所以,对肥胖症不能掉以轻心,应积极治疗。

【病因病机】

单纯性肥胖除部分与遗传因素有关外,主要是饮食过多,摄入高蛋白、高脂肪及高糖类食物,并缺乏运动而引起体内热能的摄入与消耗不平衡,形成脂肪堆积而发胖。中医认为,过食肥甘厚腻,贪图安逸,或情志不畅,导致脾胃运化失常,产生水湿痰浊内停,流溢肌肤,蓄积于皮里膜外而肥胖。

【临床表现】

临床有自幼即较胖且有家族史的体质性肥胖症和嗜食肥甘厚腻的过食性肥胖,共同特点是形体肥胖,女性主要表现在下腹部、臀部、乳房部及下肢;男性则以头、躯干为主,体重增加,超过标准体重 20% 以上。轻度肥胖常无自觉症状;中、重度者大腹便便,身体各器官负担加重,常感劳累,动则气促,心跳增快,多汗怕热,但一般无明显神经、内分泌功能障碍症状,部分肥胖者可出现肺泡换气受限综合征,常伴发糖尿病、高血压、高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、脑血管病、胆囊炎、胆石症等。女性可伴月经失调、闭经及不孕。

【辨证施灸】

辨证可分脾虚湿盛和胃强脾弱两型。前者饮食不多,形体肥胖,肌肉组织松弛,嗜睡倦怠,少气懒言,动则汗出,大便溏薄,舌淡胖,脉沉濡;后者饮食倍增,形体肥胖,肌肉组织结实,胸脘痞闷,口渴口臭,便秘溲赤,苔腻,脉滑数或弦数。

治则 健脾益气,化痰祛湿或清胃泻火。

取穴 主穴取三焦俞、阳池,配穴取大椎、命门、三阴交、地机。

方义 三焦俞、阳池有疏利三焦的作用,合三阴交、地机健脾利湿;大椎为诸阳之会,总督一身之阳,益气补虚;命门壮阳补肾,诸穴合用健脾补肾,化痰利湿以达减肥健身的目的。

灸法

(1) 艾炷隔姜灸:每次选主配穴各 1 个,各灸 5~6 壮,每日 1 次,30 次为 1 个疗程。

(2) 热砂浴法:可选用全身浴法,将热砂调配到所需的温度,放进长方形的木槽中,砂厚 8 厘米~12 厘米,患者裸卧在热砂上,身上再覆盖 5 厘米~10 厘米厚的热砂,头颈及胸部

露在外面,腹部砂应盖薄一些,外生殖器用白布遮盖,头部及心前区用冷敷,最后用床单将剑突以下部位覆盖起来。初次进行砂浴时,砂的温度不宜太高,一般以 45℃ 为宜,以后逐渐增加到 50℃~55℃。治疗时间也不宜过久,一般以 10~15 分钟为宜,以后逐渐增加至 30~40 分钟。治疗结束后,用 37℃ 温水冲洗,卧床休息 20~30 分钟。隔日 1 次,15 次为 1 个疗程。如在海滩、河滩或日光浴场进行砂浴,治疗后可用海水或河水冲洗,然后静卧在遮荫处休息 20~30 分钟。

按:肥胖患者会发生各种并发症而影响寿命。因此,及时采取有效的减肥措施,不但可以健美,还可预防疾病,有利于健康长寿。目前减肥的方法很多,肥胖者可以根据自己的特点选用。灸法减肥,以治疗单纯性肥胖为主,并可以结合针刺等方法综合治疗,效果会更佳。

消 瘦

消瘦是指体重低于正常标准 20% 以上,且非继发于其它疾病的体重下降者。可发生于任何年龄。中医称为“羸瘦”。

【病因病机】

消瘦原因复杂,除了个别患者长期饮食不足,摄入热能不够,营养缺乏者外,多与遗传因素、精神因素及自身消化吸收功能有关。儿童消瘦多为长期不良的饮食习惯及饮食失调,消化吸收功能受损,摄入热能不足引起;成人消瘦多为情志不畅,饮食不节,损伤脾胃,导致运化失司,消化吸收功能障碍而成。此外,近些年来,某些女青年受减肥热的影响,追求苗条美,盲目过度节食,导致体内营养物质缺乏而消瘦。中医认为,消瘦多由先天不足,或饮食失节,起居失常,或精神抑郁,或恣情纵欲而致脾肾不足,运化不健,气血亏虚,营养缺乏,不能润

养肌肤而致消瘦。

【临床表现】

形体消瘦,体重下降超过正常标准 20%以上,并非患病所致者。一般无明显症状,严重者可出现精神不振,怕冷不耐寒,全身无力,皮肤皱纹明显,或有精神厌食症。如极度消瘦则可影响发育,甚至影响生命。

【辨证施灸】

临床可分为脾肾亏虚和肝肾阴虚两型。前者纳呆消瘦,兼气短懒言,畏寒倦怠,面色萎黄,形体憔悴,舌淡,脉细无力;后者食欲不振,肌肉消瘦,兼心烦易怒,烦热盗汗,腰膝酸软,面色黧黑,舌红少苔,脉细数。

治则 健脾益气,滋补肝肾。

取穴 百会、陶道、身柱、神道、灵台、至阳、脾俞、胃俞、肾俞、命门、中脘、气海、关元、足三里。

方义 百会升阳益气;陶道、身柱、神道、灵台、至阳疏通经络,调理气血,通一身之阳气;脾俞、胃俞、中脘、足三里健脾和胃,消食化滞,益气化湿;肾俞、命门、气海、关元补肾壮阳,扶正培元,益气强壮。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 5~7 壮,隔日 1 次,持续 2~3 个月。

(2) 艾条温和灸:每次选 3~6 穴,各灸 10 分钟,每日 1 次,持续 2~3 个月。

面部皮肤皱纹

【病因病机】

引起面部皱纹增多的原因很多,除了遗传因素影响外,与

多种慢性疾病、内分泌功能障碍及皮肤血液循环障碍有关。凡能引起维护皮肤正常张力的弹力纤维减少,皮脂腺减弱,皮下脂肪减少,使皮肤与其皮下组织间过于松弛的原因,均可使面部出现皱纹或使原有皱纹加深。除此之外,某些职业、吸烟、长时间日晒,或长期面部一定的运动和固定某一睡眠位置,亦可引起局部组织缺氧而使皱纹加重。中医认为,皱纹的发生是由于禀赋不足,脾胃虚弱,饮食偏嗜,恣情纵欲,劳神过度等导致营养不足,精血衰少,皮肤失于濡养,促使早衰而产生皱纹。此外,情志内伤,肝气郁结,气血运行不畅,面部血脉瘀滞亦可促使皱纹出现。

【临床表现】

面部额纹、鱼尾纹、面颊纹、耳前区纹、口角纹、颈部纹提早出现或明显增多及深于相应年龄,影响容貌美观,外观给人以衰老感。

【辨证施灸】

面部皱纹过早出现或增多,有血虚及血瘀两情况。前者面额皱纹多且明显,兼气短懒言,面色无华,纳呆身重,腰膝酸软,舌淡苔白,脉细;后者面颈部皱纹深显,伴四肢头面偶发或继发老年斑,皮肤干燥脱屑,舌紫暗或有瘀点瘀斑,脉沉涩或沉弦。

治则 补养气血,活血化瘀。

取穴 百会、阳白、印堂、颧髎、下关、翳风、扶突、膈俞、肾俞、神阙、阿是穴。

方义 阿是穴及邻近穴位可疏通局部经络气血,除皱纹;百会益气升阳;膈俞养血活血化瘀;肾俞补肾益精化血;神阙补益脾胃,培元固本。

灸法

(1) 艾炷隔姜(或附片)灸:在神阙隔日晚上睡前施艾炷隔姜(或附片)灸 3~5 壮,灸至局部温暖舒适,皮肤红润为度,30 次为 1 个疗程。注意防止烫伤皮肤。

(2) 艾条温和灸:每次选 2~3 穴,各灸 10 分钟,以局部温热舒适,皮肤红润为度,每日或隔日 1 次,30 次为 1 个疗程。体型虚胖可加肝俞、脾俞、膀胱俞穴;体型瘦弱加胃俞、小肠俞、大肠俞穴;体型正常加气海、关元、足三里等穴。

(3) 太乙神针灸:取艾叶、防风各 200 克,甘草 100 克,乳香、苍术、没药、肉桂、川椒、钻地风、千年健、穿山甲、小茴香各 50 克,三七 24 克,人参 20 克,干山羊血 10 克,共研细末,加麝香少许混匀,依法制成药物艾条,施灸时取药条点燃,以数层粗布包裹,趁热按灸皱纹局部,冷后重燃再灸,每灸 5~7 次,30 次为 1 个疗程。

(4) 复方大黄敷灸:取大黄、姜黄、南星、白芷、紫荆皮、大柏皮、赤小豆、寒水石各等份,共研细末,用生地汁调成膏状,每晚敷灸眼袋区,次晨洗去,30 次为 1 个疗程。

按:艾灸能使面部气血通畅,并能调整内分泌功能,从而有利于消除皱纹和预防未老先衰,通过艾灸治疗后,可使面部皮脂腺分泌协调,促进皮肤光洁柔润。但艾灸疗法属全身调整性疗法,治疗周期长,非短时间所能奏效,故应坚持长期治疗才能收效。同时,要注意皮肤保养,尽量避免长时间日晒,还需戒烟并变换调整睡眠体位,这对预防加重皱纹有积极意义。此外,还应积极治疗所患慢性疾病,加强营养,使身体壮实,气血充盛,皮肤丰润,这是防止皱纹提早出现或加重的关键。

黄褐斑

黄褐斑是发生于面部的黄褐色色素沉着斑片,以面部对

称出现不规则蝶状褐色斑片为特点。好发于青年女性及中年以后男子。由于妊娠妇女和肝病患者常出现黄褐斑,故又有“妊娠斑”、“肝斑”之称,俗称“蝴蝶斑”。属中医的“面尘”、“黧黑”范畴。

【病因病机】

黄褐斑的病因比较复杂,至今尚无定论。一般认为,内分泌变化是主要病因,可能是性激素和自主神经功能紊乱引起。其它,如某些药物和疾病,以及日晒等外界物理因素刺激,也可促使本病的发生或加重。中医认为,多因肾气不足,肝郁气滞,血瘀颜面;脾气不旺,气血不能润泽颜面,以及虚火湿浊熏蒸颜面致生褐斑。此外,妇人经血不调,亦可生斑。

【临床表现】

面部颧、额、颊、鼻、上唇及眼眶周围可见对称分布的淡褐色或黑褐色斑片,界痕清晰,边缘不整,形如地图或蝴蝶,表面光滑,不伴红斑浸润或其它皮疹,无鳞屑及自觉症状。病程较长,发展缓慢,日晒加重。

【辨证施灸】

黄褐斑与肝郁、脾虚、肾亏关系密切。肝郁者兼见胸脘痞闷,两胁胀痛,心烦易怒,腹胀便溏,妇人月经不调,舌暗红或有瘀点瘀斑,脉弦滑;脾虚者兼见面色萎黄,气短乏力,腹胀纳差,月经量少,舌淡胖,边尖有齿痕,脉虚弱;肾亏者兼见面色黧黑,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,舌红少苔,脉细数。

治则 疏肝解郁,健脾补肾,活血祛瘀。

取穴 四白、迎香、肝俞、脾俞、肾俞、气海、足三里、三阴交、太溪、褐斑局部。

方义 褐斑局部及临近穴位有疏通气血,活血祛瘀除斑的作用;肝俞疏肝解郁,理气化滞祛瘀;脾俞、肾俞调补脾肾,

清热除湿；气海益气补肾，调理冲任；足三里健脾益气生血；三阴交调补三阴经，行气活血；太溪滋肾清虚火调冲任。

灸法

(1) 艾炷无瘢痕灸：在褐斑区灸 3~7 壮，以局部皮肤温热舒适、皮肤红润为度，隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(2) 艾条雀啄灸：在褐斑局部灸 5~10 分钟，灸至皮肤红润为度，隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。注意勿烫伤皮肤。

(3) 温针灸：每次选 3~5 穴，各灸 2 壮（或 5~10 分钟），隔日 1 次，7 次为 1 个疗程。

(4) 密陀僧敷灸：每晚取密陀僧末 20 克，用人乳或牛乳调成糊状，敷灸褐斑上，次晨洗去。

(5) 冬瓜瓢杏仁敷灸：每晚取冬瓜瓢 50 克，杏仁 15 克，共捣烂敷灸褐斑上，次晨洗去。

(6) 瓜蒌瓢敷灸：每晚取瓜蒌瓢 90 克，杏仁 10 克，猪胰 1 具，共捣烂，取适量敷灸褐斑上，次晨洗去，10 次为 1 个疗程。

(7) 复方白芷敷灸：取白芷、白丑、白僵蚕、白蒺藜各 10 克，白茯苓 15 克，共研细末，用牛乳或麻油调成糊状，每晚敷灸褐斑上，次晨洗去。

按：黄褐斑病因未明，目前无特异性治疗，尚难于根治，除选用艾灸治疗外，尚可在医生指导下选用副作用较少的中西药物治疗。平时注意精神调节和饮食调养，保持心情舒畅，避免偏嗜五味及日光暴晒，对防止黄褐斑加重有积极意义。不要滥用内服或外用药物，如果是由于服用某些药物引起者应停药；如果是某些慢性疾病引起者应积极治疗原发病。

雀 斑

雀斑是一种黑色素增多，在鼻面部形成褐色斑点为特征

的皮肤病。因其如同雀卵上的斑点而得名。多发于青春期少女,亦有儿童期即开始发病的,随着年龄的增长而逐渐增多,至青春期后达到高峰,多有遗传倾向,女性多于男性,白种人多于黄种人。中医也称“雀斑”,文献有称“面肝”、“面黧”者。

【病因病机】

病因复杂,一般认为与遗传因素有关,因日晒可使其加重,故有人认为雀斑是一种光损伤性皮肤病。中医认为,本病多因禀赋肾水不足,不能荣华于面,或虚火上炎,日晒热毒内郁蕴结为斑,或腠理不密,外卫不固,风邪外搏,肌肤失于荣润而成雀斑。

【临床表现】

鼻面等暴露部位可见针尖到米粒大小的圆形或椭圆形斑点,数目多少不定,散在或密集,对称分布,互不融合,界痕清晰,边缘整齐,表面光滑,无鳞屑和渗出,无自觉症状。夏季日晒后颜色加深,数目增多,损害变大,冬季则相反。多见于皮肤白皙的女子。

【辨证施灸】

根据临床表现特点,主要分为肾水不足或风邪外搏。前者自幼发病,多有家族史,皮损色深而大;后者多无家族史,皮损色浅而小。

治则 滋阴补肾,降火散结,或凉血活血,祛风散火。

取穴 雀斑局部、大椎、曲池、三阴交。

方义 雀斑局部疏通经络气血,祛风散结除斑;大椎、曲池疏风清热,行气活血;三阴交调补肝脾胃,凉血活血。

灸法

(1) 艾条温和灸:每穴灸 10~20 分钟,以局部皮肤红润为度,每日或隔日 1 次,10 次为 1 个疗程,症状好转后改为两

周 1 次,坚持长期治疗。

(2) 火针疗法:根据雀斑深浅、大小分别选用粗、中、细 3 种规格火针点刺,点刺后斑点变成灰白色而结痂,2 周结痂脱落,雀斑消退。注意消毒,保护创口,防止感染。

(3) 白丑茯苓敷灸:取白丑 15 克,白茯苓 10 克,共研细末,白蜜或鸡蛋清调膏,每晚睡前敷灸雀斑上,次晨洗去。

(4) 鸬鹚骨灰敷灸:取鸬鹚骨灰、白芷各适量,用猪油调膏,每晚睡前敷灸雀斑,次晨洗去。

(5) 复方密陀僧敷灸:①取密陀僧 15 克,硫黄 10 克,轻粉 6 克,共研细末,用白蜜或鸡蛋清调膏,每晚睡前敷灸雀斑,次晨洗去。②取密陀僧、硫黄、蓖麻子仁各等份,共研细末,用羊骨髓调膏,外敷雀斑,每晚 1 次。

按:雀斑大多与遗传有关,目前无特异性治疗,根治困难,艾灸可作为辅助治疗。平时避免日光暴晒,切勿滥用各种内服或外用药物,忌服光敏性药物及食物。

白 癜 风

白癜风,是一种获得性皮肤色素脱失而发生的局限或泛发性白色斑片性皮肤病。中医称“白癜”、“白驳风”。可发生于任何年龄,但以青壮年多见。

【病因病机】

病因未明,目前认为与遗传、自身免疫、黑色素细胞自身破坏、神经化学因子等因素有关。此外,内分泌失调,强烈日晒,接触某些化学物质、感染等疾病均有诱发白癜风的可能,也偶有因外伤引起者。中医认为,本病多因情志内伤,肝郁气机不畅,或亡血失精,气滞血瘀,血不荣肤而酿成白斑。

【临床表现】

本病常偶然发现。皮损可发生于任何部位,但以面颈和手背多见。皮损为形态各异、大小不等的圆形或不规则形的白色或乳白色的斑点或斑片,逐渐扩大,表面光滑,无鳞屑,不痛痒。边界清楚,边缘可有色素沉着带,中央有岛状褐色斑点。患处毛发也可变白,可单发,也可多发或泛发,常对称分布。本病不危及健康,但患病后影响美观,可使患者精神不安。病程缓慢,往往经年累月难愈,长期存在,持续终身,但亦有少数病轻者可自行消失。

【辨证施灸】

本病初起多属气血不和,皮损色白,边缘整齐,斑内毛发变白,多发于颜面四肢,有些白斑排列与局部经络循行相仿,舌淡苔白,脉细;病程长久或外伤引起者,可出现气滞血瘀症状,白斑扩大或泛发全身,白斑中心可出现色素岛,舌暗或有瘀点瘀斑,脉细涩。

治则 疏风通络,调和气血,或疏肝理气,活血化瘀。

取穴 肺俞、曲池、阳陵泉、足三里、三阴交、白斑局部。

方义 白斑局部调和气血,疏风祛斑;肺主皮毛,肺俞通达皮毛,促气血润养肌肤,是治疗皮肤病之要穴;曲池宣通毛窍,祛风通络;阳陵泉和营活络,通达肌表;足三里调理气血;三阴交滋阴凉血,祛瘀除斑。斑发头面加昆仑、阳谷;斑在上肢加手三里、中渚;斑在下肢加风市;斑生阴部加丘墟、太冲。

灸法

(1) 艾炷灸:每次选 3~5 穴,各灸 3~5 壮,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。白斑范围大者,可于斑内增灸数点。

(2) 药炷灸:取当归、桑叶、五倍子、白蒺藜、威灵仙各 100 克,石菖蒲、白芥子各 30 克,全蝎 10 克,共研细末,制成药炷

在患处灸 3~5 壮,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(3) 艾炷隔蒜灸:在白斑上隔蒜灸 3~5 壮,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(4) 艾条温和灸:每次选 3~5 穴,各灸 20 分钟,每日 2 次,20 次为 1 个疗程。初始施灸时,应灸至白斑局部皮肤高度充血呈粉红色,灸 7~8 次后,每次灸至深红色或接近肤色为宜,一般灸 30 次以后,白斑可转正常肤色或接近正常肤色。

(5) 温盒加梅花针灸:先用梅花针叩刺白斑至微出血后,再用温盒灸 15~20 分钟,每日 1 次,10 次为 1 个疗程。

(6) 火针灸:用细火针轻轻(针尖刺入皮肤约 1 毫米)点刺皮损处,每平方厘米约点刺 10 针,点刺后消毒包扎,防止感染。

(7) 斑蝥酊发泡灸:取斑蝥酊灸液涂擦白斑上,涂药 2~8 小时后即出现水疱,用消毒针头刺破水疱,3~5 日结痂脱落,每周 1 次,7~8 次后白斑可愈。

按:白癜风病因未明,目前无特异性治疗,根治困难,艾灸治疗有一定效果,少数病人可以治愈或减轻。平时适当进行日光浴有助白斑减轻。

斑 秃

斑秃是一种以头发突然成片脱落,局部皮肤正常,无明显自觉症状的皮肤病。中医称“油风”,俗称“鬼舐头”、“鬼剃头”等。可发生于任何年龄,但以青年人患病更为普遍。

【病因病机】

斑秃的病因尚未完全清楚,可能与中枢神经系统功能紊乱及自身免疫性疾病有关。临床往往在过度劳累、睡眠不足、精神紧张或受刺激后发病;内分泌障碍、局部病灶感染、肠道

寄生虫病或其它内脏疾病等也可成为诱因。此外,有人提出可能与遗传因素有关。中医认为,斑秃是由于血虚不能濡养肌肤,风邪乘虚外袭,风盛血燥,发失所养而成片脱落;或因情志抑郁,肝郁气滞血瘀,毛发失养所致。又因肝藏血,发为血之余,肾藏精,其华在发,肝肾不足,亦可导致脱发。

【临床表现】

脱发前无自觉症状,起病多突然,常被别人发现或患者自己在无意中发现头发呈圆形或不规则形成片脱落。大小、数目不等,大的如钱币,小的如指甲。患部皮肤平滑光亮,无炎症现象。有的可继续进展,范围扩大,数目增多。少数(约5%~10%)头发可全部脱光,称全脱。个别严重者甚至眉须、腋毛、阴毛乃至全身毳毛也全部脱落,称普脱。病程较长,可达数月甚至数年,有半数以上可以自愈,但可复发。

【辨证施灸】

本病的辨证在于辨别血热、血瘀和血虚。血热者多见于青年人或肥胖者,发落肤痒,头皮油质分泌物较多,伴心绪烦乱,口渴,便秘溲赤,或纳差便溏,舌红苔黄,脉滑数;血瘀者头发大片或全部脱落,甚或发生普脱,日久不长,伴头痛寐差,胸胁胀痛,面色黯晦,舌有瘀点,脉细涩;血虚者多发于病后、产后,头发细软,干燥少华,成片脱落,渐进性加重,伴头晕失眠,心悸健忘,舌淡苔薄,脉细;肝肾不足者,患者年龄多数较大,平素头发焦黄或花白,头发大片脱落,甚至全脱或普脱,伴头晕耳鸣,腰酸膝软,畏寒肢冷,面色苍白等。

治则 血热者凉血清热消风;血瘀者活血祛瘀通窍;血虚者益气补血祛风;肝肾不足者滋补肝肾。

取穴 风池、肝俞、脾俞、肾俞、斑秃局部。

方义 风池疏风清热;肝俞、脾俞、肾俞健脾益气,养血祛

风,调补肝肾;斑秃局部疏通气血,祛瘀消风生发。血热加曲池、气海;血瘀加膈俞、丘墟、太冲;血虚加足三里;肝肾不足加三阴交、太溪。

灸法

(1) 艾条温和灸:每次选3~5穴,各灸5~10分钟,局部灸10~20分钟,每日1次,10次为1个疗程。

(2) 梅花针艾条灸:在斑秃局部先用梅花针叩刺至微出血,用干棉球擦去血迹后再用艾条熏灸10~20分钟,隔日1次,10次为1个疗程。

(3) 梅花针生姜艾条灸:在斑秃局部先用梅花针叩刺至微出血,再用姜片擦局部至有灼热感,然后用艾条熏灸2~3分钟,隔日1次,10次为1个疗程。

酒渣鼻

酒渣鼻俗称“红鼻子”,是一种以鼻面部皮肤弥漫性潮红,上起丘疹、结节或脓疱及毛细血管扩张,最后形成鼻赘为特征的慢性皮肤病。中医称“酒皴皮”、“酒糟鼻”等,多见于中壮年人或嗜酒之人。

【病因病机】

病因不甚明确,可能是在皮脂溢出的基础上,由于寒湿、饮食、精神等多种刺激因素,以及内分泌失调、胃肠功能紊乱、病灶感染等引起患处血管舒缩神经失调,毛细血管长期扩张所致。此外,有人认为与毛囊螨虫感染有关。中医认为,本病主要由于过食辛辣、肥甘厚味,以致肺胃积热上蒸,复遇风寒外束,血瘀凝结而成;或偏嗜酒浆,酒气熏蒸,复遇风寒之邪交阻肌肤而致。

【临床表现】

皮损以红斑为主,多累及鼻准、鼻翼两侧,也可延及两颊、前额,常对称分布。病程经过缓慢,可时轻时重,依临床特点可分为红斑、丘疹、鼻赘三期。初始鼻部皮肤为弥漫性红斑,时现时隐,寒冷刺激、进食辛辣食物或情绪激动时更为显著。以后渐成持续性红斑,鼻头红赤,局部皮肤油腻,多伴皮脂溢出和毛细血管扩张。日久在红斑的基础上出现散在性痤疮样小丘疹或脓疱,毛细血管扩张更为显著,呈血丝显露,如红丝缠绕,自觉瘙痒。病至晚期,鼻部皮色渐由鲜红变成紫褐,局部皮肤增生肥厚,鼻尖上丘疹增大融合,形成大小不等的乳头样结节,呈瘤状隆起,形成鼻赘。

【辨证施灸】

初期鼻部以红斑为主,属肺胃积热,进刺激性食物或激动时明显,渐出现丘疹、脓疱,伴口渴,便秘溲赤,舌红苔薄黄,脉滑数或弦数;病久鼻部皮肤紫黯或紫褐,皮肤增厚,结节隆起,表面凹凸不平,终致瘀血结聚形成鼻赘,舌黯红或有瘀点瘀斑,脉弦涩。

治则 清阳明胃热兼凉血化瘀祛斑。取阳明经穴为主。

取穴 素髻、迎香、鼻通、天府、侠白。

方义 素髻清肺治鼻疮;迎香疏风散热;鼻通清热解毒;天府清肺热;侠白行气活血。

灸法

(1) 艾炷无瘢痕灸:每次选2~3穴,各灸5~7壮,15次为1个疗程。注意防止烫伤皮肤。

(2) 复方密陀僧敷灸:取密陀僧、轻粉、白矾各3克,硫黄30克,或密陀僧、冰片各6克,白附子、白芷、滑石各15克,干荷花60克,绿豆750克,共研细末,每晚睡前用温水调成糊

状,敷灸患处,次晨洗去。注意本方有毒,切勿入口。

(3) 复方桃仁珍珠敷灸:取桃仁、麻仁各 9 克,珍珠 1.5 克,轻粉、红粉各 0.15 克,共研细末,用猪脂调成膏状,每晚敷灸患处,晨起洗去。本方有毒,切勿入口。

(4) 硫黄敷灸:取白萝卜 1 个挖空,将硫黄适量放入萝卜内封固,置糠火中煨一宿,取出加轻粉、乌头尖各少许,共研细末,用酥油调成膏状,每晚敷灸患处,晨起洗去。本方有毒,切勿入口。

按:酒渣鼻病因未定,目前无特异性治疗,可选用艾灸等方法进行综合治疗,平时应避免精神紧张和冷热刺激,饮食宜清淡,忌烟酒及进食辛辣等刺激性食物,保持大便通畅有助于减轻症状。

臭汗症

大汗腺分泌的汗液有特殊臭味者称臭汗症,又称体气。以腋窝、外生殖器等部位较常见,故又称“腋臭”。中医称之为“狐臭”、“腋气”、“腋漏”等。多见于青壮年,以女性较多,常始于青春期,老年以后逐渐减轻或消失。

【病因病机】

本病属遗传性疾病。人体大汗腺分泌的汗液中含有大量的有机物质,经局部细菌作用后,产生不饱和脂肪酸,放出特殊臭味而形成汗臭。中医认为,本病与先天禀赋有关,由湿热内蕴,气血不和,浊气随汗从毛孔而出形成汗臭。

【临床表现】

本病多发生在大汗腺发达部位,以腋窝最为明显,常有特殊臭汗味散发,但轻重不一,轻者在不出汗时,几乎没有臭味,重者不出汗也有臭味,出汗时更为明显,奇臭难闻,波及四周,

甚至腹股沟、外阴肛门部、脐窝及乳晕也散发野狐臭气。一般夏季出汗多明显,冬季出汗少减轻,情绪波动,进食刺激性食物及妇女月经期、怀孕期间臭味加重,多数到更年期以后,由于大汗腺逐渐萎缩,臭汗减少或消失。部分患者可伴汗多、色汗及油耳等。

【辨证施灸】

本病对健康无损,患者常因汗臭味波及四周,臭气熏人,令人不愿接近而就医颇为迫切,不需内服药物,可采用艾灸等综合疗法或手术治疗。

(1) 艾炷灸:先剃去腋毛,取淀粉适量用水调成糊状,敷于腋下,6~7日后腋下淀粉糊表面出现针尖大小黑点,即为大汗腺所在部位,然后取小艾炷放在黑点上直接施灸,每次3~4壮,每周1次。

(2) 艾条隔药灸:取密陀僧末12克,加面粉适量,用水调成糊状,敷于极泉穴上,用艾条点燃悬灸10~20分钟,每日1次,10次为1个疗程。

(3) 火针灸:先剃去腋毛,用肥皂水清洗干净,局部消毒,以1%普鲁卡因行局麻后,选粗火针对准毛囊和汗腺呈45°角速刺入毛囊和汗腺的基地部,速进疾出,并在毛囊及汗腺周围围刺5~10针,然后将囊内臭液及少许血挤出,再消毒后涂以抗生素软膏,包扎固定,防止感染。

(4) 铁落熨灸:取铁落(或铁砂)适量,炒烫用布包乘热熨灸腋下,每次30~60分钟,每日或隔日1次。

(5) 蜘蛛敷灸:取大蜘蛛1个,用黄泥、赤石脂粉、盐各少许,和匀水调裹蜘蛛火煨存性,再研细末,加轻粉少许,用醋调成糊状,临睡前洗净腋窝,将药糊敷于腋下,每晚1次。

按:臭汗症属遗传性疾病,对健康无损,目前无特异性治疗,

根治不易,切勿滥用内服药物,用艾灸治疗,可减轻汗臭味。

保 健 灸

1. 保健灸的起源和发展

保健灸的历史悠久,我国古代劳动人民很早就采用艾灸进行保健强身,防治疾病。文献中记载之“逆灸”就是现代的保健灸。古人非常重视艾灸保健,在《内经》中就有“大风汗出,灸谿谿”,“灸则强食生肉”的记载,并把掌握针灸保健技术的医生称为上工。唐代医家孙思邈提出了用灸法预防疾病,把灸足三里称为“长寿灸”,可以防病抗衰老。宋代《针灸资生经》提出了脐灸有壮元阳的功效,能强壮身体,延年益寿;灸百会可以预防小儿惊风。《医说》指出“若要安,丹田、三里常不干”,《扁鹊心书》说:“人于无病时,常灸关元、气海、命门、中脘……虽未得长生,亦可保百余年寿矣。”明代《针灸大成》在运用灸法预防中风时,主张“便宜急灸三里、绝骨四处,各灸三壮”,“如春交夏时,夏交秋时俱宜灸,常令二足有灸疮为妙”。《医学入门》说:“凡一年四季各熏一次,元气坚固,百病不生。”清代医家张璐在夏月三伏用药敷灸肺俞、膏肓俞、百劳等穴,可预防冬季哮喘发病。当代保健灸在继承古代经验的基础上,已取得了很大的发展和进步,发明了很多新的灸疗方法和器械,药物穴位敷灸防治慢性气管炎、心绞痛等疾病,取得了显著的效果。运用灸法,减肥防皱,使艾灸疗法步入美容延缓衰老的领域,受到世界医学界的注目。通过大量临床和实验研究,逐渐阐明保健灸的作用原理。保健灸可以调整脏腑功能,促进机体新陈代谢,增加红、白细胞的数量和吞噬细胞的吞噬功能,调整和提高机体的免疫功能,增强机体的抗病能力,从而可达防病健身、延年益寿的目的。

2. 保健灸对世界医学的影响

保健灸随着中医学很早就流传到世界各国,对世界医学产生了一定影响,特别是深受日本、朝鲜及东南亚各国医家和人民的重视。在日本,保健灸很盛行,三里灸广为流行,《养生一言草》载有“灸治确为养生诀,年逾四十灸三里。施灸不为寒暑限,疲劳施灸为上策。小儿患病应施灸,胜似服药有神效”。日本很多医家都非常重视长寿灸,提倡婴儿时期灸身柱,以促进婴儿生长发育;17岁左右灸风门,以预防呼吸系统疾病;24岁左右灸三阴交,以避免生殖泌尿系统疾病;30岁灸足三里,以增强脾胃功能,预防一切疾病;老年加灸曲池,以降低血压,预防中风,使眼睛明亮。在朝鲜《东宝医鉴》称脐灸有“养丹田,助两肾,添精补髓,返老还童,防病延寿”之功。

3. 保健灸的特点

(1) 适应范围广,保健灸不仅能防病强身,延年益寿,而且可预防传染病,对治疗临床各科各种疾病均有明显的效果。

(2) 保健灸方法多种多样,有艾灸、脐灸、隔药灸、药物敷灸等。

(3) 疗效确切,安全可靠,操作简便,可以自己操作,副作用少,既适宜在医疗单位开展,也可在家庭操作。

4. 保健灸的临床应用

(1) 灸三里:足三里是足阳明胃经的合穴,为五腧穴之一,为全身最重要的强壮穴。具有健脾胃,助运化,调气血,扶正气,壮元阳,祛风邪及强身壮体益寿的作用,灸之能调整胃肠、心肺功能,使呼吸、代谢功能显著增强,调节血压、血糖,提高免疫功能。主治一切胃肠病证、虚损劳疾。无病灸之有防病健身、增强机体抵抗力、延缓衰老的作用。对防治高血压、低血压、动脉硬化、肺心病、冠心病、中风、慢性胃肠病都有较好的

效果。故俗话说“若要安，(足)三里不要干”，是古今最常选用的保健灸。古人多采用化脓灸，每次灸3~5壮，灸后发疱化脓形成灸疮，约20~40日结痂，灸痂脱落痊愈后遗留瘢痕，可每年灸1次。

现在多采用艾炷无瘢痕灸或艾炷隔药灸，即当艾炷点燃灸至局部有灼热感时即用镊子夹去艾炷，再换新炷施灸，连灸3~5壮。亦可采用艾条温和灸，每次10~15分钟，灸至局部有温热感，皮肤出现红晕为度，每日或隔日1次，每月灸10次。

(2) 灸神阙穴：神阙穴属任脉经穴，为保健灸要穴，一向受养生家重视。具有复苏固脱，温补元阳，健运脾胃，延年益寿及强壮作用。对防治慢性肠炎有较好的效果。可选用艾炷隔盐(或姜，或附子饼)灸、炼脐灸、艾条温和灸，每次5~7壮(或10~15分钟)，灸至腹内有温暖舒适感，局部皮肤红润发热为度，每日或隔日1次，每月灸10次。本穴不宜采用化脓灸。

(3) 灸关元穴：关元穴属任脉经穴，为足三阴与任脉之会，手太阳小肠的募穴。具有温肾固精，益气回阳，培元固本，理气和血，通调冲任及强壮的作用，灸之能调整膀胱的张力，促进垂体-性腺功能，提高机体免疫力，防病强身保健。主治诸虚百损。对防治遗尿、遗精、习惯性便秘有较好的效果。为中老年人保健灸的常用穴。多采用艾炷无瘢痕灸、艾炷隔药灸、艾条温和灸、温盒灸、药物敷灸等，每次灸3~5壮或10~20分钟，灸至小腹温暖舒适感，局部皮肤红晕发热为度，每日或隔日1次，每月灸10次。注意孕妇忌用。

(4) 灸气海穴：气海穴属任脉经穴，为保健要穴。具有培补元气，益肾固精，调理冲任及强壮作用，灸之能调整肠及肾的功能，提高机体免疫力。对腹泻、遗尿有防治作用。可选用

艾炷灸、艾炷隔姜（或附子）灸、艾条温和灸、药物敷灸等。灸法和注意事项同关元。

（5）灸肾俞穴：肾俞穴为足太阳膀胱经背俞穴，具有补肾益精，强健腰脊，聪耳明目，壮骨健身，温阳散寒等强壮作用。灸之能调整肾功能，促进肾上腺皮质功能，调整膀胱张力，兴奋网状内皮系统的吞噬能力，主治肾虚腰痛、精少早衰、诸虚百损等。对肾虚腰痛、遗精、阳痿、早泄、遗尿、哮喘有防治作用。可选用艾炷无瘢痕灸、艾炷隔姜（或附子饼）灸、艾条温和灸、药物敷灸等，灸法同足三里。

（6）灸膏肓俞穴：膏肓俞穴为足太阳膀胱经之背俞穴，有调整肺气，养阴清肺，补虚益损的功效。灸之能缓解支气管痉挛，增加血红蛋白和红细胞数，防治肺结核、咳喘、虚劳及一切血证。可选用艾炷无瘢痕或瘢痕灸、艾炷隔姜灸、艾条温和灸等。

（7）灸风门穴：风门穴属足太阳膀胱经穴，为足太阳膀胱经与督脉交会穴，又称热府，是风邪出人之门户。具有宣肺解表，疏散风邪，调整气机的功效。灸之能调整肺功能，增加肺通气量。主治一切风证，防治感冒、中风、痲痘等。预防高血压可选用艾条温和灸或温盒灸，每次10~30分钟，每日1次，每月灸10次；预防流行性感胃可选用艾炷隔姜灸，每次10~20分钟，灸至皮肤潮红温热舒适为度，在感冒流行季节，每日施灸1次，可连灸7~10次。

（8）灸身柱穴：身柱穴属督脉经穴，为小儿强壮保健要穴。具有通阳解表，祛风退热，清心宁神的功效。可防治小儿惊痫、癫狂。每次用小艾条温和灸5~10分钟，隔日1次，每月灸10次，亦可配合灸风门。

（9）灸大椎穴：大椎穴属督脉经穴，又名百劳，为手、足三

阳，督脉之会，又称督脉之海，有总督诸阳之义，能主宰全身，故为保健要穴。具有通阳解表，清热解毒，疏风散寒，清脑宁神，肃肺调气的功效。灸之能调整肺、甲状腺及免疫功能、对血液循环、白细胞也有调整作用，配灸足三里可防治白细胞减少。可选用艾炷无瘢痕灸、隔物灸及艾条温灸。

(10) 灸三阴交穴：三阴交穴属足太阴脾经穴，为足三阴经之交会，具有健脾和胃，调补肝肾，调理经血，主生殖的作用。灸之能调整胃分泌功能，女性生殖功能，调整心律、心率，调节胰岛素分泌，预防生殖系统疾病。主治肝、脾、肾三脏的疾病，能防治高血压、月经不调、子宫功能性出血。可选用艾炷无瘢痕灸，每次 3~5 壮，3 日 1 次，每月共灸 5 次；或艾条温和灸，每次 10~20 分钟，每日 1 次，每月共灸 10 次。

(11) 灸涌泉穴：涌泉穴属足少阴肾经井穴，为老年保健要穴，有补肾益精，宁神开窍，舒调肝气的作用。灸之有降低血压的作用，防治高血压，能纠正胎位，并有强壮保健益寿之功。可选用艾炷无瘢痕灸或隔姜灸，每次灸 5~10 壮，灸至局部感觉灼痛时即用镊子夹去未燃尽的艾炷，更换新炷再灸。

(12) 伏天灸：取白芥子、半夏（或延胡）各 21 克，甘遂、细辛各 12 克，共研细末，加麝香少许调匀，用生姜汁调制成 18 个小饼，于每年三伏（头、中、末）时分别敷灸肺俞、心俞、膈俞（或百劳、定喘、膏肓）穴，用胶布固定，每次灸 4~6 小时或更长时间，每伏 1 次，每年共敷灸 3 次，连续 3 年，可预防哮喘冬季发病。